15/10/2026

Número: **0008172-04.2026.8.17.2480**

Classe: **Procedimento Comum Cível**
Órgão julgador: **5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru**
Última distribuição : **29/05/2026**
Valor da causa: **R$ 30.100,00**
Assuntos: **Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos**
Nível de Sigilo: **0 (Público)**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES (AUTOR(A))	
	MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA (ADVOGADO(A))
UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)	
	JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ (ADVOGADO(A))

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
242020091	29/05/2026 21:17	Petição Inicial (Outras)	Petição Inicial (Outras)
242020092	29/05/2026 21:17	1. CNH-e	Outros Documentos
242020093	29/05/2026 21:17	2. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA	Outros Documentos
242020094	29/05/2026 21:17	3. PROCURAÇÃO	Instrumento de Procuração
242020095	29/05/2026 21:17	4. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA	Outros Documentos
242020096	29/05/2026 21:17	5. SIFES - Sistema de Financiamento Estudantil	Outros Documentos
242020100	29/05/2026 21:17	6. CONTRATO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED CARUARU	Outros Documentos
242020101	29/05/2026 21:17	7. LAUDO E ENCAMINHAMENTO - MAMOPLASTIA REDUTORA	Laudo (Outros)
242020102	29/05/2026 21:17	8. Negativa UNIMED CARUARU	Outros Documentos
242020103	29/05/2026 21:17	9. E-MAIL RESPOSTA - Resposta à NIP n. 158861-2026 - Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres	Outros Documentos
242020104	29/05/2026 21:17	10. NF 377 - MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES	Outros Documentos
242020105	29/05/2026 21:17	11. Comprovante-RECIBO de pagamento dos materiais cirurgicos	Outros Documentos
242020106	29/05/2026 21:17	12. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS ULTIMAS FATURAS - UNIMED	Outros Documentos
242020107	29/05/2026 21:17	13. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DA CIRURGIA	Outros Documentos
242048631	31/05/2026 15:51	ADITAMENTO À INICIAL	Petição (Outras)

242057885	31/05/2026 15:51	Fatura maio - Maria - UNIMED	Outros Documentos
242085446	01/06/2026 15:23	Despacho	Despacho
243131682	09/06/2026 10:01	Despacho\Intimação\Intimação (Outros)	Despacho\Intimação\Intimação (Outros)
244550823	19/06/2026 09:14	Certidão (Outras)	Certidão (Outras)
245851538	07/07/2026 22:12	Petição Simples de Terceiro Interessado	Petição Simples de Terceiro Interessado
245851539	07/07/2026 22:12	Doc. 01. Procuração (sede)	Anexo
245851540	07/07/2026 22:12	Doc. 02. Substabelecimento	Anexo
245851541	07/07/2026 22:12	Doc. 03. Estatuto Social	Anexo
245851542	07/07/2026 22:12	Doc. 04. Ata de assembleia	Anexo
245851547	07/07/2026 22:25	Manifestação ao pedido de tutela antecipada	Manifestação (Outras)
245851548	07/07/2026 22:25	01. Contrato de Plano de Saúde	Anexo
245851549	07/07/2026 22:25	02. Relatório de Beneficiários - Dados Pessoais, Bancários, Endereços e Telefones	Anexo
245851550	07/07/2026 22:25	03. Relatório de Beneficiários - Sobre o Contrato	Anexo
245851551	07/07/2026 22:25	04. Parecer Técnico 19_2024 da ANS	Anexo
245851552	07/07/2026 22:25	05. Justificativa de Negativa de Procedimento da Guia-N 144786009 (1)	Anexo
245851553	07/07/2026 22:25	06. Justificativa de Negativa de Procedimento da Guia-N 144786009	Anexo
245851554	07/07/2026 22:25	07. GuiaDeInternacao-N 144786009 (negada)	Anexo
246438453	13/07/2026 13:58	Manifestação (Outras)	Manifestação (Outras)
246438455	13/07/2026 13:58	Doc. 01 - NFS-e 53016 - Hospital Memorial Sao Gabriel - R$ 3.000,00	Outros Documentos
246438457	13/07/2026 13:58	Doc. 02 - NFS-e 53017 - Hospital Memorial Sao Gabriel - R$ 1.400,00	Outros Documentos
246438458	13/07/2026 13:58	Doc. 03 - Conta Hospitalar Detalhada - Hospital Memorial Sao Gabriel - R$ 4.400,00	Outros Documentos
246438460	13/07/2026 13:58	Doc. 04 - NFS-e 5345 - Albuquerque Anestesias - R$ 1.600,00	Outros Documentos
246438462	13/07/2026 13:58	Doc. 05 - Recibo - Instrumentacao Cirurgica 16-06-2026 - R$ 750,00	Outros Documentos
246438463	13/07/2026 13:58	Doc. 06 - Recibo - Servicos Cirurgicos 16-06-2026 - R$ 450,00	Outros Documentos
246438466	13/07/2026 13:58	Doc. 07 - Recibo - Cuidados Pos-Operatorios - R$ 400,00	Outros Documentos
246438467	13/07/2026 13:58	Doc. 08 - Registro Fotografico - Identificacao de Leito - Internamento 16-06-2026	Outros Documentos
249706193	09/08/2026 23:17	Decisão	Decisão
253221618	01/09/2026 17:04	Contestação	Contestação
253221619	01/09/2026 17:04	01. Nota Técnica - NatJus - NT1530	Anexo
253221620	01/09/2026 17:04	Intimação (Outros)	Intimação (Outros)
254296894	10/09/2026 20:11	Réplica	Réplica
257307344	07/10/2026 11:13	Despacho	Despacho

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU/PE

MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, brasileira, solteira, estudante, portadora do CPF nº 097.798.184-30, residente e domiciliada na Avenida Aracaju, nº 784, primeiro andar, Bairro Universitário, Caruaru/PE – CEP 55016-640, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, com endereço eletrônico melquisedequelima@delimaadvocacia.com, onde recebe intimações (instrumento de mandato em anexo), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de **UNIMED CARUARU, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.449.225/0001-98, com Registro ANS nº 340952, com sede no Caruaru Corporate, 3º Andar, Av. Adjar da Silva Casé, nº 800, Indianópolis, Caruaru/PE, CEP 55.024-740, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

I. DA COMPETÊNCIA

Esta Vara Cível da Comarca de Caruaru/PE é competente para processar e julgar a presente demanda por fundamento triplo, cumulativamente verificado no caso concreto.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

1. Foro do Réu (art. 53, III, CPC)	2. Foro do Consumidor (art. 101, I, CDC)	3. Foro dos Fatos (complementar)
A Requerida tem sede em Caruaru/PE, fixando a competência nesta Comarca no foro do domicílio do réu e no local de cumprimento da obrigação.	A Requerente é domiciliada em Caruaru/PE, atraindo a regra protetiva que assegura ao consumidor o direito de ajuizar no seu domicílio.	Todos os fatos desta demanda (contrato, laudo, negativa, procedimento cirúrgico) ocorreram em Caruaru/PE.

A cláusula do art. 97 do instrumento contratual, que elege o foro de Garanhuns/PE, é nula de pleno direito por flagrante abusividade (art. 51, IV e XV, do CDC): o foro eleito não guarda qualquer vínculo com as partes, com o contrato ou com os fatos desta demanda, configurando foro aleatório vedado pelo art. 63, § 3º, do CPC. O Egrégio TJPE, pela sua Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru, fixou tese expressa a respeito:

> *"Em relações de consumo, o foro do domicílio do consumidor prevalece sobre cláusula contratual de eleição de foro. É abusiva a cláusula de eleição de foro que imponha ao consumidor litigar em localidade diversa de seu domicílio."* (TJPE, AI nº 0003617-27.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 10/12/2025)

II. DOS FATOS

II.1. Do contrato e da regularidade do vínculo

A Requerente é beneficiária do Plano ÚNICO (Proposta de Admissão nº 432912), contratado pela titular Maria Lucimara da Silva junto à Requerida em 26/10/2005. O contrato encontra-se plenamente ativo, sem qualquer rescisão, aditivo de exclusão ou interrupção de cobertura, como demonstram os comprovantes de pagamento das mensalidades de fevereiro, março e abril de 2026, todos efetuados em nome da própria Requerente junto à Unimed Caruaru, no valor de R$ 305,74 cada.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

A data de inclusão da Requerente no plano remonta a outubro de 2005, de modo que qualquer período de carência encontra-se há muito superado.

A Requerida, ao continuar cobrando mensalidades com a inclusão da Requerente após sua maioridade, sem qualquer notificação de exclusão ou exigência de migração para plano individual, aceitou tacitamente a prorrogação da cobertura.

Essa conduta é incompatível com a invocação posterior do limite de idade como fundamento de exclusão (boa-fé objetiva, art. 422 do Código Civil, e vedação ao comportamento contraditório).

Portanto, temos:

Razão 1 — Aceitação tácita da operadora: Ao continuar cobrando mensalidades com a inclusão da autora após a maioridade, sem qualquer notificação de exclusão ou exigência de migração para plano individual, a Unimed Caruaru aceitou tacitamente a prorrogação da cobertura. Essa conduta é incompatível com a invocação posterior do limite de idade como fundamento de exclusão, por configurar comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e pela teoria do *venire contra factum proprium*.

Razão 2 — Continuidade contratual expressa: O art. 26, parágrafo único, do próprio contrato prevê que o dependente que perder essa condição pode assinar contrato em nome próprio em até 30 dias, aproveitando as carências já cumpridas. O fato de a operadora jamais ter adotado qualquer providência nesse sentido, mantendo o contrato ativo, demonstra que ela mesma não considerou encerrada a cobertura da autora. Esse reconhecimento tácito tem força probatória relevante em eventual contestação.

II.2. Do quadro clínico e do laudo médico

A Requerente, com 20 anos de idade, é portadora de macromastia com repercussão funcional direta e objetivamente documentada sobre a coluna vertebral. Em 07/04/2026, o Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins, Neurocirurgião (CRM 20619/PE, RQE 10833), do Instituto NeuroCor de Caruaru/PE, emitiu laudo médico fundamentado com os seguintes achados clínicos:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

(i) dorsalgia crônica mecânico-postural, com alívio apenas parcial com analgésicos;
(ii) alteração postural com anteriorização do tronco e hipercifose torácica;
(iii) dor à palpação da musculatura paravertebral torácica e região interescapular;
(iv) quadro compatível com sobrecarga musculoligamentar posterior;
(v) escoliose torácica leve (18,9° a 20°), com necessidade de tratamento conservador e compensação muscular.

A análise clínica e radiográfica concluiu que a sobrecarga biomecânica imposta pelo volume mamário excessivo é a principal mantenedora da dor e da desorganização biomecânica da coluna, com repercussão direta sobre a postura e a sobrecarga do segmento torácico.

O laudo afasta expressamente o caráter estético, concluindo tratar-se de **quadro patológico e funcional, com repercussão clínica objetiva sobre a coluna vertebral e musculatura de sustentação**.

Os CIDs expressos são: N62 (Hipertrofia da mama), M54.6 (Dor na coluna torácica), M40.2 (Outras cifoses e lordoses) e M41.9 (Escoliose, não especificada). A conclusão é de **indicação médica formal de mamoplastia redutora com caráter reparador/funcional, e não estético**.

II.3. Da solicitação e da negativa da requerida

Em 07/04/2026, foi apresentada à Requerida a Guia de Solicitação de Internação acompanhada do laudo médico, com pedido expresso de cobertura do procedimento. Em 09/04/2026, a Requerida emitiu o Comprovante de Negativa Contratual/Assistencial (Guia nº 144786009), com o único fundamento de que o procedimento seria de natureza estética.

A Requerida não apresentou contraparecer técnico, não indicou médico próprio que avaliasse o caso concreto e não demonstrou a existência de alternativa terapêutica equivalente. A Requerente formalizou reclamação junto à ANS (NIP nº 158861/2026), tendo a Requerida invocado, em resposta, o Parecer Técnico nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

Dessa forma, é evidente que se está diante de uma negativa ilegal, visto que carente de fundamentação adequada capaz de afastar a cobertura, limitando-se a justificar-se em limitação de rol taxativo da ANS, por entender, repita-se, de modo totalmente equivocado, que o procedimento é de ordem estética.

II.4. Do dano patrimonial já suportado e da urgência

Diante da negativa, a família da Requerente contraiu o procedimento cirúrgico com data marcada para **13 de junho de 2026**. Os desembolsos já realizados e o remanescente estimado compõem o seguinte quadro:

Item	Valor	Documentação
Honorários do cirurgião (Dr. Marcos Gomes)	R$ 9.000,00	NF-e nº 377 (26/05/2026)
Materiais cirúrgicos (sutiã, linha e cola)	R$ 1.100,00	Comprovante em anexo
Remanescente (hospital, anestesia e demais itens)	Estim. R$ 9.900,00	Orçamento em anexo
TOTAL JÁ DESEMBOLSADO	**R$ 10.100,00**	

O quadro acima revela a dimensão concreta do dano patrimonial já suportado pela família da Requerente em razão da negativa indevida da Requerida. Uma jovem de 20 anos, sem renda própria, dependente de sua família, viu-se compelida a mobilizar R$ 10.100,00 de recursos que não dispunha, apenas para acessar um procedimento que o plano de saúde, ao qual sua família contribui há mais de vinte anos, tinha obrigação de custear. O valor remanescente estimado de R$ 9.900,00, que será exigido na data da cirurgia, representa um segundo dano patrimonial iminente, igualmente causado pela conduta ilícita da Requerida. Essa é a razão pela qual a tutela de urgência ora requerida é indispensável: não apenas para garantir o custeio do procedimento, mas para impedir o agravamento de um dano que já se materializou de forma concreta e documentada.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

III. PRELIMINARMENTE – DA HIPOSSUFICIÊNCIA E DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nobre julgador, a Requerente é estudante de medicina, sendo o seu curso financiado 100% pelo FIES (nº contrato: 15.0051.187.0001083-30), com 20 anos de idade, sem renda própria, dependendo financeiramente de seus familiares para se manter. Não possui emprego formal, renda autônoma ou patrimônio que lhe permita arcar com as custas processuais e honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento.

Essa condição de hipossuficiência econômica é juridicamente relevante por dois motivos distintos e cumulativos.

Gratuidade da Justiça (inteligência do art. 98 do CPC)	**Inversão do Ônus da Prova (inteligência do art. 6º, VIII, do CDC)**
A declaração de hipossuficiência acostada aos autos goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, salvo prova em sentido contrário. O TJPE confirma esse entendimento (AI nº 0010373-08.2023.8.17.9000, j. 21/05/2026).	A hipossuficiência técnica e econômica da Requerente, consumidora em relação tipicamente assimétrica com operadora de plano de saúde, autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação, incumbindo à Requerida demonstrar a legitimidade da negativa.

Importa registrar que a hipossuficiência econômica da Requerente torna ainda mais grave a conduta da Requerida: diante da negativa indevida de cobertura, a família da Requerente precisou reunir recursos financeiros extraordinários para custear o procedimento cirúrgico (R$ 10.100,00 já desembolsados), esforço que não lhe seria exigível não fosse o inadimplemento contratual da operadora. Esse contexto reforça tanto o dano moral quanto o periculum in mora para fins de tutela de urgência.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

IV. DO DIREITO

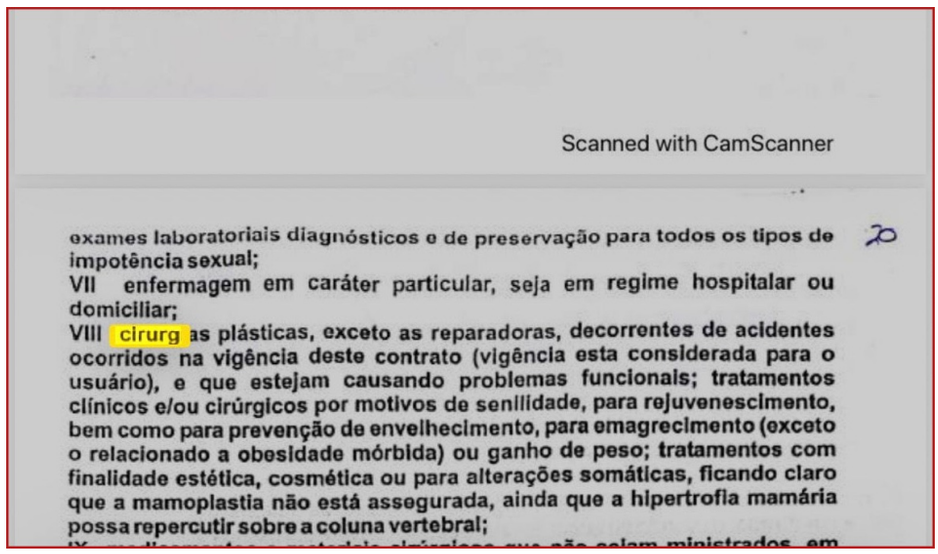
IV.1. Da aplicação do código de defesa do consumidor

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, submetendo-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 1º da Lei nº 9.656/98 e da Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Decorre daí: a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável à Requerente (art. 47 do CDC); a nulidade de pleno direito das disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC); e a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação (art. 6º, VIII, do CDC).

IV.2. Da nulidade da cláusula contratual de exclusão (art. 54, VIII)

O Capítulo III do contrato (Das Exclusões Contratuais) lista, em seu art. 54, VIII, as cirurgias plásticas como excluídas da cobertura. O trecho que constitui o principal obstáculo do caso é o seguinte:


Scanned with CamScanner

exames laboratoriais diagnósticos e de preservação para todos os tipos de impotência sexual;
VII enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;
VIII cirurgias plásticas, exceto as reparadoras, decorrentes de acidentes ocorridos na vigência deste contrato (vigência esta considerada para o usuário), e que estejam causando problemas funcionais; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por motivos de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção de envelhecimento, para emagrecimento (exceto o relacionado a obesidade mórbida) ou ganho de peso; tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral;

Contrato Plano ÚNICO — art. 54, VIII: trecho que menciona expressamente a mamoplastia e a hipertrofia mamária com repercussão vertebral.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

"[...] tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral."

Esse trecho é central: a Unimed antecipou, na própria cláusula contratual, exatamente o argumento clínico que o laudo do Dr. Felipe utiliza (repercussão da macromastia sobre a coluna vertebral) e o afastou expressamente como fundamento de cobertura.

Tal cláusula é nula por abusividade, por três vetores autônomos e cumulativos.

1º Vetor: Abusividade intrínseca (inteligência do art. 51, IV, CDC)	**2º Vetor: Interpretação restritiva (inteligência do art. 47, CDC)**	**3º Vetor: Exceção reparadora (inteligência do art. 39, CDC)**
A cláusula exclui, a priori, qualquer avaliação clínica individualizada, impedindo que um laudo especializado tenha eficácia contratual. Isso coloca o consumidor em desvantagem exagerada.	As cláusulas de exclusão devem ser lidas de forma mais favorável ao consumidor, alcançando apenas mamoplastias puramente estéticas, não as com indicação médica funcional documentada.	O próprio contrato garante cobertura à Cirurgia Plástica Reparadora para restauração de funções. A mamoplastia prescrita visa à restauração da função biomecânica da coluna torácica.

O Egrégio TJPE fixou tese expressa sobre cada um desses vetores:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. *PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.*

1. Caso em exame Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura integral de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora prescrito à autora, bem como o pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00.

2. Questão em discussão Há duas questões centrais postas em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde encontra respaldo contratual legítimo e se o procedimento

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

cirúrgico possui natureza meramente estética ou terapêutica;(ii) saber se a sentença merece reforma quanto ao índice de correção monetária aplicado sobre a indenização moral arbitrada. III. Razões de decidir

3. Os laudos médicos carreados aos autos, firmados por especialistas em mastologia, ortopedia e cirurgia plástica, apontam para a necessidade clínica da intervenção cirúrgica, restando demonstrada a finalidade terapêutica do procedimento e, por conseguinte, a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional ao abalo vivenciado e compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares.

5. No que concerne à atualização do montante indenizatório, aplica-se o entendimento firmado no REsp n. 2.170.806/RJ, julgado em 17/03/2025 pela Terceira Turma do STJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que estabelece a Taxa SELIC como índice unificado para correção monetária e juros moratórios nas condenações por danos morais, afastando a cumulatividade com o IPCA. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para alterar o critério de correção monetária da indenização por danos morais, que deverá observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, desde a data da sentença. Tese de julgamento: ***1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora, quando clinicamente indicada, ainda que prevista exclusão contratual, por se tratar de procedimento de finalidade terapêutica.*** *2. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice unificado de atualização monetária e juros de mora sobre indenização por danos morais.*

(...)

(TJPE, AC nº 0097813-53.2024.8.17.2001, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. **08/10/2025**);

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL. HIPERTROFIA MAMÁRIA SINTOMÁTICA (CID N62.0). NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE CIRURGIA ESTÉTICA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CARÁTER TERAPÊUTICO/REPARADOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO*. I. Caso em exame*

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando-a a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora bilateral indicada em razão de hipertrofia mamária acentuada, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de deferir tutela provisória e fixar honorários advocatícios. II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) definir se é devida a cobertura de mamoplastia redutora bilateral indicada por prescrição médica, diante da alegação de ausência no rol da ANS e de natureza estética do procedimento; (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável pela negativa de cobertura; e (iv) aferir a adequação do quantum fixado e dos consectários da condenação. III.

Razões de decidir 3. Inexistência de cerceamento de defesa. O magistrado é destinatário da prova (CPC,

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

arts. 355, I, e 370), podendo indeferir diligências desnecessárias quando suficientes os elementos documentais constantes dos autos. Ausência de demonstração de prejuízo concreto (CPC, art. 282, § 1º).

4. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação contratual mais favorável ao consumidor e controle de abusividade.

5. Mamoplastia redutora indicada em razão de hipertrofia mamária sintomática não se confunde com cirurgia meramente estética, possuindo natureza terapêutica/corretiva, voltada à preservação da saúde e da funcionalidade.

6. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, não autorizando negativa automática quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento e inexistente alternativa terapêutica eficaz. Abusividade da recusa configurada.

7. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde, em contexto de necessidade terapêutica comprovada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

(TJPE, AC nº 0020862-60.2023.8.17.3130, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 8ª Câmara Cível Especializada, j. **17/04/2026**);

EMENTA: Direito à Saúde. Plano de Saúde. Agravo de Instrumento. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pedido de tutela de urgência. Decisão interlocutória que determinou a realização de prova pericial médica. Reforma. Desnecessidade da perícia. ***Existência de laudo médico fundamentado. Prerrogativa do profissional assistente. Abusividade de cláusula restritiva****. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC . Provimento do recurso.*

(...)

Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento adequado ao paciente. A cláusula contratual que limita cobertura de tratamento prescrito por profissional qualificado é nula de pleno direito, por violar o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor."

(TJPE, AI nº 0007731-91.2025.8.17.9000, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. **29/09/2025**);

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO- HOSPITALARES E DE DANOS MORAIS. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO E NÃO ESTÉTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A cirurgia de correção de hipertrofia mamária consiste em um procedimento médico para atenuar os problemas corporais do paciente, que afetam a sua saúde e qualidade de vida, reduzindo o risco de agravamento do estado de saúde, demonstrando o seu caráter não estético.

2. No caso em análise, existe solicitação pormenorizada do profissional de saúde indicando o procedimento solicitado como solução adequada à condição médica apresentada pela paciente.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

Configurado está, portanto, o ato abusivo do plano de saúde ao recusar a cobertura da cirurgia reparadora pleiteada.

3. A hipertrofia mamária está listada na Classificação Internacional de Doenças – CID 10 da Organização Mundial de Saúde e, por isso, é obrigatória a cobertura do respectivo tratamento por parte dos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98.

4. O rol da ANS não é taxativo, pois contém apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional, de maneira que funciona como mero orientador das prestadoras de serviços de saúde, consoante jurisprudência majoritária.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em situações semelhantes (negativa indevida de cobertura por plano de saúde), caracteriza-se o dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), anulando as cláusulas consideradas abusivas perante a situação desigual entre as partes, bem como a necessidade da interpretação do contrato em favor do consumidor, conforme arts. 47 e 51, incisos I e IV do CDC.

8. Resta configurado e imperioso o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário referentes à cirurgia de correção de hipertrofia mamária unilateral.

9. Inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados estes em 20% sobre o valor da condenação. 10. Apelação provida, à unanimidade.

(TJPE, AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. **29/05/2020**, envolvendo a Unimed Caruaru)

Portanto, nobre julgador, firme em tais e uníssonos precedentes, há de ser afastada a mencionada cláusula, por ser abusiva e, portanto, nula de pleno direito, por colocar o consumidor em enorme desvantagem contratual, para se reconhecer o direito inafastável da autora em ver seu procedimento plenamente acobertado pelo plano de saúde contratado, por não se tratar de procedimento estético, mas estritamente terapêutico.

IV.3. Da fragilidade do parecer técnico nº 19/2024 da ANS e da taxatividade mitigada

A Requerida invocou o Parecer Técnico nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 da ANS como fundamento da negativa. Pareceres técnicos internos não têm força

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

normativa de Resolução Normativa. A exclusão formal de um procedimento do Rol obrigatório exige edição de RN com procedimento regulatório adequado. Mero parecer interno não supre esse requisito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051 (EREsp 1.886.929/SP, 2ª Seção, j. 08/06/2022)[1], consagrado na Lei nº 14.454/2022, preservou expressamente a possibilidade de cobertura quando há **indicação médica individualizada sem alternativa terapêutica equivalente no rol**. Os requisitos dessa exceção estão plenamente presentes nos autos:

Requisito 1 atendido	**Requisito 2 atendido**
Laudo individualizado de neurocirurgião atestando indicação formal e fundamentada de mamoplastia redutora de caráter funcional, com quatro CIDs ortopédicos e neurológicos.	Inexistência de procedimento substituto no rol capaz de tratar a causa biomecânica do quadro doloroso. O tratamento conservador apenas atenua sintomas sem eliminar o volume mamário que os provoca.

Neste sentido, inclusive, recentíssimos julgados do E. TJPE:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ***PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA POR GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA E NÃO MERAMENTE ESTÉTICA. ROL DA ANS QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTAMENTE TAXATIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA****. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.*

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Demonstrada por meio de documentação médica a existência de quadro clínico de

[1]STJ, Notícia Oficial, 08/06/2022. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx. Acesso em: 24 mai. 2026.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

gigantomastia associada a patologias ortopédicas, com recomendação expressa de cirurgia redutora, revela-se legítima a determinação judicial de custeio do procedimento pelo plano de saúde.

3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não constitui lista absolutamente exaustiva, admitindo-se exceções quando comprovada a eficácia do tratamento e inexistente alternativa terapêutica eficaz, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A negativa de cobertura de procedimento indispensável à preservação da saúde do beneficiário configura conduta abusiva.

5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada.

(TJPE, AI nº 0016006-29.2025.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 8ª Câmara Cível Especializada, j. **17/04/2026**)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ***PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CARDÍACO. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. APLICABILIDADE DO CDC. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS DO SISTEMA UNIMED.*** *MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)*

RAZÕES DE DECIDIR 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde firmados com Operadoras privadas, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98, conforme orientação consolidada na Súmula 608 do STJ.

3. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS revela-se abusiva quando presentes prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico eficaz e comprovação científica da eficácia do tratamento indicado.

4. A Lei nº 14.454/2022 incorporou ao ordenamento jurídico a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, ***assegurando cobertura de procedimentos não expressamente previstos quando observados critérios técnicos e científicos***.

5. A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial à preservação da vida de paciente idoso e cardiopata configura dano moral presumido, por extrapolar mero inadimplemento contratual e atingir a dignidade e a segurança existencial do consumidor.

6. As Operadoras integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor quando participam da cadeia de fornecimento do serviço, em razão da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

7. O desprovimento integral do Recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJPE, AC nº 0139285-34.2024.8.17.2001, Rel. para o Acórdão Des. Mozart Valadares Pires, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 13/05/2026)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

IV.4. Dos Danos Morais

A negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico com indicação médica funcional documentada, sem qualquer contraparecer técnico, que compeliu a Requerente a arcar com R$ 10.100,00 de seus próprios recursos, ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O dano moral é *in re ipsa*, prescindindo de prova do abalo específico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO NECESSÁRIO. QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO - O Contrato de plano de saúde, ainda que celebrado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, que nulificam cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada - A negativa de cobertura para tratamento necessário recomendado por médico, com base na ausência de previsão contratual, configura prática abusiva, em desacordo com a finalidade do contrato de plano de saúde, que é a proteção da saúde do segurado - ***A negativa indevida de cobertura causa graves transtornos ao segurado, caracterizando dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização - Mantém-se a sentença que condenou o plano de saúde a fornecer o tratamento requerido e a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, considerando a abusividade da cláusula contratual que exclui a cobertura necessária*** *- Apelação desprovida. A C Ó R D Ã O Visto, discutido e votado este recurso, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, negar provimento à presente Apelação Cível, tudo nos termos dos votos e notas taquigráficas, caso estas últimas sejam juntadas aos autos. Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator*

(TJ-PE - Apelação Cível: 00566789520238172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

"*EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO- HOSPITALARES E DE DANOS MORAIS. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO E NÃO ESTÉTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA*

1. A cirurgia de correção de hipertrofia mamária consiste em um procedimento médico para atenuar os problemas corporais do paciente, que afetam a sua saúde e qualidade de vida, reduzindo o risco de agravamento do estado de saúde, demonstrando o seu caráter não estético. *2. No caso em análise, existe solicitação pormenorizada do profissional de saúde indicando o procedimento solicitado como solução adequada à condição médica apresentada pela paciente. Configurado está, portanto, o ato abusivo do plano de saúde ao recusar a cobertura da cirurgia*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

reparadora pleiteada.

3. A hipertrofia mamária está listada na Classificação Internacional de Doenças – CID 10 da Organização Mundial de Saúde e, por isso, é obrigatória a cobertura do respectivo tratamento por parte dos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98.

*4. **O rol da ANS não é taxativo, pois contém apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional, de maneira que funciona como mero orientador das prestadoras de serviços de saúde, consoante jurisprudência majoritária.***

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em situações semelhantes (negativa indevida de cobertura por plano de saúde), caracteriza-se o dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), anulando as cláusulas consideradas abusivas perante a situação desigual entre as partes, bem como a necessidade da interpretação do contrato em favor do consumidor, conforme arts. 47 e 51, incisos I e IV do CDC.

*8. Resta configurado e **imperioso o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário referentes à cirurgia de correção de hipertrofia mamária unilateral**.*

9. Inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados estes em 20% sobre o valor da condenação.

10. Apelação provida, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação nº 0009675-12.2016.8.17.2480, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, Desembargador JOSÉ VIANA ULISSES FILHO Relator"

(TJ-PE - AC: 00096751220168172480, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

Considerando os parâmetros praticados pelo TJPE em casos análogos (Súmula 35 do TJPE[2]), requer-se a fixação da indenização em **R$ 10.000,00 (dez mil reais)**.

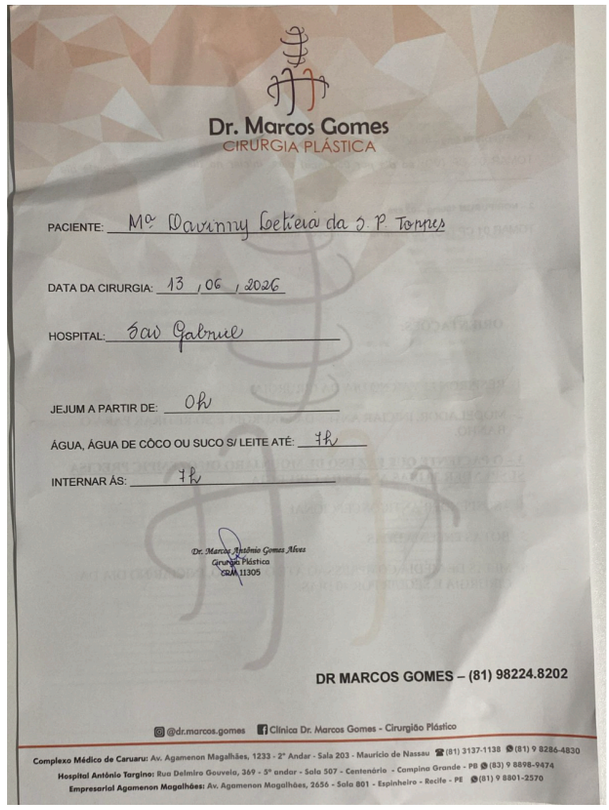
Saliente-se, ainda, que a correção monetária deverá observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC desde a data da sentença, conforme orientação do STJ (REsp n. 2.170.806/RJ, j. 17/03/2025).

[2] SUMÚLA 35 – TJPE: A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

V. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Este é o tópico mais urgente da presente demanda. A cirurgia de mamoplastia redutora está agendada para **13 de junho de 2026**, data a menos de três semanas do ajuizamento desta ação. Vejamos:



Dr. Marcos Gomes
CIRURGIA PLÁSTICA

PACIENTE: Mª Davanny Coelho da S P Torres

DATA DA CIRURGIA: 13 / 06 / 2026

HOSPITAL: São Gabriel

JEJUM A PARTIR DE: 0h

ÁGUA, ÁGUA DE CÔCO OU SUCO S/ LEITE ATÉ: 7h

INTERNAR ÁS: 7h

Dr. Marcos Antônio Gomes Alves
Cirurgião Plástico
CRM 11305

DR MARCOS GOMES – (81) 98224.8202

@dr.marcos.gomes Clínica Dr. Marcos Gomes - Cirurgião Plástico

Complexo Médico de Caruaru: Av. Agamenon Magalhães, 1233 - 2º Andar - Sala 203 - Maurício de Nassau (81) 3137-1138 (81) 9 8286-4830
Hospital Antônio Targino: Rua Delmiro Gouveia, 369 - 5º andar - Sala 507 - Centenário - Campina Grande - PB (83) 9 8898-9474
Empresarial Agamenon Magalhães: Av. Agamenon Magalhães, 2656 - Sala 801 - Espinheiro - Recife - PE (81) 9 8801-2570

Sem a concessão da tutela de urgência nos próximos dias, a Requerente se verá diante de duas alternativas igualmente danosas: ou cancela o procedimento, perpetuando o sofrimento físico e o risco de cronificação do quadro doloroso; ou a família arca com, aproximadamente, R$ 9.900,00 remanescentes, por conta própria, relativamente ao pagamento, no dia da cirurgia já marcada, ao hospital pela utilização de suas dependências/estrutura, instrumentação cirúrgica, anestesista e fisioterapeuta, agravando o dano patrimonial já existente de R$ 10.100,00 desembolsados.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

Em ambos os casos, o dano de difícil reparação estará consumado antes mesmo de a lide ser solucionada.

Estão plenamente presentes, portanto, os dois requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, com a densidade probatória raramente encontrada em casos desta natureza:

Probabilidade do direito (*fumus boni iuris*)	**Perigo de dano e de difícil reparação (*periculum in mora*)**
Laudo de neurocirurgião com indicação formal de caráter funcional, CIDs ortopédicos e neurológicos, negativa sem contraparecer técnico e precedentes do próprio TJPE, inclusive contra a própria Requerida (AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480).	Cirurgia agendada para **13/06/2026** (menos de três semanas). Sem a tutela, a família arcará com o remanescente estimado de R$ 9.900,00, agravando o dano patrimonial já existente de R$ 10.100,00 já desembolsados.

V.1. Da probabilidade do direito (*fumus boni iuris*)

A probabilidade do direito não se funda em mera verossimilhança abstrata. Ela está sustentada por um conjunto probatório objetivo, técnico e documental já acostado a esta inicial, composto por:

(i) Laudo de neurocirurgião (CRM e RQE ativos) com indicação formal, individualizada e tecnicamente fundamentada de mamoplastia redutora de caráter funcional, descrevendo cinco achados clínicos objetivos e quatro CIDs ortopédicos e neurológicos;
(ii) Contrato do Plano ÚNICO ativo há mais de vinte anos, sem qualquer cláusula de exclusão que afaste, legitimamente, a cobertura de procedimento com indicação médica funcional documentada;
(iii) Negativa da Requerida sem contraparecer técnico, sem avaliação clínica individualizada e sem indicação de alternativa terapêutica equivalente, fundada exclusivamente em enquadramento abstrato de "procedimento estético";
(iv) Precedentes do próprio TJPE, incluindo a Câmara Regional de Caruaru, reconhecendo a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

obrigatoriedade de cobertura em casos idênticos, com condenação da própria Unimed Caruaru ao ressarcimento das despesas com cirurgia de correção de hipertrofia mamária (AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480);

(v) Comprovantes de pagamento de mensalidades pela própria Requerente, demonstrando a regularidade e a continuidade do vínculo contratual.

Esse conjunto probatório não deixa margem de dúvida quanto à probabilidade do direito. A demanda não está fundada em tese jurídica inovadora ou em interpretação controvertida: está fundada em jurisprudência consolidada do TJPE, aplicada por unanimidade em casos com os mesmos elementos fáticos, inclusive com a mesma ré, conforme se verá a diante.

V.2. Do perigo de dano de difícil reparação (*periculum in mora*)

O *periculum in mora*, no caso dos autos, não é presumido nem hipotético: é concreto, documentado e iminente. A data do procedimento cirúrgico é **13 de junho de 2026**. A presente ação é ajuizada em 29 de maio de 2026. O intervalo entre o ajuizamento e a data da cirurgia é de quinze dias.

Nesse curtíssimo prazo, a Requerida precisará ser intimada, a tutela apreciada e cumprida. A ausência de decisão liminar célere produz, inevitavelmente, um dos dois cenários abaixo:

Cenário A: Cirurgia cancelada e perpetuação do sofrimento físico	**Cenário B: Família arca com o remanescente**
A Requerente aguarda a decisão judicial, a cirurgia não se realiza na data agendada, e o quadro de dorsalgia crônica, hipercifose e limitação funcional se prolonga indefinidamente. O risco de cronificação dolorosa e agravamento postural, expressamente mencionado no laudo do Dr.	A família da Requerente reúne os R$ 9.900,00 remanescentes por conta própria, agravando o dano patrimonial já existente de R$ 10.100,00, totalizando R$ 20.000,00 de prejuízo causado pela negativa indevida da operadora. Uma jovem sem renda e uma família hipossuficiente sacrificam recursos

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

Felipe Augusto Fernandes Martins, se concretiza. O dano físico, uma vez instalado de forma crônica, é de reparação genuinamente difícil.	extraordinários para custear, às suas expensas, obrigação que deveria ter sido cumprida pela Requerida.

Em qualquer dos dois cenários, o dano estará consumado antes da sentença, e sua reparação posterior, embora possível no plano teórico, será insuficiente para desfazer o sofrimento físico prolongado (cenário A) ou o sacrifício financeiro imposto a uma família de forma desarrazoada (cenário B). Essa é a definição precisa de dano de difícil reparação para fins do art. 300 do CPC.

Acrescente-se que a irreversibilidade apontada pela Requerida em eventual resistência à tutela, caso argua que o custeio do procedimento antes da sentença constituiria situação irreversível, não se sustenta. A jurisprudência do TJPE é pacífica no sentido de que o custeio de procedimento médico urgente não configura medida irreversível vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC, pois o eventual insucesso da demanda comporta ressarcimento patrimonial pela parte beneficiada.

O risco de irreversibilidade real está no lado oposto: no agravamento do quadro clínico da Requerente que decorreria do não atendimento.

Neste sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA POR GIGANTOMASTIA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA E NÃO MERAMENTE ESTÉTICA. ROL DA ANS QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTAMENTE TAXATIVO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civilz

***2. Demonstrada por meio de documentação médica a existência de quadro clínico de gigantomastia associada a patologias ortopédicas, com recomendação expressa de cirurgia redutora, revela-se legítima a determinação judicial de custeio do procedimento pelo plano de saúde**.*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não constitui lista absolutamente exaustiva, admitindo-se exceções quando comprovada a eficácia do tratamento e inexistente alternativa terapêutica eficaz, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A negativa de cobertura de procedimento indispensável à preservação da saúde do beneficiário configura conduta abusiva.

5. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a decisão agravada.

(TJPE, AI nº 0016006-29.2025.8.17.9000, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 17/04/2026)

Requer-se, portanto, a concessão da tutela de urgência *inaudita altera parte*, determinando que a Requerida autorize e custeie integralmente o procedimento de mamoplastia redutora agendado para 13/06/2026 (honorários médicos, taxa hospitalar, anestesia e materiais), no prazo de **48 (quarenta e oito) horas** a contar da intimação, sob pena de multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

VI. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Requerente:

a) A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte (art. 300 do CPC), determinando que a Requerida autorize e custeie integralmente o procedimento de mamoplastia redutora agendado para 13/06/2026 (honorários médicos, taxa hospitalar, anestesia e materiais), no prazo máximo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de astreintes de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento;

b) Caso o procedimento cirúrgico seja realizado antes do deferimento e cumprimento da tutela de urgência, a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, condenando a Requerida ao reembolso integral de todos os valores desembolsados (estimados em R$ 20.000,00), devidamente corrigidos, a serem apurados em fase de liquidação de sentença;

c) A condenação da Requerida ao ressarcimento imediato das despesas já suportadas, no valor de R$ 10.100,00 já documentados, acrescido do valor remanescente a apurar, corrigidos pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) A condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Taxa SELIC a partir da data da sentença (STJ, REsp n. 2.170.806/RJ);

e) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), com majoração em caso de recurso desprovido (Tema 1.059 do STJ);

f) A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;

g) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, conforme declaração acostada.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

VII. DO VALOR DA CAUSA

Inicialmente, atribui-se à causa o valor de **R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais)**, correspondente à soma: procedimento cirúrgico (R$ 9.900,00 – valor remanescente), indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e despesas já documentadas e adiantadas pela autora a ressarcir (R$ 10.100,00), devendo ser consideradas ainda as despesas que eventualmente a autora tenha que arcar em virtude da negativa da ré, na forma do art. 292, II, VI, e § 3º, do CPC/15[3].

VIII. DAS PROVAS

Requer-se a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial:

(i) **prova documental**, consistente nos documentos acostados a esta inicial;

(ii) **prova testemunhal**, caso seja cabível e necessário, a ser especificada em momento oportuno; e

(iii) **prova pericial médica**, caso Vossa Excelência entenda necessária, ressaltando desde já que o laudo do Dr. Felipe Augusto

[3] Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
(...)
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
(...)
§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

Fernandes Martins constitui prova técnica suficiente, nos termos da jurisprudência do TJPE (AI nº 0007731-91.2025.8.17.9000), sendo desnecessária a dilação probatória para o julgamento da tutela de urgência.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 29 de maio de 2026.

Melquisedeque S. De Lima

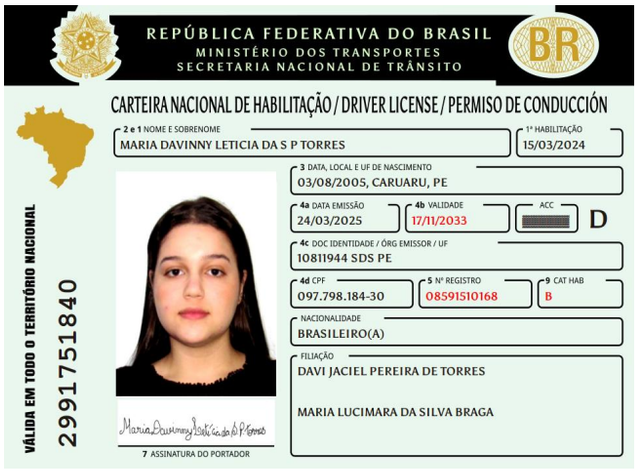
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03

DOCUMENTOS ANEXOS

1. CNH (documento de identificação);
2. Comprovante de residência;
3. Procuração;
4. Declaração de hipossuficiência econômica;
5. Comprovante SIFES (FIES);
6. Contrato do Plano ÚNICO, Proposta de Admissão nº 432912 (Unimed Caruaru);
7. Laudo médico, Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins (NeuroCor, Caruaru/PE, 07/04/2026) e guia de solicitação de internação (07/04/2026);
8. Comprovante de Negativa Contratual/Assistencial, Guia nº 144786009 (09/04/2026);
9. Resposta à NIP nº 158861/2026 (Unimed Caruaru);
10. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 377 (honorários, R$ 9.000,00);
11. Comprovante de pagamento dos materiais cirúrgicos (R$ 1.100,00);
12. Comprovantes de pagamento das mensalidades, fevereiro, março e abril de 2026;
13. Agendamento/encaminhamento da cirurgia marcada para 13/06/2026.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170323600000235353796
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170323600000235353796
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2991751840

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARIA DAVINNY LETICIA DA S P TORRES

1ª HABILITAÇÃO
15/03/2024

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
03/08/2005, CARUARU, PE

4a DATA EMISSÃO
24/03/2025

4b VALIDADE
17/11/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
10811944 SDS PE

4d CPF
097.798.184-30

5 Nº REGISTRO
08591510168

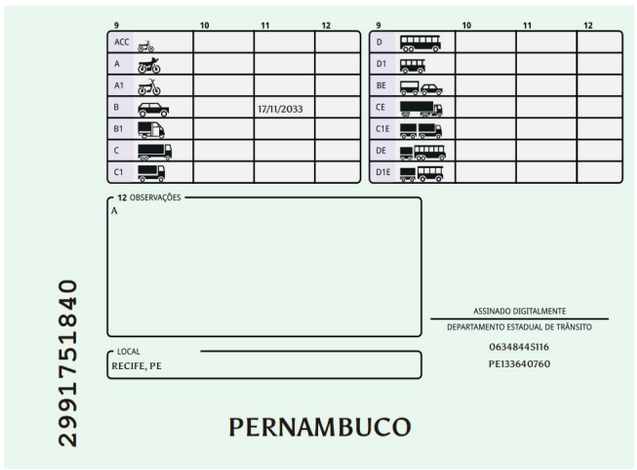
9 CAT HAB
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
DAVI JACIEL PEREIRA DE TORRES

MARIA LUCIMARA DA SILVA BRAGA

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		17/11/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
06348445116
PE133640760

LOCAL
RECIFE, PE

PERNAMBUCO

2991751840

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA085915101<684<<<<<<<<<<<<
0508034F3311178BRA<<<<<<<<<<<6
MARIA<<D<LETICIA<DA<S<P<TORRES

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

brisanet

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código do Cliente: **3456660**
Cliente: **Maria Davinny Leticia Da Silva Pereira Torres**
Endereço: **Avenida Aracaju, 784altos, Universitário**
Cidade: **Caruaru - PE**

Forma de Pagamento: **Pix Bradesco**
Data de Vencimento: **30/05/2026**
Data de Pagamento: **08/05/2026 12:11:36**
Valor: **R$ 84,99**

Descrição: **Fatura referente a competência de 2026-04-30 até 2026-05-30**

Lançamentos

DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR
OFERTA PROMO 500MB COM APPS	Débito	R$ 84,99
Livro I (Skeelo)	Débito	R$ 0,00
REFORCA LIGHT	Débito	R$ 0,00

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, brasileira, solteira, estudante, devidamente inscrita no CPF sob o nº 097.798.184-30 e RG 10.811.944SDS/PE, residente e domiciliada à Endereço: Av. Aracaju 784, primeiro andar, bairro Universitário – CEP 55016-640.

OUTORGADO: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA, brasileiro, solteiro, advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB/SP sob nº 427.574, OAB/PE sob nº 56.324 e na OAB/PB sob nº 34.626-A, CPF 094.168.334-60, residente e domiciliado à Av. Ulisses Montarroyos, 6337, apto. 802, B – Candeias – Jaboatão dos Guararapes/PE – CEP 51020-041.

PODERES: Pelo presente instrumento particular de procuração a **OUTORGANTE** constitui como seu bastante procurador o **OUTORGADO**, a quem confere amplos poderes para o foro em geral à defesa de seus direitos e interesses, com as cláusula ad judicia e et extra, em qualquer Esfera, Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, assim como demais procedimentos e atos administrativos que se fizerem necessários para a persecução de seus direitos, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, substabelecer poderes, agindo em conjunto ou separadamente, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Caruaru/PE, 25 de maio de 2026

_____

MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170399700000235353799
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170399700000235353799
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA

Eu, **MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES**, brasileira, solteira, estudante de Medicina, nascida em 03/08/2005, portadora do CPF nº 097.798.184-30, residente e domiciliada na Avenida Aracaju, nº 784, altos, Bairro Universitário, Caruaru/PE, na forma do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, DECLARO, sob as penas da lei, que:

1. Não possuo emprego formal, renda autônoma ou qualquer fonte de renda própria, dependendo financeiramente de meus familiares para custear meu sustento e meus estudos.

2. Meu curso de graduação em Medicina é financiado 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES – nº contrato: 15.0051.187.0001083-30), não representando renda ou patrimônio disponível.

3. Não sou proprietária de imóveis, veículos ou quaisquer outros bens de valor expressivo, não possuindo patrimônio que me permita arcar com as custas processuais, honorários periciais e demais despesas do processo sem prejuízo do meu próprio sustento.

4. Em razão da negativa indevida de cobertura pela Unimed Caruaru, minha família foi compelida a reunir recursos financeiros extraordinários para custear o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, despesa que não lhe seria exigível não fosse a conduta ilícita da operadora de plano de saúde.

5. Declaro, por fim, que as informações prestadas nesta declaração são verdadeiras e que tenho plena ciência de que a prestação de informações falsas configura crime de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os fins legais e processuais que se fizerem necessários, especialmente para instrução do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170421100000235353800
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170421100000235353800
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

Caruaru/PE, 29 de maio de 2026.

_____

Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres

CPF: 097.798.184-30

Declarante

Nota: Esta declaração é prestada nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo requerente goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca em sentido contrário. O TJPE confirma esse entendimento (AI nº 0010373-08.2023.8.17.9000, j. 21/05/2026).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170421100000235353800
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170421100000235353800
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

Contrato

Dados do Contrato

Código FIES:
020.475.979

Número do contrato:
15.0051.187.0001083-30

CPF:
097.798.184-30

Nome:
MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

Data Nascimento:
03/08/2005

Estudante Prouni:
Não

Forma de Cobrança:
-

Data da Última Parcela Paga:
08/05/2026

Valor da Última Parcela Paga:
R$55,38

Conta Corrente de Débito:
3880.1288.728079305-4

Autoriza débito sobre limite:
Sim

Autoriza débito de parcela vencida:
Sim

Situação da contratação:
CONTRATO ENVIADO AO SIAPI

Situação do contrato:
NORMAL

Pesquisa SIPES:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170440200000235353801
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170440200000235353801
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

Estudante

097.798.184-30: Sem pesquisa

Instituição de Ensino:

CENTRO UNIVERSITÁRIO TABOSA DE ALMEIDA

Telefone I.E.S.:

(81) 2103-2000

Cidade I.E.S.:

CARUARU

Curso:

MEDICINA

Valor Mensalidade:

R$9.996,43

Mensalidade com desconto:

R$9.996,43

Valor do Contrato:

R$59.978,55

Saldo Devedor:

R$187.452,37

Taxa de Juro:

0.00%

Seguro de Vida:

ALLSEG SEGURADORA S/A

Valor do Seguro:

R$12,80

Data Assinatura:

17/03/2025

Estudante

Boleto(s) em aberto

Amortização de Contrato

Sair

CAIXA/CEDESBR | Versão 6.96.2.0 | #EXTERNO.CONFIDENCIAL | Usuário: MARIA | CPF: 09779818430 | Data: 29/05/2026 | Hora: 17:29:42 |

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170440200000235353801
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170440200000235353801
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

CAIXA 104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento

Vencimento: 26/10/05

Cedente: UNIMED CARUARU COOP. DE TRABALHO ME

Agência / Código cedente: 0051.870.00000079.5

Data documento | Número do documento | Esp. docum. | Aceite | Data processamento: 07/06/05

Nosso número: 8172028888.2

Uso do banco | Carteira: SR | Espécie | Quantidade | x | Valor

(=) Valor do documento: 47,45

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos: 15,00

(=) Valor cobrado: 62,45

Sacado: MARIA DAVINNY DA SILVA P. TORRES
PROPOSTA Nº 43262

Sacador / Avalista

Código de barra
Autenticação mecânica

020-436-A

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170458800000235353805
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170458800000235353805
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

Cooperativa de Trabalho Médico
Rua Deputado Souto Filho, 178 - Maurício de Nassau
CEP: 55012.310 - Caruaru - PE - Fone/Fax: (81) 3721.5068
E-mail: unimed@unimedcaruaru.com.br

MED CROSS SEGUROS
Rua Frei Caneca, 178 Sl. 02
Centro CEP: 55 012-330
Caruaru-PE Fone 3721-1999

Normal

Nº 036113

GUIA DE ENCAMINHAMENTO PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA

VALDIR & SERGIO
REPRESENTAÇÕES
3722-3769

VENDEDOR: Walquíria Barros Rep. Nº Proposta 132912

NOME: MARIA DÁVINNY LETICIA DA S. P. TORRES D.N 03 / 08 / 05

RESP. MARIA LUCIMARA DA SILVA Plano:

R.G. 2573523-9 Fone: 9933-7170 Data 26 / 10 / 05

SOMENTE PODERÁ SER ATENDIDO:

MENOR QUE ESTIVER PORTANDO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU RG) E RG DO RESPONSÁVEL.

ADULTO COM RG, DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO, RESERVISTA OU CTPS.

TODOS DEVEM TRAZER OS EXAMES REALIZADOS RECENTEMENTE.

RESULTADO:

☒ NORMAL: ☐ CPT DATA 26 / 10 / 05

Dr. José Almeida
Clínico - Médico
CRM-PE 10795

Assinatura do Médico

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170458800000235353805
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170458800000235353805
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:04

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade
Emissão
CORREIOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
Cadastro de Pessoas Físicas
Número de Inscrição
153.678.108-88
Nome
MARIA LUCIMARA DA SILVA
Nascimento
21/02/1975

MED CROSS SEGUROS
Rua Frei Caneca, 178 Sl. 02
Centro CEP 55.012-320
Caruaru-PE Fone 3721-1999

unimed CARUARU

Proposta de Admissão

Plano de Assistência Médica Hospitalar - Ambulatorial
Hospitalar - Obstétrico - Enfermaria ou Apartamento

5019 48176900-0

Rua Desembargador Souto Filho, 178 - Maurício de Nassau
Caruaru - Pernambuco - CEP 55013-310
Fone: (81) 3721-9999

Registro provisório do Ministério da Saúde Nº 42453393-4 | Vinculado ao Contrato Nº | Plano UNICA | Proposta de Adesão Nº Nº 432912

Rubrica para preenchimento exclusivo da operadora | Pagamento 01 Boleto 02 Consignação 09 Espécie 10 a 29 Fins | Estado Civil 1 Solteiro 2 Casado 3 Viúvo 4 Outros | Sexo M Masculino F Feminino | 30 a 39 Fins 32 Pix 31 Misto 40 Outros

01 - Usuário Titular

Nome	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Peso	Altura
MARIA DÁVINNY LETICIA DA SILVA	03 08 05	F	S	47,95	1,49
MARIA LUCIMARA DA SILVA (PEREIRA TORRES)					

02 - Dados do Titular

Profissão	RG	CPF
PROFESSORA	2573532 3 - 9	153678108 88

Endereço	Nº
AV 31 DE MARÇO	519

Bairro	CEP	Cidade	Fone	Fone
CENTRO	55300000	AGUA PRETA - PE		

Código Nacional Residencial | Celular 081 99337170 | Pager | Cel. | Fax | E-mail | Valor da Renda

03 - Usuários Dependentes / Agregados

Cód.	Nome do Dependente	Data de Nascimento	Sexo	Est. Civil	Peso	Altura	GP	Valor do Plano R$

Pm.: 185
Vdmc: 30

04 - Condições Gerais

~~SEGMENTO DO PLANO TOP~~
A - Ambul. + Hosp. com Parto + Enf.
~~B - Ambul. + Hosp. com Parto + Apto.~~
~~C - Ambul. + Hosp. sem Parto + Enf.~~
~~D - Ambul. + Hosp. sem Parto + Apto.~~
E - Ambulatorial
F - Hospitalar com Parto + Enf.
G - Hospitalar com Parto + Apto.
H - Hospitalar sem Parto + Enf.
I - Hospitalar sem Parto + Apto.

Acomodação Contratada? SIM ☐ NÃO ☒

O agravo para Doenças e Lesões Pré existentes cobertura de ____ % sobre a tabela em vigor durante os primeiros 24 meses

DATA DE ADESÃO	DATA VENCIMENTO
De 01 a 05	Dia 10 subsequente
De 06 a 10	Dia 15 subsequente
De 11 a 15	Dia 20 subsequente
De 16 a 20	Dia 25 subsequente
De 21 a 31	Dia 30 subsequente

OPÇÕES PARA CO-PARTICIPAÇÃO

Procedimento	10%	15%	30%	35%
1 - Consultas	☐	☐	☒	☐
2 - Exames	☐	☐	☒	☐
3 - Materiais e Medicamentos	☐	☐	☒	☐
4 - Internações R$			0,00	

05 - Carência

Em se tratando de migração de outra operadora, informar os dados abaixo e anexar contrato, carteira e 3 últimos pagamentos.
(Aproveitamento / Redução de carências sujeito a aprovação e a critério da Unimed Caruaru.

Empresa | Plano | Início | Fim | Para uso da Unimed Caruaru: Tempo de Plano ____ Meses ☐ Solicitação de redução

06 - segmentação Contratual

☒ Individual
☐ Familiar

Coletivo Empresarial
☐ Com menos de 50 usuários
☐ Com 50 ou mais usuários

Coletivo por Adesão
☐ Com menos de 50 usuários
☐ Com 50 ou mais usuários

07 - Área Geográfica de Abrangência do Plano

☐ Referência ☐ Estadual ☐ Regional A - Grupo de Estados da Região N/NE
☐ Nacional ☐ Esmeralda ☒ Regional B - Grupo de Municípios - Área de Ação das Unimed's Caruaru, Agreste Meridional e Pernambuco Central

08 - Tipo de Acomodação

ENFE A MARIA

09 - Observações Diversas

Beneficiário para fins de Seguro | Parentesco

Declaro que entre as segmentações de planos oferecidos, indico minha opção e de meus dependentes/agregados conforme especificado nas condições gerais do presente contrato as quais me foram apresentadas e delas conhecimento.

26 10 05
Data de Adesão

Ambl + Hosp. sem parto + enf.
Plano Adquirido

Maria Lucimara da Silva
Assinatura do Titular ou Responsável

Este Contrato terá início de vigência na data da aceitação desta proposta pela contratada e duração mínima de 12 meses.

10 - Recibo

O Vendedor abaixo assinado, declara que por autorização da Unimed Caruaru recebeu do titular desta proposta a importância abaixo, referente ao pagamento da 1ª mensalidade e da taxa de inscrição do plano ora proposto, ficando estabelecido que se a proposta não for aceita, os valores serão integralmente restituídos na forma da lei. As demais mensalidades deverão ser pagas somente nos bancos.

Valor da mensalidade	R$ 47,95
Taxa de inscrição	R$ 15,00
Valor do Atendimento Domiciliar	R$
Total Pago	R$ 62,95

Nome do Vendedor: Walquíria Barros | Código: 39 | Assinatura do Vendedor

Valor Total por Extenso: Sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos

11 - Corretor/Área Autorizada

VALDIR & SERGIO
REPRESENTAÇÕES

12 - Aprovação Unimed Caruaru

Data ____/____/____ Sup. Vendas | Data ____/____/____ Setor de Cadastro | Data 27/10/05

Esta proposta deverá ser preenchida e acompanhada da Declaração de Saúde | 1ª VIA CADASTRO | 2ª VIA FINANCEIRO | 3ª VIA USUÁRIO

AO CONTRATANTE:

OBS1: **NÃO EFETUAR PAGAMENTOS AOS VENDEDORES ANTES DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO CLÍNICA;**

OBS 2: EFETUAR OS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES DIRETAMENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, **NUNCA A TERCEIROS**. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO NÃO CUMPRIMENTO;

OBS 3: **ANTES DE ASSINAR ESTÁ PROPOSTA,** FAVOR VERIFICAR TODOS OS CAMPOS REFERENTES AO PRODUTO ESCOLHIDO, COM OS SEUS DEVIDOS CÓDIGOS E VALORES;

OBS 4: SE VOCÊ NÃO RECEBER A FATURA DE PAGAMENTO ATÉ CINCO DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO, SOLICITE À UNIMED CARUARU OU PELO SITE DA COOPERATIVA. EVITE MULTAS. **WWW.UNIMEDCARUARU.COM.BR;**

OBS 5: EVENTUAIS DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM DEPARTAMENTO COMERCIAL DA UNIMED CARUARU PELO FONE 81-3721.5068, RAMAIS **224/225/204;**

OBS 6: **O ATRASO NO PAGAMENTO** DA CONTRAPRESTAÇÃO **POR PERÍODO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS**, CONSECUTIVOS OU NÃO, REFERENTE AO ANO CONTRATUAL **CANCELARÁ SEU PLANO.**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 25.735.323-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/JAN/90

NOME MARIA LUCIMARA DA SILVA

FILIAÇÃO ALONCO BERTO DA SILVA

E JOSEFA MARIA DA SILVA

NATURALIDADE CACHOEIRINHA -PE DATA DE NASCIMENTO 21/FEV/1975

DOC ORIGEM CACHOEIRINHA.PE.
CACHOEIRINHA.
CN:LV.028A/FLS.0206/N.015570

Maria Lucimara da Silva

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

9102-5

Maria Lucimara da Silva

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO D[illegible] ISTRO CIVIL DAS [illegible] FÍSICA - Maria [illegible] Silva - [illegible] Cachoeirinha - PE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO D E PERNAMBUCO

MUNICÍPIO D E CACHOEIRINHA DISTRITO D E SEDE

NASCIMENTO Nº 14.738

Eu MARIA CLARA DA SILVA Oficial do Registro Civil.

Certifico que às folhas 115 do livro, Nº "A" – 13 do registro de nascimento foi feito hoje, o assento de MARIA DÁVINNY LETÍCIA DA SILVA PEREIRA TORRES.

nascid a aos três (03) de agosto (08) de dois mil e cinco (03/08/2005) às 01 horas 20 minutos em Caruaru – Estado de Pernambuco

do sexo, feminino

filh a de Davi Jaciel Pereira de Torres

natural Cachoeirinha – PE

e de Dona Maria Lucimara da Silva

natural Cachoeirinha – PE

São avós paternos Dionísio José de Torres

e Dona Maria Pereira da Silva

e avós maternos Alonço Berto da Silva

e Dona Josefa Maria da Silva

foi declarante O genitor Testemunhas diepensadas, de acordo

e serviram de testemunhas com o art. 197, titulo II do Lº IV de Regimento da Corregedoria

Observações Lavrado na forma da Lei em Vigor

O referido é verdade e dou fé.

Registro de acordo com Lei Nº 9.534/97 de 10 de Dezembro de 1997.

Cachoeirinha 12 de Agosto de 2005

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO SELO Autenticidade e Fiscalização CERTIDÃO ABP 49823

Válido Somente com o Selo de Autenticidade e Fiscalização

ATO GRATUITO

compesa

Companhia Pernambucana de Saneamento

MERCADINHO E PRAÇA SÃO JOÃO

PAGO

MATRÍCULA	ESCRITÓRIO	VENCIMENTO
0467642.4	CACHOEIRINHA	16/10/2005

NOME: MARIA LUCIMARA DA SILVA

INSCRIÇÃO: 031.020.204.0003.100.4

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AV 31 DE MARCO,N. 519

FATURA: 09/2005-8

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA:

ÁGUA: LIGADO

ESGOTO: POTENCIAL

REFERÊNCIA	ECONOMIAS	CONSUMO FATURADO
08/2005 -	0	97
07/2005 -	10	97
06/2005 -	0	97
05/2005 -	0	97
04/2005 -	0	97
03/2005 -	0	97

1 10 0EOFL43100010

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	DIAS	MÉDIA/DIA (M³)
000000	000010	10	31	0,32
24.08.2005	24.09.2005			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA - TARIFA SOCIAL		
RESIDENCIAL 01 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R$ 7,25 (POR UNIDADE)	MINIMO	7,25
MULTA REFERENTE A(S) FATURA(S) 07/2005		0,14

AVISO ANEXO

QUALIDADE DA ÁGUA - Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS

TOTAL R$ 7,39

As informações da Qualidade da Água encontram-se disponíveis no seguinte local:

GERENCIA REGIONAL DE BELO JARDIM - R. SAO BENEDITO DO SUL, S/N - BARRAGEM NOVA - CEP 55.150-000

CORPO DE BOMBEIROS - 30 DE OUTUBRO:
118 ANOS SALVANDO VIDAS; MUITAS AINDA A SALVAR.

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 007.031

IMPRESSO LASER - COMPESA - FORM 004/CTC

unimed CARUARU

Rua Deputado Souto Filho, 178 - Maurício de Nassau
Caruaru - Pernambuco - CEP 55012-210
Fone: (81) 3721-3002

Declaração de Saúde

Normal

4245339-4 ÚNICO

ANS nº	Registro provisório do Ministério da Saúde nº	Vinculado ao Contrato nº	Plano	Proposta de Adesão nº
3140195				

Estou ciente da minha obrigação de informar nesta oportunidade, se eu, ou algum dos meus dependentes indicados, portador da doença ou lesões, se existentes, sob a pena de imputação nos termos do Art. 299, do Código Penal, assim como nos termos do Art. 186, do Código Civil.

Estou ciente também que havendo dolo ou culpa de minha parte ao promover as declarações abaixo, além das penalidades acima expressas ainda **fica rescindido, de pleno direito, o contrato de plano de saúde firmado,** implicando na minha responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas efetuadas com a assistência médica hospitalar.

Declaro ainda que a **Unimed Caruaru** colocou a minha disposição, sem ônus algum, profissionais médicos para orientação quanto ao preenchimento desta declaração. Porém ainda faculta-lhe, caso eu não queira utilizar os profissionais médicos colocados a minha disposição, escolher, com ônus financeiro meu, o profissional médico que desejar.

MÉDICO ORIENTADOR

Dispenso a presença do médico orientador.

( ) SIM ( ) NÃO (X) Indicado pela unimed Caruaru ( ) De minha escolha

Dr. Jeri Almeida — Nome

10793 — Nº do CRM

DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Item	Responda as questões abaixo, assinalando (S) para as respostas afirmativas e (N) para as negativas	Especifique	Titular	Dependentes 01	02	03	04	05
01	Sofre(u) de alguma doença infecto-contagiosa (AIDS, hepatite, chagas, tuberculose, meningite, outros)?		N					
02	Sofre(u) de doença respiratória (enfisema, asma, bronquite, pneumonia, outros)?		N					
03	Sofre(u) de problemas ortopédicos (escoliose, cifose, artrose, fraturas, hérnia de disco) ou outro distúrbio ósseo ou de membros?		N					
04	Sofre(u) de doença neurológica (derrame cerebral ou outros)?		N					
05	Sofre(u) de diabetes?		N					
06	Sofre(u) de Câncer (tumoração ou leucemia)?		N					
07	Sofre(u) de Hérnia de qualquer natureza?		N					
08	Sofre(u) de doença cardíaca, vascular ou hipertensão arterial?		N					
09	Sofre(u) de alguma doença do aparelho urinário (rins, bexiga, próstata, uretra)?		N					
10	Sofre(u) de algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico?		N					
11	Sofre(u) de doenças ginecológicas (cisto de ovário, endometriose, mioma, incontinência urinária, tumor de mama)?		N					
12	Sofre(u) de doença reumatológica (reumatismo, artrite, outras)?		N					
13	Sofre(u) de seqüela de acidente, moléstia adquirida ou congênita?		N					
14	Sofre(u) de úlcera ou outras doenças do aparelho digestivo?		N					
15	Tem indicação de submeter-se a alguma intervenção cirúrgica?		N					
16	Tem qualquer deficiência visual (catarata, glaucoma, outros) ou auditiva?		N					
17	Sofre(u) tratamento de quimioterapia ou radioterapia?		N					
18	É (foi) obeso?		N					
19	É (foi) fumante?		N					
20	Sofre(u) de alguma doença não relacionada acima que tenha obrigado a internar-se ou submeter-se a algum tipo de exame ou tratamento?		N					

Este documento foi gerado pelo usuário 004.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57

Unimed
CARUARU

É informada, neste momento, que com a ocorrência de resposta afirmativa fica facultada a minha opção pela Cobertura Parcial e Temporária ou pelo Agravo, nos termos, respectivamente, das alíneas "a" e "b", do Inc. I, da Resolução ANS/RN n. 20/2002.

No caso de opção pela Cobertura Parcial Temporária, a carência para doenças e lesões pré-existentes serão de 24 (vinte e quatro) meses, para procedimentos de alta complexidade, cirúrgicos ou leitos de alta tecnologia relacionada à doença ou lesão declarada.

No caso de opção pelo Agravo será promovido um acréscimo no valor das contraprestações pecuniárias mensais do plano de assistência à saúde, para dar direito à cobertura completa da doença ou lesão pré-existente declarada, após os prazos de carências contratuais.

Opto pela:

( ) Cobertura Parcial Temporária ( ) Agravo

Caruaru/PE, 26/10/2005

Maria Lucimara da Silva

Declarante (Titular ou responsável, caso o titular seja menor de 18 anos)

Dr. [illegible]

Médico(a) Orientador(a)

Cobertura Parcial Temporária - Aditivo ao Contrato de Plano de Saúde

Este aditivo é parte integrante do contrato que ora se assina, válido para todos os usuários indicados na proposta de adesão que optarem pela Cobertura Parcial Temporária, na Declaração de Saúde.

Com base nas respostas afirmativas da Declaração de Saúde, caracterizando, assim, doença ou lesão pré-existente, ficam estabelecidas as coberturas parciais temporárias, conforme indicadas abaixo, exceto aos atendimentos de urgência e emergência e aos procedimentos previstos nos itens "b", "d" e "e", do artigo 55, do contrato de assistência médica hospitalar que permanecem inalterados:

Item	O item "c", do artigo 55 para procedimentos abaixo, em decorrência de resposta afirmativa na Declaração de Saúde, fica com suas carências alteradas conforme segue:	DE	PARA
01	Sofre(u) de alguma doença infecto-contagiosa (AIDS, hepatite, chagas, tuberculose, meningite, outras).	180 dias	720 dias
02	Sofre(u) de doença respiratória (enfisema, asma, bronquite, pneumonia, outros).	180 dias	720 dias
03	Sofre(u) de problemas ortopédicos (escoliose, obesidade, artrose, fraturas, hérnia de disco) ou outro distúrbio ósseo ou de membros.	180 dias	720 dias
04	Sofre(u) de doença neurológica (derrame cerebral ou outros).	180 dias	720 dias
05	Sofre(u) de diabetes.	180 dias	720 dias
06	Sofre(u) de Câncer (tumoração ou leucemia).	180 dias	720 dias
07	Sofre(u) de Hérnia de qualquer natureza.	180 dias	720 dias
08	Sofre(u) de doença cardíaca, vascular ou hipertensão arterial.	180 dias	720 dias
09	Sofre(u) de alguma doença do aparelho urinário (rins, bexiga, próstata, uretra).	180 dias	720 dias
10	Sofre(u) de algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico.	180 dias	720 dias
11	Sofre(u) de doenças ginecológicas (cisto de ovário, endometriose, mioma, incontinência urinária, tumor de mama).	180 dias	720 dias
12	Sofre(u) de doença reumatológica (reumatismo, artrite, outras).	180 dias	720 dias
13	Sofre(u) de sequela de acidente, moléstia adquirida ou congênita.	180 dias	720 dias
14	Sofre(u) de úlcera ou outras doenças do aparelho digestivo.	180 dias	720 dias
15	É (foi) obeso.	180 dias	720 dias
16	Sofre(u) de doença(s) especificada(s) no item 16 da Declaração de Saúde.	180 dias	720 dias
17	Sofre(u) de doença(s) especificada(s) no item 20 da Declaração de Saúde.	180 dias	720 dias

26/10/05
Data da Declaração

Maria Lucimara da Silva
Assinatura do Titular
(ou responsável caso o titular seja menor de 18 anos)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.*** ***-60 em 15/10/2026 21:21:57

PLANO

UNICO

UNIMED - CARUARU

unimed

CARUARU-PE

Scanned with CamScanner

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA E HOSPITALARES

TIPO DE CONTRATO:
( ) INDIVIDUAL ( ) FAMILIAR

( ) COM OBSTETRÍCIA ( ) SEM OBSTETRÍCIA

CIÊNCIA DA FRANQUIA DE 20% PARA CONSULTAS E EXAMES: ( ) SIM

CIÊNCIA DA FRANQUIA DE 100,00 (CEM REAIS) QUANDO DA INTERNAÇÃO ( )SIM

CIÊNCIA DE QUE O ATENDIMENTO ESTÁ RESTRITO AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DAS UNIMED'S, SALVO EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CONTRATO Nº

Certificado de Registro na ANS Nº 34095-2

Contratante: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

CEP.: _____ Fone: _____ Estado Civil: _____

Data de Nasc.: ___/___/_____ RG.: _____

C.P.F.: _____

Scanned with CamScanner

TÍTULO I DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

Art. 1°. O presente contrato tem por objeto a cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar, de diagnóstico e terapia, conforme rol de procedimentos para os planos ambulatorial e hospitalar com ou sem obstetrícia, anexo à Resolução n.° 10, publicada em 4 de novembro de 1998, aos usuários regularmente inscritos, na forma e condições deste instrumento, na área de abrangência das Unimed's Caruaru, Agreste Meridional (Garanhuns) e Pernambuco Central (Arcoverde), conforme relação abaixo:

ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED CARUARU: Agrestina, Altinho, Brejo da M. de Deus, Belo Jardim, Belém de Maria, Barra de Guabiraba, Bonito, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Catende, Caruaru, Cupira, Cumaru, Gravatá, Ibirajuba, Jurema, Lajedo, Panelas, Lagoa dos Gatos, Riacho das Almas, Sairé, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, Surubim, São Bento do Uma, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes, Quipapá.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED AGRESTE MERIDIONAL (GARANHUNS): Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Lagoa do Ouro, Palmerina, Saloá, São João, Terezinha e Jucati.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL (ARCOVERDE): Arcoverde, Alagoinha, Afogados da Ingazeira, Brejo da Madre de Deus, Buique, Brejinho, Betânia, Caetés, Carnaíba, Calumbi, Custódia, Calumbi, Flores, Inajá, Ingazeira, Iguaraci, Ibirimim, Itapetim, Jataúba, Pesqueira, Porção, Pedra, Sanharó, Santa Terezinha, Serra Talhada, Sertânia, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tacaratú, Terezinha, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa.

Art. 2°. A assistência ora pactuada visa à prevenção da doença e à recuperação da saúde, observando-se a legislação vigente nesta data e os termos deste instrumento.

Art. 3°. É parte integrante deste contrato a Proposta de Admissão de n.° .....

Art. 4°. Este contrato terá o início de vigência e a duração mínima previstos na Proposta de Admissão, prorrogando-se automaticamente, por tempo indeterminado.

TÍTULO II DAS DEFINIÇÕES

Art. 5°. Para os efeitos deste contrato, são adotadas as seguintes definições:
I CONTRATANTE: é a **pessoa física** (qualificada na proposta de admissão em anexo) que contrata a prestação de serviços de assistência à saúde para si, seus dependentes ou agregados.

Scanned with CamScanner

II CONTRATADA: é a operadora de planos privados de assistência à saúde descrita na Proposta de Admissão, que se obriga, na qualidade de mandatária de seus cooperados, a garantir a prestação de serviços de assistência à saúde aos usuários do plano ora convencionado, nos termos deste instrumento, através de seus médicos cooperados e de rede própria ou contratada.
III USUÁRIO: é a pessoa física, inscrita e aceita pela Contratada, que usufruirá dos serviços ora pactuados, seja na qualidade de titular, seus respectivos dependentes ou ainda, agregados, conforme definido no Título V.
IV PROPOSTA DE ADMISSÃO: é o documento validado pela Contratada, preenchido pelo Contratante, que expressa a constituição jurídica das partes e firma as condições do contrato.

Art. 6º. Também são assim definidos:
I ACIDENTE PESSOAL: é o evento exclusivo, com data caracterizada, diretamente externo, súbito, imprevisível, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, torne necessário o tratamento médico.
II AGRAVO DA CONTRAPRESTAÇÃO: é qualquer acréscimo no valor da contraprestação pecuniária do plano, decorrente da aceitação de inclusão de tratamento doenças pré-existentes e que elide a possibilidade de se omitir atendimentos no período legalmente permitido de 24 meses.
III ATENDIMENTO AMBULATORIAL: é aquele executado no âmbito do ambulatório, sem necessidade de internação hospitalar, incluindo a realização de curativos, pequenas cirurgias, primeiros socorros e outros procedimentos que não exijam uma estrutura mais complexa para o atendimento.
IV BENEFICIÁRIO: é aquele que é favorecido por uma cobertura denominada de benefício.
V BENEFÍCIO: é uma cobertura não obrigatória, oferecida aos usuários, nas condições expressas do contrato.
VI CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo estatístico com base em análise de informações sobre a freqüência de utilização, peculiaridades do usuário, tipo de procedimento, com vistas a manutenção do equilíbrio financeiro do plano e o cálculo das contraprestações.
VII CARÊNCIA: é o prazo ininterrupto, contado a partir do início de vigência do contrato, durante o qual os usuários não têm direito, total ou parcial, às coberturas contratadas.
VIII CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO: é a cédula onde se determina a identidade do usuário (nome, idade, código de inscrição na cooperativa contratada, etc.) e é, também, o comprovante de sua aceitação no plano de saúde.
IX CERTIFICADO CONTRATUAL: é o documento que, juntamente com o Cartão Individual de Identificação, comprova a contratação do plano de assistência à saúde.
X CID-10: é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 10ª revisão.
XI CO-PARTICIPAÇÃO: é o montante, definido na Proposta de Admissão, em termos percentuais ou valores monetários, para cada procedimento realizado, o

Scanned with CamScanner

possibilita uma investigação diagnóstica, para melhor avaliar as condições clínicas do usuário.

. São considerados EXAMES SIMPLES de diagnóstico e terapia: 1) Ácido Úrico; 2) Colesterol total; 3) Glicose; 4) Triglicerídeos; 5) Eritrograma; 6) Hemograma completo; 7) Leucograma; 8) Beta HCG; 9) Rotina de urina. São considerados EXAMES ESPECIAIS de diagnóstico e terapia:1) análises clínicas; 2) histocitopatologia; 3) eletrocardiograma convencional; 4) eletroencefalograma convencional; 5) exames radiológicos simples sem contraste. 6) angiografia; 7) angioplastia; 8) arteriografia; 9) eletroencefalograma prolongado, potencial evocado, polissonografia e mapeamento cerebral; 10) ecocardiograma uni e bidimensional, inclusive com Doppler colorido; 11) eletrocardiografia dinâmica (Holter); 12) endoscopia diagnóstica e cirúrgica; 13) ultra-sonografia; 14) tomografia computadorizada; 15) ressonância nuclear magnética; 16) medicina nuclear; 17) densitometria óssea; 18) laparoscopia diagnóstica; 19) monitorização ambulatorial de pressão arterial; 20) litotripsia; 21) radiologia com contraste e intervencionista; 22) cineangiocoronariografia e videolaringoestroboscopia computadorizada; 23) videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica; 24) oxigenoterapia hiperbarica; 25) tratamento esclerosante de varizes; 26) exames e testes alergológicos; 27) exames e testes oftalmológicos; 28) exames e testes ortorrinolaringológicos; 29) eletromiografia; 30) eletroneuromiografia; 31) prova de função pulmonar; 32) inaloterapia; 33) teste ergométrico. São também considerados procedimentos especiais a quimioterapia, radioterapia, diálise e hemodiálise.

XXVII GUIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE: é a relação de serviços próprios e contratados pela operadora.

XXVIII HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA: é aquele hospital que utiliza sua própria lista de preços e procedimentos, não se sujeitando a Tabela de Referência de terceiros.

XXIX INSCRIÇÃO: é o ato de incluir um usuário no plano, condicionado ao aceite da Contratada.

XXX INTERNAÇÃO HOSPITALAR: é quando o usuário adentra o hospital, ficando sob os seus cuidados, para ser submetido a algum tipo de tratamento.

XXXI MÉDICO COOPERADO: é o médico que participa com cotas, numa das cooperativas de trabalho médico, existentes no Sistema Nacional UNIMED.

XXXII MENSALIDADE: é o valor pecuniário a ser pago mensalmente à Contratada, em face das coberturas previstas no contrato.

XXXIII ÓRTESE: acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou totalmente nenhum órgão ou membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente.

XXXIV PATOLOGIA: modificações funcionais produzidas pela doença no organismo.

XXXV PLANO: é a opção de coberturas adquirida pelo Contratante.

XXXVI PLANO BÁSICO: Plano de coberturas com internação em quarto coletivo

Scanned with CamScanner

XXXVII PLANO ESPECIAL: Plano de coberturas com internação em quarto privativo com banheiro e direito a acompanhante de acordo com a disponibilidade do hospital.

XXXVIII PRIMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de urgência ou emergência.

XXXIX PRODUTOS: são modalidades de planos oferecidos pela Contratada.

XL PRÓTESE: é a peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcial ou total de um órgão ou membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função.

XLI RECURSOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS ou CREDENCIADOS: são aqueles colocados à disposição do usuário pela Contratada, para atendimento médico-hospitalar, mas que não são realizados pelos médicos cooperados ou pela rede própria das cooperativas, e sim, por terceiros.

XLII ROL DE PROCEDIMENTOS: é a lista editada pelo CONSU através de anexo à Resolução n.º 10/98, publicada em 4 de novembro de 1998, que referencia os procedimentos básicos obrigatórios, individualizados para os planos especificados (ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia, hospitalar com obstetrícia, odontológico e o plano referência).

XLIII SISTEMA NACIONAL UNIMED: é o conjunto de todas as UNIMEDs, cooperativas de trabalho médico, constantes da relação entregue ao Contratante, associadas entre si ou vinculadas contratualmente, para a prestação de serviços aos usuários.

XLIV TABELA DE REFERÊNCIA: é a lista indicativa de procedimentos e seus respectivos valores, aplicada às hipóteses em que seja necessária a aferição de preços dos serviços de assistência à saúde.

XLV UNIMED é uma cooperativa de trabalho médico, regida pela Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, criada e dirigida por médicos.

XLVI URGÊNCIA: é o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional.

Art. 7º. Por convenção, adotou-se neste contrato o gênero masculino quando há referência ao(à) CONTRATANTE, aos(às) usuários(as), aos(às) filhos(as), aos(às) menores, etc.

TÍTULO III DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

Art. 8º. O presente contrato se caracteriza pela contratação individual, por livre adesão de pessoas físicas, com ou sem seu grupo familiar.

Parágrafo único. Em face de o CONTRATANTE ter a faculdade de incluir seus dependentes ou grupo familiar, este plano também é denominado contrato **familiar**.

Art. 9º. No plano de assistência à saúde sob o regime de contratação individual ou familiar, poderá haver cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, além de ser facultada a exigência de cumprimento de prazos de carência.

Scanned with CamScanner

Parágrafo único. Na Proposta de Admissão estão especificadas as condições do plano mencionadas no caput deste artigo.

TÍTULO IV DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Os serviços ora contratados serão prestados pela CONTRATADA, através de seus médicos cooperados e de rede própria básica ou por ela contratada, na área geográfica de abrangência do plano conforme consta opção na Proposta de Admissão, bem como por todas as cooperativas médicas que integram o SISTEMA REGIONAL UNIMED (Caruaru, Arcoverde e Garanhuns), além do SISTEMA NACIONAL UNIMED, quando em caso de urgência e/ou emergência.

Parágrafo único: Somente em caso de urgência e emergência o atendimento será prestado através do SISTEMA NACIONAL UNIMED.

CAPÍTULO II DO INÍCIO DO DIREITO

Art. 11. Os serviços previstos neste contrato serão prestados aos usuários regularmente incluídos através da Proposta de Admissão e aceitos pela CONTRATADA, **após o cumprimento das carências específicas** para os procedimentos, conforme o caso, de acordo com as coberturas contratadas.

Parágrafo único. Contratada a ampliação da cobertura através dos módulos adicionais, os usuários sujeitar-se-ão às carências e limites previstos para cada um deles.

CAPÍTULO III DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

Art. 12. Somente terão direito aos serviços ora contratados os usuários regularmente inscritos.

Art. 13. A CONTRATADA assegurará aos usuários os serviços médico-hospitalares, ambulatoriais, auxiliares de diagnóstico e terapia, previstos neste contrato, **obedecida a cobertura contratada**, conforme especificado abaixo:
a) consultas: os usuários serão atendidos no consultório do médico escolhido, **dentre os cooperados das cooperativas médicas que integram o SISTEMA REGIONAL UNIMED;**
b) atendimentos clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais: serão prestados em consultórios, clínicas, serviços ou hospitais próprios;
c) exames complementares e serviços auxiliares: serão prestados através de rede própria ou contratada, mediante solicitação do médico assistente.

Scanned with CamScanner

Art. 14. Neste ato o CONTRATANTE e SEUS DEPENDENTES SAÚDE, editado pela CONTRATADA, informando a relação de seus prestadores, médicos cooperados, hospitais e clínicas, bem como a relação, com os respectivos endereços, das cooperativas participantes do Sistema Regional e Nacional UNIMED, devendo, entretanto, o usuário, ao utilizar-se dos serviços, confirmar as informações nele contidas em razão do processo dinâmico do quadro de médicos cooperados e da rede contratada e/ou credenciada.

Art. 15. A CONTRATADA não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa da pactuada.

CAPÍTULO IV DO REEMBOLSO

Art. 16. A CONTRATADA assegurará o reembolso no limite das obrigações deste contrato, das despesas efetuadas pelo usuário com assistência à saúde, dentro do território nacional, **nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando não for comprovadamente possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados** pelo Sistema UNIMED REGIONAL.

Art. 17. O reembolso de que trata o artigo anterior será efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência vigente à data do evento, praticada pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente serão devolvidos, na hipótese de reembolso parcial:

a) solicitação de reembolso através de preenchimento de formulário próprio;
b) relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, descrição do tratamento e respectiva justificação dos procedimentos realizados, data do atendimento, e, quando for o caso, período de permanência no hospital e data da alta hospitalar;
c) conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos consumidos, com preço por unidade, juntamente com notas fiscais, faturas ou recibos do hospital;
d) recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, discriminando funções e o evento a que se referem;
e) comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia, e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico assistente.

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo do **caput**, o valor a ser reembolsado será atualizado, a partir da data de entrada do requerimento, pelo IGP-M/FGV, ou por outro índice que vier a substituí-lo, de modo a repor a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 18. **Só serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o atendimento ao usuário, realizado enquanto perdurar o estado de urgência ou emergência.**

Art. 19. **O CONTRATANTE perderá o direito ao reembolso decorridos doze**

Scanned with CamScanner

meses da data do evento.

TÍTULO V DOS USUÁRIOS

CAPÍTULO I DO TITULAR

Art. 20. Para efeito deste contrato, o CONTRATANTE é o usuário titular.

CAPÍTULO II DOS DEPENDENTES

Art. 21. São usuários dependentes, com grau de parentesco ou afinidade e dependência econômica em relação ao usuário titular:
a) o cônjuge;
b) os filhos solteiros com até 18(dezoito anos)
c) o enteado, o menor sob a guarda por força de decisão judicial e o menor tutelado, que ficam equiperados aos filhos;
d) convivente, havendo união estável, na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial;
e) os filhos comprovadamente inválidos.

CAPÍTULO III DOS AGREGADOS

Art. 22. A critério da CONTRATADA, poderão ser admitidas outras pessoas indicadas pelo usuário titular, na qualidade de usuários agregados, para apenas utilizarem a assistência médica e hospitalar, objeto deste Instrumento, excluídos os benefícios do Título XIII.

CAPÍTULO IV DA INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Art. 23. A inclusão do CONTRATANTE e respectivos dependentes e agregados será processada através da Proposta de Admissão que, aceita pela CONTRATADA, integrará este contrato para todos os fins de direito.

Art. 24. Ficará a critério da CONTRATADA a realização de exame prévio de admissão nos usuários, a fim de averiguar lesões e doenças preexistentes, bem como de solicitar, a qualquer tempo, documentação probatória das declarações do CONTRATANTE.

Art. 25. É assegurada a inclusão:
I do recém-nascido, filho natural ou adotivo do usuário titular, isento do cumprimento dos períodos de carência, contanto que, simultaneamente:
a) As carências para atendimento obstétrico já tenham sido cumpridas integralmente;
b) A inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias após o nascimento.

Scanned with CamScanner

II do filho adotivo, menor de doze anos, com aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos pelo usuário titular adotante, **desde que efetivada em até trinta dias após o deferimento da adoção**;

III do cônjuge do usuário titular, com aproveitamento dos períodos de eventual carência já cumpridos por este, **quando contrair matrimônio durante a vigência deste contrato**, e for inscrito no prazo de 30 (trinta) dias a contar do evento.

Parágrafo único. Ultrapassados os prazos previstos neste artigo, ressalvadas as condições específicas das coberturas adicionais posteriormente contratadas, cujo cumprimento de carências se dará integralmente, e ainda, quando à observância do disposto no Capítulo II do Título XIII, **os novos usuários cumprirão os períodos de carências indicados na Proposta de Admissão.**

Art. 26. **O usuário que, por qualquer motivo, deixar de atender às condições exigidas para sua inscrição, será automaticamente excluído do contrato.**

Parágrafo único. O dependente que vier a perder a condição de dependência poderá assinar contrato em seu próprio nome, **em até 30 (trinta) dias a contar da data da perda do direito como usuário dependente**, aproveitando as carências já cumpridas neste contrato.

TÍTULO VI CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 27. A CONTRATADA fornecerá aos usuários o Cartão Individual de identificação referente ao plano a que pertencerem, com prazo de validade, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade legalmente reconhecido e o recibo de pagamento das mensalidades em dia, na forma da lei, assegura a fruição dos direitos e vantagens deste contrato, podendo a CONTRATADA adotar, a qualquer tempo, novo sistema para melhor atendimento dos usuários.

Art. 28. É obrigação do CONTRATANTE, na hipótese de rescisão, resolução ou resilição deste contrato, devolver os respectivos cartões de identificação e quaisquer outros documentos porventura fornecidos pela CONTRATADA, respondendo, sempre, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido desses documentos, restando isenta, neste caso, de qualquer responsabilidade, a CONTRATADA, a partir da rescisão do usuário, resolução ou resilição do presente.

§ 1º. Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para obter atendimento, mesmo que na forma contratada, pelos usuários que perderam essa condição, por exclusão ou término do contrato, ou, em qualquer hipótese, por terceiros, que não sejam usuários, com ou sem o conhecimento destes.

§ 2º. O uso indevido do cartão de identificação, de qualquer usuário, a critério da CONTRATADA, ensejará pedido de indenização por perdas e

Scanned with CamScanner

danos, bem como a exclusão do respectivo titular, e suas conseqüências, ainda que o ato tenha sido praticado sem o seu conhecimento, além de ser o CONTRATANTE responsabilizado penalmente.

Art. 29. Ocorrendo a perda ou extravio de qualquer desses documentos, o CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, o fato à CONTRATADA, para cancelamento ou, quando for o caso, emissão de segunda via. O cancelamento só terá validade quando reconhecido por escrito, pela CONTRATADA.

TÍTULO VII DO PLANO

Art. 30. Os usuários farão jus, satisfeitas as respectivas condições, à cobertura básica prevista neste Título, exclusivamente dentro dos recursos próprios, nos termos da Proposta de Admissão.

Parágrafo único. É facultada a opção pelas coberturas de módulos opcionais, sujeitando-se, no entanto, às respectivas condições específicas de cada um deles.

Art. 31. A cobertura básica está discriminada neste Título nos capítulos I e II, que, respectivamente, discriminam o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar sem obstetrícia, cujo somatório representa o plano contratado.

CAPÍTULO I DA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL

SEÇÃO I DA COBERTURA

Art. 32. A cobertura deste capítulo compreende os atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios, definidos e listados no Rol de Procedimentos anexo à Resolução nº10/98 do CONSU, observada a seguinte abrangência:

I cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho federal de Medicina;

II cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, **desde que não demandem o apoio da estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas;**

III cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, **pelo período de até 12 (doze) horas;**

IV cobertura de remoção por via terrestre, após realizados os atendimentos classificados como urgência ou caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação;

V a psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, **com duração máxima de 12 (doze) semanas,** tendo início imediatamente após o

Scanned with CamScanner

atendimento de emergência e serão limitadas a 12 (doze) sessões por ano de contrato, não cumulativas;
VI cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais:
a) hemodiálise e diálise peritonial CAPD;
b) quimioterapia ambulatorial;
c) radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletronterapia, etc.);
d) hemoterapia ambulatorial;
e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais.

SEÇÃO II DAS EXCLUSÕES

Art. 33. **Estão excluídos desta cobertura qualsquer atendimentos odontológicos, bem como as exclusões genéricas descritas no Capítulo III deste título.**

Art. 34. **Também estão excluídas da cobertura deste capítulo:**
I os procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas;
II serviços como de recuperação pós anestésica, UTI, CETIN e similares;
III procedimentos diagnósticos e terapêutica em Hemodinâmica;
IV procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, sedação ou bloqueio;
V quimioterapia intra-tecal ou as que demandem internação;
VI radiomoldagens, radioimplantes e braquiterapia;
VII nutrição enteral ou parenteral:
VIII embolizações e radiologia intervencionista.

Parágrafo único. Os procedimentos deste artigo estarão cobertos pela segmentação hospitalar, integrante deste plano, se tiver sido contratada, após o cumprimento dos períodos de carência, conforme o caso.

Art. 35. Dentro da abrangência desta segmentação, quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, e esta esteja em cumprimento de carências, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do CONTRATANTE, não cabendo ônus algum à CONTRATADA.

CAPÍTULO II DA SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR, SEM OBSTETRÍCIA

SEÇÃO I DA COBERTURA

Art. 36. <u>Durante a internação</u> clínica, inclusive a psiquiátrica e/ou cirúrgica, a CONTRATADA garante aos usuários, dentro dos recursos próprios, os seguintes

Scanned with CamScanner

serviços hospitalares:
I diárias de internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor máximo e quantidade, desde que justificada pelo médico assistente cooperado: a) Plano Básico Internação em quarto coletivo ou padrão enfermaria e b) Plano Especial: Internação em quarto privativo.
II exames complementares especializados para diagnóstico e controle do tratamento e da evolução da doença que tenha motivado a internação, **exceto os não cobertos por este contrato;**
III assistência médica através de médicos cooperados;
IV medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões de sangue e derivados e demais recursos terapêuticos;
V taxas de sala de cirurgias, inclusive material utilizado e esterilização, de acordo com o porte cirúrgico;
VI serviços gerais de enfermagem, **exceto em caráter particular;**
VII utilização de leitos especiais, monitores e toda aparelhagem e material, indispensáveis ao tratamento;
VIII unidade de terapia intensiva ou isolamento, quando determinado pelo médico assistente;
IX alimentação específica ou normal, fornecidas pelo hospital, até a alta hospitalar, limitada aos recursos do estabelecimento;
X acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital a acompanhante do usuário menor de 18 (dezoito) anos, nas mesmas condições da cobertura contratada, exceto no caso de internação em UTI ou similar;
XI despesas com remoção inter-hospitalar do usuário, em ambulância, quando comprovadamente necessária ao atendimento coberto, e de acordo com a área geográfica de abrangência do plano;
XII cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções, sendo que, a urgência decorrente de acidente pessoal será garantida, sem restrições, **após o período de carência legal de 24 (vinte quatro) horas.**

Art. 37. Estão incluídos na cobertura, os seguintes **procedimentos** considerados **especiais**, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada a nível de internação.
a) hemodiálise e diálise peritoneal (CAPD);
b) quimioterapia;
c) radioterapia, incluindo radiomoldagem, radioimplantes e braquiterapia;
d) hemoterapia;
e) nutrição parenteral ou enteral;
f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica;
g) embolizações e radiologia intervencionista;
h) exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
i) remoções em urgências ou emergências;
j) fisioterapia.

Scanned with CamScanner

Art. 38. Terão cobertura as cirurgias [illegible]
ambiente hospitalar.

17

Art. 39. A Cirurgia Plástica Reparadora terá cobertura contratual quando efetuada, exclusivamente, para restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidas em virtude e acidentes pessoais ocorridos na vigência deste contrato para o respectivo usuário, e que estejam causando problemas funcionais.

Art. 40. Os transplantes de córnea e rim, estarão cobertos, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, isto é, todos aqueles necessários à realização do transplante, sem prejuízo da legislação específica que normativa estes procedimentos, incluindo:
a) despesas assistenciais com doadores vivos;
b) medicamentos nacionais utilizados durante a internação;
c) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, **exceto medicamentos de manutenção.**
Parágrafo único. **Os transplantes de córnea e rim provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, estarão cobertos desde que o usuário esteja cadastrado em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, integrantes do Sistema Nacional de Transplantes, sujeito ao critério de fila única de espera e de seleção.**

Art. 41. Com exceção dos casos de dependência química, tratados no artigo seguinte, estará coberto o tratamento de usuários portadores de transtornos mentais, que estiverem em situação de crise ou de surto psicótico agudo e que necessitarem de internação hospitalar, em hospitais psiquiátricos especializados no tratamento de quadros agudos ou em unidades psiquiátricas de hospitais gerais, **pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contínuos ou não, durante o período de 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia de internação.** Após esse prazo, essas internações estarão sujeitas a co-participação financeira nas despesas, conforme referenciado na Proposta de Admissão, ou ficará isenta a CONTRATADA da responsabilidade pelo atendimento após o prazo acima, quando não for contratada co-participação.
§ 1º. Quando o CONTRATANTE fizer opção de também co-participar nas despesas para custeio das internações referentes às demais especialidades médicas, **não haverá a isenção a que se refere o *caput*.**
§ 2º. Não estando coberto o atendimento referente ao "caput" deste artigo, no contrato, poderá o usuário ser atendido, por custo operacional, ou seja, pagando tabela própria da CONTRATADA, previamente ao serviço necessitado.
Art. 42. Também estarão cobertas as internações para os usuários portadores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que necessitem hospitalização.
§ 1º. As internações, circunscritas ao tratamento de "desintoxicação", serão **isentas de co-participação** pelo prazo máximo de **15 (quinze) dias contínuos ou não, por ano, não cumulativos**. Após esse prazo, essas internações estarão sujeitas a co-participação financeira nas despesas, conforme referenciado na

Scanned with CamScanner

Proposta de Admissão, ou ficará isenta a CONTRATADA da responsabilidade pelo atendimento após o prazo acima, quando não for contratada co-participação. ..
§ 2º. Quando o CONTRATANTE fizer opção de também co-participar nas despesas para custeio das internações referentes às demais especialidades médicas, **não haverá a isenção a que se refere o *caput*.**
§ 3º. As internações do que trata este artigo estarão sujeitas a exclusão por cobertura parcial temporária pelo prazo fixado na Proposta de Admissão.
§ 4º. Não estando coberto o atendimento referente ao "caput" deste artigo, no contrato, poderá o usuário ser atendido, por custo operacional, ou seja, pagando tabela própria da CONTRATADA, previamente ao serviço necessitado.

Art. 43. As lesões auto-infligidas e as intercorrências clínicas agudas ocorridas em usuários portadores de transtornos mentais, serão sempre tratadas em hospitais gerais quando a hospitalização for necessária.

SEÇÃO II DAS EXCLUSÕES PARA INTERNAÇÃO

Art. 44. **Além das exclusões genéricas descritas no Capítulo III deste Título. esta segmentação também não inclui:**
a) medicamentos não prescritos pelo médico cooperado assistente;
b) despesas de acompanhantes, excepcionadas as de alimentação (servida exclusivamente pela instituição) e acomodação de um acompanhante para o paciente menor de 18 anos;
c) produtos de toalete e higiene pessoal;
d) serviços telefônicos ou qualquer outra despesa que não seja vinculada diretamente à cobertura;
e) despesas decorrentes de serviços médico-hospitalares prestados por médicos não cooperados do SISTEMA NACIONAL UNIMED ou entidades não credenciadas por este;
f) serviços realizados em desacordo com o disposto neste contrato;
g) consultas ou internações referentes a obstetrícia (parto).

SEÇÃO III DOS PROCEDIMENTOS

Art. 45. As internações hospitalares serão processadas mediante pedido firmado por médico cooperado, e guia de internação expedida pela UNIMED prestadora do atendimento em favor do usuário.

Art. 46. Nos casos de urgência, o usuário, ou quem por ele responda, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da internação para providenciar os documentos acima mencionados, sob pena da CONTRATADA não se responsabilizar por quaisquer despesas.

Art. 47. Os usuários deste contrato obrigam-se, ao se internarem, a fornecer à

Scanned with CamScanner

administração do hospital, juntamente com a guia de internação, o documento de identidade, o cartão de identificação emitido pela UNIMED, em pleno vigor, e o comprovante de pagamento da mensalidade atualizado, na forma da lei.

Art. 48. O prazo de internação, fixado pela UNIMED, constará da guia expedida e corresponderá à média de dias utilizados para casos idênticos.

Art. 49. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de internação previamente autorizado, o usuário ou quem por ele responda deverá apresentar à UNIMED a solicitação de prorrogação emitida pelo médico cooperado assistente.

Art. 50. O pagamento das despesas não cobertas deverá ser realizado diretamente pelo usuário ao prestador do atendimento.

Art. 51. Na hipótese do usuário optar por acomodação hospitalar superior àquela contratada, deverá arcar com a diferença de preço e a complementação dos honorários médicos e hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou hospital.

Art.52. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado particularmente pelos usuários com médicos, hospitais ou entidades contratadas, ou não, por ela. Tais despesas correm por conta exclusiva do usuário.

Art. 53. Para todos os efeitos será considerado um mesmo evento a nova internação ocorrida no período de sete dias da alta hospitalar, desde que motivada pela mesma patologia.

CAPÍTULO III DAS EXCLUSÕES CONTRATUAIS

Art. 54. Estão excluídas da cobertura deste contrato:
I consultas, tratamentos e internações realizados antes do início da cobertura ou do cumprimento das carências previstas;
II tratamentos e cirurgias experimentais, exames e medicamentos ainda não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia (S.N.F.M.F.), cirurgias e tratamentos não éticos ou ilegais, cirurgias para mudança de sexo e inseminação artificial;
III atendimento nos casos de calamidade pública, conflitos sociais, guerras, revoluções e outras perturbações da ordem pública, e ainda de envenenamentos de caráter coletivo ou outra causa física que atinja maciçamente a população;
IV tratamentos e cirurgias decorrentes de danos físicos ou lesões causados por radiações ou emanações nucleares ou ionizantes.
V vacinas; medicamentos importados, exceto aqueles cujos custos sejam inferiores ou iguais aos nacionais;
VI tratamentos e cirurgias para controle de natalidade, para infertilidade, esterilidade e suas conseqüências, bem como tratamento cirúrgico e

Scanned with CamScanner

exames laboratoriais diagnósticos e de preservação para todos os tipos de impotência sexual; 20

VII enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;

VIII cirurgias plásticas, exceto as reparadoras, decorrentes de acidentes ocorridos na vigência deste contrato (vigência esta considerada para o usuário), e que estejam causando problemas funcionais; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por motivos de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção de envelhecimento, para emagrecimento (exceto o relacionado a obesidade mórbida) ou ganho de peso; tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral;

IX medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados, em internações ou em atendimentos em prontos-socorros;

X *check-up*, investigação diagnóstica eletiva, em regime de internação hospitalar, necrópsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo;

XI exames para piscina e ginástica;

XII aparelhos ortopédicos, fornecimento de próteses e órteses não ligados ao ato cirúrgico;

XIII aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

XIV consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência;

XV tratamentos de lesões ou doenças causadas por atos reconhecidamente perigosos, praticados pelo usuário e que não sejam motivados por necessidade justificada (nos termos do art. 160 do Código Civil) ou ainda causados por competição com veículos, inclusive treinos preparatórios, ou outras atividades esportivas de risco voluntário;

XVI despesas não vinculadas diretamente à cobertura deste contrato.

XVII implantes e transplantes, exceto os de córnea e rim que estarão cobertos, de acordo com as condições expressas neste contrato;

XVIII tratamentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casos sociais e clínicas de idosos.

XIX procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área geográfica de abrangência contratada.

TÍTULO VIII DAS CARÊNCIAS

Art. 55. Os períodos de carência para cada procedimento, serão os seguintes

I A CONTRATADA assegura, aos usuários titulares, dependentes e agregados quando for o caso, regularmente inscritos, a realização de consultas e procedimentos de diagnóstico e terapia, e internações hospitalares, exclusivamente dentro dos recursos contratados, quando solicitados por médico cooperado e de acordo com as carências a seguir:

Scanned with CamScanner

a) 24 (vinte e quatro) horas, para atendimentos de urgência e emergência;
b) 45 (quarenta e cinco) dias para consultas e exames simples;
c) 180 (cento e oitenta) dias: exames especiais de diagnóstico e terapia e fisioterapia;
d) 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e internamentos clínicos, quimioterapia, radioterapia, diálise e hemodiálise;
e) 180 (cento e oitenta) dias para o benefícios adicionais do Título XIII deste contrato;
f) 300 (trezentos) dias, para partos.

Parágrafo único. Desde que o parto esteja coberto por este contrato e que a mãe ou adotante tenha cumprido as carências específicas, estarão cobertas as despesas com honorários do pediatra, diárias de berçário e UTI do recém-nascido, filho natural ou adotivo, bem como medicamentos e materiais indispensáveis ao seu tratamento, pelo período de 30 (trinta) dias, contado da data de nascimento ou sentença de adoção. Após esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do recém-nascido no contrato ter ocorrido da forma determinada pelo Art. 25 do presente contrato.

TÍTULO IX DA FRANQUIA

Art. 56. Os valores/percentuais de franquia para cada procedimento se houver, estão dispostos na Proposta de Admissão.

Parágrafo único. **Será de responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento da franquia pactuada, no ato da realização dos procedimentos médicos (consulta, exames e internação).**

TÍTULO X DAS LESÕES E DOENÇAS PREEXISTENTES

Art. 57. O CONTRATANTE está obrigado, por ocasião da contratação, a informar, por si e por seus dependentes e agregados, ser conhecedor ou não da condição de portador ou sofredor de doença ou lesão preexistente.
§ 1º. A informação será prestada, através de declaração de saúde, cujo formulário está à disposição do CONTRATANTE na sede da CONTRATADA, a fim de que seja realizada a entrevista qualificada com um médico cooperado sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, ou, a seu critério, com um médico não pertencente ao quadro de cooperados, assumindo, neste caso, as despesas daí decorrentes.
§ 2º. Na declaração de saúde, o usuário titular deverá relacionar todas as lesões e doenças preexistentes à contratação, sob pena da sua omissão caracterizar fraude contratual.
§ 3º. É condição prévia para inclusão do usuário a apresentação da declaração a que se refere o § 1º.

Scanned with CamScanner

§ 4º. Fica a critério da CONTRATADA a realização de exame pré-admissional, posteriormente ou não à realização da entrevista qualificada, visando a identificar a existência de doenças ou lesões preexistentes. 22

§ 5º. A constatação seja através da entrevista qualificada, seja através do exame pré-admissional, da existência de lesão ou doença preexistente, que venha a gerar impacto nos custos da CONTRATADA, resultará em AGRAVO do valor da mensalidade ou na cobertura parcial temporária pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a critério do CONTRATANTE.

§ 6º. O valor correspondente ao agravamento será previamente informado ao CONTRATANTE.

§ 7º. Fica a critério da CONTRATADA, ainda, a solicitação, a qualquer tempo durante a relação contratual, de documentação comprobatória das declarações do CONTRATANTE, prestadas por ocasião da celebração do contrato.

§ 8º. A constatação, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, contados do início da vigência do contrato, da condição de portador ou sofredor de lesão ou doença preexistente caracterizará fraude, sujeitando o usuário, a critério da CONTRATADA, à suspensão da cobertura ou denúncia do contrato, sem prejuízo do direito de pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento em decorrência da doença não informada.

TÍTULO XI DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
CAPÍTULO I DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE

Art. 58. O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, por si e por seus dependentes e agregados inscritos neste contrato, os valores relacionados na Proposta de Admissão para efeito de inscrição, franquia e mensalidade.

Parágrafo Único. Os valores a serem pagos a título de franquia deverão ser efetuados no ato da realização do procedimento e/ou internação no local onde o mesmo for prestado, devendo o prestador do serviço emitir recibo ao CONTRATANTE.

Art. 59. As mensalidades e os eventuais valores relativos à franquia serão pagos, conforme o acordado na Proposta de Admissão, podendo a CONTRATADA, a qualquer tempo, adotar a forma e a modalidade de cobrança que melhor lhe aprouver, desde que comunicado ao CONTRANTE previamente.

Parágrafo único. Quando a data de vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado até o primeiro dia útil subseqüente.

Art. 60. Se o CONTRATANTE não receber o documento que o possibilite realizar o pagamento de sua obrigação, até cinco dias antes do respectivo vencimento, deverá solicitá-lo diretamente na Unimed para que não se sujeite as conseqüências da mora, podendo ainda acessar a internet, através do site **www.unimedcaruaru.com.br.**

Scanned with CamScanner

SEÇÃO I DA INADIMPLÊNCIA

Art. 61. Ocorrendo impontualidade no pagamento da mensalidade, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado, ou ainda, conforme o caso, ressarcimento por perdas e danos, honorários advocatícios e reembolso de custas judiciais.

SEÇÃO II DA SUSPENSÃO DO CONTRATO

Art. 62. **O atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, implicará, sempre, na suspensão total dos atendimentos até a efetiva liquidação do débito, nos termos do artigo anterior, e sem prejuízo do direito da CONTRATADA denunciar o contrato.**

Parágrafo Único. Caso haja, de algum modo utilização no período da suspensão do contrato, a CONTRATADA poderá cobrar judicialmente os valores do que fora utilizado.

CAPÍTULO II DA VARIAÇÃO DOS VALORES

SEÇÃO I DO REAJUSTE E /OU REVISÃO

Art. 63. Os valores previstos na Proposta de Admissão foram fixados com base em cálculo atuarial levando-se em consideração os preços dos serviços colocados à disposição dos usuários, a freqüência de utilização desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos não cobertos, as carências, os limites, valor e/ou percentual de franquia e a carga tributária que hoje recai sobre as cooperativas de trabalho médico. **Assim, qualquer alteração desses itens ensejará novos valores.**

Art. 64. Nos termos da lei, **o valor das mensalidades e inscrições será reajustado anualmente, observadas as formalidades legais, levando-se em conta os índices de elevação de preços observados para cada componente do custo, conforme fórmula genérica expressa no § 1º deste artigo, que também poderá ser revisto se houver utilização comprovada acima da média normal, acréscimo de novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamento ou aumento comprovado dos custos dos serviços contratados que venha a afetar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.**

Scanned with CamScanner

§ 1º. O cálculo dos reajustes obedecerá a seguinte formula: REAJUSTE = (DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (DESPESAS ADMINISTRATIVAS X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (SINISTRALIDADE DA MASSA DE USUÁRIOS).
I Compõem as despesas médicas e/ou hospitalares: a) honorários médicos, sobre as consultas e outros procedimentos; b) diárias e taxas hospitalares; c) materiais e d) medicamentos.
II Compõem as despesas administrativas: a) salários; e b) outras despesas.

§ 2º. Caso nova legislação venha a autorizar o reajustamento em período inferior a doze meses, a mesma terá aplicação imediata sobre este contrato.

Art. 65. Se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não puder praticar o reajustamento, nos termos do artigo anterior, provisoriamente, a mensalidade será reajustada, na periodicidade legal, pela variação do IGP-M (Índice de Preços do Mercado), **segmento saúde**, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período.

Art. 66. Fica estabelecido que os valores relativos a inclusões de dependentes, ou de módulos adicionais, terão o primeiro reajuste, proporcional, na data de aniversário de vigência do presente contrato para o usuário titular, unificando-se as respectivas datas base.

§ 1º. Os valores e/ou percentuais previstos na proposta de admissão a título de franquia, serão reajustados, na da data de aniversário do presente instrumento, observada a periodicidade legal, pela variação do IGP-M, **segmento saúde,** ou na falta deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período.
§ 2º. Os reajustes subseqüentes à unificação das datas base respeitarão as disposições contidas neste Capítulo.

SEÇÃO II DAS FAIXAS ETÁRIAS

Art. 67. As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada usuário inscrito esteja enquadrado. Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos usuários que importe em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será aumentada automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do usuário.

Art. 68. As faixas etárias para os fins deste contrato são:
a) 1ª - 00 (zero) a 18 (dezoito) anos; b) 2ª - de 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; c) 3ª - de 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; d) 4ª - de 29 (vinte e

Scanned with CamScanner

nove) a 33 (trinta e três) anos; e) 5ª - de 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; f) 6ª - de 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos e g) 7ª - 44 (quarenta e quatro) anos a 48 (quarenta e oito); anos; 8ª de 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; 9ª de 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; 10ª de 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 69. Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária corresponderão aos percentuais indicados a seguir:

FAIXAS	IDADES	VARIAÇÃO (%)
1ª	0 - 18	0 %
2ª	19 - 23	35,2 %
3ª	24 - 28	10,5 %
4ª	29 - 33	4,9 %
5ª	34 - 38	10,5 %
6ª	39 - 43	57,4 %
7ª	44 - 48	22,1 %
8ª	49 - 53	17,8 %
9ª	54 - 58	10,5 %
10ª	59 ou mais	38,7 %

Art. 70. Os usuários com mais de 60 (sessenta) anos de idade e que tiverem permanecido no plano por pelo menos 10 (dez) anos, consecutivos, estarão isentos do aumento decorrente de modificação de faixa etária.

TÍTULO XII DA RESCISÃO DO CONTRATO

Art. 71. **Será considerado rescindido este contrato, se houver atraso no pagamento da contraprestação por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, sem prejuízo do direito da CONTRATADA requerer judicialmente a quitação do débito com suas conseqüências moratórias.**

Art. 72. Rescinde-se também este contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ocorrendo:

a) Qualquer ato ilícito praticado pelos usuários, na utilização do objeto deste contrato;

b) Abuso, considerado como tal a utilização absolutamente desnecessária dos serviços contratados;

c) Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED;

d) Omissão ou distorção de informações em prejuízo da UNIMED ou do resultado

Scanned with CamScanner

de perícias ou exames, quando necessários;
e) Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato;
f) A exclusão do usuário titular.

Art. 73. Antes do término do prazo mínimo fixado na Proposta de Admissão, é facultado ao CONTRATANTE denunciar o presente contrato, **mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sujeitando-se ao pagamento de multa pecuniária equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo.**
§ 1º. O contrato que estiver vigente por prazo indeterminado poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.
§ 2º. A falta de comunicação, nos termos deste artigo, implica na subsistência das obrigações assumidas.
§ 3º. Durante o prazo previsto neste artigo, não será admitida inclusão ou exclusão de usuários.

Art. 74. A responsabilidade da CONTRATADA sobre os atendimentos iniciados durante a vigência do contrato cessa no último dia do prazo de 30 (trinta) dias mencionado no artigo anterior, correndo as despesas a partir daí por conta do CONTRATANTE.

Art. 75. O CONTRATANTE reconhece como dívida líquida e certa, em favor da CONTRATADA, quaisquer despesas decorrentes de atendimento prestado a ele, seus dependentes e agregados, cessadas as responsabilidades da CONTRATADA, independentemente da data de início do tratamento, bem como aquelas coberturas deferidas liminar ou cautelarmente em procedimento judicial, e posteriormente revogadas ou decididas em contrário, e ainda, os procedimentos não cobertos explicitamente por este instrumento.

TÍTULO XIII DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS
CAPÍTULO I SEGURO DE VIDA UNIMED

Art.. 76. Este benefício assegura ao titular ou dependentes inscritos **seguro de vida** do titular, em favor dos beneficiários indicados na proposta de adesão, ou na falta destes, de acordo com a legislação específica, tudo de conformidade com as Condições da Apólice do seguro, em poder desta UNIMED, respeitadas as seguintes condições:
§ 1º. Somente será assegurada a cobertura se o usuário titular:
a) estiver em perfeito estado de saúde, na data de sua inscrição;
b) tiver idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos, na data de sua inscrição;
c) estiver rigorosamente em dia o pagamento das mensalidades, na data do óbito; e,
d) ter cumprido o prazo de permanência de 06 (seis) meses no plano, contados da

Scanned with CamScanner

data da sua inscrição.
§ 2º. O seguro de vida é instituído em forma de seguro de vida em grupo, sendo devido nos casos de morte natural ou morte acidental;
§ 3º. O valor das indenizações será aquele vigente na data do sinistro.
§ 4º. Fica preservado ao usuário titular o direito de alterar, a qualquer tempo, os beneficiários da cláusula.
§ 5º. Em caso de sinistro, deverão ser encaminhados à Seguradora, através da CONTRATADA, os seguintes documentos: I Do Segurado falecido: a) aviso de sinistro devidamente preenchido; b) Certidão de Óbito; c) cópia autenticada do documento de identidade. I.1 Para morte acidental, mais os seguintes: a) cópia do Boletim de Ocorrência; b) cópia do Laudo Cadavérico; c) cópia do Laudo de Dosagem Toxicológica, se houver. II Do(s) beneficiário(s): a) cônjuge: Certidão de Casamento atualizada (emitida após o óbito) e cópia do documento de identidade; b) filhos: Certidão de Nascimento; c) pais: Certidão de Nascimento, ou de Casamento; d) convivente: prova dessa condição; e) incapazes: alvará judicial e, quando for o caso, termo de tutela ou curatela.
§ 6º. Poderão, ainda, ser solicitados quaisquer outros documentos que se façam necessários à liquidação do sinistro.

Art. 77. O atraso nos pagamentos das mensalidades implicará na suspensão do seguro de que trata esta cláusula, enquanto perdurar.
Parágrafo único. O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das mensalidades implicará no cancelamento do seguro.

Art. 78. A indenização não será devida na hipótese do usuário titular, ou seu respectivo dependente, de alguma maneira, der causa ou contribuir para a ocorrência do falecimento, bem como os eventos cujas despesas decorram, direta ou indiretamente, de:
a) atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, guerra civil, rebelião, insurreição, guerrilha, revolução, agitação, motim, revolta, sedição, tumulto, confisco, sublevação, greves, bem como quaisquer outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, e, ainda, atos das Forças Armadas e de Segurança em tempos de paz;
b) inundação, furacão, ciclones, erupção vulcânica, tempestades, terremotos, maremotos, movimentos sísmicos ou movimentos de terra em geral e qualquer outro fenômeno atmosférico, meteorológico, sísmico ou geológico de caráter extraordinário e outras convulsões da natureza;
c) radiações Ionizantes, materiais e armas nucleares, contaminação pela radioatividade ou resíduo de combustão de material nuclear e explosões nucleares;
d) ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários à lei;
e) competições com veículos, inclusive treinos preparatórios;
f) doenças preexistentes e conhecidas pelo usuário na época da contratação do seguro e acidentes ocorridos antes da contratação individual do seguro;

Scanned with CamScanner

Art. 79. O presente seguro será coberto pela UNIMED Seguradora S/A, com sede na cidade de São Paulo SP.

28

CAPÍTULO II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR FAC

Art. 80. Ocorrendo o falecimento do usuário titular, com idade de até 59(cinqüenta e nove) anos na data da assinatura deste contrato, que seja há mais de 06 (seis) meses participante do plano de assistência à saúde objeto deste contrato, que as mensalidades estejam rigorosamente em dia na data do óbito, os usuários dependentes abaixo indicados, terão direito aos serviços previstos no plano em que estiverem inscritos, observadas as respectivas condições, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades.
Parágrafo único. Não estão incluídos neste benefício os eventuais valores de franquia por procedimento, cuja obrigação de pagamento pelos usuários subsistirá na forma e condições anteriores.

Art. 81. Desde que inscrito há mais de 06 (seis) meses; antes da data do óbito, considera-se usuário dependente aquele indicado no art. 21, aceito como tal no plano, **excluídos os agregados mencionados no art. 22 deste contrato.**
Parágrafo único. O direito ao FAC também é conferido ao nascituro, considerado filho do usuário titular falecido, nos termos da legislação civil, inscrito na forma do Capítulo IV do Título V deste instrumento.

Art. 82. O usuário dependente que não for inscrito no mesmo ato de inscrição do usuário titular, ou em até 30 (trinta) dias do implemento da condição que permitisse seu ingresso no plano, só terá direito ao benefício se o óbito ocorrer após decorrido o prazo de 12 (doze) meses de sua respectiva inscrição.
Art. 83. Perderá imediatamente o direito ao benefício estabelecido neste Capítulo o dependente que vier a perder sua condição de dependência.

Art. 84. O benefício previsto neste Capítulo fica condicionado à apresentação, pelos usuários dependentes, da Certidão de Óbito do usuário titular, além de cópias autenticadas dos documentos que se fizerem necessários à comprovação da dependência.
§ 1º. Os usuários dependentes que não apresentarem os documentos exigidos no ***caput***, ficam impedidos de gozar do benefício do FAC, ainda que estivessem em gozo do direito à cobertura deste contrato, quando vivo o usuário titular, salvo se houver continuidade nos pagamentos das mensalidades.
§ 2º. Os valores pagos nos termos do parágrafo anterior, sob nenhuma hipótese, serão devolvidos.

Art. 85. Os cartões de Identificação dos usuários dependentes, no caso de falecimento do titular, serão substituídos pela Identificação Pessoal do FAC.

Art. 86. O direito Assistência Complementar (FAC), aos dependentes do usuário

Scanned with CamScanner

titular falecido, será assegurado na mesma área de abrangência do plano de assistência à saúde contratado.

TÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87. Os usuários com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos têm privilégio na marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos.

Art. 88. Na eventualidade de insatisfação quanto ao plano ou atendimento dos profissionais e empregados da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá encaminhar reclamação escrita para o endereço constante da Proposta de Admissão, para a devida apuração.

Art. 89. A utilização dos serviços contratados, durante o período de suspensão ou de carência, neste caso, ressalvadas as urgências e emergências, implica em dever do CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o respectivo custo, aferido através da Tabela de Referência.

Art. 90. A CONTRATADA reserva-se o direito de rescindir o contrato com qualquer participante da sua rede assistencial, bem como de contratar novos serviços, a seu exclusivo critério, sempre objetivando o aprimoramento da prestação dos serviços previstos neste instrumento.

Art. 91. O CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual é apenas com a CONTRATADA, mesmo em caso de atendimento por outras cooperativas integrantes do SISTEMA NACIONAL UNIMED.

Art. 92. A inserção de mensagens no recibo de cobrança das mensalidades valerá como intimação do CONTRATANTE, para todos os efeitos deste contrato, a partir da data do respectivo pagamento.

Art. 93. Qualquer tolerância não implica perdão, novação, renúncia ou alteração do pactuado.

Art. 94. **O CONTRATANTE, por si e pelos dependentes e agregados, autoriza a CONTRATADA a prestar todas as informações cadastrais, inclusive quanto aos atendimentos, solicitadas pelos órgãos de fiscalização da assistência à saúde.**

Art. 95. Integram este contrato, para todos os fins de direito, a Proposta de Admissão e demais anexos firmados pelos contraentes.

Art. 96. Casos omissos e eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre os contraentes e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

Scanned with CamScanner

o Contratante se obriga a pagar a Contratada.
FRANQUIA: Custeio por parte do contratante de um valor e/ou, previamente
:uado no ato da realização do procedimento.
COBERTURA: é a cláusula contratada, que o usuário tem direito.
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA: é aquela que admite num prazo
arminado, a concessão de apenas algumas das coberturas contratadas, com a
pensão de cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e
cedimentos de alta complexidade, relacionados às exclusões estabelecidas
contrato.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU): é o órgão
egiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
npetência para deliberar sobre questões relacionadas à prestação de serviços
saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico.
'I CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP): é o órgão
legiado vinculado ao Ministério da Fazenda que, dentre outras atribuições, é
sponsável por ditar as características gerais dos instrumentos contratuais
lizados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.
/II CONSULTA: é o ato realizado pelo médico, que avalia as condições clínicas
usuário.
/III CONTRATO INDIVIDUAL: é aquele oferecido para livre adesão de
suários, pessoas físicas, com ou sem seu grupo familiar.
IX CONTRATO FAMILIAR: é aquele em que é facultado ao contratante, pessoa
sica, a inclusão de seus dependentes ou grupo familiar.
X CONVIVENTE: é a pessoa que vive em união estável com outrem em
timidade, familiaridade, concubinato ou mancebia; amigado; amasiado;
ompanheiro.
XI DOENÇA: é o processo mórbido definido, tendo um conjunto característico
e sintomas e sinais, que leva o indivíduo a tratamento médico.
XII DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE: é todo evento mórbido, congênito
u adquirido, que comprometa função orgânica ou coloque em risco a saúde do
ndivíduo, quer por sua ação direta ou indiretamente por suas conseqüências, do
ual o usuário tenha conhecimento ou recebido tratamento clínico ou cirúrgico,
ntes até a data de inclusão no plano.
XIII ELETIVO: é o termo usado para designar procedimentos médicos não
considerados de urgência ou emergência.
XIV EMERGÊNCIA: é o evento que implicar no risco imediato de vida ou de
esões irreparáveis para o usuário, caracterizado em declaração do médico
assistente.
XXV EVENTO: é o conjunto de ocorrências ou serviços de assistência médica ou
hospitalar que tenham por origem, ou causa, dano involuntário à saúde ou à
integridade física do usuário, em decorrência de acidente ou doença, desde que
tenha se verificado durante a vigência do contrato e não figure como exclusão de
cobertura. O evento se inicia com a comprovação médica de sua ocorrência e
termina com a alta médica definitiva, concedida ao paciente, com o abandono do
tratamento por parte do usuário, ou com a sua morte.
XXVI EXAME: é o procedimento complementar solicitado pelo médico, que

Scanned with CamScanner

MÓDULO OPCIONAL - INTERNAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO

Art. 1º. Se firmado este Módulo, a contratação e os valores estarão expressos na Proposta de Admissão.

Art. 2º. Desde que contratado, será assegurado aos usuários, o direito à internação em quarto privativo com banheiro, e direito a acompanhante, de acordo com a disponibilidade do hospital.

Art. 3º. O direito à ampliação, ora contratada, será conferido aos usuários após o cumprimento das seguintes carências, quando for o caso, não cumulativas ao contrato, contadas da data da vigência do respectivo Módulo:

§ 1º. Sendo este Módulo contratado até trinta dias contados da assinatura deste contrato ou do implemento da condição que permita a inscrição do usuário no plano, os usuários estarão isentos de carências de acordo com as coberturas a seguir:

a) urgências e emergências;

b) binternações;

c) parto, desde que contratada a cobertura obstétrica.

§ 2º. Sendo este Módulo contratado após o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o usuário deverá cumprir os seguintes período de carência:

a) 300 dias: partos, desde que contratada a cobertura obstétrica; e

b) 180 dias: quaisquer outras internações.

Art. 4º. É responsabilidade do CONTRATANTE, o pagamento de despesas não vinculadas diretamente à cobertura do contrato.

Art. 5º. Fica estabelecido que o CONTRATANTE não poderá renunciar à ampliação ora contratada e manter as demais coberturas, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data da inscrição do usuário neste Módulo.

Art. 6º. Por conseqüência da contratação deste Módulo, fica alterado o preço pactuado, que é acrescido da quantia descrita na Proposta de Admissão, por usuário inscrito.

Parágrafo único. Os valores referentes a este módulo, são calculados em função das mesmas faixas etárias descritas no Capítulo II do Título X e adotam o mesmo critério de variação e reajuste.

Art. 7º. Permanecem em plena vigência as Cláusulas do contrato não alteradas por este Módulo.

Scanned with CamScanner

Art. 97. Fica eleito o foro do domicílio da prestação dos serviços (Garanhuns-PE), dirimir qualquer demanda sobre o presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Art. 98. Este contrato foi elaborado levando-se em consideração a legislação vigente até 31/12/98, assim, qualquer alteração das normas que implique em necessária modificação do que aqui foi avençado, sujeitará a novo ajuste das condições, inclusive com possíveis reflexos na contraprestação.

Por estarem assim, justos e contratados, firmam a Proposta de Admissão que é parte integrante deste instrumento.

Contratada: UNIMED CARUARU/COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Contratante:_____

Testemunhas:

1. Nome:_____

RG.: _____ **C.P.F.:**_____

2. Nome:_____

RG.: _____ **C.P.F.:**_____

CONTRATO REGISTRADO SOB Nº_____

Cartório de Registro de Títulos e Documentos

_____

Scanned with CamScanner

MÓDULO OPCIONAL ATENDIMENTO OBSTÉTRICO

DA COBERTURA

Art. 1º. Este módulo é complementar à cobertura definida no Capítulo II do Título VII, que é acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de assistência médica hospitalar decorrente da condição gestacional coberta por este módulo, porém, estando a usuária ainda cumprindo período de carência, a CONTRATADA estará obrigada a tão-somente cobrir o atendimento prestado nas mesmas condições previstas na segmentação ambulatorial (Capítulo I do Título VII).

Art. 2º. Desde que a mãe ou adotante tenha cumprido as carências específicas, estarão cobertas as despesas com honorários médicos, diárias de berçário e centro de terapia intensiva do recém-nascido, filho natural ou adotivo, bem como materiais e medicamentos ministrados durante a internação, e exames indispensáveis ao seu tratamento, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento. Decorrido esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do recém-nascido em plano de assistência à saúde, observado o disposto no Título V.

DAS EXCLUSÕES

Art. 3º. As exclusões deste módulo são as mesmas da segmentação Hospitalar sem Obstetrícia, exceto no que se refere à cobertura de procedimentos obstétricos, ora contratada.

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 4º. Para este módulo, observar-se-ão os mesmos procedimentos dispostos na Seção III do Capítulo II do Título VII.

Caruaru, _____ de _____ de _____

Scanned with CamScanner

Endereços

SEDE
Rua Deputado Souto Filho, 178 Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-312 Fone/fax (81) 3721-5068

POSTOS DE VENDAS
CARUARU
Glmar Representações
Rua Silvino Macêdo, 125 A Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-380 Fone/Fax: (81) 3721-7215

Allyson Representações
Rua Dom Sebastião Leme, 60 Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-360 Fone/Fax: (81) 3721-2454

Rosineide Representações
Rua Capitão João Velho, 201 Centro
Caruaru PE CEP 55002-400 Fone/Fax: (81) 3721-8971

Valdir e Sérgio Representações
Rua Cel. Limeira, 25 Centro
Caruaru PE CEP 55002-350 Fone/Fax: (81) 3722-3769

Antônio Filho Representações
Rua Tiradentes, 55 Centro
Caruaru PE CEP 55004-230 Fone/Fax: (81) 3721-4911
E-mail: marianeide@ig.com.br

CUPIRA
Antônio Filho Representações
Rua Dr. Aderbal Jurema, 10 Centro
Fone: (81) 3738-1459

GRAVATÁ
Antônio Filho Representações
Rua Rui Barbosa, 91 1° andar Centro
Gravatá -PE- CEP 55640-000 Fone/Fax: (81) 3533-1325

TORITAMA
Betânia Representações
Rua do Comércio, 184 Centro
Toritama Pe CEP 55125-000 Fone: (81) 3741-1803

BELO JARDIM
Gonzaga e Cristina Representações
Rua Valdemar de Lira, 65 Boa Vista
Belo Jardim -PE CEP 55150-000 Fone/Fax: (81) 3726-1712

PALMARES
Rua Conselheiro João Alfredo, Casa A, 95 Centro
Fone: (81) 3661-4874

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Betânia Representações
Av. 29 de Dezembro, 381 Centro
Santa Cruz do Capibaribe PE CEP 55190-000 Fone: (81) 3731-2321

UTI Móvel Ambulância
Fone: (81) 9104-1063

UNIVIDA AIR Remoção Aérea
Fone: 0800-992500

HOSPTIAL UNIMED
Rua Arthur Antônio da Silva, 549 Fone: (81) 3722-8600

Scanned with CamScanner

2026, 0

NeuroCor
INSTITUTO

Paciente: Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres **Data de Nasc:** 03/08/2005 **CPF:** 097.798.184-30
Realizado em: 07/04/2026 **Convênio:** Unimed
Solicitante: -

LAUDO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que a paciente acima identificada encontra-se em acompanhamento especializado por quadro de dorsalgia crônica mecânico-postural, associada a hipercifose torácica e sobrecarga musculoesquelética axial, em contexto de macromastia com repercussão funcional sobre a coluna vertebral.

A paciente apresenta queixa de dor dorsal persistente, com piora em posturas mantidas, ortostatismo prolongado e atividades habituais, havendo apenas alívio parcial com analgésicos. A avaliação clínica demonstra que o quadro álgico não decorre primariamente de deformidade escoliótica estrutural grave, mas sim de sobrecarga biomecânica contínua imposta pelo volume mamário excessivo, que desloca o centro de gravidade anteriormente, aumenta a demanda compensatória da musculatura paravertebral e periescapular e favorece agravamento da cifose torácica, com consequente dor axial crônica e limitação funcional.

Ao exame, observa-se:

alteração postural com anteriorização do tronco;
hipercifose torácica;
dor à palpação de musculatura paravertebral torácica e região interescapular;
quadro compatível com sobrecarga musculoligamentar posterior;
escoliose torácica leve, em torno de 18,9° a 20°, sem indicação de correção cirúrgica específica para deformidade, mas com necessidade de tratamento conservador e compensação muscular.

A análise clínica e radiográfica permite concluir que:

A escoliose é leve, sem critério de tratamento cirúrgico da coluna.
O principal fator mantenedor da dor e da desorganização biomecânica é a macromastia, com repercussão direta sobre a postura e sobre a sobrecarga do segmento torácico.
Há nexo funcional claro entre o excesso ponderal mamário e o quadro de dorsalgia mecânica, hipercifose e incapacidade postural.
Trata-se de quadro não estético, mas sim patológico e funcional, com repercussão clínica objetiva sobre a coluna vertebral e musculatura de sustentação.

Diante do exposto, há indicação médica de mamoplastia redutora com finalidade funcional/reparadora, visando:

redução da sobrecarga axial anterior;
melhora da biomecânica da coluna torácica;
diminuição da dor dorsal crônica;
melhora do equilíbrio postural;
redução da necessidade de analgesia contínua;
prevenção de cronificação dolorosa e piora do condicionamento musculoesquelético.

Dr. Felipe Fernandes
Neurocirurgião
CRM: 20619 / RQE: 10833

Caruaru, 07/04/2026

Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins
Neurocirurgião
CRM 20619/PE RQE 10833

INSTITUTO NEUROCOR
Rua Nossa Senhora de Fátima, 351
Maurício de Nassau
Caruaru-PE CEP: 55012-600

Contatos
Telefone: (81) 3719-6799
E-mail: ineurocor@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170486600000235353806
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170486600000235353806
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

NeuroCor
INSTITUTO

Paciente: Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres **Data de Nasc:** 03/08/2005 **CPF:** 097.798.184-30
Realizado em: 07/04/2026 **Convênio:** Unimed
Solicitante: -

Ressalto que a indicação do procedimento não se fundamenta em motivação estética, mas em benefício funcional e terapêutico, diante de quadro clínico estabelecido, sintomático e diretamente relacionado ao volume mamário excessivo.

CID-10 sugeridos:

N62 – Hipertrofia da mama
M54.6 – Dor na coluna torácica
M40.2 – Outras cifoses e lordoses
M41.9 – Escoliose, não especificada

Conclusão:
Paciente com macromastia sintomática, associada a dorsalgia mecânico-postural crônica, hipercifose torácica e sobrecarga funcional da coluna, apresentando indicação médica formal de mamoplastia redutora com caráter reparador/funcional, e não estético.

Dr. Felipe Fernandes
Neurocirurgião
CRM: 20619/PE RQE: 10833

Caruaru, 07/04/2026

Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins
Neurocirurgião
CRM 20619/PE RQE 10833

INSTITUTO NEUROCOR
Rua Nossa Senhora de Fátima, 351
Maurício de Nassau
Caruaru-PE CEP: 55012-600

Contatos
Telefone: (81) 3719-6799
E-mail: ineurocor@gmail.com

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170486600000235353806
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170486600000235353806
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

Unimed Piauí

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

2- Nº Guia no Prestador
(O número da guia tem que criado pelo Prestador)

1 - Registro ANS

3 - Número da Guia Atribuido pela Operadora

4 - Data da Autorização

5 - Senha

6 – Data de Validade da Senha

Dados do Beneficiário

7 - Número da Carteira

8 - Validade da Carteira

9-Atendimento a RN

10 - Nome
Maria Darinny Leticia da S. P. Tones

11 - Cartão Nacional de Saúde

Dados do Contratado Solicitante

12 - Código na Operadora

13 - Nome do Contratado

14 - Nome do Profissional Solicitante
Marcos Gomes

15 - Conselho Profissional

16 - Número no Conselho
11305

17 - UF

18 - Código CBO

Dados do Hospital /Local Solicitado / Dados da Internação

19 - Código na Operadora / CNPJ

20 - Nome do Hospital/Local Solicitado
Hospital São Gabriel

21 - Data sugerida para internação

22 - Caráter do Atendimento
E

23 - Tipo de Internação
C

24 - Regime de Internação
H

25 - Qtde. Diárias Solicitadas
01

26 – Previsão de uso de OPME

27 – Previsão de uso de quimioterápico

28 - Indicação Clínica
Solicito avaliação do paciente com hipertrofia mamária, encaminhado com laudo do Neurologista, informando a necessidade de Mastoplastia para redução de sobrecarga axial, melhora biomecânica de coluna, diminuição de dor cervical, melhora do equilíbrio, redução da analgesia e monitorização adequada e prova muscular esquelética.

29-CID 10 Principal (Opcional)
M609

30 - CID 10 (2) (Opcional)

31 - CID 10 (3) (Opcional)

32 - CID 10 (4) (Opcional)

33 - Indicação de Acidente (acidente ou doença relacionada)

Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados

	34-Tabela	35 - Código do Procedimento ou Item Assistencial	36 - Descrição	37 - Qtde Solic	38 – Qtde Aut
01-			Mastoplastia Redutora	02	
02-					
03-					
04-					
05-					
06-					
07-					
08-					
09-					
10-					
11-					
12-					

Dados da Autorização

39 - Data Provável da Admissão Hospitalar

40 - Qtde. Diarias Autorizadas

41 - Tipo da Acomodação Autorizada

42 - Código na Operadora / CNPJ autorizado

43 - Nome do Hospital / Local Autorizado

44 - Código CNES

45 - Observação / Justificativa

46 - Data da Solicitação
07/04/26

47- Assinatura do Profissional Solicitante
Marcos Gomes

48- Assinatura do Beneficiário ou Responsável

49- Assinatura do Responsável pela Autorização

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170486600000235353806
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170486600000235353806
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

COMPROVANTE DE NEGATIVA CONTRATUAL/ ASSISTENCIAL - em conformidade com a RN nº 319

CARUARU - PE,09/04/26 13:26

Dados da Operadora
Razão Social: Unimed Caruaru
Registro ANS: 340952
CNPJ: 24449225000198
Endereço: CARUARU CORPORATE, 3º ANDAR - AV. ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 INDIANÓPOLIS
Protocolo: 34095220260409034269

Dados do Beneficiário
Nome: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Data De Nascimento: 03/08/2005 **CPF:** 09779818430
Número da Carteira: 174 5019481769000 **Data De Inclusão:** 26/10/2005
Plano: 536 - UNICO ENFERMARIA PESSOA FISICA III
Abrangência: Grupo de Municípios **Acomodação:** ENFERMARIA
Número da Guia: 144786009
Contrato: 62689 - MARIA LUCIMARA DA SILVA

A Unimed Caruaru - Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de assistência privada a saúde, registrada na ANS sob o nº340952, inscrita no CNPJ/MF sob o nº24.449.225/0001-98, com sede Av. Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis, Ed. Empresarial Caruaru Corporate, 3º Andar, Caruaru Shopping, Caruaru, Pernambuco, CEP: 55024-740, informa acerca de sua solicitação médica de acordo com o dispositivo legal:

Dados dos Procedimentos

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
22	30602351	Mamoplastia	2

Motivo Da Negativa

Em conformidade com a RN 623/24, Art. 14, vimos apresentar a justificativa da negativa de autorização do exame/procedimento referido. Esclarecemos que o contrato ao qual V.Sa. está vinculado é regido pela Lei nº 9.656/98, tratando-se, portanto, de um contrato regulamentado, que possui cobertura estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no chamado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Atualmente, o referido Rol está previsto na RN nº 465/2021 da ANS, que, em relação ao exame/procedimento solicitado, estabelece, em seus Anexos II e III, Diretrizes de Utilização (DUT) e Diretrizes Clínicas (DC) que devem ser observadas para que a cobertura se torne obrigatória.

Ocorre que a solicitação do exame apresentada por V.Sa., após análise técnica realizada, recebeu parecer desfavorável, tendo como justificativa que, segundo a Lei nº 9.656/98 (Lei Geral dos Planos de Saúde), procedimentos de natureza estética não possuem obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de saúde.

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
18	60000805	DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO	1

Motivo Da Negativa

Motivo citado acima.

Atenciosamente,

Relacionamento com o Cliente

Obs: A Lei nº 9.656/98 e as normas citadas acima podem ser consultadas no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br). A presente informação, relata as razões da negativa de cobertura que poderá ocorrer por razões contratuais ou assistenciais, ou ambas.
É facultado ao cliente requerer a reanálise de sua solicitação, devendo direcionar o seu pedido com a Indicação do número deste protocolo de atendimento e de documentos adicionais que corroborem na análise mais precisa do caso, para ser apreciada pela Ouvidoria através de Email: ouvidoria@unimedcaruaru.com.br ou presencialmente, no endereço: Shopping Caruaru - Corporate / Rua Adjar da Silva Casé, 800- Indianópolis.

Outlook

Fwd: Resposta à NIP Nº 158861/2026 - Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres

De Maria Dávinny Letícia <mariadavinnyleticia@icloud.com>
Data Sex, 29/05/2026 17:47
Para Melquisedeque Lima <melquisedequelima@delimaadvocacia.com>

1 anexo (5 KB)
Justificativa de Negativa de Procedimento da Guia-N 144786009.pdf;

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ana Doralice Silva de Souza <ana.souza@unimedcaruaru.com.br>
Data: 15 de abril de 2026 às 17:04:43 BRT
Para: mariadavinnyleticia@icloud.com
Assunto: Resposta à NIP Nº 158861/2026 - Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres

Prezada Senhora Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres,

Em atenção à sua reclamação registrada junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob o número 158861/2026, informamos o seguinte:

Inicialmente, esclarecemos que a senhora é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei no 9.656/98, cujo a cobertura garantida é aquela definida pelo Rol de Procedimentos editado pela ANS.

Em seguida, comunicamos que o procedimento Mamoplastia conforme o PARECER TÉCNICO Nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024: MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória. Segue em anexo a negativa formalizada.

Permanecemos à disposição em caso de dúvidas através dos canais de atendimento abaixo.
Telefone: 81 2103-5000 (ligação e whatsapp)
E-mail: centralfaleconosco@unimedcaruaru.com.br

--
Atenciosamente,
Ana Souza
Relacionamento com o cliente
Fone: (81) 2103-5068

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170523700000235353808
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170523700000235353808
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

Email tracked with Mailsuite · Opt out

<Justificativa de Negativa de Procedimento da Guia-N 144786009.pdf>

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170523700000235353808
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170523700000235353808
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 377 Código de Verificação XE2UARVHX Emissão da NFS-e 26/05/2026 14:58:38	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 375	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.446.918/0001-64 Inscrição 90607804

Nome/Razão Social: MARCOS ANTONIO GOMES A LVES

Endereço Avenida Agamenon Magalhães Número: 1233

Complemento: Bairro: Maurício de Nassau

CEP: 55014-000 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil

E-mail: CCAGRESTE@HOTMAIL.COM Telefone: 3719-1419

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 097.798.184-30 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: MARIA DAVINNY LETÍCIA DA SILVA PEREIRA TORRES

Endereço: Rua RUA 17 DE DEZEMBRO Número: 210

Complemento: CENTRO Bairro: Cachoeirinha

CEP: 55380-000 Município: CACHOEIRINHA UF: PE País: Brasil

E-mail: marialucimara1975@gmail.com Telefone: (81)99914-4694

Atividade Econômica

6.02 / 960250201 - ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA

Discriminação do Serviço

PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA PLASTICA DE MASTOPLASTIA, HOSPITAL SÃO GABRIEL

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	9.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		Base de Cálculo	9.000,00
Classificação Tributária		Alíquota	2,00
Competência	05/2026	ISSQN	
Município Prestação	CARUARU - PE	IBS	
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	9.000,00

Outras Informações

Dr. Marcos Gomes
CIRURGIA PLÁSTICA

Recibo

Recebi da paciente: Maria Davinny Letícia da Silva Pereira a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) referente ao Kit cirurgico (suturas e cola cirurgica)

Pato,

25/05/2026

Emilia

@dr.marcos.gomes Clínica Dr. Marcos Gomes - Cirurgião Plástico

Complexo Médico de Caruaru: Av. Agamenon Magalhães, 1233 - 2° Andar - Sala 203 - Maurício de Nassau ☎ (81) 3137-1138 (81) 9 8286-4830
Hospital Antônio Targino: Rua Delmiro Gouveia, 369 - 5° andar - Sala 507 - Centenário - Campina Grande - PB (83) 9 8898-9474
Empresarial Agamenon Magalhães: Av. Agamenon Magalhães, 2656 - Sala 801 - Espinheiro - Recife - PE (81) 9 8801-2570

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170568600000235353810
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170568600000235353810
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:05

Comprovante de pagamento

30 ABR 2026 - 17:36:17

Valor	R$ 305,74

Destino

Favorecido	UNIMED CARUARU C T MEDICO
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Vencimento	30 ABR 2026
Código de barras	341910925532 292757880810 543900001143 20000030574

Origem

Pagador	Maria Dávinny Letícia da Silva Pereira Torres
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	844426839-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
69f3bd40-2960-4d75-8679-7eb02b5f7681

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170596300000235353811
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170596300000235353811
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:06

Comprovante de pagamento

30 MAR 2026 - 07:48:30

Valor	R$ 305,74

Destino

Favorecido	UNIMED CARUARU C T MEDICO
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Vencimento	30 MAR 2026
Código de barras	341910925526 522467880810 543900002140 10000030574

Origem

Pagador	Maria Dávinny Letícia da Silva Pereira Torres
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	844426839-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 69ca54fe-d40f-4483-961b-f3f8bc87c462

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170596300000235353811
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170596300000235353811
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:06

Comprovante de pagamento

27 FEV 2026 - 08:26:49

Valor	R$ 305,74

Destino

Favorecido	UNIMED CARUARU C T MEDICO
Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Vencimento	28 FEV 2026
Código de barras	341910925520 544277880810 543900001137 10000030574

Origem

Pagador	Maria Dávinny Letícia da Silva Pereira Torres
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	844426839-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 69a17f79-e1ac-4d10-91e8-093171bb22a7

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170596300000235353811
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170596300000235353811
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:06

Dr. Marcos Gomes
CIRURGIA PLÁSTICA

PACIENTE: Mª Davinny Coelho da S. P. Torres

DATA DA CIRURGIA: 13 / 06 / 2026

HOSPITAL: São Gabriel

JEJUM A PARTIR DE: 0h

ÁGUA, ÁGUA DE CÔCO OU SUCO S/ LEITE ATÉ: 7h

INTERNAR ÁS: 7h

Dr. Marcos Antônio Gomes Alves
Cirurgia Plástica
CRM 11305

DR MARCOS GOMES – (81) 98224.8202

@dr.marcos.gomes Clínica Dr. Marcos Gomes - Cirurgião Plástico

Complexo Médico de Caruaru: Av. Agamenon Magalhães, 1233 - 2º Andar - Sala 203 - Maurício de Nassau (81) 3137-1138 (81) 9 8286-4830
Hospital Antônio Targino: Rua Delmiro Gouveia, 369 - 5º andar - Sala 507 - Centenário - Campina Grande - PB (83) 9 8898-9474
Empresarial Agamenon Magalhães: Av. Agamenon Magalhães, 2656 - Sala 801 - Espinheiro - Recife - PE (81) 9 8801-2570

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26052921170618100000235353812
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052921170618100000235353812
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 29/05/2026 21:17:06

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU – PE

Proc. nº 0008172-04.2026.8.17.2480

MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, já qualificada nos autos do processo epigrafado, que tramita perante esta 5ª Vara Cível, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, com fundamento no art. 329, I, do Código de Processo Civil, vem, tempestivamente, antes da citação da Requerida, requerer o **ADITAMENTO** da petição inicial para acrescentar ao tópico *III — Preliminarmente* os subtópicos abaixo, **mantendo-se inalterados todos os demais fatos, fundamentos jurídicos e pedidos da exordial**, que não são objeto do presente aditamento:

1. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL

Ao tópico III da petição inicial (Preliminarmente — Da Hipossuficiência e da Gratuidade da Justiça), acrescentam-se os seguintes subtópicos:

III.1. Da legitimidade ativa da requerente

A Requerente, Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres, figura nos autos como beneficiária dependente do Plano ÚNICO (Proposta de Admissão nº 432912), cujo contrato foi celebrado pela titular Maria Lucimara da Silva junto à Unimed Caruaru em 26/10/2005. Antecipando eventual arguição de ilegitimidade ativa pela Requerida com fundamento de que o contrato foi celebrado pela titular e não pela beneficiária, a Requerente esclarece que sua legitimidade processual é plena, autônoma e incontroversa.

A legitimidade ativa da beneficiária dependente decorre diretamente de sua condição de destinatária final da cobertura contratual e de parte diretamente

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

atingida pela negativa. Foi a Requerente quem: (i) necessitou do procedimento cirúrgico indicado no laudo; (ii) sofreu a negativa de cobertura; (iii) arcou com os R$ 10.100,00 já desembolsados; e (iv) suportou o dano moral decorrente da conduta ilícita da operadora. É ela, portanto, a titular do direito material em discussão e a parte legítima para figurar no polo ativo.

A jurisprudência desta Egrégia Corte é expressa e inequívoca:

> *EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA.* ***ÚNICO NÚCLEO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO". EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL****. PRECEDENTES STJ E TJPE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AFASTAMENTO. REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTOS. ÍNDICES ANUAIS AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIARES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.* ***1. Os demandantes são beneficiários do plano de saúde coletivo, possuindo, portanto, legitimidade ativa para discutir quaisquer cláusulas contratuais que afetem seus direitos.***
>
> *2. Não há que se falar em prescrição da pretensão de revisão, mas tão somente dos valores pagos a maior anteriores ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.*
>
> *3. O plano de saúde que prevê cobertura para apenas seis vidas, integrantes do mesmo núcleo familiar, ainda que esteja travestido de contrato coletivo empresarial, assemelha-se em tudo a um contrato individual/familiar ou a um "falso coletivo", de modo que se aplicam a ele as normas aplicáveis aos planos individuais quanto aos percentuais de reajuste. Precedentes STJ e TJPE.*
>
> *4. Tratando-se de um contrato "falso coletivo" devem ser afastados os reajustes por sinistralidade e os anuais aplicados e incidir apenas os índices anuais autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares.*
>
> *5. Apelação que se nega provimento.*
>
> (TJ-PE - Apelação Cível: 0010049-29.2024.8.17.2001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: **01/03/2025**, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))
>
> *EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.* ***DEPENDENTE. LEGITMIDADE ATIVA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO****. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREVISÃO CONTRATUAL.*
>
> ***1. O dependente de plano de saúde ostenta a capacidade de ajuizar ação em que visa discutir a sua exclusão do plano indevidamente, ou o cumprimento de quaisquer de suas cláusulas contratuais, por ser o beneficiário final. Entendimento do STJ.***
>
> ***2. Tratando-se de contrato antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas as normas da legislação consumerista.***
>
> *3. Não há qualquer cláusula contratual que preveja a exclusão de dependente ao atingir maioridade ou por não ser mais dependente financeiramente, de maneira que se revela abusiva retirada dos agravados*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

do plano de saúde de seu genitor.

4. Ademais, incabível a alegação de exclusão pelo advento da cessação de dependência econômica, pois a parte autora já conta com 40 anos, de maneira que a inércia da seguradora gera expectativa legítima de ser mantida como dependente no plano de saúde do genitor, mediante pagamento das mensalidades. Supressio/surrectio.

5. Exclusão de dependente após período prolongado de tempo que caracteriza comportamento contraditório contrário à boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Precedentes.

6. Recurso não provido. Decisão unânime.

(TJPE, AI nº 0019647-59.2024.8.17.9000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, j. **23/07/2024**)

EMENTA - APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE DEPENDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. ABUSO DE DIREITO.DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para garantir a manutenção de dependente no contrato de assistência à saúde titularizado por sua genitora, independentemente da comprovação de dependência econômica após os 21 anos. A recorrente seguradora alegou ilegitimidade ativa da autora e a legalidade da exclusão contratual. Pugnou pela reforma da sentença também no tocante aos danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de dependente do plano de saúde em razão da maioridade e ausência de comprovação de dependência econômica; (ii) estabelecer se houve dano indenizável-moral e material- decorrente do ato da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3. A autora possui legitimidade ativa para discutir o vínculo contratual de que é beneficiária, ainda que o contrato tenha sido firmado por sua mãe. A jurisprudência reconhece legitimidade concorrente de dependentes em demandas que envolvam sua relação com o plano de saúde.

4. A súbita alteração das condições contratuais sem exigência de comprovação de dependência econômica viola os princípios da boa-fé objetiva e da legítima expectativa.

5. A cláusula contratual que rege a inclusão de dependentes não impõe, expressamente, a necessidade de comprovação de dependência financeira, sendo abusiva a interpretação restritiva realizada unilateralmente pela operadora de saúde.

6. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica aos contratos de plano de saúde, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvida, nos termos do art. 47 do CDC. 7. A operadora de saúde não demonstrou que a permanência do dependente causaria desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, limitando-se a alegar previsão contratual sem efetiva comprovação de prejuízo. 8. A exclusão imotivada do dependente viola a função social do contrato e compromete a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

continuidade da assistência à saúde, sendo abusiva e contrária à sua finalidade.

9. A de exclusão do plano com a efetiva concretização do dano, configura abalo moral passível de indenização. 10. Dano Material configurado e devidamente comprovado decorrente do cancelamento indevido do plano de saúde. Restituição devida.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0028705-34.2024.8.17.2001, Relator: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: **09/09/2025**, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º))

O primeiro precedente é particularmente preciso: o TJPE reconhece que o dependente tem capacidade para ajuizar ação visando ao cumprimento de *quaisquer* cláusulas contratuais do plano, por ser o beneficiário final, com fundamento no próprio entendimento do STJ. Essa tese abrange diretamente a negativa de cobertura objeto desta ação.

Vejamos o que o STJ sedimenta a esse respeito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO REVISIONAL. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADES. ***USUÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.*** *NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A OPERADORA. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. DEMONSTRAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.*

(...)

5. Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante (promissário) quanto o beneficiário podem exigir do promitente (ou prestador de serviço) o cumprimento da obrigação (art. 436, parágrafo único, do CC). Assim, na fase de execução contratual, o terceiro (beneficiário) passa a ser também credor do promitente.

6. Os princípios gerais do contrato amparam tanto o beneficiário quanto o estipulante, de modo que havendo no contrato cláusula abusiva ou ocorrendo fato que o onere excessivamente, não é vedado a nenhum dos envolvidos pedir a revisão da avença, mesmo porque as cláusulas contratuais devem obedecer a lei.

(...)

(STJ - REsp: 1510697 SP 2011/0229492-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

Ademais, os comprovantes de pagamento das mensalidades de fevereiro, março e abril de 2026, juntados com a inicial, demonstram que foi a própria Requerente quem efetuou os pagamentos em seu nome, reforçando seu vínculo direto e ativo com a relação contratual. Portanto, afasta-se de plano qualquer alegação de ilegitimidade ativa, por carecer de amparo fático, jurídico e jurisprudencial.

III.2. Do pedido subsidiário de inclusão de litisconsorte ativa facultativa (por máxima cautela)

Sem que isso implique qualquer reconhecimento de fragilidade na legitimidade ativa da Requerente, e **exclusivamente por máxima cautela processual**, requer-se, subsidiariamente, que, na **remota e improvável hipótese** de Vossa Excelência não reconhecer a plena legitimidade ativa da Requerente para propor esta demanda isoladamente, seja determinada a inclusão de **MARIA LUCIMARA DA SILVA**, brasileira, portadora do CPF nº 153.678.108-88, residente na Rua 17 de Dezembro, nº 210, Centro, Cachoeirinha/PE, no polo ativo da demanda na condição de litisconsorte ativa facultativa, nos termos do art. 113 do CPC.

Enfatiza-se que a inclusão da genitora no polo ativo é juridicamente desnecessária, conforme amplamente demonstrado no subtópico anterior.

A titularidade formal do contrato por Maria Lucimara da Silva não afasta a legitimidade ativa autônoma da Requerente, que é a beneficiária diretamente atingida pela negativa de cobertura.

O presente pedido é formulado exclusivamente para blindar o processo contra eventual incidente processual que, embora infundado, **pudesse retardar a apreciação do mérito e, sobretudo, o deferimento da tutela de urgência, providência cuja urgência é absolutamente incompatível com debates processuais protelatórios**.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

III.3. Do reforço da competência territorial — irrelevância do domicílio da titular para a fixação do foro

Por ocasião do recebimento da fatura de maio de 2026 emitida pela Requerida, que desde já requer sua juntada, conforme se observa, é dirigido à titular do contrato, Maria Lucimara da Silva, com endereço em Cachoeirinha/PE.

Esse fato, por si só irrelevante para os autos, poderia ser instrumentalizado pela Requerida para arguir incompetência territorial desta Comarca. A arguição, se eventualmente formulada, será destituída de qualquer fundamento, e o presente subtópico tem por finalidade antecipá-la e afastá-la.

A competência territorial desta Vara Cível da Comarca de Caruaru/PE está fundada no domicílio da *Requerente* (autora da ação), não no domicílio da titular do contrato.

São figuras jurídicas distintas: a titular do contrato é Maria Lucimara da Silva, que não é parte neste processo; a Requerente é Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres, **beneficiária dependente**, domiciliada na Avenida Aracaju, nº 784, Bairro Universitário, Caruaru/PE, conforme comprovante de residência acostado à inicial.

O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito de propor a ação no foro do seu domicílio. **O consumidor, neste caso, é a Requerente, domiciliada em Caruaru**.

O domicílio de quem não é parte no processo é completamente irrelevante para a fixação de competência. Acrescente-se que a Requerida tem sede em Caruaru (art. 53, III, do CPC), que todos os fatos desta demanda ocorreram em Caruaru, e que o foro eleito contratualmente (Garanhuns/PE) já foi expressamente impugnado na exordial como abusivo e sem vínculo algum com as partes ou os fatos.

A Câmara Regional de Caruaru deste Egrégio TJPE já afirmou que *"Em relações de consumo, o foro do domicílio do consumidor prevalece sobre cláusula contratual de eleição de foro"* (AI nº 0003617-27.2025.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

Pimentel, j. 10/12/2025). O consumidor, repita-se, é a Requerente, domiciliada em Caruaru. A competência desta Vara é plena e inatacável.

2. DA INCLUSÃO DOS NOVOS PEDIDOS

Dos pedidos do aditamento

Ante o exposto, requer a Requerente, em aditamento aos pedidos formulados na petição inicial, que permanecem inalterados:

a) O reconhecimento da plena legitimidade ativa da Requerente, Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres, beneficiária dependente diretamente atingida pela negativa de cobertura objeto desta demanda, para figurar no polo ativo como única autora, nos termos da jurisprudência do TJPE (AI nº 0019647-59.2024.8.17.9000);

b) Subsidiariamente, e apenas na remota hipótese de Vossa Excelência não reconhecer a legitimidade ativa isolada da Requerente, a inclusão de **MARIA LUCIMARA DA SILVA**, CPF nº 153.678.108-88, residente na Rua 17 de Dezembro, nº 210, Centro, Cachoeirinha/PE, no polo ativo da demanda na condição de **litisconsorte ativa facultativa** (art. 113, do CPC/15), com aproveitamento de todos os atos processuais já praticados;

c) O reconhecimento da plena competência desta Vara Cível da Comarca de Caruaru/PE para processar e julgar o feito, com rejeição de qualquer arguição de incompetência territorial

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

fundada no domicílio da titular do contrato, que não é parte neste processo;

d) A juntada aos autos da fatura de maio de 2026 emitida pela Unimed Caruaru, ora acostada como documento complementar, que identifica a Requerente como beneficiária do plano.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Caruaru/PE, 31 de maio de 2026.

Melquisedeque S. De Lima

OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26053115513854000000235382967
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26053115513854000000235382967
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 31/05/2026 15:51:38

Fique ligado!

INFORME **UNIMED CARUARU**

• ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Prezado(a) cliente, você mudou de telefone, endereço, e-mail ou qualquer outro dado cadastral? Procure nosso atendimento presencial na Av. Agamenon Magalhães, 426 – Maurício de Nassau, Caruaru/PE ou nos envie um e-mail para cadastro@unimedcaruaru.com.br e realize sua atualização cadastral.

• EMISSÃO DE BOLETOS

Informamos que para melhor atendê-lo, dispomos de canais para emissão de boletos de forma online;
– Telefone ou WhatsApp (81) 2103–5000;
– App Unimed Caruaru Cliente;
– Portal Unimed Caruaru (https://www.unimedcaruaru.coop.br)
– Caso deseje, se cadastre para receber seu boleto por e-mail; Solicite através do e-mail: cadastro@unimedcaruaru.com.br;

• REAJUSTE DOS PLANOS

Prezado(a) contratante,

Reajuste dos planos individuais: De acordo com o ofício da ANS Nº 252/2025/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, datado em 23/06/2025, o percentual máximo de reajuste dos planos individuais ou familiares de assistência médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, será de 6,06%, válido para o período entre maio/2025 a abril/2026.

Ainda segundo a ANS, para os contratos com aniversário em maio, junho e julho, será permitida aplicação retroativa do reajuste, na forma prevista pela RN no 171/2008.

Reajuste dos planos empresariais: Os percentuais de reajuste ficarão limitados ao que estiver estabelecido no contrato.

O reajuste aplicado aos contratos individuais ou familiares celebrados antes de 1º de Janeiro de 1999 e não adaptados à Lei no 9.656/98 (planos antigos), fica limitado ao que estiver estipulado no contrato.

• REAJUSTE DOS VALORES DE FRANQUIA:

Informamos que as tabelas de franquias (valor cobrado no ato do atendimento aos beneficiários da Unimed Caruaru, cujo contrato possua essa modalidade) sofrerão reajustes de 6,06%, para os atendimentos ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2026.

As referidas tabelas já se encontram disponibilizadas na Área do Beneficiário no nosso portal na internet (www.unimedcaruaru.com.br).

IMPORTANTE: A partir de 01 de janeiro de 2026, solicite o seu recibo com QR Code no ato do pagamento da franquia. Dessa forma, você poderá conferir seus dados e o valor pago com mais segurança.

• DESCREDENCIAMENTO:

Informamos o descredenciamento do prestador: CENTRO ESPECIALIZADO EM ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – CNPJ 02.364.221/001-74, Caruaru/PE.
O referido prestador integrará a nossa rede credenciada até o dia 01/03/2026 e será substituído pelo seguinte prestador: UNILAB LABORATÓRIO – UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – CNPJ 24.449.225/0003-50, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, nº 1301-A, bairro Maurício de Nassau, Caruaru/PE – Contato: (81) 2103-5000.

Em caso de qualquer dúvida, pedimos que entre em contato com a Unimed Caruaru, através do telefone/WhatsApp (81) 2103-5000.

Unimed Caruaru

2025 Ano Internacional das Cooperativas
Cooperativas constroem um mundo melhor

somos coop

CNPJ: 24.449.225/0001-98
Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Caruaru Corporate,
3° Andar - 55024-740 Indianópolis, Caruaru-PE
T. 81 2103-5000 **www.unimed.coop.br/caruaru**
/UnimedCaruaruOficial

Cliente

MARIA LUCIMARA DA SILVA

17 DE DEZEMBRO 210 CASA - CENTRO - CACHOEIRINHA - PE - 55380-000

Vencimento

30/05/2026

Valor

R$ 305,74

Detalhes fatura

Descrição	Beneficiário	Planos	Valor	Total
MENSALIDADE	MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PERE	1745019481769000	R$ 305,74	R$ 305,74

Registro ANS: 471341149

Reajuste:

Para visualização da relação completa de beneficiários contidos em contrato, contactar o setor financeiro da Unimed Caruaru.

Avisos importantes

Lembrando que de acordo com o inciso II do Art. 13, da lei 9656/98, atraso superior a 60 dias consecutivos ou não, poderá acarretar no cancelamento do contrato, desde que notificado, sendo permitida a cobrança das mensalidades em aberto até a solicitação expressa de cancelamento do contrato.

De acordo com ofício Nº 252/2025/GEAP/GGREP/DIPRO/ANS da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste para os planos individuais e familiares para o período entre Maio de 2025 e Abril de 2026 será de 6,06%. Os contratos firmados com PJ sofrerão reajuste de acordo com o cálculo atuarial, conforme cláusula contratual art. 74.1 de contrato ou IGP-M acumulado

Documento	Vencimento	Valor

Atraso total: 0,00

Descrição

Item	Descrição	Quantidade	Valor
1	MENSALIDADE	1	R$ 305,74

Unimed Caruaru

CNPJ: 24.449.225/0001-98
Av. Adjar da Silva Casé, 800 - Caruaru Corporate,
3° Andar - 55024-740 Indianópolis, Caruaru-PE
T. 81 2103-5000 **www.unimed.coop.br/caruaru**
/UnimedCaruaruOficial

Cliente

MARIA LUCIMARA DA SILVA - 153.678.108-88

17 DE DEZEMBRO 210 CASA - CENTRO - CACHOEIRINHA - PE - 55380-000

Vencimento

30/05/2026

Valor

R$ 305,74

Pague com Pix

Leia o QR Code com o aplicativo do seu banco

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse

PIX COPIA E COLA:

00020101021226820014BR.GOV.BCB.PIX2560api.itau/pix/qr/v2/cobv/d0821b31-1381-493a-a19a-a13a08825754520400005303986580 2BR5914UNIMED CARUARU6007CARUARU62070503**

Itaú | 341 | 34191.09255 37374.837880 81054.390000 7 14620000030574

Beneficiário

UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | CNPJ: 24.449.225/0001-98

Data do documento	Nr. do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso número
13/05/2026	25373748	7888.788800105439	109253737483

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M.

Vencimento 30/05/2026

Valor R$ 305,74

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

MARIA LUCIMARA DA SILVA 153.678.108-88

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

Processo nº **0008172-04.2026.8.17.2480**

AUTOR(A): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DESPACHO

Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre o pedido de tutela de urgência. Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Caruaru-PE, 01/06/2026.

Elias Soares da Silva

Juiz de Direito

DIRETORIA DAS VARAS CÍVEIS DA REGIÃO METROPOLITANA E DO INTERIOR

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837

5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru
Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480
AUTOR(A): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

INTIMAÇÃO

Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru, fica(m) a(s) parte(s) intimada(s) do teor do Despacho de ID 242085446, conforme segue transcrito abaixo:

"(...) Intime-se a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, falar sobre o pedido de tutela de urgência. Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Caruaru-PE, 01/06/2026. (...)"

CARUARU, 9 de junho de 2026.

IARA CELLI ALVES DE ARAUJO

Diretoria das Varas Cíveis da Região Metropolitana e do Interior

5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru
Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480

CERTIDÃO

Registro, para os devidos fins, que houve ciência expressa de citação/intimação por meio do Domicílio Judicial Eletrônico.

CARUARU, 19 de junho de 2026.

AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480
Autor(a): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Réu: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 24.449.225/0001-98, com sede na Av. Adjar da Silva Casé, 800, Edf. Caruaru Corporate, 3º andar, Indianópolis, Caruaru/PE, representada por seu presidente, Pedro José de Oliveira Melo, médico, inscrito no CPF sob o nº 226.455.784-20, residente e domiciliado na Av. Marcionilo Francisco da Silva, nº 198, Apt. 402, Caruaru/PE, por meio dos seus advogados legalmente constituídos, conforme procurações e substabelecimentos anexos **(docs. 01 e 02)**, com endereço profissional na Av. Adjar da Silva Casé, 800, Edf. Caruaru Corporate, 3º andar, Indianópolis, Caruaru/PE, vem, a presença de Vossa Excelência, **requerer a juntada dos documentos em anexo para fins de habilitação**.

Requer, também, que todas as publicações sejam realizadas em nome do **Salomão Francisco Alves Filho**, OAB/PE 27.989 e **José Lucas Romano da Luz**, OAB/PE 60.980, sob pena de nulidade.

Os patronos da empresa requerente atestam, sob sua responsabilidade, que as cópias dos documentos colacionados aos autos são autênticas e foram extraídas dos originais, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Caruaru (PE), data da assinatura eletrônica.

Salomão Francisco Alves Filho

OAB/PE 27.989

José Lucas Romano da Luz

Unimed Caruaru

www.unimed.coop.br/caruaru
Av. Adjar da Silva Casé, 800, Caruaru Corporate,
3º andar, 55024-740, Indianópolis, Caruaru - PE
T. (81) 2103-5000

FSC

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica portadora do CNPJ sob o nº 24.449.225/0001-98, estabelecida à Avenida Adjar da Silva Casé, 800- Caruaru Corporate, 3ª andar, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE, ora representada por seu Presidente PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MELO, CRM nº 8722, RG nº 1.436.660 SSP/PE, CPF nº 226.455.784-20, residente e domiciliado na Av. Marcionilo Francisco da Silva, nº198, Apt. 402, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP nº 55.000-000.

OUTORGADOS: SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO, inscrito na OAB/PE sob o nº 27.989 e **SAMIR DE SIQUEIRA ALVES**, inscrito na OAB/PE nº 27.990,todos com endereço profissional na Avenida Adjar da Silva Casé, 800- Caruaru Corporate, 3ª andar, Bairro Indianópolis, Caruaru-PE, para envio das correspondências de costume.

PODERES: Específicos da Cláusula **"AD JUDICIA ET EXTRA"**, a quem confere amplos poderes para o Foro em geral, para propositura de demandas judiciais e/ou administrativas visando os interesses da outorgante, devendo ainda defendê-la nas contrárias, seguindo umas as outras, e, podendo para tanto, recorrer a qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, agindo em conjunto ou separadamente, podendo assinar, discordar, concordar, transigir, substabelecer, desistir, receber e dar quitação, dando tudo por bom, firme e valioso, para o fiel cumprimento deste mandato.

Caruaru, 15 de maio de 2025.

Pedro José de Oliveira Melo
Presidente da Unimed Caruaru

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123230300000239055235
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123230300000239055235
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Unimed Caruaru
www.unimed.coop.br/caruaru
Av. Adjar da Silva Casé, 800, Caruaru Corporate,
3º andar, 55024-740, Indianópolis, Caruaru - PE
T. (81) 2103-5000

FSC

SUBSTABELECIMENTO

Por esse instrumento particular de substabelecimento de procuração, Salomão Francisco Alves Filho, inscrito na OAB/PE nº 27.989 e Samir de Siqueira Alves, inscrito na OAB/PE nº 27.990, com endereço comercial na Avenida Adjar da Silva Casé, 800 – Caruaru Corporate – 3º Andar – Indianópolis, Caruaru/PE, **SUBSTABELECEM** com reserva o advogado: **José Lucas Romano da Luz**, com registro na OAB/PE nº 60.980, os poderes que lhes foram outorgados pela Unimed Caruaru Cooperativa de Trabalho Médico, nos autos do processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480, para que possa atuar em conjunto com subscritores.

Ressalva-se que todas as publicações e/ou intimações do processo em tela, deverão ocorrer em nome do advogado SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO – OAB/PE nº 27.989 e do advogado José Lucas Romano da Luz, com registro na OAB nº 60.980, sob pena de nulidade do ato processual.

Caruaru, 07 de julho de 2026.

Salomão Francisco Alves Filho
OAB/PE nº 27.989

Samir de Siqueira Alves
OAB/PE nº 27.990

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123254600000239055236
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123254600000239055236
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024.

Aos três dias do mês de fevereiro de 2024 realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Unimed Caruaru - Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 24.449.225/0001-98, Número de Identificação de Registro de Empresa – NIRE – nº 26400000875. Para todos os fins legais, a assembleia geral será considerada como realizada na sede da cooperativa, situada à na Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800 – bairro Indianópolis, Caruaru - PE, 55024-740 – Caruaru Corporate – Térreo e 3º Andar. A Assembleia teve início às 09:00h, em terceira e última convocação, compondo-se a mesa pelo Dr. Pedro José de Oliveira Melo, Diretor Presidente da Unimed Caruaru. Na oportunidade também esteve presente o Cooperado Dr. Alexandre Bezerra de Souza Junior, que fora designado como secretário da Assembleia Geral Extraordinária e o Assessor Jurídico Dr. Salomão Francisco Alves Filho. Devidamente composta a mesa, foi passada a palavra o Diretor Presidente que deu boas-vindas a todos os presentes, esclareceu como serão conduzidos os trabalhos e passou a fazer a leitura do Edital de Convocação da AGE, publicado no Jornal do Comércio, no dia 23 de janeiro de 2024, nos seguintes termos: "**UNIMED CARUARU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 24.449.225/0001-98 – NIRE: 26400000875 – Registro ANS: 340952. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES A **UNIMED CARUARU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, através do seu Diretor-Presidente, em estrito respeito ao Estatuto Social, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 44 e artigo 50, inciso I do referido diploma, nos termos da lei nº 5.764/71, convoca os sócios regularmente inscritos para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária (AGE)** a ser realizada na cidade de Caruaru-PE, no **Teatro Difusora**, situado à Avenida Agamenon Magalhães, nº 444, bairro Maurício de Nassau, CEP 55.012.290, Caruaru (PE), em virtude da falta de espaço físico na sede da cooperativa para acolher confortavelmente

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

todos os cooperados, **no dia 03 de fevereiro de 2024 (sábado)**, às 07:00h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 08:00h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; e às 09:00h em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo, 10 (dez) cooperados em condições de votar, a fim de deliberar sobre os seguintes itens: **ORDEM DO DIA**

1. Votar a reforma do Estatuto Social – em atendimento as boas práticas de governança impostas pela Resolução ANS n. 518/2022 –, aprovando ou rejeitando, as propostas e as redações dispostas em bloco para os dispositivos estatutários disponibilizadas aos cooperados pelos canais oficiais da cooperativa, podendo ser apresentado destaque, por qualquer Cooperado, a artigos, parágrafos, incisos e alíneas, observando a seguinte ordem de votação em Blocos, consoante disposição a seguir: **Bloco 1** – Regulatório - Capítulos I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII e XIV; **Bloco 2** – Governança - Capítulos IX e XI; **Bloco 3** – Processo Eleitoral - Capítulo VIII; **Bloco 4** – Cooperados - Capítulo III; **Bloco 5** – Transição - Capítulo XV.
2. Consolidar o Estatuto Social recém alterado, renumerando e padronizando, se necessário, títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos e alíneas, inclusive suas respectivas citações, tendo como referência a Lei Complementar nº 95/1998, bem como efetuar revisão ortográfica e gramatical, contudo, sem modificar o sentido dos dispositivos estatutários aprovados. ***Observações:***

a) *Conforme determina o artigo 47, inciso IV do Estatuto Social da Cooperativa e o artigo 45 da Lei 5.764/1971, a presente Assembleia Geral se restringirá, exclusivamente, à ORDEM DO DIA supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação;*

b) *Conforme determina o artigo 50, inciso I, §1º do Estatuto Social da Cooperativa e o parágrafo único do artigo 46 da Lei 5.764/1971, serão necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes, em cada votação, para tornarem válidas as deliberações de que tratam este edital de convocação;*

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

c) *As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto Social da Cooperativa vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes;*

d) *Para fins de quórum, o número de cooperados aptos a votar na presente data é de 408 (quatrocentos e oito) cooperados.* Caruaru (PE), 23 de janeiro de 2024. UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MELO. Diretor Presidente.".

Em continuidade aos trabalhos o Dr. Pedro Melo instou a Assembleia a deliberar sobre a forma da votação, devendo ser secreta ou aberta, se assim a AGE decidir. Na ocasião foi decidido por unanimidade em realizar a votação aberta. Na sequência foi proposto por Dr. Pedro Melo as seguintes regras de convivência: a) A votação será em blocos conforme o Edital; b) A leitura dos artigos, parágrafos e incisos não deverá ser interrompida até o seu final; c) Durante a leitura dos artigos, parágrafos e incisos, a plenária poderá se manifestar com a frase. "destaque para o... "(artigos, parágrafos, incisos e alíneas); d) Finda a leitura poderá haver defesa do autor, (3 min.); réplica (2 min. e tréplica (2 min.; e) Ao final do debate, a proposta será encaminhada para votação no bloco com exceção do destaque quando houver; f) Havendo destaque, após a votação do bloco, será feita a defesa por quem destacou; a contestação pelo autor e em seguida o encaminhamento para votação; g) Caso não haja destaque, nem proposta encaminhada, a aprovação ou reprovação poderá ser feita por contraste; h) O arredondamento para o quórum de aprovação ocorrerá do seguinte modo: até 0,5 para menos, a partir de 0,6 para mais; i) O quórum presencial não sofrerá alteração quando instalado e enquanto durar o regime de votação. A observância destas regras permitirá que tenhamos um bom debate, que evitemos o embate e que transformemos a nossa assembleia em um combate. Isto posto, não deverá haver nem vencidos nem vencedores. Todas as regras de convivência postas foram aprovadas pela Assembleia. Em seguida, para cumprimento da ordem do dia, Dr. Pedro Melo passou a realizar a leitura do **Bloco 01 – Regulatório - Capítulos I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII E XIV**. **Durante a leitura dos artigos, foi apresentado destaque pelo cooperado**

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

ao artigo 64 do Capítulo VII da Proposta única da Diretoria. Após a leitura das propostas, o Dr. José Alves solicitou esclarecimentos quanto ao procedimento de apresentação de destaque, bem como informou que enviou sugestões de propostas por e-mail, de modo que requereu a inclusão das suas propostas para discussão pela plenária. Dr. Pedro Melo esclareceu que o envio das sugestões do Dr. José Alves ocorreu, no dia 24/01/2024, em momento posterior a publicação do Edital de Convocação da AGE, ocorrido em 23/01/2024, de modo que não era mais possível proceder com a inclusão de novas propostas, sob pena de ferimento às disposições contidas no Edital de Convocação da AGE, especialmente no que se refere a observação descrita na alínea "a" do Edital de Convocação. Ato seguinte, o quórum de votação foi devidamente instalado com 155 (cento e cinquenta e cinco) cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **155 (cento e cinquenta e cinco)** Cooperados votaram pela aprovação da Proposta única da Diretoria relativo aos capítulos I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII E XIV, houve **0 (zero)** voto pela reprovação e **0 (zero)** abstenção. Foi apresentado destaque ao artigo 64 do Capítulo VII da Proposta única da Diretoria pelo Cooperado Dr. João Rodrigues. Após esclarecimentos, foi instalado o quórum de votação com cooperados aptos a votar no montante **155**. Submetida a votação, **155 (cento e cinquenta e cinco)** cooperados votaram pela aprovação do artigo 64 do Capítulo VII da Proposta Única da Diretoria, houve **0 (zero)** reprovação e **0 (zero)** abstenção. **Portanto, a Assembleia aprovou, por unanimidade, a Proposta única da Diretoria para reforma do Estatuto referente aos capítulos I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII E XIV**.

Em seguida, Dr. Pedro Melo iniciou **o Bloco 02 – Governança -** com a leitura das propostas do capítulo IX, contendo a Proposta 01 da Diretoria e a Proposta 02 do Comitê Independente, além da leitura do Capítulo XI contento a Proposta única da Diretoria. **Durante a leitura dos artigos, foi apresentado destaque pelo cooperado Dr. José Alves aos artigos 88 §4º; 95, incisos XV e XVI; 97, I; 102, parágrafo único e 106, *Caput*, todos relativos a Proposta 01 da Diretoria**. Após a leitura integral das propostas e realizados os devidos esclarecimentos, foi instalado o quórum

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

de votação com **152 (cento e cinquenta e dois)** cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **137 (cento e trinta e sete)** cooperados votaram pela aprovação da **Proposta 01 da Diretoria**, **15 (quinze)** votaram pela aprovação da proposta **02 do Comitê Independente** e houve **0 (zero)** abstenção. Em seguida, passou-se aos debates relativos aos destaques realizados pelo Dr. José Alves. O Dr. José Alves obteve esclarecimentos quanto ao artigo 88, parágrafo 4º da Proposta 01 da Diretoria; e optou por retirar o destaque, de modo que a Assembleia ratificou a aprovação dos artigos com a votação já realizada para o Bloco 02. Ato seguinte foi instalado o quórum de votação para o destaque do artigo 95, incisos XV e XVI da Proposta 01 da Diretoria com 152 (cento e cinquenta e dois) cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **136 (cento e trinta e seis)** cooperados votaram pela aprovação da Proposta 01 da Diretoria, **16 (dezesseis)** cooperados votaram pela reprovação da Proposta 01 da Diretoria e houve **0 (zero)** abstenção. Em seguida, o Dr. José Alves obteve esclarecimentos quanto aos artigos 97, inciso I e 102, parágrafo único, ambos da Proposta 01 da Diretoria; e optou por retirar os destaques, de modo que a Assembleia ratificou a aprovação dos artigos com a votação já realizada para o Bloco 02. Ato contínuo, foi instalado o quórum de votação para o destaque do artigo 106, *Caput* da Proposta 01 da Diretoria com 152 (cento e cinquenta e dois) cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **148 (cento e quarenta e oito)** cooperados votaram pela aprovação da Proposta 01 da Diretoria, **03 (três)** cooperados votaram pela reprovação da Proposta 01 da Diretoria e houve **0 (zero)** abstenção. **Portanto, a Assembleia aprovou, por quórum superior a 2/3 dos votos, a Proposta 01 da Diretoria para reforma do Estatuto referente aos capítulos IX e XI.**

Em seguida, Dr. Pedro Melo deu início ao **Bloco 03 – Do Processo Eleitoral – Capítulo VIII** com a leitura integral da Proposta 01 da Diretoria e da Proposta 02 do Comitê Independente. Após a leitura integral das propostas e realizados os devidos esclarecimentos, não havendo destaques, foi instalado o quórum de votação com **124 (cento e vinte e quatro)** cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **112 (cento e doze)** cooperados votaram pela aprovação da **Proposta 01 da Diretoria**, **10 (dez)**

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

votaram pela aprovação da **Proposta 02 do Comitê Independente** e **02 (dois)** se abstiveram. **Portanto, a Assembleia aprovou, por quórum superior a 2/3 dos votos, a Proposta 01 da Diretoria para reforma do Estatuto referente ao capítulo VIII.**

Ato seguinte, Dr. Pedro Melo deu início ao **Bloco 04 – Cooperados – Capítulo III -** com a leitura integral da Proposta única da Diretoria. Após a leitura integral das propostas e realizados os devidos esclarecimentos, não havendo destaques, foi instalado o quórum de votação com **135 (cento e trinta e cinco)** cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **133 (cento e trinta e três)** cooperados votaram pela aprovação da **Proposta única da Diretoria**, houve **0 (zero)** voto de reprovação e **02 (dois)** se abstiveram. **Portanto, a Assembleia aprovou, unanimidade, a Proposta única da Diretoria para reforma do Estatuto referente ao capítulo III.**

Por fim, Dr. Pedro Melo deu início ao **Bloco 05 – Transição – Capítulo XV -** com a leitura integral da Proposta única da Diretoria. Após a leitura integral das propostas e realizados os devidos esclarecimentos, não havendo destaques, foi instalado o quórum de votação com **118 (cento e dezoito)** cooperados aptos a votar. Submetida a votação, **117 (cento e dezessete)** cooperados votaram pela aprovação da **Proposta única da Diretoria**, houve **0 (zero)** voto de reprovação e **01 (uma)** abstenção. **Portanto, a Assembleia aprovou, unanimidade, a Proposta única da Diretoria para reforma do Estatuto referente ao capítulo XV.**

Após votação em Assembleia dos 5 (cinco) blocos e apurados os votos de no mínimo 2/3 dos cooperados, em consonância com o artigo 46, inciso I, parágrafo único da Lei 5.764/71, o Estatuto passará a ter a seguinte redação:

ESTATUTO SOCIAL DA UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, aprovado em A.G.C. de 16.11.1989, alterado em A.G.E. de 04.08.1995, alterado em A.G.E. de 30.03.1996, nova redação e alteração em A.G.E. DE 02.12.2000, alterado em A.G.E. de 25.04.2002, alterado e Consolidado em 22.03.2003, alterado em A.G.E. de 22.12.2004, alterado em A.G.E. de 24.10.2005, alterado em A.G.E. de 21.06.2006, alterado em A.G.E de 27.11.2006, alterado em A.G.E. de 30.08.2007, alterado em A.G.E. de 27.09.2007, alterado em A.G.E. de 27.10.2008, alterado em A.G.E. de 08.06.2009, alterado em A.G.E. de 27.09.2011, alterado em A.G.E. de

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

27.05.2014, alterado em A.G.E. de 31.08.2015, alterado em A.G.E de 18.04.2016, alterado em A.G.E de 30.01.2018, alterado e consolidado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de fevereiro de 2024.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO – SEDE – FORO - PRAZO DE DURAÇÃO E ANO SOCIAL – ÁREA DE AÇÃO E ADMISSÃO – SÍMBOLO

Art. 1º. A UNIMED CARUARU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA é uma sociedade cooperativa de natureza civil (cooperativa simples de responsabilidade limitada), formada exclusivamente por médicos, sem fins lucrativos, constituída para prestar serviços aos cooperados, regida pelo presente estatuto, pelo seu regimento interno e pela legislação brasileira que lhe é aplicável, em especial as Leis de n.º 5.764 de 16.12.1971; 9.656 de 03.06.1998; e 10.406 de 10.01.2002, com registros no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 24.449.225.0001/98 e na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 34095-2.

Art. 2º. A cooperativa tem como sede administrativa e foro jurídico a cidade e comarca de Caruaru, estado de Pernambuco, e está situada na Avenida Adjar da Silva Casé, 800, Edifício Caruaru Corporate, Térreo e 3º Andar, bairro Indianópolis, CEP – 55.024-740.

Parágrafo único. Cabe ao Conselho de Administração fixar o endereço da cooperativa, respeitados a sede e o foro definidos neste artigo.

Art. 3º. O prazo de duração da cooperativa é indeterminado e o ano social é compreendido entre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Art. 4º. A área de ação e de admissão dos sócios compreende as seguintes cidades:

Agrestina, Águas Belas, Altinho, Angelim, Barra de Guabiraba, Belém de Maria, Belo Jardim, Brejo da Madre de Deus, Bezerros, Bom Conselho, Bonito, Brejão, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Caruaru, Catende, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Caetés, Correntes, Cumaru, Cupira, Frei Miguelinho, Garanhuns, Gravatá, Iati, Itaíba, Ibirajuba, Jataúba, Jucati, Jupi, Lagoa dos Gatos, Lagoa do Ouro, Lajedo, Limoeiro, Panelas, Palmares, Palmeirina, Paranatama, Passira, Quipapá, Riacho das Almas, Sairé, Saloá, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Maria do Cambucá, São Bento do Una, São Caitano, São Joaquim do Monte, São João, Surubim, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Toritama e Vertentes.

Art. 5º. A cooperativa terá como logomarca o pinheiro divulgado pela Unimed do Brasil e utilizado por todas as Unimeds.

CAPÍTULO II

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

DOS OBJETIVOS DA COOPERATIVA

Art. 6º. A cooperativa promoverá a educação cooperativista e participará das campanhas de expansão do cooperativismo e da modernização de suas técnicas bem como fortalecerá e atualizará profissionalmente os cooperados, por intermédio da disseminação dos conhecimentos oriundos do ensino, pesquisa e de trabalhos técnico-científicos.

Art. 7º. A cooperativa tem como objetivo a defesa econômica e social do trabalho de seus cooperados, através do aprimoramento das condições para o exercício da medicina.

§ 1º. No cumprimento da sua missão, a cooperativa poderá assinar, em nome dos cooperados, contratos com hospitais, clínicas, laboratórios e outros serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento ou optar por operar com serviços próprios não médicos, tais como psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia, dentre outros, assim como firmar contratos de prestação de serviços de assistência à saúde com pessoas físicas e jurídicas, sob as formas coletiva, familiar ou individual, visando, com isso, assegurar trabalho aos cooperados.

§ 2º. No cumprimento de suas finalidades, a cooperativa poderá também adquirir quaisquer serviços próprios indispensáveis para o desempenho do ato médico complementar mediante aprovação da assembleia geral.

§ 3º. Os cooperados executarão os serviços concedidos pela cooperativa, em seus estabelecimentos individuais, em sua sede social, nos serviços próprios e/ou credenciados, observando o princípio da livre oportunidade, além de obedecer ao Código de Ética Médica.

Art. 8º. Além do disposto no artigo anterior, a cooperativa objetivará com base na colaboração recíproca a que se obrigam os cooperados:

I – contratar serviços de interesse para seus cooperados em condições e preços convenientes;

II – realizar, em benefício dos cooperados interessados, seguros de vida, de incapacidade para o trabalho, dentre outros;

III – adquirir bens necessários para a realização das ações e operações propostas, inclusive produtos ou materiais complementares a assistência à saúde de seus beneficiários;

IV – operar com serviços próprios na área de segurança e medicina do trabalho;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

V – exercer função social dentro da cooperativa na qual está inserida, incluindo a responsabilidade social como forma de gestão estratégica e de negócio, com o intuito de contribuir de forma ética e transparente para ajudar a melhorar as condições sociais e ambientais nos municípios da sua área de ação.

Art. 9º. Nos contratos celebrados pela cooperativa, esta representará os cooperados na qualidade de mandatária.

Parágrafo único. A cooperativa estará autorizada a propor ações civis públicas para a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de seus cooperados, desde que a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos cooperados, que tenham relação com as operações de mercado da cooperativa e haja autorização expressa manifestada individualmente pelos cooperados ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida judicial, conforme disposto no Art. 88-A da Lei 5.764/1971.

Art. 10. A cooperativa poderá fornecer serviços e bens a não cooperados desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais.

Art. 11. A cooperativa atuará, sempre, com neutralidade política e sem discriminação sexual, racial, religiosa ou social.

Art. 12. A cooperativa poderá se associar a outras cooperativas, federações ou confederações de cooperativas ou, ainda, a outros tipos societários, visando sempre à defesa econômico-social dos seus cooperados e à consecução plena dos seus objetivos.

Parágrafo único. A cooperativa se obriga a disponibilizar para a Federação a qual estiver associada todas as informações necessárias para monitoramento por indicadores bem como submeter-se a auditoria na forma disposta pela referida Federação.

CAPÍTULO III

DOS COOPERADOS

Seção I

Da Admissão do Cooperado

Art. 13. Podem associar-se à UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços por parte desta, entendida como insuficiência de demanda de serviços médicos cooperativos, os médicos que preencham os requisitos infradescritos, atendendo os critérios de ingresso, preenchendo a proposta de admissão fornecida pela cooperativa, assinando-a em companhia de três cooperados

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

apresentantes, que será encaminhada ao presidente do Conselho de Administração para as providências necessárias.

§ 1º. Será considerada impossibilidade técnica de prestação de serviços, mencionada no caput deste artigo, a suficiência de profissionais em determinada especialidade, calculada e decidida pelo Conselho de Administração, sob a consultoria de empresa especializada e ouvido previamente o Comitê de Especialidades Médicas.

§ 2º. Atende ao requisito do título de especialista, exigido no caput deste artigo, um dos seguintes documentos:

I – certificado de conclusão de residência médica em programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação, na especialidade que o cooperado pretenda exercer dentro da cooperativa;

II – título de especialista expedido pela Associação Médica Brasileira na especialidade que o cooperado pretende exercer dentro da cooperativa;

III – título de especialista expedido pela Sociedade Médica Brasileira da especialidade que o cooperado pretenda exercer dentro da cooperativa, com registro no Conselho Regional de Medicina.

§ 3º. As especialidades e áreas de atuação serão aquelas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina ou Associação Médica Brasileira e Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação.

§ 4º. O ingresso de novos cooperados ocorrerá sempre de acordo com a possibilidade técnica de prestação de serviços nos termos do caput e parágrafo primeiro deste artigo e no caso de necessidade técnica da prestação de serviços, sendo que o número de vagas será definido em edital a cada processo de ingresso, podendo ser realizada ou não seleção de provas e títulos.

§ 5º. Será considerada necessidade técnica da prestação de serviços a ocorrência de vazio assistencial, assim entendido como a inexistência de número suficiente de médicos disponíveis para atender imediatamente a demanda dos clientes em determinada especialidade médica ofertada dentro da área de cobertura contratada, conforme determina a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

§6º. Para os médicos que apresentarem diplomas expedidos por instituições estrangeiras de ensino superior, será exigida aprovação no Revalida.

§7º. A realização do processo seletivo será feita por empresa independente contratada pela cooperativa.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

§8º. O conteúdo do exame, a forma de aplicação e avaliação, os critérios de exclusão dos candidatos e as regras para convocação serão divulgados no edital de convocação, previamente aprovado pelo Conselho de Administração da cooperativa.

§9º. Os médicos filhos dos cooperados que desejarem associar-se, cumpridas as exigências legais, não serão submetidos à seleção prevista neste artigo.

§10º. Excepcionalmente, a cooperativa facultará a associação de médico que exerça suas atividades na área de ação frisada no artigo 4º deste estatuto, sem residência fixa, em função de preservar a cobertura dos serviços médicos aos usuários dos planos de saúde.

§11º. O número de cooperados, observadas as disposições estatutárias, é ilimitado quanto ao máximo, obedecidas as necessidades do mercado e a avaliação econômico-financeira realizada por empresa específica contratada para este fim.

§12º. Não será admitida, sob nenhuma condição, pessoa jurídica como associada.

Art. 14. Para se tornar cooperado, o candidato deve apresentar a proposta de admissão preenchida e com as devidas assinaturas, devendo instruí-la com os seguintes documentos:

I – cópia do diploma de conclusão do curso de medicina devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;

II – cópia da inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco;

III – título de especialista na forma do parágrafo §2º, incisos II e III do artigo 13;

IV – cópia de documento de identidade, CPF válido bem como fornecimento dos números do NIT e PIS/PASEP;

V – duas fotos 3x4;

VI – certidão negativa de condenação ético-profissional expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco;

VII – apresentar certificado de conclusão do Curso de Formação Básica em Cooperativismo pelo SESCOOP/PE ou similar;

VIII – apresentar os documentos do consultório, se houver (alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária e CNES);

IX – Declaração de plena ciência e concordância com os termos do estatuto social e

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

demais regulamentações internas da cooperativa.

Parágrafo único. A proposta de admissão abonada por três cooperados da especialidade mencionada no caput deste artigo poderá ser dispensada pelo Conselho de Administração na hipótese de necessidade técnica da prestação de serviços ou em caso de ausência do número de especialistas na cooperativa.

Art. 15. Deferida a proposta de admissão, seja por possibilidade ou necessidade técnica da prestação de serviços, o candidato aprovado ingressará na cooperativa em regime de estágio probatório pelo prazo de três anos, contados do deferimento da proposta, durante o qual seu desempenho será avaliado pelos critérios abaixo mencionados, sem prejuízo de outros que possam ser definidos em regimento interno:

I – condutas ético-disciplinar e técnica;

II – cumprimento do estatuto social, regimento interno, decisões assembleares e demais normas internas da cooperativa editadas pelo Conselho de Administração;

III – pontualidade nos deveres financeiros com a cooperativa;

IV – observância das diretrizes emitidas pelo Comitê de Especialidades Médicas;

V – presença em 100% (cem por cento) das assembleias gerais da cooperativa, salvo ausência justificada por motivo de força maior, devidamente comprovada, no prazo máximo de 15 dias contados da realização da assembleia;

VI – disponibilidade da agenda para atendimentos dos clientes Unimed.

§ 1º. Em até 120 dias antes do encerramento do período do estágio probatório, o Conselho Técnico emitirá uma avaliação de desempenho, na qual recomendará ao Conselho de Administração a admissão definitiva ou a reprovação.

§ 2º. Sendo a conclusão da avaliação de desempenho pela reprovação, o médico será cientificado para se manifestar sobre ela, caso queira, no prazo de dez dias, sendo-lhe assim oportunizada ampla defesa e contraditório sobre a opinião que lhe é desfavorável. Findos os quais, o Conselho de Administração decidirá pela admissão definitiva ou reprovação.

§ 3º. Da decisão de reprovação, caberá recurso à próxima assembleia geral, a ser interposto no prazo de 15 dias contados da ciência da decisão.

§ 4º. O cooperado em regime de estágio probatório deverá participar dos cursos e/ou seminários patrocinados pelo Núcleo de Formação e Relacionamento dos cooperados que objetivarão esclarecer as legislações que disciplinam o funcionamento das

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

cooperativas e das operadoras de planos de assistência à saúde, as disposições estatutárias e as normas internas de funcionamento da cooperativa, sendo obrigatória a participação, por definição do Conselho de Administração.

§ 5º. A não participação nos cursos/seminários torna sem efeito a decisão do Conselho de Administração que deferiu a proposta de admissão em regime de estágio probatório, ocorrendo automaticamente o indeferimento dela.

§ 6º. O indeferimento perdurará até que o candidato faça o curso/seminário que o ensejou.

Art. 16. Atendido integralmente ao disposto nos artigos 13 a 15 deste estatuto, deverá o candidato subscrever e integralizar as quotas-partes de capital nos termos e condições previstas neste estatuto, devendo ainda assinar o livro ou ficha de matrícula junto ao presidente do Conselho de Administração, adquirindo, a partir desse momento, em caráter precário, decorrente do estágio probatório, todos os direitos e obrigações decorrentes da legislação, deste estatuto e das deliberações do Conselho de Administração e decisões assembleares.

Art. 17. Não serão admitidos no quadro de cooperados os médicos que exerçam qualquer atividade considerada prejudicial ou que colida com os objetivos dela, assim como aqueles médicos que já participaram da cooperativa e foram eliminados por decisão do Conselho de Administração.

Art. 18. O número de cooperados não terá limite quanto ao máximo, mas não poderá, em hipótese alguma, ser inferior ao número mínimo necessário a compor a administração e fiscalização da cooperativa, ou seja, no mínimo 20 cooperados.

Art. 19. O cooperado que se demitir e vier a pedir readmissão após receber o seu capital social, no todo ou em parte, deverá, na hipótese de deferimento da readmissão, subscrever e integralizar:

I – Tantas quotas-partes recebidas por ocasião de sua demissão, obedecendo ao mínimo estabelecido neste estatuto;
II – Os valores subscritos e integralizados pelo corpo social no período do seu afastamento, em decorrência de dispositivos deste estatuto ou de deliberação da assembleia geral.

Seção II

Dos Direitos e Obrigações do Cooperado

Art. 20. São direitos do cooperado:

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

I – participar das atividades da cooperativa, com ela operando e cooperando em benefício dos seus objetivos econômicos e sociais;

II – participar de assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, discutindo e votando os assuntos nelas tratados, ressalvados os impedimentos legais e estatutários;

III – votar e ser votado para membro dos órgãos administrativos, técnicos, fiscais e semelhantes da cooperativa, ressalvadas as disposições contrárias deste estatuto;

IV – solicitar esclarecimentos sobre as atividades da cooperativa, sendo-lhe facultado examinar, dentro dos 30 dias que antecedem à assembleia geral ordinária, na sede da entidade, o balanço geral, os livros contábeis e o livro de matrícula;

V – pedir, em qualquer tempo, sua demissão do quadro de cooperados;

VI – receber da cooperativa as sobras apuradas em balanço devidamente aprovadas e que lhe couberem na proporção de suas operações, desde que assim destinadas pela assembleia geral, bem como receber adiantamentos por conta dessas sobras, na forma e na periodicidade fixadas pelo Conselho de Administração;

§1. Nenhum dispositivo deste estatuto deverá ser interpretado no sentido de impedir os cooperados de se credenciarem ou referenciarem-se a outras operadoras de planos de saúde ou seguradoras especializadas em saúde, que atuam regularmente no mercado de saúde suplementar, bem como deverá ser considerado nulo de pleno direito qualquer dispositivo estatutário que possua cláusula de exclusividade ou de restrição à atividade profissional.

§2. Sem prejuízo de qualquer direito legalmente garantido, fica resguardado, aos herdeiros do cooperado falecido, o direito às quotas-partes do capital social que integralizou e demais créditos que houver, observando-se o devido processo legal.

Art. 21. São obrigações do cooperado:

I – executar, em seu local de trabalho ou em instituição contratada ou autorizada pela cooperativa, os serviços que forem objeto dos contratos de assistência à saúde, celebrados com pessoas físicas e jurídicas, sob as formas coletiva, familiar ou individual;

II – subscrever e integralizar as quotas-partes do capital social, nos termos deste estatuto, e contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais que forem instituídos pelo Conselho de Administração;

III – prestar aos contratantes da cooperativa, dentro de sua especialidade, serviços de assistência médica sem restrições;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

IV – prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre os serviços executados em nome da cooperativa;

V – cumprir fielmente o que dispõe a legislação brasileira aplicável às cooperativas, o estatuto e o regimento interno da cooperativa, normas internas, o Código de Ética Médica editado pelo Conselho Federal de Medicina, assim como acatar as deliberações das assembleias gerais e do Conselho de Administração;

VI – não exercer qualquer atividade considerada prejudicial ou que colida com os objetivos da cooperativa;

VII – zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativa, colocando os interesses da coletividade acima dos interesses individuais, não difamando a imagem da cooperativa ou de seus administradores, submetendo por escrito, à apreciação do Conselho de Administração, suas eventuais queixas ou críticas à condução dos negócios sociais;

VIII – pagar sua parte nas perdas do exercício, apuradas em balanço, proporcionalmente às operações que realizou com a cooperativa, se o fundo de reserva não for suficiente para cobri-las;

IX – concorrer para a cobertura das despesas administrativas e operacionais da cooperativa;

X – ressarcir prontamente os prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa à cooperativa ou a terceiros;

XI – levar ao conhecimento do Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal a existência de qualquer irregularidade que atente contra a legislação brasileira aplicável às cooperativas, o estatuto, o regimento interno da cooperativa, o Código de Ética Médica editado pelo Conselho Federal de Medicina, as deliberações das assembleias gerais e do Conselho de Administração;

XII – não emprestar seu nome para outro médico ou pessoa física ou jurídica para fins de utilização dos serviços da cooperativa;

XIII – não delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica;

XIV – não assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou efetivamente;

XV – não praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

XVI – não exagerar na gravidade do diagnóstico ou prognóstico, assim como não complicar a terapêutica, ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos;

XVII – não utilizar material médico, medicamentos e serviços desnecessários;

XVIII – não se associar com empresas fornecedoras de material médico, equipamentos médicos, medicamentos, órteses e próteses com o intuito de benefícios diretos ou indiretos sobre a venda deles;

XIX – não divulgar, direta ou indiretamente, em redes sociais ou similares, qualquer fato que tenha conhecimento e envolva qualquer assunto interno da cooperativa, exceto em páginas oficiais, criadas e administradas pela cooperativa;

XX – participar das escalas de plantão no Hospital Unimed Caruaru e dos demais serviços próprios, durante o período probatório, para atender solicitação do Conselho de Administração da Cooperativa.

XXI – realizar um número mínimo de consultas com valor equivalente ao que for determinado pela assembleia geral ordinária para cobrir o estabelecido a ser pago referente ao plano de saúde do cooperado. No caso das especialidades que não possuem atendimento em consultório, o cooperado deverá prestar serviço equivalente à cooperativa, sob pena de ter que arcar com a mensalidade dele.

Art. 22. Não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus cooperados, tampouco entre esses e os tomadores de serviço daquela.

Seção III

Da Responsabilidade do Cooperado perante Terceiros e a Cooperativa

Art. 23. O cooperado responde subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela cooperativa perante terceiros, até o limite do valor das quotas-partes de capital que subscreveu e pela parcela das perdas que lhe caibam, na proporção das operações que houver realizado, se o fundo de reserva não bastar para cobri-las.

Parágrafo único. A responsabilidade do cooperado perante terceiros, por compromissos da cooperativa, só poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.

Art. 24. O cooperado é exclusivamente responsável perante os contratantes da cooperativa, pessoas físicas ou jurídicas, pelos casos de erro médico, dolo, imprudência, negligência ou imperícia na prestação dos serviços médicos, obrigando-se a ressarcir a cooperativa caso ela seja condenada judicialmente a pagar qualquer importância indenizatória por ato seu.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 25. A responsabilidade do cooperado demitido, excluído ou eliminado perante terceiros, por compromissos da cooperativa, cessa somente após a aprovação pela assembleia geral do balanço patrimonial e da prestação de contas do ano social em que se deu o desligamento.

Art. 26. As obrigações do cooperado falecido, contraídas com a cooperativa, e as oriundas de sua responsabilidade como cooperado, perante terceiros, transmitem-se aos herdeiros, prescrevendo, porém, após um ano contado do dia da abertura da sucessão.

Seção IV

Do Desligamento do Cooperado

Art. 27. O desligamento do cooperado dar-se-á por:

I – demissão;

II – eliminação;

III – exclusão.

Subseção I
Da Demissão do Cooperado

Art. 28. A demissão do cooperado, que não poderá ser negada, dar-se-á unicamente a seu pedido em requerimento dirigido ao presidente do Conselho de Administração da Cooperativa.

§ 1º. O requerimento deverá ser levado ao conhecimento do Conselho de Administração, na primeira reunião subsequente ao pedido, e averbada no livro de matrícula mediante termo assinado pelo presidente do Conselho de Administração.

§ 2º. Salvo circunstâncias especiais, a juízo do Conselho de Administração, a readmissão só poderá ser deferida depois de decorridos dois anos contados da data da efetiva demissão.

§ 3º. Não será permitida a readmissão do cooperado que tenha pedido demissão durante o trâmite de processo administrativo desta cooperativa.

Subseção II

Da Advertência, Suspensão e Eliminação do Cooperado

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Art. 29. As penalidades de advertência, suspensão e eliminação poderão ser aplicadas pelo Conselho de Administração ao cooperado que infringir a Lei, o estatuto social, o regimento interno, o Código de Ética Médica e resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina, as deliberações das assembleias gerais, Conselho de Administração e do Comitê Técnico e de Especialidades Médicas, observando o disposto no art. 5º, inciso LV, Constituição Federal de 1988.

§1º. Os casos com indícios de infração ao Código de Ética Médica serão devidamente encaminhados ao Conselho Regional de Medicina.

§2º. Excetuadas as penalidades de advertência, que poderão ser aplicadas diretamente por deliberação da maioria simples do Conselho de Administração, após garantido ao cooperado o contraditório e a ampla defesa, previstos no caput deste artigo, as penalidades de suspensão e eliminação somente poderão ser aplicadas após processo administrativo disciplinar, consoante procedimento previsto no artigo 31 deste estatuto.

§3º. Constituem também infrações:

I – A fraude, a falsificação e a adulteração de produções pelo associado;

II – A negociação, a intermediação ou a comercialização de equipamentos, produtos e materiais cirúrgicos ou não pelo cooperado aos beneficiários;

III – A cobrança, pelo associado, de qualquer valor adicional, diretamente ou indiretamente, ao beneficiário, como condição para qualquer tipo de atendimento, exceto as cobranças de franquias previstas nos contratos dos beneficiários;

IV – Promover o associado a instigação de qualquer beneficiário a propor medida judicial ou administrativa com o fim de auferir vantagens próprias em detrimento da cooperativa e demais cooperados;

V – Praticar atos contrários ao espírito cooperativista e à harmonia do quadro social;

VI – Exercer ou vir a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à cooperativa, que colida com seus objetivos;

VII – Ofender, desrespeitar, caluniar, agredir, verbal e/ou fisicamente, bem como expor o nome de forma desrespeitosa dos membros ocupantes de cargo social ou funções delegadas pelo Conselho de Administração em redes sociais, no exercício da função.

§4º. As penas previstas no art. 30º serão aplicadas de acordo com a natureza da infração e suas circunstâncias.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 30. As penalidades a serem aplicadas em caso de procedência são as seguintes:

I. Advertência verbal;

II. Advertência confidencial por escrito;

III. Advertência pública em assembleia geral;

IV. Suspensão de atividades na cooperativa por três meses;

V. Suspensão de atividades na cooperativa por seis meses;

VI. Suspensão de atividades na cooperativa por 12 meses;

VII. Eliminação do cooperado.

Parágrafo único. Pune-se, obrigatoriamente, com a pena de eliminação, o cooperado que:

Deixar de exercer, na área de ação da cooperativa, a atividade que lhe facultou associar-se;

b) Receber qualquer vantagem e/ou benefício pecuniário, direta ou indiretamente, por parte de beneficiários, fornecedores, entre outros, exceto aqueles permitidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Art. 31º. Formalizada a denúncia, será o denunciado notificado, a fim de que apresente defesa, por escrito, ao Conselho Técnico, no prazo de 15 dias, contados do recebimento da notificação.

§1º. Decorrido o prazo, sem que haja a defesa, o denunciado será considerado revel, procedendo-se a juntada ao processo o termo de revelia, assinado por, pelo menos, dois membros do Conselho Técnico.

§2º. Após a manifestação do denunciado ou juntada do termo de revelia, os autos serão remetidos ao Conselho Técnico, que analisará a denúncia, a defesa, caso exista, e decidirá pelo arquivamento ou julgamento do processo.

§3º. Só se procederá ao arquivamento ou baixa da denúncia com o voto, neste sentido, de todos os membros efetivos do Conselho Técnico.

§4º. Compete ao Conselho de Administração o julgamento dos processos, aplicando, caso procedente a denúncia, uma das penalidades previstas no artigo 30º.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

§5º. Proferido o julgamento, e se procedente a denúncia, o Conselho de Administração expedirá notificação ao cooperado, informando a pena fixada e dando execução a ela.

§6º. Caso a procedência da denúncia não tenha sido por unanimidade, caberá ao cooperado, no prazo de dez dias do recebimento da notificação, apresentar recurso suspensivo, inclusive acostando novas provas, dirigido ao próprio Conselho de Administração.

§7º. No caso de a pena fixada for a prevista no art. 33º, inciso VII, deste estatuto, poderá o denunciado apresentar, ainda, no prazo de 30 dias do recebimento da notificação, recurso especial com efeito suspensivo à assembleia geral extraordinária, que deverá, obrigatoriamente, ser convocada no prazo máximo de 60 dias, a contar do decurso do prazo para interposição do recurso especial.

§8º. Reformada ou mantida a decisão da assembleia geral, ela será irrecorrível.

§9º. Mantida a eliminação do associado, será averbado tal termo no registro de matrícula e assinada a sua eliminação pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo seu vice.

§10. Cópia autenticada do termo de eliminação será remetida ao cooperado, por processo que comprove as datas de remessa e de recebimento.

§11. Os motivos que determinarem a eliminação do cooperado deverão constar nos termos da decisão e serem registrados no termo de eliminação.

§12. O cooperado eliminado ficará definitivamente impedido de ser readmitido pela cooperativa.

§13. Mediante prévia justificativa, poderão, a assessoria jurídica, o Conselho Técnico e o Conselho de Administração, solicitar prazo de até 30 dias para análise, opinião e julgamento sobre a denúncia, respectivamente.

§14. O cooperado que, por ato ilícito, causar dano à cooperativa, aos seus cooperados e aos seus beneficiários fica obrigado a ressarcir todos os prejuízos que deu causa, na forma fixada pelo Conselho de Administração, podendo, inclusive, ser objeto de desconto de sua produção mensal, eventual rateio de sobras ou acerto de contas.

Subseção III

Da Exclusão do Cooperado

Art. 32. A exclusão do cooperado dar-se-á por:

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

I – falecimento;

II – incapacidade laboral permanente;

III – por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa.

§ 1º. Não será excluído e permanecerá em regime especial, na condição de cooperado aposentado, gozando da mesma prerrogativa do cooperado ativo, exclusivamente em relação à permanência no plano de saúde, aquele que tenha atingido a idade de 70 anos ou pelo menos 30 anos de atividade médica com a cooperativa, desde que não exerça mais a atividade médica em qualquer âmbito, seja público ou privado.

§ 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, o cooperado não será excluído e permanecerá na condição de cooperado aposentado ativo, gozando da mesma prerrogativa do cooperado ativo, exclusivamente em relação à permanência no plano de saúde, desde que apresente documentação comprobatória de sua incapacidade laboral permanente, previamente analisada e com parecer favorável do Conselho Técnico.

§ 3º. Enquadra-se, na hipótese no inciso III, dentre outras situações, o descumprimento da obrigação de prestar serviços de assistência médica sem restrições aos contratantes da cooperativa.

§ 4º A decisão de exclusão fundada no inciso III deste artigo é de competência exclusiva do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV

DO CAPITAL SOCIAL

Seção I

Da Subscrição e Integralização

Art. 33. O capital social é dividido em quotas-partes, ilimitado quanto ao máximo e variável segundo o número de quotas-partes subscritas, não podendo, entretanto, ser inferior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

§ 1º. Cada quota-parte equivale ao valor de R$ 1,00 (um real).

§ 2º. O cooperado obriga-se a subscrever e integralizar no mínimo 120.000 (cento e vinte mil) quotas-partes do capital social e, no máximo, o número de quotas-partes equivalente a 1/3 (um terço) do capital social previsto no c*aput* deste artigo.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Art. 34. A integralização das quotas-partes poderá ser feita de uma só vez em pagamento à vista ou de forma parcelada nos termos do regimento interno, a critério do Conselho de Administração.

Parágrafo único. Na hipótese de ingresso por necessidade técnica da prestação de serviços, o Conselho de Administração poderá estabelecer condições diferenciadas para o pagamento da integralização das quotas-partes em relação aos demais ingressantes.

Art. 35. O capital integralizado pelo cooperado responde pelas obrigações dele perante a sociedade.

Art. 36. A sociedade cooperativa poderá distribuir juros capitalizados, anualmente, de até 6% (seis por cento), contados exclusivamente sobre a parte integralizada do capital, mediante prévia deliberação de assembleia geral e desde que tenha havido sobras no exercício correspondente.

Art. 37. Caso ocorra fracionamento de quota-parte no capital do cooperado, o valor correspondente à fração será automaticamente incorporado ao fundo de reserva.

Art. 38. Não será exigida a complementação de capital por parte dos cooperados que já compõem o quadro social da sociedade, na hipótese em que houver posterior aumento do capital mínimo de associação.

Art. 39. Havendo posterior redução do capital mínimo de associação, não é devido o resgate da parte excedente, exceto no caso de desligamento do cooperado.

§1º. A cooperativa poderá emitir boletos de cobrança, no valor das parcelas a integralizar, ou definir outra forma de cobrança a critério do Conselho de Administração.

§2º. A cooperativa poderá reter as sobras líquidas e/ou a produção mensal que couber ao cooperado para cobertura das prestações vencidas daqueles que se atrasarem na integralização.

§3º. Não havendo sobras líquidas e/ou a produção mensal para cobertura das prestações vencidas dos cooperados que se atrasarem na integralização, serão cobrados juros de 1% (um por cento) a.m. pro rata dia e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores em atraso, que não farão parte do capital social integralizado e serão destinados ao fundo de reserva.

Seção II

Da Transferência e Restituição

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Art. 40. As quotas-partes são indivisíveis e intransferíveis, exceto para outro cooperado, não podendo ser negociadas ou dadas em garantia, e todo o movimento de subscrição, integralização, transferência e restituição será sempre escriturado no livro de matrícula ou em dispositivos eletrônicos, conforme decisão do Conselho de Administração.

Parágrafo único. A transferência entre cooperados de quotas-partes já integralizadas depende de autorização da Assembleia Geral, respeitado o limite de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes que compõem o capital social, assim como pagamento de taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor da transferência, e ainda estar o cooperado adimplente com a sociedade.

Art. 41. O cooperado reprovado em estágio probatório, demitido, eliminado ou excluído terá direito à restituição do capital que integralizou, sem atualização monetária, acrescido, tão somente, dos juros distribuídos na forma do artigo 36 deste estatuto.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do cooperado e consequente exclusão, é assegurada aos herdeiros a restituição do capital na forma disposta no caput deste artigo e conforme dispuser forma de partilha ou alvará judicial.

Art. 42. A restituição de que trata o artigo anterior somente poderá ser exigida após a aprovação, pela assembleia geral, do balanço do exercício em que se deu o desligamento do cooperado.

Art. 43. O Conselho de Administração poderá determinar que a restituição do capital e juros seja feita em até 12 parcelas iguais, mensais e consecutivas, a partir do mês em que se realizou a assembleia que aprovou o balanço do exercício em que se deu o desligamento.

Art. 44. Será contabilizado, em conta passiva de capital social a restituir, o valor das quotas-partes restituíveis por ocasião do pedido de demissão ou da decisão de eliminação ou exclusão do cooperado, conforme disposto no § 4º do artigo 24 da Lei nº 5.764/1971. E, sobre ele, não incidirão juros ou qualquer atualização, conforme disposto no artigo 4º da Lei 9.249/1995.

Art. 45. O desligamento por reprovação no estágio probatório, demissão, eliminação ou exclusão acarreta o vencimento das dívidas do cooperado na sociedade, devendo tais dívidas e outras obrigações eventualmente ainda não liquidadas serem compensadas e deduzidas na restituição do capital e pagamento de sobras.

Art. 46. O cooperado demitido, eliminado ou excluído deverá ressarcir a cooperativa de todos os prejuízos a ela eventualmente causados, assim como seus eventuais débitos, ficando a cooperativa autorizada a proceder à compensação prevista no artigo 368 do Código Civil Brasileiro de seus eventuais créditos.

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

CAPÍTULO V

DOS LIVROS

Art. 47. A sociedade deverá possuir os seguintes livros:

I – de matrícula;

II – de presença dos cooperados às assembleias gerais;

III – de atas das assembleias gerais;

IV – de atas das reuniões do Conselho de Administração;

V – de atas das reuniões da Superintendência Executiva;

VI – de atas das reuniões do Conselho Fiscal;

VII – de atas das reuniões do Conselho Técnico;

VIII – de atas dos Comitês de Especialidades;

IX – de inscrição de candidaturas individuais para o Conselho de Administração e chapas para o Conselho Fiscal e Conselho Técnico;

X – de atas de reuniões da junta eleitoral;

XI – fiscais e contábeis obrigatórios e outros exigidos por lei.

Parágrafo único. É facultada a adoção de livros com folhas soltas ou fichas, inclusive emitidas por processamento eletrônico de dados, devidamente numerados.

Art. 48. No livro de matrícula, os cooperados serão inscritos por ordem cronológica de admissão, dele constando:

I – número de inscrição;

II – registro do RQE;

III – nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão, residência, RG, CRM e CPF do sócio;

IV – a data de admissão e, quando for o caso, de sua demissão a pedido, eliminação ou exclusão;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

V – a conta-corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

CAPÍTULO VI

DOS FUNDOS

Art. 49. A cooperativa é obrigada a constituir antes de qualquer outra destinação:

I – fundo de reserva, com 10% (dez por cento) das sobras líquidas de cada exercício;

II – o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) com 5% (cinco por cento) das sobras líquidas de cada exercício;

III – o fundo para pagamento da remuneração das quotas- partes de capital social, nos termos e forma preconizada pelo artigo 36 deste estatuto, com 6% (seis por cento) das sobras líquidas de cada exercício.

Art. 50. O fundo de reserva destina-se a reparar eventuais perdas que a cooperativa venha a sofrer, assim como visa atender ao desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo único. Além da taxa de 10% (dez por cento) das sobras líquidas apuradas no balanço do exercício, revertem em favor do fundo de reserva os créditos não reclamados pelos cooperados decorrido um ano; os auxílios e doações sem destinação especial; os bens doados ou legados com este fim, devidamente registrados em documento legal; e a taxa cobrada para a transferência de quotas-partes entre sócios.

Art. 51. O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) destina-se à prestação de assistência aos cooperados e aos seus familiares.

Parágrafo único. Os serviços atendidos por este fundo poderão ser executados mediante convênio com entidades especializadas, públicas ou privadas.

Art. 52. A assembleia geral poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, fixando o modo de formação, aplicação e extinção.

CAPÍTULO VII

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Seção I

Disposições Gerais

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Art. 53. A assembleia geral dos cooperados, que poderá ser ordinária ou extraordinária, é o órgão estratégico da cooperativa que, dentro dos limites da Lei e deste estatuto, poderá decidir sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, sendo que suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 54. A assembleia geral será convocada por meio de edital, que deverá conter os seguintes requisitos:

I – a denominação da cooperativa, seguida da expressão convocação de assembleia geral, ordinária ou extraordinária, conforme o caso;

II – o dia e a hora da assembleia e de cada uma das convocações, observado o intervalo mínimo de uma hora entre elas;

III – o endereço do local da realização da assembleia, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social;

IV – a sequência ordinal das convocações e quórum de instalação;

V – a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações e, em caso de reforma do estatuto, a indicação precisa da matéria;

VI – o número de cooperados existentes na data da sua expedição, para efeito de cálculo do quórum de instalação;

VII – nome por extenso e respectiva assinatura do responsável pela convocação.

Art. 55. A assembleia geral será convocada e presidida pelo presidente do Conselho de Administração.

§ 1°. Poderão efetuar a convocação se ocorrerem motivos graves ou urgentes ou ainda se for ultrapassado o prazo estatutário para a convocação da assembleia geral ordinária:

I – o Conselho de Administração pela maioria de seus membros;

II – o Conselho Fiscal, após solicitação escrita com a indicação das matérias a serem tratadas e não atendidas no prazo de 30 dias pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo próprio conselho;

III – Um quinto (1/5) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, após solicitação escrita com indicação das matérias a serem tratadas e não atendidas no prazo de 30 dias pelo presidente do Conselho de Administração ou pelo próprio conselho.

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

§ 2°. Nos casos de convocação feita por um dos órgãos colegiados da cooperativa, o edital de convocação conterá o nome e a respectiva assinatura da maioria dos membros. No caso de convocação feita pelos cooperados, o edital será assinado, no mínimo, pelos cinco primeiros signatários da solicitação dirigida ao presidente do Conselho de Administração ou ao próprio conselho.

Art. 56. A assembleia geral ordinária será convocada com antecedência mínima de dez dias para a primeira convocação e de uma hora de intervalo para a segunda e a terceira convocações.

§ 1°. As três convocações poderão ser feitas em um só edital, desde que nele constem, expressamente, os prazos para cada uma delas.

§ 2°. Não havendo quórum para instalação da assembleia, será feita nova convocação, com antecedência mínima de 15 dias e, se ainda assim não houver quórum para a sua instalação, o fato será entendido como intenção de dissolver a sociedade.

Art. 57. O quórum mínimo para a instalação da assembleia geral é o seguinte:

I – dois terços (2/3) do número de cooperados com direito a voto na primeira convocação;

II – metade mais um dos cooperados com direito a voto na segunda convocação;

III – mínimo de dez cooperados com direito a voto na terceira e última convocação.

Parágrafo único. O número de cooperados presentes em cada convocação será comprovado pela assinatura no livro de presença ou através do registro da plataforma digital.

Art. 58. O edital de convocação será afixado em local visível nas dependências dos recursos próprios mais comumente frequentadas pelos cooperados, publicado através de jornal de grande circulação local, quando houver, publicado nas páginas digitais oficiais e comunicado por circular aos cooperados.

Art. 59. Qualquer cooperado pode impugnar o edital desde que o faça no prazo improrrogável de cinco dias contados da publicação, em requerimento dirigido ao Conselho de Administração apontando os motivos de fato e de direito que justificam a impugnação.

Art. 60. O acesso ao recinto onde se realizar a assembleia geral é limitado aos cooperados e demais pessoas autorizadas por Lei. Sempre que necessário, o presidente do Conselho de Administração convidará para participar dos trabalhos empregados da cooperativa, assim como prestadores de serviço, técnicos, assessores, dentre outros.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 61. Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos pelo presidente do Conselho de Administração e secretariado por um conselheiro de Administração.

Parágrafo único. Nas assembleias gerais que não forem convocadas pelo presidente do Conselho de Administração, os trabalhos serão dirigidos por um cooperado escolhido na ocasião e secretariado por outro nomeado por aquele.

Art. 62. Na assembleia geral em que for discutida a prestação de contas, o presidente do Conselho de Administração, após a leitura do relatório do Conselho de Administração dos documentos contábeis mais importantes e dos pareceres do Conselho Fiscal e auditoria independente, solicitará ao plenário que indique um cooperado para a direção dos debates e votação da matéria.

§ 1º. O cooperado indicado pela plenária nomeará entre os presentes um secretário para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata da assembleia.

§ 2º. Atendido o disposto no caput do artigo, o presidente do Conselho de Administração e os demais membros do Conselho irão para o plenário, onde ficarão à disposição da assembleia para quaisquer esclarecimentos.

Art. 63. Fica impedido de votar e ser votado, nas assembleias gerais, o cooperado que:

I – tenha sido admitido na cooperativa após a convocação da assembleia;

II – mantenha ou tenha mantido vínculo empregatício com a cooperativa até que a assembleia geral aprove as contas do ano social em que cessou o vínculo.

Art. 64. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal estão impedidos de votar nas deliberações que a eles se refiram direta ou indiretamente, notadamente as de prestação de contas, fixação de valor de honorários e de cédulas de presença, podendo, contudo, participarem dos debates.

Parágrafo único. Fica também impedido de votar todo e qualquer cooperado cuja deliberação a ele se referir direta ou indiretamente, podendo, contudo, participar dos debates.

Art. 65. Independentemente do número de quotas-partes que possua no capital da sociedade, cada cooperado presente tem direito a um só voto nas deliberações de assembleia geral, não sendo admitido, em hipótese alguma, voto por procuração.

Art. 66. As deliberações da assembleia geral somente poderão versar sobre assuntos constantes no edital de convocação ou que tenham com eles direta e imediata relação

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

ou decorrência natural.

Art. 67. Excetuada as matérias de que trata o artigo 76, as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria de votos dos cooperados presentes com direito a voto.

Art. 68. Excetuadas as hipóteses de concorrência a cargos eletivos na cooperativa e destituição dos membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, nas quais o voto será secreto, as demais votações serão em regra a descoberto, ou seja, os cooperados se manifestarão levantando uma das mãos ou placas de sinalização distribuídas previamente.

Art. 69. As deliberações da assembleia constarão em ata sumária, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada, no final dos trabalhos, pelos membros do Conselho de Administração presentes e por uma comissão de dez cooperados designados pela assembleia e quem mais quiser assinar.

Parágrafo único. Havendo, por qualquer motivo, impossibilidade de se acompanhar, mediante registro imediato em ata, todos os trabalhos desenvolvidos pela assembleia geral, é permitida a gravação deles em fita magnética ou meio eletrônico, que será usada como memória da assembleia e utilizada para posterior lavratura da ata.

Art. 70. É da competência, tanto de assembleia geral ordinária quanto de extraordinária, alienar ou doar bens imóveis.

Art.71. Caso seja necessário, a assembleia poderá, pela maioria de votos dos presentes, ser declarada suspensa e continuar os trabalhos iniciados em outra data, devendo, contudo, ocorrer nova convocação via publicação de edital com antecedência mínima de dez dias, caso a prorrogação seja por prazo maior do que 72 horas.

Seção II

Da Assembleia Geral Ordinária

Art. 72. A assembleia geral ordinária realizar-se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer do primeiro trimestre subsequente ao encerramento do exercício social, e deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar na ordem do dia:

I – prestação das contas relativas ao exercício anterior, compreendendo o relatório da gestão, o balanço geral, o demonstrativo da conta de sobras e perdas e pareceres do Conselho Fiscal e auditores independentes;

II – destinação das sobras ou rateios das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

III – os planos de trabalho programados pelo Conselho de Administração para o exercício corrente, incluindo apresentação de orçamento de receita e despesa;

IV – fixação dos valores relativos aos honorários dos membros do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos Técnico e Fiscal;

V – quaisquer outros assuntos de interesse social, desde que mencionados no respectivo edital, excluindo-se os de competência exclusiva da assembleia geral extraordinária;

VI – eleição e reeleição dos membros dos conselhos de Administração, Técnico e Fiscal.

Parágrafo único. A aprovação sem reserva do relatório, balanço e contas desonera os membros do conselho da responsabilidade pela gestão, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude, simulação e infração da lei ou do estatuto.

Art. 73. Quando houver eleições para o Conselho de Administração, Conselho Técnico e/ou Conselho Fiscal, a assembleia geral ordinária se instalará normalmente no horário previsto e será dividida em duas fases, sendo a primeira para apreciação das matérias tratadas nos incisos I a VI do artigo 72. Encerrada a primeira fase, inicia-se o procedimento eleitoral, podendo o Conselho de Administração decidir pela inversão dessa ordem.

Seção III

Da Assembleia Geral Extraordinária

Art. 74. A assembleia geral extraordinária realizar-se-á sempre que necessário, devendo ser convocada com antecedência mínima de dez dias, tendo poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da sociedade, desde que mencionados no edital de convocação.

Art. 75. É da competência exclusiva da assembleia geral extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – reforma do estatuto social;

II – fusão, incorporação ou desmembramento;

III – mudança do objeto da sociedade;

IV – opção por operar com serviços médicos próprios;

V – dissolução voluntária da sociedade e nomeação dos liquidantes;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

VI – aprovação das contas do liquidante.

Parágrafo único. São necessários os votos válidos de dois terços (2/3) dos cooperados presentes para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo, desconsiderando-se as abstenções e votos nulos.

Art. 76. As assembleias gerais ordinária e extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora e registradas em ata única.

§ 1º. A assembleia geral extraordinária poderá ser realizada na sequência da assembleia geral ordinária, ou vice-versa, não se permitindo apenas que os assuntos de uma e de outra assembleia sejam discutidos alternadamente.

§ 2º. Na votação das matérias, deverá ser observado o quórum de aprovação de cada uma das assembleias.

CAPÍTULO VIII

DO PROCEDIMENTO ELEITORAL PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS NOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, TÉCNICO E FISCAL

Art. 77. Para a eleição ou reeleição dos membros dos conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, será sempre nomeada uma junta eleitoral pelo Conselho de Administração, composta por três cooperados, cuja função será presidir e disciplinar todo o procedimento eleitoral, zelando para que ele se desenvolva com imparcialidade e legalidade.

§ 1º. A junta eleitoral deverá ser nomeada com antecedência mínima de até 35 dias contados da data fixada para a realização da assembleia geral.

§ 2º. Não poderão fazer parte da junta eleitoral cooperados que estejam ocupando cargos nos conselhos de Administração, Técnico e Fiscal ou que pretendam concorrer a cargo nestes conselhos.

§ 3º. A junta eleitoral se reunirá com direito à cédula de presença e terá um presidente escolhido, na primeira reunião, pelos membros que a integram, cuja função será a de coordenar os trabalhos.

§ 4º. Será lavrada ata em todas as reuniões da junta eleitoral, sobretudo para fins de registro das suas decisões.

Art. 78. Para concorrer aos cargos no Conselho de Administração, as candidaturas serão individuais, enquanto que, para os cargos no Conselho Técnico e Conselho Fiscal, as

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

candidaturas deverão ser apresentadas em chapas completas e indivisíveis.

§ 1º. Os cooperados interessados em concorrer individualmente aos cargos no Conselho de Administração ou constituir chapas completas e indivisíveis para os cargos nos Conselhos Técnico e Fiscal deverão apresentar requerimento de inscrição até 21 dias antes da data fixada para a realização da assembleia geral convocada para tal fim.

§ 2º. No caso de chapa aos cargos nos Conselho Técnico e Fiscal, deverão os requerimentos distinguir quem serão os conselheiros efetivos e suplentes.

§ 3º. Os cooperados que desejarem concorrer aos cargos de conselheiro de Administração e Fiscal deverão possuir os certificados de conclusão dos cursos de formação concedidos pelo SESCOOP/OCB ou similar.

§ 4º. No caso de candidatura ao cargo de conselheiro de Administração, também será obrigatório apresentar a certificação em MBA ou pós-graduação em gestão de cooperativas ou serviços de saúde.

Art. 79. Serão indeferidos, pela junta eleitoral, os requerimentos de candidaturas individuais ou chapas que não preencherem os requisitos exigidos pelo artigo 80 deste estatuto ou que não atendam as legislações aplicáveis às sociedades cooperativas de trabalho médico e operadoras de planos de assistência à saúde.

Parágrafo único. Da decisão que indeferir requerimento, caberá recurso no prazo de dois dias.

Art. 80. No caso de indeferimento de um ou mais nomes que integram a chapa para os Conselhos Técnico e Fiscal, será permitida, no prazo de dois dias, a substituição do nome indeferido, devendo o substituto cumprir os requisitos exigidos pelo artigo 80 deste estatuto no prazo de cinco dias.

§ 1º. A não substituição do nome no prazo definido no parágrafo anterior acarretará o indeferimento da inscrição de toda a chapa.

§ 2ª. A junta eleitoral decidirá no prazo de dois dias sobre a inclusão do substituto.

Art. 81. A votação para preenchimento dos cargos nos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal ocorrerá mediante votação nominal e secreta e serão eleitos os mais votados.

§ 1º. Cada cooperado poderá votar somente em um nome para os cargos no Conselho de Administração e em uma chapa para os Conselhos Técnico e Fiscal.

§ 2º. Será considerado nulo o voto que assinalar o nome de mais de um candidato para

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

os cargos no Conselho de Administração e mais de uma chapa para os Conselhos Técnico e Fiscal.

§ 3º. A posição na cédula eleitoral de cada candidato ao Conselho de Administração ou das chapas concorrentes ao Conselho Fiscal observará a ordem cronológica do protocolo dos requerimentos de inscrição.

Art. 82. São inelegíveis e, portanto, não podem concorrer a cargos nos Conselhos de Administração e Fiscal, tampouco continuarem ocupando cargos nesses conselhos, além das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Parágrafo único. São também inelegíveis e, portanto, não podem concorrer a cargos nos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal os cooperados que estejam ocupando cargos de diretoria em hospitais contratados ou credenciados pela cooperativa ou que deles sejam sócios, ainda que minoritários.

Art. 83. Até três dias antes da assembleia geral de eleição, a junta eleitoral publicará em jornal de grande circulação local, se houver, e/ou através das páginas digitais oficiais as candidaturas individuais e as chapas que tiveram seus requerimentos deferidos para concorrer às eleições.

Art. 84. No caso de inscrição de apenas sete candidaturas individuais para os cargos no Conselho de Administração ou apenas uma chapa para concorrer aos cargos nos Conselhos Técnico e/ou Fiscal, a votação poderá ocorrer pelo sistema de aclamação, sem necessidade de votação nominal e secreta.

Art. 85. A posse dos candidatos e chapas vencedores ocorrerão em até sete dias da eleição, devendo os membros do Conselho de Administração sucedidos ficarem à disposição dos sucessores para fins de transição de responsabilidades e obrigações, pelo prazo mínimo de 15 dias, devendo receberem, por tal período, remuneração proporcional aos dias trabalhados.

Art. 86. Não poderão concorrer a cargos nos órgãos sociais os cooperados que estejam há menos de três anos na cooperativa na data em que se encerrem as inscrições.

CAPÍTULO IX

DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 87. São órgãos de administração da cooperativa:

I – Conselho de Administração;

II – Superintendência Executiva.

Art. 88. A cooperativa será administrada por um Conselho de Administração (CONAD) com sete membros, todos eleitos, individualmente, entre os cooperados, pela assembleia geral, para um mandato de quatro anos, sendo obrigatória, no término de cada período, a renovação de, no mínimo, um terço (1/3) dos conselheiros de Administração.

§1. Poderá integrar o Conselho de Administração qualquer cooperado, desde que atenda as disposições deste estatuto, do regimento interno e que comprove atendimento ao beneficiário na cooperativa por um período mínimo de três anos consecutivos.

§2. Os integrantes do Conselho de Administração não são pessoalmente responsáveis pelos compromissos que assumirem em nome da cooperativa, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se procederem culposamente ou dolosamente.

§3. Os membros do Conselho de Administração que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da cooperativa poderão ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela contraídas, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais cabíveis.

§4. O conselheiro não poderá acumular mais de um cargo ou função remunerada na singular, porém é permitido o exercício de cargos e/ou funções em qualquer dos outros órgãos do Sistema Unimed e auxiliares.

§5. O presidente do Conselho de Administração será o mais votado pela assembleia e o vice-presidente será escolhido entre os seus pares, por maioria simples. Em caso de empate na votação, o primeiro critério de desempate será o tempo de admissão na cooperativa, sendo eleito aquele cooperado que tiver o maior tempo, e, persistindo o empate, o segundo critério será a idade, sendo eleito aquele cooperado que tiver a maior.

§6. Não podem fazer parte, do Conselho de Administração, os parentes entre si até segundo grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral e, também, o cônjuge ou companheiro. Havendo eleição de cooperados caracterizados desse modo, ficará no cargo o cooperado com mais votos na eleição individual.

§7. Fica assegurada a obrigatoriedade da participação do presidente e do vice-presidente imediatamente anterior ao mandato vigente, até o registro da ata da

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

assembleia geral de eleição, limitado este prazo em até 90 dias após a realização da assembleia, com direito a tomar parte nos debates e cédula de presença, porém sem direito a voto e fazendo jus a 50% (cinquenta por cento) do valor do pró-labore.

Art. 89. O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas:

I – Reúne-se, ordinariamente, duas vezes por semana, sendo uma obrigatória com os superintendentes, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente do Conselho de Administração, da maioria do próprio Conselho de Administração ou por solicitação do Conselho Fiscal; podendo as reuniões ocorrerem de forma digital (virtualmente), semipresencial ou presencial;

II – Delibera, validamente, com a presença da maioria dos seus membros, sendo proibida a representação, e com as decisões tomadas pela maioria simples de votos, reservado ao presidente do Conselho de Administração o exercício do voto de desempate;

III – As deliberações do Conselho de Administração serão consignadas em atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio ou folhas separadas, aprovadas e assinadas pelos participantes da reunião ao final dos trabalhos.

Art. 90. Nas faltas ou impedimentos, por prazo inferior a 90 dias, operar-se-á a substituição, pela forma seguinte:

a) Do presidente pelo vice-presidente;

b) Do vice-presidente pelo conselheiro mais antigo na cooperativa e, em caso de empate, pelo de maior idade;

c) De um conselheiro pelo cooperado mais votado após os sete eleitos.

Art. 91. Ocorrendo a vacância do cargo de presidente do CONAD, ou se ficar vaga a metade mais um dos cargos do Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração, ou seu substituto, convocará, no prazo de até 30 dias, assembleia geral para o respectivo preenchimento.

§1. Os substitutos exercerão o cargo até o final do mandato dos substituídos;

§2. Ocorrerá vacância do cargo:

a) Por morte;

b) Por renúncia;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

c) Por perda da qualidade de cooperado;

d) Por destituição;

e) Por falta sem justificativa prévia a três reuniões consecutivas ou seis alternadas, no decurso de cada ano de mandato;

f) Por impedimentos superiores a 90 dias.

g) Art. 92. Compete ao Conselho de Administração, dentro dos limites da Lei e deste estatuto, atendidas as decisões da assembleia geral, planejar e traçar normas para operações e serviços e gerenciar os resultados.

§1. No desempenho de suas funções, cabem-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Propagar as operações e serviços da cooperativa;

b) Fixar as despesas de administração, em orçamento anual, que indiquem a fonte de recursos para cobertura;

c) Contratar os serviços de auditoria interna e externa;

d) Estabelecer normas de controle das operações e serviços, verificando, mensalmente no mínimo, o estado econômico-financeiro da cooperativa e o desenvolvimento dos negócios e atividades em geral, através de balancetes da contabilidade e demonstrativos específicos;

e) Deliberar sobre convocação da assembleia geral;

f) Assessorar a cooperativa, quando necessário, nas áreas por ela necessitada;

g) Analisar, modificar e aprovar o regimento interno da cooperativa;

h) Deliberar sobre a admissão, eliminação e exclusão dos cooperados, devendo, a seu critério, aplicar as penalidades previstas neste estatuto.

§2. As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em forma de instruções e passarão a integrar o regimento interno da cooperativa.

§3. O Conselho de Administração poderá criar comitês especiais, transitórios ou não, observadas as regras estabelecidas neste estatuto, para estudar, planejar, apurar e coordenar a solução de questões específicas decorrentes destas atribuições.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 93. O Conselho de Administração garantirá aos cooperados que exercerem funções e/ou cargos administrativos, na gestão da cooperativa, a assistência advocatícia especializada na área demandada, seja judicialmente ou extrajudicialmente, por fato ligado ao cargo ou função que exercem ou exerceram na direção da cooperativa.

Parágrafo único. Exclui assistência advocatícia, ora prevista, à hipótese de a demanda ter origem em fato ou ato cometido contra os interesses da cooperativa, como, por exemplo, gestão fraudulenta, mas não limitado a ela, ainda que a demanda não tenha sido promovida pela própria cooperativa.

Art. 94. A assistência advocatícia dar-se-á sob a forma da contratação e assunção dos respectivos honorários, pela cooperativa, de advogado habilitado ao patrocínio dos interesses dos seus cooperados em demanda contra si intentada, até sua decisão final.

Parágrafo único. Os cooperados deverão concordar com o advogado indicado pela cooperativa, mas poderão, a qualquer tempo, destituí-lo, arcando, neste caso, com os honorários do novo advogado por eles, eventualmente, constituído.

Art. 95. Compete ao presidente do Conselho de Administração:

I – ocupar, em regime de dedicação exclusiva, o cargo de presidente, com carga horária mínima de 30 horas semanais.

Parágrafo único. Para efeito de antiguidade em função assistencial, o ocupante do cargo não perderá os direitos adquiridos antes do exercício do mandato, mantendo o status anterior após a conclusão do mandato.

III – representar e atuar com direito a voto nas reuniões e assembleias gerais das empresas e cooperativas do Sistema Unimed de segundo e terceiro grau, além das empresas auxiliares;

IV – convocar e presidir as assembleias gerais;

V – convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, estabelecendo dia, hora e pauta, assegurando que temas relevantes estejam sempre presentes;

VI – apresentar, à assembleia geral ordinária, o relatório de gestão, demonstrações financeiras, prestação de contas e pareceres do Conselho Fiscal e auditores independentes, bem como os planos de trabalho e programas para o exercício em curso;

VII – proferir voto de desempate em caso de empate em qualquer deliberação do Conselho;

VIII – liderar o Conselho, assegurando que os demais conselheiros participem

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

ativamente para o sucesso da cooperativa, recebendo informações completas com antecedência necessária sobre os itens da pauta de reunião, bem como possam se manifestar com independência sobre qualquer matéria colocada em votação;

IV – decidir sobre tema urgente e inadiável, submetendo o Conselho para deliberação colegiada na primeira reunião subsequente;

X – acompanhar a execução das deliberações e recomendações do Conselho;

XI – supervisionar a administração geral e as atividades da cooperativa;

XII – assinar os cheques bancários em conjunto com o vice-presidente e/ou CEO;

XIII – assinar, em conjunto com o vice-presidente e/ou CEO, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;

XIV – representar a cooperativa em juízo ou fora dele, como também nomear representante legal;

XV – supervisionar, orientar, delegar poderes e atribuições à Superintendência Executiva;

XVI – coordenar o processo de estratégia geral da cooperativa;

XVII – representação de caráter político-institucional;

XVIII – relacionamento com o Sistema Unimed e demais participantes da saúde suplementar;

XIV – relacionamento com os órgãos reguladores;

XV – relacionamento com o governo;

XVI – ouvidoria;

XVIII – acompanhar a formatação e execução do planejamento estratégico;

XIX - acompanhar a formatação e execução do orçamento.

Art. 96. Compete ao vice-presidente do Conselho de Administração:

I – ocupar o cargo de vice-presidente com carga horária mínima de 20 horas semanais;

II – substituir o presidente em todos os seus impedimentos;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

III – supervisionar as atividades econômico-financeiras em todos os níveis da cooperativa;

III – assinar os cheques bancários em conjunto com o presidente e/ou CEO;

IV – assinar, em conjunto com o presidente e/ou CEO, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;

V – acompanhar a execução orçamentária e o planejamento estratégico junto à Superintendência Executiva;

VI – acompanhar as atribuições da Superintendência Executiva.

Art. 97. São de competência privativa do Conselho de Administração:

I – exercer a administração estratégica da cooperativa, fixando diretrizes, políticas e orientações gerais dos negócios para um futuro de médio e longo prazo;

II – atuar como guardião dos valores da cooperativa, assegurando sua perenidade e sucesso no longo prazo;

III – nomear, avaliar a performance, substituir e reconduzir, a qualquer tempo, os superintendentes executivos da cooperativa;

IV – deliberar sobre a remuneração dos membros da Superintendência Executiva;

V – monitorar e fiscalizar as atividades da Superintendência Executiva;

VI – definir as atribuições e poderes da Superintendência Executiva, bem como os limites de alçada não estabelecidos no estatuto, inclusive por intermédio de documento formal de delegação de responsabilidades e regime de competências;

VII – deliberar sobre a criação de novos cargos na Superintendência Executiva;

VIII – promover um processo estruturado e regular de autoavaliação do conselho como órgão colegiado, dos comitês e dos conselheiros individualmente;

IX – monitorar os resultados econômico-financeiros e os indicadores de performance da cooperativa;

X – aprovar e monitorar os investimentos;

XI – aprovar o orçamento anual, o relatório de gestão e as demonstrações financeiras elaboradas pela Superintendência Executiva, encaminhando-os para debate e votação

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

em assembleia geral;

XII – deliberar sobre a convocação de assembleia geral e estabelecer sua ordem do dia;

XIII – deliberar sobre admissão, reprovação em estágio probatório, exclusão, advertência, suspensão e eliminação de cooperados, podendo, a seu exclusivo critério, aplicar, por escrito, advertência prévia;

XIV – instaurar e julgar processo administrativo disciplinar para aplicação das penalidades de suspensão ou eliminação;

XV – aprovar todo e qualquer regimento interno da cooperativa;

XVI – aprovar o código de conduta da cooperativa;

XVII – normatizar as situações que julgar necessárias para o bom funcionamento da cooperativa, editando, para tanto, resolução específica;

XVIII – deliberar sobre as políticas gerais de finanças e recursos humanos da cooperativa;

XIX – deliberar sobre uma política de formação e sucessão de conselheiros de Administração, submetendo-a a uma assembleia geral, bem como um plano de atualização para os que estiverem no exercício do cargo;

XX – deliberar sobre a constituição de comitês para análises e/ou condução de assuntos específicos;

XXI – contratar, sempre que julgar necessário, o assessoramento de técnicos ou especialistas para auxiliá-lo no esclarecimento de assuntos a decidir;

XXII – decidir sobre casos omissos no estatuto, podendo-se entender conveniente levá-los à assembleia geral;

XXIII – deliberar sobre aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis da cooperativa, submetendo a decisão a posterior aprovação da assembleia geral;

XXIV – fiscalizar se as melhores práticas de governança corporativa estão sendo adotadas pela cooperativa;

XXV – deliberar sobre a constituição de cooperativas ou associação a outras cooperativas, federações ou confederações de cooperativas ou ainda a outros tipos societários;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

XXVI – deliberar sobre políticas que evitem conflitos de interesses entre a cooperativa e seus cooperados e/ou administradores, bem como sobre a adoção de providências que julgar necessárias na eventualidade do surgimento do conflito, fazendo prevalecer sempre o interesse da cooperativa;

XXVII – deliberar sobre solicitações ou recomendações encaminhadas pelos Conselhos Técnico e Fiscal da cooperativa;

XXVIII – deliberar sobre formas de utilização do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);

XXIX – contratar e dispensar serviços de auditoria interna e externa;

XXX – elaborar proposta ou projeto de alteração de reforma do estatuto social;

XXXI – fixar os valores a serem cobrados dos contratantes de assistência médica, assim como fixar os valores que deverão ser pagos aos cooperados, aos serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, empresas credenciadas e aos hospitais, ouvindo-se previamente a Superintendência Executiva;

XXXII – nomear e substituir membros dos seguintes órgãos de controle da cooperativa: auditoria, gestão de riscos, compliance, controles internos e ouvidoria;

XXXIII – nomear e substituir os membros da junta eleitoral;

XXXIV – implementar programa de educação cooperativista.

Art. 98. Das decisões e resoluções do Conselho de Administração, caberá recurso sem efeito suspensivo à próxima assembleia geral, no prazo de dez dias, contados da ciência da decisão ou resolução, excetuado o disposto no parágrafo único do artigo 30 deste estatuto.

Art. 99. Os membros do Conselho de Administração receberão honorários em valor fixado pela assembleia geral ordinária.

Art. 100. O membro do Conselho de Administração que, em qualquer operação, tenha interesse oposto ao da cooperativa não poderá participar das deliberações referentes a essa operação, cumprindo-lhe acusar o seu impedimento.

Art. 101. No caso de vacância de todos os cargos do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal assumirá, temporariamente e de forma colegiada, a função até a posse dos novos conselheiros, a qual se dará imediatamente após a proclamação do resultado de eleição por ele convocada e realizada em até 40 dias, contados da data da vacância.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Parágrafo único. Na falta de convocação da assembleia geral pelo Conselho Fiscal, o direito de convocação caberá a qualquer cooperado.

Subseção I

Dos Comitês e Dos Órgãos De Controle

Art. 102. Para fins de assessoramento do Conselho de Administração, poderá formar os seguintes comitês e órgãos de controle:

I – Comitê de Conduta;

II – Comitê de Especialidades Médicas;

III – Comitê de Auditoria;

IV – Comitê de Inovação;

V – Secretaria de Governança;

VI – Auditoria Interna;

VII – Gestão de Riscos;

VIII – Compliance;

IX – Controles Internos;

X – Ouvidoria.

Parágrafo único. O Comitê de Conduta e o Comitê de Especialidades Médicas serão obrigatoriamente integrados apenas por cooperados.

Art. 103. O Conselho de Administração disciplinará, em regimento interno, missão, prazo de mandato, composição, atribuições e regras gerais de funcionamento de cada um dos comitês e órgãos de controle.

Art. 104. Além dos comitês obrigatórios e permanentes, o Conselho de Administração poderá criar outros para fins de assessorá-lo caso considere necessário.

Seção II

Da Superintendência Executiva

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Art. 105. O Conselho de Administração deverá contratar um profissional de mercado para ocupar a função de CEO, que terá, entre suas funções, a obrigação de fazer a ligação entre a Superintendência Executiva e o Conselho de Administração, sendo responsável pela supervisão daquela. Além disso, terá, sob sua responsabilidade, a assessoria jurídica (regulatória, contencioso, contratos e cooperativista) e a área de controladoria, responsável pelas áreas de compras, contabilidade, faturamento, financeiro, planejamento e orçamento.

Art. 106. A Superintendência Executiva é um órgão subordinado ao Conselho de Administração, responsável pelos atos de gestão cotidiana da cooperativa, composta por um CEO e quatro membros com os títulos de superintendente administrativo-financeiro, superintendente de provimento de saúde, superintendente de serviços próprios e superintendente de mercado e inovação, todos nomeados pelo Conselho de Administração para um mandato por performance.

§1º. Todos os superintendentes e o CEO deverão cumprir jornada mínima definida em contrato e possuir formação técnica compatível com o cargo, bem como comprovada competência e experiência.

§2º. Os superintendentes de provimento de saúde e serviços próprios serão obrigatoriamente médicos, podendo ou não serem cooperados.

Art. 107. Os superintendentes executivos poderão ser substituídos, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração, por maioria simples dos votos, após avaliação da performance.

Art. 108. A Superintendência Executiva rege-se, dentre outras, pelas seguintes normas:

I – reúne-se, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do CEO ou da maioria da própria superintendência, ou ainda por solicitação do Conselho de Administração;

II – delibera, validamente, com a presença da maioria de seus membros, sendo vedada a representação;

III – as deliberações serão consignadas em atas resumidas, lavradas em livro próprio ou folhas avulsas, lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes.

Art. 109. Os membros da Superintendência Executiva não serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa, em virtude de ato regular de gestão praticado nos limites das suas atribuições, mas responderão solidariamente pelos prejuízos de seus atos se procederem com culpa ou dolo ou ainda com violação da lei, do estatuto ou das determinações do Conselho de Administração.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 110. Não poderão integrar a Superintendência Executiva, além dos mencionados no artigo 84 deste estatuto, aqueles que tenham laços de parentesco com qualquer dos seus integrantes ou com os membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal, entre si até segundo grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, e o cônjuge ou companheiro.

Art. 111. Compete à Superintendência Executiva:

I – executar as políticas, diretrizes estratégicas e orientação geral dos negócios da cooperativa fixadas pelo Conselho de Administração;

II – comandar as operações diárias e de curto prazo da cooperativa;

III – identificar, avaliar e propor ao Conselho de Administração oportunidade de novos negócios;

IV – elaborar orçamento anual com estimativa da despesa e receita;

V – elaborar e propor, ao Conselho de Administração, políticas de interesse para a cooperativa;

VI – elaborar as demonstrações financeiras e o relatório de gestão, submetendo-os ao Conselho Fiscal, aos auditores independentes e ao Conselho de Administração, o qual, por sua vez, submeterá tais documentos à aprovação da assembleia geral;

VII – estabelecer objetivos, políticas e diretrizes específicas da gestão operacional;

VIII – elaborar planos de sucessão para a Superintendência Executiva;

IX – estimar e sugerir, ao Conselho de Administração, valores a serem cobrados dos contratantes de assistência médica, assim como os valores que deverão ser pagos aos cooperados, aos serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, empresas credenciadas e também aos hospitais;

X – administrar o nível de risco aceitável do negócio estabelecido pelo Conselho de Administração, identificando, mensurando e gerenciando os riscos aos quais a cooperativa está exposta;

XI – propor e implantar sistema de controles internos e de informação que assegurem adequada confiabilidade da gestão, incluindo políticas e limites de alçada;

XII – assegurar que as atividades da cooperativa sejam conduzidas de forma ética e dentro da lei;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

XIII – executar as diretrizes de governança corporativa, bem como monitorar sua observância em toda a cooperativa;

XIV – deliberar sobre assuntos considerados pelo CEO ou pelos demais superintendentes como de competência colegiada da Superintendência Executiva;

XV – desempenhar outras atividades delegadas pelo Conselho de Administração ou pela assembleia geral;

XVI – aprovar todos e quaisquer atos, contratos e documentos em valores que serão definidos pelo Conselho de Administração;

XVII – elaborar e propor, ao Conselho de Administração, uma política geral de recursos humanos e de finanças;

XVIII – estabelecer as normas de controle das operações e serviços, verificando mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro da cooperativa e o desenvolvimento das operações e serviços, por meio de balancetes e demonstrativos específicos;

XIX – contratar, sempre que julgar necessário, o assessoramento de técnicos ou especialistas para auxiliá-los no esclarecimento de assuntos a decidir;

XX – elaborar e propor, ao Conselho de Administração, as políticas de responsabilidade institucional da cooperativa, tais como meio ambiente e responsabilidade social e executar as políticas aprovadas;

XXI – realizar a contratação, dispensa e definição da remuneração dos níveis gerenciais;

XXII – implantar um sistema periódico de avaliação para os níveis gerenciais.

§1º. O CEO e os membros da superintendência executiva deverão manter, durante o mandato e após o término dele, pelo prazo de cinco anos, sigilo absoluto sobre toda e qualquer informação privilegiada, dado confidencial ou estratégico, obtidos ou recebidos no exercício do cargo, não podendo também utilizá-los para benefício próprio, respondendo administrativa, civil e criminalmente pela violação de tal dever.

§2º. O membro da superintendência executiva que, diante de qualquer matéria sob análise, perceber a existência de algum tipo de conflito de interesse, tal como interesse particular ou oposto ao da cooperativa, não poderá participar da apreciação e decisão da matéria, cumprindo-lhe acusar imediatamente o impedimento.

Art. 112. Compete ao CEO:

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

I – exercer a gestão executiva da cooperativa, coordenando e supervisionando as atividades dos demais superintendentes;

II – convocar e presidir as reuniões da Superintendência Executiva, estabelecendo dia, hora e pauta;

III – proferir voto de desempate em caso de empate em qualquer deliberação colegiada da Superintendência Executiva;

IV – assegurar, aos demais membros da Superintendência Executiva, as melhores condições de trabalho;

V – constituir-se como elo entre o Conselho de Administração e os demais superintendentes;

VI – indicar, dentre os membros da Superintendência Executiva, os substitutos dos superintendentes em casos de impedimento temporário ou ausência;

VII – manter o Conselho de Administração informado sobre o desenvolvimento das operações e atividades, o andamento dos trabalhos administrativos mais relevantes e o estado econômico-financeiro da cooperativa;

VIII – assinar os cheques bancários em conjunto com o presidente e/ou vice-presidente;

IX – assinar, em conjunto com o presidente e/ou vice-presidente, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações.

Art. 113. Compete ao superintendente administrativo:

I – exercer a gestão administrativo-financeira da cooperativa, coordenando e supervisionando as atividades e áreas correspondentes, em especial planejamento financeiro, faturamento, crédito e cobrança, controladoria, contabilidade, controle de ativos, compras e tesouraria;

II – avaliar e providenciar o montante de recursos financeiros necessários ao atendimento das operações e serviços da cooperativa;

III – promover estudos e propor alternativas para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da cooperativa;

IV – fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa da cooperativa;

V – escolher instituição financeira, bancária ou não, nas quais serão realizados negócios

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

e depositados recursos financeiros, obtendo, em seguida, a aprovação do CEO e do Conselho de Administração;

VI – garantir a adequada contabilização e o acompanhamento das operações econômico-financeiras da cooperativa;

VII – aprovar a admissão e demissão de pessoas ligadas às suas áreas de responsabilidade;

VIII – assinar, junto ao diretor-superintendente, as demonstrações financeiras da cooperativa;

IX – exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas assembleias gerais, Conselho de Administração ou pelo CEO;

X – ao CEO caberá, entre outras atribuições, as seguintes áreas: cadastro, condomínio (infraestrutura e logística), gestão da holding, gestão de pessoas (gente e RH), gestão da qualidade e gestão da tecnologia, informação e inovação.

Art. 114. Compete ao superintendente de Mercado:

I – exercer a gestão de mercado da cooperativa, coordenando e supervisionando as atividades e áreas correspondentes;

II – alinhar a área e equipe com os objetivos e posicionamento estratégico da cooperativa;

III – exercer a gestão de marketing e assessoria de imprensa;

IV – exercer a gestão da estrutura de atividades relacionadas à inteligência de mercado, envolvendo análise de dados sobre concorrência, consumidores, tendências e cenários, com o objetivo de definir políticas e processos e subsidiar informações às áreas de marketing, comunicação e comercial na busca por oportunidades de crescimento;

V – coordenar o planejamento e desenvolvimento dos produtos, aprovando preços e acompanhando o processo de vendas, monitorando resultados e adotando, se necessário, medidas corretivas;

VI – definir a estratégia comercial da cooperativa, determinando os acordos e as condições de venda interna, supervisionando a administração das vendas, coordenando a estratégia de marketing, tais como: lançamento de novos produtos e serviços, acompanhamento do mercado, política de preços, seguir as negociações comerciais de alto nível e as principais contas da cooperativa;

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

VII – responder pela gestão da cooperativa nas atividades relacionadas a vendas e planejando, organizando e controlando os programas e sua execução, avaliando resultados segundo a política específica e a política comercial para assegurar a venda dos produtos e serviços em condições que atendam aos resultados previstos, monitorar o sistema de informações comerciais, propor e manter rituais de acompanhamento do desempenho dos indicadores da área comercial, avaliar as necessidades e o grau de satisfação dos clientes e corretores;

VIII – interpretar os dados constantes nas pesquisas para orientar o setor de desenvolvimento de novos produtos, definir mudanças na política comercial e reorganização dos processos, definir o cenário para a elaboração dos planos de vendas internas, elaborar plano de lançamento de novos produtos, realizar o planejamento operacional de vendas internas, elaborar o plano de margem de contribuição, plano de precificação, comunicação, plano promocional e elaborar o orçamento por área funcional;

IX – exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas assembleias gerais, Conselho de Administração ou pelo CEO;

X – aprovar a admissão e demissão de pessoas ligadas às suas áreas de responsabilidade;

XI – ao superintendente de Mercado caberá, entre outras atividades, as seguintes áreas: gestão de vendas (pré e pós-vendas), marketing, relacionamento com clientes PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) e desenvolvimento de produtos.

Art. 115. Compete ao superintendente de Provimentos:

I – exercer a gestão da área coordenando e supervisionando as atividades e áreas correspondentes;

II – manter frequente contato com os diretores de clínicas, hospitais e chefes dos demais serviços médicos oferecidos pela cooperativa, sempre objetivando o aperfeiçoamento dos serviços;

III – avaliar qualidade, custo e utilização dos serviços que estão sendo prestados e se estão de acordo com os padrões e procedimentos estabelecidos pela cooperativa;

IV – comunicar à Superintendência Executiva e ao Conselho de Administração, por escrito e detalhadamente, eventuais irregularidades praticadas por clientes, cooperados, hospitais, clínicas e serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento;

V – apresentar à Superintendência Executiva, trimestralmente, relatório das atividades da área;

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

VI – representar a cooperativa nas negociações dos contratos a serem firmados ou renovados com hospitais, clínicas e demais serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento;

VII – verificar a necessidade de novos credenciamentos para a rede prestadora de serviços de acordo com as coberturas contratuais e segmentações dos planos de assistência à saúde ofertados;

VIII – negociar acordos com a rede credenciada para o estabelecimento de protocolos e/ou gabaritos;

IX – monitorar as autorizações de procedimentos médicos, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento e de internações hospitalares;

X – monitorar a produção médico-hospitalar;

XI – deliberar sobre todas as questões relacionadas às auditorias médicas;

XII – monitorar o processo de entrevistas qualificadas para a inclusão de novos clientes;

XIII – exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas assembleias gerais, Conselho de Administração ou pelo CEO;

XIV – aprovar a admissão e demissão de pessoas ligadas às suas áreas de responsabilidade;

XV – gerir as seguintes áreas de responsabilidade: contas médicas, rede assistencial credenciada, controle dos custos assistenciais, gestão do atendimento e gestão do OPME.

Art. 116. Compete ao superintendente de Serviços Próprios:

I – exercer a gestão da área, coordenando e supervisionando as atividades e áreas correspondentes;

II – administrar as unidades assistenciais próprias da cooperativa, monitorando os resultados e tomando medidas corretivas, se necessário;

III – propor à Superintendência Executiva e ao Conselho de Administração a criação de novas unidades próprias para atendimento dos clientes da cooperativa ou a extinção das existentes;

IV – avaliar e controlar a qualidade dos serviços e dos custos assistenciais das unidades

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

próprias;

V – prestar orientação geral no que se refere aos serviços próprios, bem como acompanhar o desempenho dos mesmos;

VI – exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas assembleias gerais, Conselho de Administração ou CEO;

VII – aprovar a admissão e demissão de pessoas ligadas às suas áreas de responsabilidade.

Art. 117. Os cooperados poderão, preferencialmente, ocupar as Superintendências de Provimentos e de Recursos Próprios se possuírem as competências necessárias para o cargo.

Parágrafo único. O sócio, no exercício do cargo, não poderá votar nem ser votado na eleição subsequente ao final do exercício do ano que ocupar a função.

CAPÍTULO X

DO CONSELHO FISCAL

Art. 118. A administração da sociedade cooperativa será fiscalizada assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal constituído de três membros efetivos e três membros suplentes, todos cooperados eleitos pela assembleia geral para um mandato de um ano, contado da data da posse, sendo permitida apenas a reeleição de um terço dos seus membros.

Art. 119. O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de, pelo menos, dois dos seus membros.

Art. 120. Em sua primeira reunião, o Conselho Fiscal escolherá um coordenador entre os seus membros efetivos, incumbido de convocar e presidir as reuniões, e um secretário que lavrará ata dos trabalhos e substituirá o coordenador na sua ausência ou impedimentos.

Art. 121. O Conselho Fiscal poderá ser convocado por qualquer um dos seus membros, por solicitação do Conselho de Administração ou da assembleia geral.

Art. 122. As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria simples de votos, sendo proibida a representação, e constarão em ata lavrada em livro próprio ou folhas avulsas, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos membros presentes.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 123. Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras, as seguintes atribuições:

I – exercer assídua e minuciosa fiscalização sobre as operações, atividades e serviços da sociedade, examinando livros, contas e documentos;

II – fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

III – verificar se os administradores estão cumprindo as determinações emanadas da assembleia geral;

IV – conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em caixa, verificando se ele está dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administração;

V – verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da sociedade;

VI – verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem em volume, qualidade e valor às previsões e às conveniências econômico-financeiras da sociedade;

VII – examinar se o montante das despesas está em conformidade com os planos e decisões do Conselho de Administração;

VIII – certificar se o Conselho de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua composição;

IX – averiguar se existem reclamações dos cooperados quanto aos serviços prestados;

X – certificar se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, previdenciárias, trabalhistas ou administrativas ou de planos de saúde;

XI – verificar se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os compromissos são atendidos com pontualidade;

XII – averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, bem como se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das regras próprias;

XIII – analisar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o relatório de gestão da Superintendência Executiva, emitindo parecer para a assembleia geral;

XIV – dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus

14/11/2024
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

trabalhos, denunciando a esse e à assembleia geral as irregularidades encontradas;

XV – convocar assembleia geral se ocorrerem motivos graves ou urgentes que justifiquem, após cumpridos os requisitos do artigo 55, §º 1º, inciso II deste estatuto.

Art. 124. Para o desempenho das suas funções, o Conselho Fiscal terá acesso a quaisquer livros, contas, documentos, empregados, cooperados e outros, independentemente de autorização prévia do Conselho de Administração.

Art. 125. Para a consecução de suas atribuições, poderá o conselho fiscal contratar assessoramento técnico especializado, inclusive serviço de auditoria.

Art. 126. Estão impedidos de integrar o Conselho Fiscal, além dos inelegíveis mencionados no artigo 82 deste estatuto, aqueles que tenham laços de parentesco entre si ou com os membros do Conselho de Administração, até o segundo grau, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta ou colateral, e o cônjuge ou companheiro.

Art. 127. Exceto na hipótese do artigo 101 deste estatuto, não se pode acumular o cargo de conselheiro de administração com o de conselheiro fiscal, e vice-versa.

Parágrafo único. Fica também proibida, a qualquer conselheiro fiscal, a acumulação remunerada de cargos na estrutura organizacional da sociedade.

Art. 128. Em caso de renúncia, impedimento ou perda do mandato, e ainda na hipótese de falecimento, os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos pelos suplentes.

Art. 129. Ficando vagos três ou mais cargos no Conselho Fiscal, o Conselho de Administração convocará assembleia geral para o seu preenchimento.

Art. 130. O membro do Conselho Fiscal que, sem justificativa, faltar a duas reuniões consecutivas ou a quatro alternadas, no período de um ano, perderá automaticamente o cargo.

Art. 131. Com a finalidade de treinamento e educação cooperativista, essenciais à formação de novos dirigentes, poderão os membros suplentes participar das reuniões e das discussões do Conselho, sem direito a voto, podendo, contudo, receberem cédula de presença.

CAPÍTULO XI

DO CONSELHO TÉCNICO

Art. 132. O Conselho Técnico será formado por seis cooperados, sendo três membros

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

efetivos e três membros suplentes, quaisquer destes para substituir quaisquer daqueles, eleitos na mesma assembleia geral que eleger os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para um período de quatro anos, sendo permitida a reeleição de, no máximo, dois terços de seus integrantes para o período imediato, cabendo-lhe as seguintes atribuições:

I – Apresentar parecer prévio sobre a admissão de cooperados, fazendo relatório pormenorizado, no caso de optar pela não admissão;

II – Receber denúncias, analisar ocorrências, instaurar processos administrativos e sindicâncias para apuração e julgamento de fatos que envolvam cooperados acusados de infringir a Lei n°. 5.764/71, o Código de Ética Médica, este estatuto, o regimento interno, normas, rotinas ou quaisquer outras disposições relativas à cooperativa, garantindo, aos cooperados acusados, amplo direito de defesa;

III – Julgar os processos administrativos e submeter suas decisões à apreciação do Conselho de Administração, recomendando a aplicação das penalidades previstas neste estatuto aos cooperados que, comprovadamente, cometerem infrações às normas relacionadas no inciso anterior;

IV – Assessorar o Conselho de Administração, no caso de eliminação de cooperados, por indisciplina ou desrespeito às normas da cooperativa, devendo apresentar relatório pormenorizado e fundamentando as argumentações que levaram a tal decisão;

V – Apresentar parecer em todos os casos que dizem respeito à inobservância do Código de Ética Médica ou à disciplina dos serviços da cooperativa;

VI – Assessorar, quando necessário, a cooperativa nas áreas por ela necessitada.

§ 1º. Os componentes do Conselho Técnico escolherão entre si um coordenador e um secretário, em sua primeira reunião.

§ 2º. O Conselho Técnico reunir-se-á sempre que houver demanda para sua apreciação, com a participação de, no mínimo, três membros. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas por qualquer um dos seus membros.

§ 3º. As deliberações serão tomadas por maioria simples de voto e constarão em ata lavrada em livro próprio ou folhas avulsas, para posterior leitura e assinatura dos membros presentes.

§ 4º. Perderá o cargo, automaticamente, o conselheiro técnico que, sem justificativa, faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou seis alternadas, durante o ano, após notificação expressa.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

§ 5º. Ocorrendo vacância, o presidente do Conselho de Administração incluirá na pauta da assembleia geral seguinte a eleição para o devido preenchimento.

CAPÍTULO XII

DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO E RELACIONAMENTO COM OS COOPERADOS

Art. 133. O Núcleo de Formação e Relacionamento com os cooperados é um órgão da cooperativa com a finalidade de preparar os cooperados para os cursos de formação cooperativista bem como implementar a política de formação permanente do quadro cooperativo e de relacionamento dos cooperados com esta.

§1º. O coordenador do Núcleo será nomeado pelo presidente do Conselho de Administração.

§2º. Na ausência do coordenador do Núcleo, os trabalhos serão coordenados por substituto indicado pelo presidente do Conselho de Administração.

§3º. O coordenador do Núcleo, em conjunto com a anuência da presidência do Conselho de Administração, nomeará secretária-geral para organizar os trabalhos inerentes.

CAPÍTULO XIII

DO BALANÇO, DAS DESPESAS, DA COBERTURA DAS PERDAS E DA DESTINAÇÃO DAS SOBRAS

Art. 134. O balanço geral anual, incluindo o confronto da receita e despesa, será levantado na data de referência de 31 de dezembro de cada ano e será publicado até o dia 31 de março, devidamente auditado por auditoria independente.

Parágrafo único. Os resultados serão apurados separadamente segundo a natureza das operações ou serviços.

Art. 135. As despesas da cooperativa serão cobertas pelos cooperados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços.

Art. 136. As perdas de cada exercício, apuradas em balanço, serão cobertas com o saldo do fundo de reserva e, sendo este insuficiente, por rateio entre os cooperados em partes diretamente proporcionais às operações e aos serviços realizados com a sociedade.

Art. 137. A assembleia poderá definir critérios de pagamento do rateio das perdas apuradas, podendo inclusive estabelecer parcelamento.

Art. 138. As sobras líquidas verificadas no exercício, depois de deduzidas as taxas para

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

os fundos legais e estatutários, serão rateadas entre os cooperados, proporcionalmente às operações e aos serviços realizados por eles no período, salvo deliberação diversa da assembleia geral.

CAPÍTULO XIV

DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 139. A cooperativa se dissolverá de pleno direito:

I – quando assim deliberar a assembleia geral, salvo se os cooperados, em número mínimo necessário para o funcionamento da cooperativa, assegurarem sua continuidade;

II – devido à alteração de sua forma jurídica;

III – pela redução do número mínimo de cooperados ou do capital social mínimo, se até a assembleia geral subsequente, realizada em prazo não superior a seis meses, esses quantitativos não forem restabelecidos;

IV – pela paralisação de suas atividades por mais de 120 dias.

§ 1°. Quando a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas neste artigo, a medida deverá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer cooperado.

§ 2°. Quando a dissolução for deliberada pela assembleia geral, esta nomeará um liquidante ou mais, e um Conselho Fiscal composto de três membros para proceder à sua liquidação.

§ 3°. A assembleia geral, nos limites de suas atribuições, poderá, em qualquer época, destituir os liquidantes e membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos.

§ 4°. Em todos os atos e operações, os liquidantes deverão usar a denominação da cooperativa seguida da expressão "em liquidação".

§ 5°. Os liquidantes, nos termos da legislação em vigor, terão todos os poderes normais de administração, podendo praticar atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo.

§ 6°. Enquanto não for extinta a sociedade, a assembleia geral poderá deliberar a cessação do estado de liquidação, mediante reposição da cooperativa em sua vida normal.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

Art. 140. O patrimônio líquido apurado, após a realização dos ativos e pagamento do passivo, será distribuído entre os cooperados remanescentes na proporção de suas quotas-partes.

Art. 141. Extingue-se a cooperativa pela publicação do arquivamento da ata de encerramento da liquidação.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS

GERAIS

Art. 142. Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos pelo Conselho de Administração de acordo com a Lei, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do Direito, ou a critério do próprio conselho, levados à assembleia geral.

Art. 143. A nova estrutura de governança, composta pelo Conselho de Administração e pela Superintendência, suas respectivas novas composições, cargos, normas e atribuições, previstas neste estatuto social, que forem introduzidas ou alteradas na assembleia geral extraordinária (AGE) de 03/2/2024, somente passarão a viger a partir da assembleia geral ordinária do ano 2025, ficando vigentes até lá aquelas que constam da consolidação estatutária aprovada na AGE de 30/1/2018.

Parágrafo único. A atual diretoria deverá, até o final do ano 2024, adequar, no que for possível, o organograma da cooperativa de tal forma a facilitar a mudança prevista no caput deste artigo, bem como as demais que tratam da governança da cooperativa.

Art. 144. O regimento interno somente poderá ser alterado em reunião conjunta do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, convocada pelo próprio Conselho de Administração para tal fim, e aprovado pela maioria dos membros efetivos de cada órgão social.

§ 1º Não havendo quórum mínimo para aprovar e/ou alterar o regimento interno, conforme disposto no caput deste artigo, será convocada nova reunião e, persistindo a falta de quórum, será convocada assembleia geral extraordinária para tal fim, com abertura de processo administrativo disciplinar para os membros ausentes injustificadamente.

§ 2º As alterações do regimento interno só passarão a viger após o seu respectivo arquivamento na Junta Comercial do Estado do Pernambuco (JUCEPE), sendo, então, o documento disponibilizado aos cooperados no site da cooperativa, na área restrita ao cooperado, bem como na sede da Unimed Caruaru.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

§ 3º Excepcionalmente, as necessárias adequações no regimento interno, em virtude das alterações estatutárias ocorridas na assembleia geral extraordinária de 03/2/2024, deverão ser objeto de deliberação, nos termos deste artigo, em até 180 dias, contados a partir da data de arquivamento da ata da referida AGE na Junta Comercial do Estado do Pernambuco (JUCEPE) e da homologação do estatuto reformado pela Unimed do Brasil.

Art. 145. As mudanças estatutárias aprovadas na assembleia geral extraordinária, específica para este fim, realizada em 03/2/2024, serão implementadas ao longo dos meses que antecederem a assembleia geral ordinária de 2025, referente ao exercício social de 2024.

I – As mudanças na governança deverão ocorrer de maneira gradativa de modo que as alterações, substituições e necessárias contratações não causem desequilíbrio financeiro e não coloquem em risco a operação da empresa;

II – Serão disponibilizados cursos de formação para conselheiros fiscais e de Administração, através do SESCOOP/PE, a partir do primeiro semestre de 2024, para todos os cooperados que desejem, ou não, ser candidatos;

III – Será disponibilizado curso de pós-graduação em Gestão de Cooperativas ou de serviços de saúde para os interessados em concorrer ao cargo de conselheiro de Administração.

TRANSITÓRIAS

Art. 146. A primeira eleição pós-reforma para o Conselho de Administração será excepcional e única, transcorrendo do seguinte modo:

I – Na primeira eleição pós-reforma, os membros do Conselho de Administração serão eleitos em uma chapa única com sete membros;

II – Os conselheiros eleitos escolherão entre si o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração;

III – Também serão eleitos, em chapa única, dois diretores executivos para um mandato de transição;

IV – Os diretores executivos serão respectivamente: um diretor administrativo e um diretor de Provimentos;

§1º A função do diretor administrativo será de realizar a transição da Diretoria Administrativa e Financeira, junto à Diretoria de Comércio e Mercado, para o modelo de Superintendência Administrativa e Superintendência de Mercado.

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

§2º A função do diretor de Provimentos será de realizar a transição das diretorias de Rede Própria e Operacional para o modelo de Superintendência de Rede Própria e Superintendência de Provimento.

§3º Os diretores terão uma carga horária mínima de 20 horas semanais e sua remuneração será definida em assembleia geral ordinária (AGO).

V – Na segunda eleição pós-reforma, elegem-se, de forma individual, os membros aptos para o Conselho de Administração, conforme o estatuto reformado, e elimina-se definitivamente a diretoria executiva.

Art. 147. O artigo 146, deste estatuto, perderá seu efeito imediatamente após o final da assembleia geral ordinária que elegerá o segundo Conselho de Administração pós-reforma estatutária.

Parágrafo Único. Após o período transitório, as regras do estatuto reformado passarão a viger na sua integralidade.

FINAIS

Art. 148. Revogam-se o estatuto anterior e todas as disposições em contrário.

Caruaru, 3 de fevereiro de 2024.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e, para constar, eu, Bel. Salomão Francisco Alves Filho, que abaixo subscrevo, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e por um grupo de 10 (dez) cooperados, nos termos do parágrafo 2°, do artigo 42 do Estatuto desta cooperativa. Caruaru, 03 de fevereiro de 2024.
****

PRESIDENTE DR. PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MELO _____

SECRETÁRIO DR. ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA JUNIOR_____

14/11/2024
Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

DR. ANDRÉ RICHARDE SOARES MUNIZ_____

DR. MARCELO GUERRA DE A. ROSENDO _____

DRA. ROBERTA DE O. TRIGUEIRO DA SILVA _____

DR. CLÁUDIO JOSÉ GOMES PIRES RAPOSO_____

DR. IGOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA_____

DR. ANTÔNIO JOSÉ DE SIQUEIRA _____

DR. JOÃO ANTÔNIO SALES CALDAS _____

DRA. LIANE MARIA GUIMARÃES RÊGO_____

DR. ALEXANDRE BRAGA GUIMARAES _____

DR. SELEM BRANDÃO ASMAR _____

Membro da Aliança Cooperativa Internacional
SistemaOCB/PE
FECOOP NE - OCB/PE - SESCOOP/PE
ANS - nº 340952

14/11/2024

Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

ADVOGADO SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO_____

Esta ata representa a expressão original do livro de atas de assembleias gerais da cooperativa. Caruaru (PE), 03 de fevereiro de 2024.

****
****

14/11/2024

Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

248565729

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**
PROTOCOLO	**248565729 - 21/08/2024**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26400000875
CNPJ 24.449.225/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2024
SOB N: 20248565729

EVENTOS

019 - ESTATUTO SOCIAL ARQUIVAMENTO: 20248565729

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02583091484 - ROBERTA DE OLIVEIRA TRIGUEIRO DA SILVA - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 04678774408 - MARCELO GUERRA DE ALBUQUERQUE ROSENDO - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 04786432415 - CLAUDIO JOSE GOMES PIRES RAPOSO - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 06349403410 - SALOMAO FRANCISCO ALVES FILHO - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 14743663415 - ALEXANDRE BEZERRA DE SOUZA JUNIOR - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 22074775415 - ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 22645578420 - PEDRO JOSE DE OLIVEIRA MELO - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 29884900400 - JOAO ANTONIO SALES CALDAS - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 41998740463 - LIANE MARIA GUIMARAES REGO - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37
Cpf: 77289781449 - ANDRE RICHARDE SOARES MUNIZ - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

1

14/11/2024

Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

248565729

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**
PROTOCOLO	**248565729 - 21/08/2024**
ATO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**
EVENTO	**007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26400000875
CNPJ 24.449.225/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2024
SOB N: 20248565729

EVENTOS

019 - ESTATUTO SOCIAL ARQUIVAMENTO: 20248565729

Cpf: 91156025591 - SELEM BRANDAO ASMAR - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37

Cpf: 96796898591 - IGOR EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA - Assinado em 14/11/2024 às 12:22:37

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

14/11/2024

Certifico o Registro em 14/11/2024
Arquivamento 20248565729 de 14/11/2024 Protocolo 248565729 de 21/08/2024 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 237136085607467

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123276700000239055237
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123276700000239055237
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:32

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO REALIZADA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2025, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Unimed Caruaru Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 24.449.225/0001-98, Número de Identificação de Registro de Empresa – NIRE – nº 26400000875, no Auditório do Shopping Difusora situado à Avenida Agamenon Magalhães, nº 44, bairro Maurício de Nassau, CEP nº 55.012-290, na cidade de Caruaru-PE. Para todos os fins legais, em razão da ausência de espaço físico suficiente e confortável para acomodar todos os 405 (quatrocentos e cinco) cooperados aptos a votar, a assembleia geral será considerada como realizada na sede da cooperativa, situada à na Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800 – bairro Indianópolis, Caruaru - PE, 55024-740 – Caruaru Corporate – 3º Andar. Após a primeira convocação realizada às 07:00h, não havendo a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados e segunda convocação realizada às 08:00h, não havendo a presença de metade mais um dos cooperados, a Assembleia teve início às 09:00h, em terceira e última convocação, com o quórum instalado de 23 (vinte e três) cooperados, compondo-se a mesa com o Dr. Pedro José de Oliveira Melo, diretor presidente da Unimed Caruaru e o Dr. Marcelo Guerra de Albuquerque Rosendo, diretor administrativo e financeiro da Unimed Caruaru. Na oportunidade, também esteve presente o Assessor Jurídico da Unimed Caruaru, Dr. Salomão Francisco Alves Filho, OAB/PE nº 27.989, designado como secretário da Assembleia Geral Ordinária, o Superintendente da cooperativa Sr. Jean Charles Ferreira dos Santos e a Contadora da cooperativa Sra. Vivian Schmidt. Devidamente composta a mesa, foi passada a palavra ao Diretor Presidente que deu boas-vindas a todos os presentes e deu início a Assembleia Geral Ordinária em cumprimento aos itens da ordem do dia. **Item 1. Instalação e abertura da Assembleia Geral Ordinária, após verificação do *quorum* legal. O início da votação ocorrerá das 09h:30min até às 18h:30min do dia 19.02.2025.** Dr. Pedro José de Oliveira Melo passou a realizar a leitura do Edital de Convocação da

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123302100000239055238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123302100000239055238
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:33

Assembleia Geral Ordinária, publicado no Jornal do Comércio, no dia 17 de janeiro de 2025, Ano 102, folha 10, nos seguintes termos: " **UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 24.449.225/0001-98 – NIRE: 264000008775 – Registro ANS: 340952 -** EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - **1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES.** O Presidente da UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em estrito respeito ao Estatuto Social da Cooperativa, no uso de suas atribuições, atendendo ao que determinam os artigos 38, §2º e 44 da lei nº 5.764/71, convoca os sócios regularmente inscritos, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária,** exclusivamente presencial, **a ser realizada na cidade de Caruaru-PE, no Auditório do Teatro Difusora**, situado à Avenida Agamenon Magalhães, nº 44, bairro Maurício de Nassau, CEP nº 55.012-290, em virtude da falta de espaço físico na sede da cooperativa para acolher confortavelmente todos os cooperados, **no dia 19 de fevereiro de 2025**, às 07:00h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 08:00h, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados; e às 09:00h terceira e última convocação, com a presença de no mínimo, 10 (dez) cooperados, em condições de votar, a fim de deliberar sobre os seguintes itens:

ORDEM DO DIA: 1. Instalação e abertura da Assembleia Geral Ordinária, após verificação do *quorum* legal. O início da votação ocorrerá das 09h:30min até às 18h:30min do dia 19.02.2025; 2. Recomposição da mesa de trabalho às 20:00h para deliberação dos demais itens da Ordem do Dia; 3. Deliberar sobre a prestação de contas do exercício anterior, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente compreendendo o relatório do Conselho de Administração, o Balanço Geral do Exercício e o Demonstrativo de contas de sobras ou perdas apuradas; 4. Dar destino às sobras ou repartir as perdas apuradas; 5. Eleição dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva de Transição, Conselho Fiscal e Conselho Técnico; 6. Fixar o valor da cédula de presença para os Membros dos diversos conselhos (Administração, Técnico e Fiscal), pelo comparecimento às respectivas reuniões, conforme previsão do art. 44, inciso IV da Lei 5.764/71; fixar o pró-labore do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; fixar

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

a remuneração dos membros da Diretoria Executiva de Transição, consoante previsão contida no artigo 146, inciso IV, §3º do Estatuto Social Reformado de 03/02/2024; 7. Deliberar sobre os Planos de Trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano entrante (2025). Para fins de *quorum,* o número de cooperados aptos a votar na presente data é de 405 (Quatrocentos e cinco) cooperados. Caruaru (PE), 17 de janeiro de 2025. UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MELO Diretor Presidente. **Notas: a)** O Balanço Patrimonial estará disponível no Portal dos Cooperados, na área de Downloads, a partir do dia 13/02/2025 através do link: http://www2.unimedcaruaru.com.br:8093/portalcooperado ; **b)** O Processo eleitoral ocorrerá em conformidade com o Estatuto Social de 30/01/2018, consoante artigos 68 a 82 do referido diploma, bem como de acordo com o Regimento Interno da Cooperativa para **eleição do novo modelo de governança** previsto nas Disposições Transitórias do Estatuto Social Reformado de 03/02/2024, em seu artigo 146. **c)** Em atenção ao disposto no artigo 75, § 3º do Estatuto Social de 30/01/2018, informa que a data limite para o protocolo do formulário do registro de chapa, com a devida documentação, para concorrer às eleições de 2025 é dia **12 de fevereiro de 2025**, até às 18:00h, na secretaria da sede da cooperativa, situada na Avenida Adjar da Silva Casé, nº 800 – bairro Indianópolis, Caruaru - PE, 55024-740 – Caruaru Corporate – 3º Andar. **d)** A votação para eleger os 07 (sete) membros do Conselho de Administração, 02 (dois) membros da Diretoria Executiva de Transição e 06 (seis) membros do Conselho Técnico, sendo 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, ocorrerá por chapa para um mandato de 4 (quatro) anos (2025 – 2028); **e)** A votação para eleger os membros 06 (seis) membros do Conselho Fiscal, sendo 03 (três) titulares e 03 (três) suplentes, ocorrerá por chapa para um mandato de 12 (doze) meses. **f) A votação ocorrerá das 09h:30min às 18h:30min no Espaço Tadeu Lins, 3º Andar do Hospital da Unimed Caruaru, situado na Rua Arthur Antônio da Silva, nº 549, bairro Universitário, Caruaru-PE** e será conduzido pela Comissão Eleitoral em conformidade com o disposto no Estatuto Social de 30/01/2018 e o Regimento Interno da Cooperativa.

Após a leitura do Edital, Dr. Pedro José de Oliveira Melo esclareceu a Assembleia que a votação prevista na alínea "f" das Notas previstas no Edital de Convocação não ocorrerá

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

por deliberação da Comissão Eleitoral, uma vez que não houve a inscrição de chapa concorrente, de maneira que a eleição ocorrerá por aclamação pela Assembleia. Ato seguinte, Dr. Pedro José de Oliveira Melo declarou suspensa a Assembleia, devendo os trabalhos retornarem às 20:00h. Em continuidade aos trabalhos foi recomposta a mesa às 20:00h, em cumprimento ao Edital de Convocação em seu **Item 2 – Recomposição da mesa de trabalho às 20:00h para deliberação dos demais itens da Ordem do dia –** Com a palavra Dr. Pedro José de Oliveira Melo recompôs a mesa dos trabalhos e deu continuidade à Assembleia Geral Ordinária, passando a deliberar sobre os demais itens constantes do Edital de Convocação. **Item 3. Deliberar sobre a prestação de contas do exercício anterior, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente compreendendo o relatório do Conselho de Administração, o Balanço Geral do Exercício e o Demonstrativo de contas de sobras ou perdas apuradas.** Com a palavra Dr. Pedro José de Oliveira Melo iniciou a exposição sobre a prestação de contas realizando uma breve retrospectiva do ano de 2024 informando crescimento do PIB em cerca de 2,3%, mas o Brasil ainda enfrentou desafios estruturais e aumento da carga tributária. O governo buscou equilíbrio fiscal, enquanto o cenário global foi impactado por instabilidades geopolíticas e pelo avanço acelerado da inteligência artificial. A tecnologia transformou a saúde, auxiliando diagnósticos, gestão hospitalar e eficiência no atendimento. A regulação da ANS se tornou mais rígida, exigindo maior transparência e sustentabilidade financeira das operadoras. A interoperabilidade dos sistemas avançou, mas ainda há desafios na integração plena entre saúde pública e privada. O envelhecimento populacional e a alta no diagnóstico de transtornos do desenvolvimento, como o autismo, seguiram pressionando o setor. Cooperativas médicas tiveram que se adaptar a um ambiente competitivo, investindo em eficiência operacional e inovação. Fusões e aquisições aumentaram, redefinindo o mercado. Modelos de remuneração baseados em desfechos clínicos continuaram ganhando espaço, incentivando o uso racional de recursos. O planejamento estratégico para os próximos anos precisará considerar a transformação digital, novos modelos assistenciais e a sustentabilidade financeira das operadoras. Essa retrospectiva fornece uma visão clara dos desafios e oportunidades que a cooperativa considerou no planejamento de 2025 a 2028 que apresentaremos ao final da AGO no

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Plano de Trabalho. Após a breve explanação da retrospectiva do último ano, Dr. Pedro José de Oliveira Melo passou a apresentar a evolução da carteira de clientes de 2021 a 2024, evidenciando um aumento na carteira de beneficiários de plano de saúde de 69.202 vidas, em 2023, para 72.427 vidas em 2024. Foi apresentada a distribuição por tipos de plano e os impactos financeiros dos contratos não regulamentados, evidenciando um aumento da sinistralidade deste grupo de 131%, em 2023, para 138% em 2024. Foi apresentado, também, a inversão na balança entre planos PF e PJ, com 55% em distribuídos em há mais planos de pessoa jurídica e 45% dos beneficiários em planos de pessoa física, número este aquém da média de mercado (83% PJ e 17% PF), porém que evidencia simbolicamente a mudança de chave da Cooperativa quanto a venda de planos para pessoa jurídica que traçou como meta para 2025 o aumento do percentual para 59% de planos PJ. Em seguida, foi apresentada a evolução da mensalidade *per capita*, comparando os dados da Unimed Caruaru com outras Cooperativas Médicas, cuja fonte foi o MV/ANS no período de 2021 a 2024. Ato seguinte, foi apresentada a evolução do faturamento total bruto da cooperativa, detalhado por receitas de mensalidades, intercâmbio e demais receitas. Em números, retirados os efeitos da Resolução Normativa 517/2022 da Agência Nacional de Saúde (antiga RN 430), foram faturados R$ 499,78 milhões de reais de faturamento em 2024, sendo R$ 373,62 milhões de reais referentes às receitas de mensalidades de planos de saúde, R$ 93,01 milhões de reais de receita com intercâmbio e R$ 33,15 milhões de reais de outras receitas de atendimentos particulares, entre outras. Apresentou as evoluções de receitas e despesas financeiras da cooperativa e a evolução das aplicações e empréstimos. Também foram apresentados os custos assistenciais da Unimed Caruaru, que atingiram em 2024 a importância de R$ 331,20 milhões de reais. Foi apresentado o comparativo da sinistralidade da Unimed Caruaru com o mercado no que se refere a evolução da frequência e do custo médio das consultas, evolução de frequência e do custo médio das OSA's, evolução da frequência e custo médio dos exames, evolução da frequência e custo médio das terapias, evolução da frequência e custo médio com internações. Foi apresentado, ainda, a evolução do custo médio de OPME de 2021 a 2024, evidenciando um custo evitado em 2024 no montante de R$ 2,78 milhões, através da atuação da Coordenação de Auditoria e Diretoria. Foi apresentada, ainda, a redução do ticket médio

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123302100000239055238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123302100000239055238
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:33

no Hospital da Unimed Caruaru de R$ 5.998,75 em 2023 para R$ 5.148,88 em 2024. Foi apresentada, também, a evolução dos números de cirurgias no Hospital Unimed Caruaru. Em seguida, Dr. Pedro José de Oliveira Melo apresentou a evolução dos custos assistenciais no intercâmbio no período de 2021 até 2024. Em seguida também foi apresentada a evolução do Saldo da PEONA, no período de 2021 até 2024, sendo esta última no valor de R$ 16,52 milhões. Apresentou a evolução da sinistralidade da Unimed Caruaru x Sinistralidade do mercado de saúde suplementar, pontuando que a sinistralidade da Unimed Caruaru fechou o ano de 2024 em 89,5%, estando acima da média das cooperativas médicas, que foi de 83,3%. Também apresentou o quantitativo das Notificações de Investigação preliminar - NIP e de demandas judiciais no período de 2021 até 2024, evidenciando uma queda de NIPS recebidas, decrescendo de 398, em 2023, para 233 em 2024. Informou sobre os quantitativos de Judicialização indicando o total de 312 novos processos em 2024, dos quais 155 com decisões liminares. Evidenciou a evolução dos custos com judicialização de 2021 a 2023, bem como apresentou os custos acentuados com demandas de Home Care e Terapias não médicas que representam mais de 71% do custo total da judicialização. Em seguida, Dr. Pedro José de Oliveira Melo, apresentou a evolução da produção dos cooperados, evolução desta sobre a despesa assistencial e sobre a receita líquida, tudo no período de 2021 a 2024. Foi demonstrado o número crescente de beneficiários inscritos na MEDPREV, saindo de 1.846, em 2020, para 14.303 em 2024. Em seguida, foi apresentado o custo evitado no ano de 2024 com o Programa Viver Bem em Casa demonstrando os custos com diárias no HUC R$ 1.185,07 e no Programa Viver bem R$ 348,00, resultando no custo evitado total de R$ 5,54 milhões em 2024. Demonstrou a evolução dos gastos com terapias especializadas infantis de 2021 a 2024, individualizando os gastos com reembolso ao beneficiário, clínicas credenciadas e intercâmbio, cobrança direta e rede própria, totalizando um custo R$ 27,29 milhões gastos em 2024 evoluindo 2073% quando comparado a 2018. Apresentou o impacto do custo evitado no HUC e Operadora no valor de R$ 5,26 milhões de reais em 2024. Em seguida, foi apresentado um resultado negativo nos recursos próprios no valor de R$ 7,27 milhões, ponderando a elevação dos gastos com o tratamento de terapias não médicas e a necessidade de contratação de mão de obra médica via pessoa jurídica

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123302100000239055238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123302100000239055238
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:33

para ocupar os postos de trabalho deficitários no Hospital Unimed Caruaru, destacado que os serviços de internações e atendimentos fossem realizados todos no intercâmbio custariam R$ 110,92 milhões a mais do que custaram na rede própria. Na sequência também foi apresentada a evolução da despesa administrativa e o déficit do plano de saúde do cooperado/colaborador. Foi demonstrada a evolução do resultado líquido dos exercícios de 2021 a 2024. Em seguida, foi apresentada a evolução do patrimônio líquido de 2021 a 2024, resultando em R$ 71,74 milhões de reais em 2024. Ao final, Dr. Pedro José de Oliveira Melo evidenciou que, do faturamento bruto de R$ 499,78 milhões de reais, 85,9% dos gastos ocorreu com despesas assistenciais, 8% com despesas administrativas, 4,8% despesas operacionais e financeiras e 0,8% com tributos, apresentando um resultado líquido positivo de R$ 2,65 milhões de reais em 2024. Por fim, Dr. Pedro José de Oliveira Melo apresentou as perspectivas para Saúde Suplementar em 2025 considerando cenários externos e internos. Logo após foram apresentadas as demonstrações contábeis contemplando o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa. Após a apresentação, foi franqueada a palavra aos cooperados para eventuais esclarecimentos. Concedida a palavra ao Auditor Independente, o Sr. Fabio Santos, representante da Walter Heuer Auditores e Consultores, este procedeu com a leitura do Relatório da Auditoria Independente que opinou pela aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis da Unimed Caruaru Cooperativa de Trabalho Médico relativas ao exercício de 2024, por se apresentarem adequadas em todos os aspectos relevantes e refletirem a posição patrimonial e financeira da Cooperativa. O auditor também destacou o encerramento do Termo de encerramento do TAOEF – Termo de Assunção de Obrigações Econômico Financeiras, destacando o início da celebração em julho de 2019, e o equacionamento das anormalidades econômicas e concessão do pedido de encerramento em julho de 2024. Em seguida, Dr. Pedro José de Oliveira Melo solicitou ao membro do Conselho Fiscal, Dr. Eraldo Emanoel Simões Barbosa Filho para realizar a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, o qual decidiu pela aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis referentes ao exercício do ano de 2024, com fundamento no parecer dos auditores independentes. Em seguida Dr. Pedro José de Oliveira Melo franqueou a palavra aos cooperados, que nada questionaram. Em ato

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

contínuo, o Dr. Pedro José de Oliveira Melo solicitou que a Assembleia indicasse um dos cooperados, a fim de presidir a mesa para deliberações do **Item 3**, sendo eleito pela Assembleia secretário *ad hoc* o Dr. Antônio José de Siqueira para condução dos trabalhos relativos à votação do balanço com o auxílio do Dr. Pedro Braz de Macedo Filho. Em continuidade e após reiterar os esclarecimentos sobre o procedimento de votação, o Dr. Antônio José de Siqueira passou a presidir os trabalhos e submeteu à Assembleia a deliberação sobre aprovação do Balanço, **sendo decidido, por unanimidade, pela aprovação do balanço patrimonial de 2024**. **ITEM 4 - Dar destino às sobras ou repartir as perdas apuradas.** Com a palavra, o Dr. Pedro José de Oliveira Melo apresentou o resultado líquido no valor de **R$ 2,65 milhões de reais**, sendo obrigatória a dedução de 10% para o Fundo de Reserva no valor equivalente a **R$ 0,27 milhões de reais** e 5% para o FATES no montante de **R$ 0,13 milhões de reais**, restando o saldo a disposição desta AGO no valor de **R$ 2,25 milhões de reais**. Dr. Pedro José de Oliveira Melo explicou que o patrimônio líquido da Cooperativa é de R$ 71,74 milhões de reais, devendo ser deduzido R$ 24,22 milhões de reais de deduções legais conforme regra da ANS (Agência Nacional de Saúde), resultando no patrimônio líquido ajustado de R$ 47,52 milhões de reais e destacou os riscos que compõem o capital baseado em riscos, que totalizam R$ 43,10, demonstrando que há uma suficiência de 110%. Como faz-se necessário a vigilância para não ficar insuficientes no Capital Baseado em Riscos e a cooperativa ter a necessidade de captar recursos dos cooperados, foi apresentada a proposta da Diretoria Executiva de transferir o resultado líquido **R$ 2,25 milhões de reais** para compor o Fundo de Reserva de Resultado, garantindo a sustentabilidade da cooperativa. Em seguida foi franqueada a palavra aos cooperados para esclarecimentos. Após os debates, a proposta da Diretoria Executiva para transferência do **R$ 2,25 milhões de reais** para compor o Fundo de Reserva de Resultado, **foi aprovada por unanimidade, pela Assembleia**. **ITEM 5. Eleição dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva de Transição, Conselho Fiscal e Conselho Técnico -** Com a palavra Dr. Pedro José de Oliveira Melo passou a palavra ao Dr. Gileno Alves de Arruda, coordenador da Comissão Eleitoral da Unimed Caruaru para apresentação do item 5 da Ordem do Dia. Com a palavra Dr. Gileno Alves de Arruda informou que foi nomeado coordenador da Comissão Eleitoral

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

da Unimed Caruaru, a qual fora composta por Dr. Antônio José de Siqueira, Dr. Alexandre Braga Guimarães, Dr. Alberes Amorim Marinho e Dr. Carlos Laerson Soares, nos exatos termos previsto no artigo 72 do Estatuto Social de 30/01/2018. Lembrou aos cooperados que o prazo para inscrição das chapas para concorrer às eleições para os cargos de Conselho de Administração, Diretoria Executiva de Transição, Conselho Técnico e Conselho fiscal encerrou no dia 12/02/2025, consoante previsto no Edital de Convocação da AGO. Esclarece que foi inscrita uma única chapa concorrente às eleições, a qual fora denominada **"Conhecer para Transformar"** e fez a leitura dos nomes dos seus integrantes e seus respectivos cargos. Informou que a chapa apresentou todos os documentos necessários previstos no Estatuto Social e no Regimento Interno, sendo acatado o pedido de registro da chapa. Em seguida foi dada publicidade imediata a chapa inscrita, bem como aberto o prazo de 2 (dois) dias para impugnação, tendo transcorrido o prazo sem qualquer oposição, sendo, portanto, homologado o pedido de inscrição da chapa "Conhecer para Transformar" para concorrer às eleições para mandato 2025/2028. Diante da ausência de concorrência, bem como não havendo sentido realizar a votação individual, a Comissão Eleitoral, com base no artigo 81 do Regimento Interno de 2018, optou pela eleição da chapa "Conhecer para Transformar" por ACLAMAÇÃO pela assembleia, a fim de otimizar os trabalhos. Após os devidos esclarecimentos e demonstrada a legalidade do processo eleitoral, foi declarada eleita a chapa **"Conhecer para Transformar"** para o mandato de 4 (quatro) anos para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva de Transição, Conselho Técnico e mandato de 1 (um) ano para o Conselho fiscal. Sendo assim, foram eleitos os seguintes cooperados. Sendo assim, foram eleitos os seguintes cooperados: **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: **Conselheiro de Administração**: Dr. Pedro José de Oliveira Melo, CRM nº 8722, RG nº 1.436.660 SSP/PE, CPF nº 226.455.784-20, PIS nº 11207242491, residente na Av. Marcionilo Francisco da Silva, nº 198, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-380; **Conselheiro de Administração**: Dr. André Richarde Soares Muniz, CRM nº 12.488, RG nº 4.301.302 SSP/PE, CPF nº 772.897.814-49, PIS nº 11970682862, residente na Rua José Rodrigues da Silva, nº 25, Edf. Solar das Acacias, Apto-201, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-800; **Conselheiro de Administração**: Dr. Almir Barbosa dos Santos, CRM nº 9207, RG nº

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

2.030.461 SSP/PE, CPF nº 656.714.904-30, PIS nº 11275177985, residente na Rua Pedro Jordão, nº 115, Apto-1702, bairro Maurício de Nassau, Caruaru- PE, CEP 55.012-640; **Conselheiro de Administração**: Dr. Deivy Faeirstein, CRM nº 21.685, RG nº 7.327.552 SDS/PE, CPF nº 084.238.974-19, PIS nº 26743545587, residente na Av. Marcionilo Francisco, nº 1 , Apto-102, bairro Sta. Maria Gorette, Caruaru-PE, CEP 55.016-620; **Conselheiro de Administração**: Dr. Ivanildo Sobral Florêncio CRM nº 17130, RG nº 2002002141628 SSP/CE, CPF 012.223.274-73, PIS nº 19035056100, residente na Rua Pastor Rubem Prado, Edf. Andrezza, nº 187, Apto-1001, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-395; **Conselheiro de Administração**: Dr. Selem Brandão Asmar, CRM nº 18272, RG nº 7093668-41 SSP-BA, CPF nº 911.560.255-91, PIS nº 19020600187, residente na Rua Ana Maria da Silva Brasileirinho, nº 39, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-325; **Conselheiro de Administração**: Dra. Veruska da Silveira Sarmento CRM nº 12572, RG nº 1.511.293 SSP/PB, CPF nº 440.887.953-34, PIS nº 11683875081, residente na Rua Luzia Florêncio Porto, nº 200, Edf. Clarissa, Apto-102, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-740. **DIRETORIA EXECUTIVA DE TRANSIÇÃO**: **Diretor Administrativo:** Dr. Marcelo Guerra de Albuquerque Rosendo, CRM nº 17.221, RG nº 4.445.033 SDS/PE, CPF nº 046.787.744-08, PIS nº 19035788144, residente na Rua Victor Hugo, nº 61- Apto-301, bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.016-520; **Diretora de Provimentos**: Dra. Roberta de Oliveira Trigueiro da Silva, CRM nº 13.116, RG nº 4.778.985 SSP/PE, CPF nº 025.830.914-84, PIS nº 19019994525, residente na Rua Lourdes Tabosa, 1QD-JLT-01, Prive Quintas da Colina, CEP 55000-000; **CONSELHO TÉCNICO: Conselheiro Técnico Efetivo**: Dr. Eraldo Emanoel Simões Barbosa Filho, CRM nº 10.266, RG nº 3.021.311 SSP/PE, CPF nº 611.448.434-72, PIS nº 12532096987, residente na Rua Leocania Maria, nº 97, bairro Nova Caruaru, Caruaru-PE, CEP 55.014-520; **Conselheiro Técnico Efetivo**: Dr. Pedro Paulo Medeiros Araújo de Moura, CRM nº 20168, RG nº 002037864 SDS/RN, CPF nº 047.660.504-01, PIS nº 13032135647, residente na Avenida Amazonas, nº 1203, Apto-1201, bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.016-430; **Conselheiro Técnico Efetivo**: Dr. Rogério Ferreira dos Santos, CRM nº 12589, RG nº 1.017.442 SSP/AL, CPF nº 955.268.624-53, PIS nº 19034273493, residente no Sitio Lagoa do Algodão, nº 502- QD-1LT 1, bairro São Rafael, Caruaru-PE, CEP 55.000-000;

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Conselheiro Técnico 1ª Suplente: Dr. Ismar Gomes de Lucena Neto, CRM nº 21651, RG nº 2000099189519 SSP/CE, CPF nº 025.193.103-08, PIS nº 20199874810, residente na Avenida Amazonas, nº 1203, Apto-1801, bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.016-430; **Conselheiro Técnico 2ª Suplente**: Dr. José Carlos Ferreira da Silva Filho CRM nº 10284, RG nº 2.898.105 SDS/PE, CPF nº 471.457.494-91, PIS nº 11344247630, Rua Ana Maria da Silva Brasileirinho, nº 77, Ed. Antares BL 01, Apt 302, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-325; **Conselheira Técnica 3ª Suplente**: Dra. Patricia Anizia dos Santos, CRM nº 30774, RG nº 002090040 SSP/RN, CPF nº 013.601.114-41, PIS nº 20630029169, residente na Rua Aspicueta Navarro, nº 199/801, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-706; **CONSELHO FISCAL**: **Conselheiro Fiscal Efetivo**: Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins, CRM nº 20619, RG nº 6813211 SDS/PE, CPF nº 051.488.444-42, PIS nº 11992548956, residente na Rua Gonçalves Ledo, nº 999, Apt-1402, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-350; **Conselheiro Fiscal Efetivo**: Dr. João Antonio Sales Caldas, CRM nº 9615, RG nº 1.897.894 SSP/PE, CPF nº 298.849.004-00, PIS nº 11208996228, residente na Rua Paraiso, nº 100 , Cond. Alphaville - QD- C LT-10, bairro Nova Caruaru, Caruaru-PE, CEP 55.014-435; **Conselheiro Fiscal Efetivo**: Dr. Múcio Roberto Silva Calazans, CRM nº 11341, RG nº 3.222.952 SSP/PE, CPF nº 520.261.914-68, PIS nº 11616365379, Rua Acacia Sombreira , nº 01, Cond. Quintas da Colina, bairro Universitário, Caruaru-PE, CEP 55.000-000; **Conselheiro Fiscal 1º Suplente**: Dr. José Albérico Patriota, CRM nº 5312, RG nº 872.718 SSP/PE, CPF nº 495.430.407-53, PIS nº 11003554835 residente na Av. Dom Bosco, nº 409, ED S. MA408 , Apto 101, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-400; **Conselheiro Fiscal 2º Suplente**: Dr. José Carlos Azevedo Bouçanova, CRM nº 8251, RG nº 1.777.283 SSP-PE, CPF nº 235.524.844-34, PIS nº 11724327180, residente na Av. Agamenon Magalhães, nº 444, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.012-290; **Conselheiro Fiscal 3º Suplente**: Dr. Ronaldo Alves de Souto CRM nº 11750, RG nº 8.909.374 SDS/PE, CPF nº 714.396.254-68, PIS nº 19008363936, residente na Rua São Gabriel, nº 411, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE, CEP 55.014-300. Com a palavra, Dr. Pedro José de Oliveira Melo informou a Assembleia que, em cumprimento ao artigo 146, inciso II do Estatuto Social de 03/02/2024, os Conselheiros de Administração se reuniram para definição de quem será

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

o Presidente e o Vice-presidente, de maneira que concedeu a palavra ao Conselheiro Dr. Almir Barbosa dos Santos para proclamar o resultado. Com a palavra, Dr. Almir Barbosa dos Santos saudou os cooperados e disse que, diante da ausência de inscrição da chapa concorrente, bem como transcorrido o prazo, no dia 17/02/2025, sem qualquer impugnação à inscrição da Chapa "Conhecer para Transformar", visando dar celeridade a transição, os membros do Conselho de Administração se reuniram para definir a eleição do Presidente e Vice-presidente do Conselho de Administração, tendo sido deliberado, por unanimidade, que a presidência da cooperativa será ocupada pelo Dr. Pedro José de Oliveira Melo e a vice-presidência pelo Dr. André Richarde Soares Muniz. Portanto, em cumprimento ao 146, inciso II do Estatuto Social de 03/02/2024, foi escolhido o conselheiro Dr. Pedro José de Oliveira Melo para ocupar a presidência do Conselho de Administração e o conselheiro Dr. André Richarde Soares Muniz para ocupar a Vice-presidência do Conselho de Administração da Unimed Caruaru Cooperativa de Trabalho Médico. **ITEM 6. Fixar o valor da cédula de presença para os Membros dos diversos conselhos (Administração, Técnico e Fiscal), pelo comparecimento às respectivas reuniões, conforme previsão do art. 44, inciso IV da Lei 5.764/71; fixar o pró-labore do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva de Transição, consoante previsão contida no artigo 146, inciso IV, §3º do Estatuto Social Reformado de 03/02/2024. –** Com a palavra, Dr. Pedro José de Oliveira Melo esclareceu aos cooperados que, com a nova governança prevista no Estatuto Social de 03/02/2024, é necessário deliberar sobre a cédula de presença dos Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico, além do pró-labore do Presidente e Vice-Presidente do CONAD e a remuneração da Diretoria Executiva de Transição. Informou que o Presidente do Conselho de Administração terá dedicação exclusiva à Cooperativa e carga horária mínima de 30 horas semanais, o Vice-presidente terá carga horária mínima de 20 horas semanais e os Diretores Executivos absorverão as quatro diretorias previstas no antigo Estatuto para realização da transição para as superintendências e terão carga horária mínima de 20 horas semanais. O Conselho de Administração terá reunião semanal de 4 horas e cada conselheiro passará a acompanhar uma das áreas da gestão da Cooperativa. Informou, ainda, que os

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Conselhos Fiscal e Técnico terão frequência de reunião ordinária mensal, podendo haver reuniões extraordinárias caso necessário. Ato seguinte, Dr. Pedro José de Oliveira Melo trouxe à Assembleia que base de cálculo para definição da proposta a ser deliberada considerou o valor do faturamento líquido anual da Cooperativa do exercício de 2024 no montante de R$ 495.836.832,67 (quatrocentos e noventa e cinco milhões oitocentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), bem como explicou que o valor mensal pago aos dirigentes de empresas privadas varia de 3% a 7% do faturamento e nas cooperativas médicas varia de 1% a 3%. Baseado na pesquisa de mercado, **a proposta apresentada a Assembleia** é de **0,55%** do faturamento líquido anual em 2024, que soma a quantia mensal de **R$ 227.258,55 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, a ser distribuído da seguinte forma: **1) Conselho de Administração** – **15%** do valor mensal = **R$ 34.088,78** – distribuído para os 5 (cinco) Conselheiros, resultando na quantia mensal de **R$ 6.817,76** para cada conselheiro; **2) Conselho Fiscal** – **4,5%** do valor mensal = **R$ 10.226,64** – distribuído para os 6 (seis) conselheiros, resultando na quantia mensal de **R$ 1.704,44** para cada conselheiro; **3) Conselho Técnico** – **2,25%** do valor mensal – **R$ 5.113,32** – distribuído para os 3 (três) conselheiros, resultando a quantia mensal de **R$ 1.704,44** para cada conselheiro; **4) Presidente do Conselho de Administração** – **26,8%** do valor mensal = **R$ 60.905,30**; **5) Vice-presidente do Conselho de Administração** – **17,5%** do valor mensal = **R$ 38.974,85** e **6) Diretoria Executiva de Transição** – **34,30%** do valor mensal = **R$ 77.949,70** – distribuído para os 2 (dois) diretores, resultando na quantia mensal de **R$ 38.974,85** para cada Diretor. Em seguida foi franqueada a palavra aos cooperados para esclarecimentos. Após os debates, Dr. Pedro José de Oliveira Melo convidou o secretário nomeado *ad hoc*, Dr. Antônio José de Siqueira para condução dos trabalhos relativos à votação da proposta apresentada a plenária. Após a votação, **foi aprovado por maioria, o percentual de 0,55% do faturamento líquido anual em 2024**, que soma a quantia mensal de **R$ 227.258,55 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**, a ser distribuído da seguinte forma: **1)** Conselhos de Administração, Fiscal e Técnico, será pago a cédula de presença no valor de **R$**

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

1.704,44 para cada conselheiro por reunião; **2) Presidente do Conselho de Administração** – Pró-labore no valor **R$ 60.905,30** por mês; **5) Vice-presidente do Conselho de Administração** – Pró-labore no valor **R$ 38.974,85** por mês e **6) Diretoria Executiva de Transição** – Remuneração no valor de **R$ 38.974,85** para cada Diretor por mês.

ITEM 07. Deliberar sobre os Planos de Trabalhos formulados pelo Conselho de Administração para o ano entrante (2025). Com a palavra Dr. Pedro José de Oliveira Melo informou que, com base nos temas mais debatidos ao longo dos anos da gestão que se finda, a nova, será pautada nos seguintes eixos estratégicos: **Atendimento**: Humanizar e otimizar os processos para garantir excelência no cuidado ao paciente (Jeito de Cuidar Unimed); **Auditoria**: Consolidar e inovar com novas ferramentas e sistematizações que otimizem o uso adequado dos nossos recursos; **Comércio e Mercado**: Diversificar a oferta de produtos e serviços visando gerar novas e sustentáveis formas de receita; **Holding**: Robustecer a estrutura organizacional, promovendo sustentabilidade, inovação, crescimento e renda para os sócios; **Inovação e Tecnologia**: Investir em sistemas modernos que otimizem processos, promovam eficiência e garantam avanços sustentáveis. Avançar no uso de inteligência artificial e biometria facial em toda a rede; **Jurídico**: Assegurar transparência e segurança em todas as relações institucionais e contratuais em defesa da marca e da nossa cooperativa; **Marketing e Comunicação**: Ampliar a visibilidade da cooperativa, valorizando o trabalho dos cooperados e sua contribuição à sociedade; **Participação Social**: Imiscuir o nome e a marca Unimed com eficiência e eficácia no plano cultural e social das cidades que configuram nossa área de atuação; **Remuneração**: Introduzir novos e justos modelos de pagamento tendo como princípio básico a valorização do ato médico e **Verticalização Plena**: Buscar incessantemente meios para ampliar cada vez mais a rede própria para evitar custos e gerar novos postos de trabalho. Após a apresentação, Dr. Pedro José de Oliveira Melo facultou à Assembleia a apresentação de novas propostas, o que não houve. Após os debates, esclarecimentos e votação sobre o tema, **a Assembleia aprovou, por unanimidade, as propostas acima**.

Em seguida Dr. Pedro José de Oliveira Melo informou que a pauta da Assembleia Geral Ordinária está cumprida. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a

14/05/2025
JUCEPE
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

presença de todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e, para constar, eu, Dr. Salomão Francisco Alves Filho, que abaixo subscrevo, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e por um grupo de 10 (dez) cooperados, nos termos do parágrafo 2°, do artigo 42 do Estatuto social de 30/01/2018.

****

PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA MELO _____

ANDRÉ RICHARDE SOARES MUNIZ_____

MARCELO GUERRA DE A. ROSENDO _____

ROBERTA DE O. TRIGUEIRO DA SILVA _____

ALMIR BARBOSA DOS SANTOS_____

FILIPE ARAGÃO FELIX_____

IVANILDO SOBRAL FLORÊNCIO_____

ANTÔNIO JOSÉ DE SIQUEIRA_____

14/05/2025
Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

SELEM BRANDÃO ASMAR_____

JOÃO ANTONIO SALES CALDAS_____

SALOMÃO FRANCISCO ALVES FILHO_____

JEAN CHARLES FERREIRA DOS SANTOS_____

VIVIAN SCHMIDT_____

Esta ata representa a expressão original do livro de atas de assembleias gerais da cooperativa. Caruaru (PE), 19 de fevereiro de 2025.

****
****

14/05/2025

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123302100000239055238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123302100000239055238
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:33

259471569

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**
PROTOCOLO	**259471569 - 28/03/2025**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26400000875
CNPJ 24.449.225/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025
SOB N: 20259471569

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259471569

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01222327473 - IVANILDO SOBRAL FLORENCIO - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:47
Cpf: 02161911490 - JEAN CHARLES FERREIRA DOS SANTOS - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:47
Cpf: 02583091484 - ROBERTA DE OLIVEIRA TRIGUEIRO DA SILVA - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:47
Cpf: 04678774408 - MARCELO GUERRA DE ALBUQUERQUE ROSENDO - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:47
Cpf: 05826604409 - FILIPE ARAGAO FELIX - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:47
Cpf: 06349403410 - SALOMAO FRANCISCO ALVES FILHO - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 08423897419 - DEIVY FAEIRSTEIN - Assinado em 22/04/2025 às 21:36:28
Cpf: 22074775415 - ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 22645578420 - PEDRO JOSE DE OLIVEIRA MELO - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 29884900400 - JOAO ANTONIO SALES CALDAS - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

14/05/2025

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722123302100000239055238
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722123302100000239055238
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:12:33

259471569

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**
PROTOCOLO	**259471569 - 28/03/2025**
ATO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**
EVENTO	**006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA**

MATRIZ

NIRE 26400000875
CNPJ 24.449.225/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025
SOB N: 20259471569

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20259471569

Cpf: 44088795334 - VERUSKA DA SILVEIRA SARMENTO - Assinado em 22/04/2025 às 19:38:22
Cpf: 65671490430 - ALMIR BARBOSA DOS SANTOS - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 77289781449 - ANDRE RICHARDE SOARES MUNIZ - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 88429318291 - VIVIAN SCHMIDT - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48
Cpf: 91156025591 - SELEM BRANDAO ASMAR - Assinado em 22/04/2025 às 11:48:48

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

2

14/05/2025

Certifico o Registro em 14/05/2025
Arquivamento 20259471569 de 14/05/2025 Protocolo 259471569 de 28/03/2025 NIRE 26400000875
Nome da empresa UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 186255424971980

AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480
Autor(a): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Réu: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados constituídos, vem à presença de Vossa Excelência apresentar **MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** em face de MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.

1. SÍNTESE FÁTICA

O(A) Autor(a) de fato é usuário(a) de plano de saúde individual/familiar administrado pela Unimed Caruaru, cujo nome comercial é "Único Enfermaria Pessoa Física III", com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e área de abrangência regional (grupo de municípios). O plano foi contratado em 26/10/2005, de forma que é regulamentado pela Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), conforme dispõe o seu art. 35, *caput*. Tudo isso conforme cópia do contrato de plano de saúde, proposta de adesão e relatórios anexos **(docs. 01, 02 e 03)**.

Em sua petição inicial, a autora alega ser portadora de **macromastia com repercussão funcional na coluna vertebral**. Sustenta que o médico assistente indicou a realização de **mamoplastia redutora de caráter reparador** em razão da sua condição clínica.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

Contudo, alega que a solicitação do procedimento foi negada pela operadora sob a justificativa de se **tratar de cirurgia com natureza estética**. A demandante sustenta que a recusa se baseou em cláusula de exclusão contratual (art. 54, VIII) considerada abusiva à luz das regras de proteção ao consumidor. Narra, por fim, que optou por agendar o procedimento de forma particular para o dia 13 de junho de 2026. Informa o desembolso prévio de R$ 10.100,00 referentes a honorários e materiais, apontando a estimativa de um custo remanescente de R$ 9.900,00 a ser pago no momento da internação.

Diante da narrativa apresentada, a parte formulou pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente a cirurgia de mamoplastia redutora. No despacho ID. 242085446, o juízo determinou que a Ré fosse intimada para falar sobre o pedido de tutela antecipada.

Em que pese as alegações da inicial, o pedido de antecipação da tutela não deve prosperar.

2. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA

O art. 300 do CPC dispõe que tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*caput*) e quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso concreto, não o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo.

2.1. Da inexistência de probabilidade do direito – Procedimento expressamente excluído da cobertura contratual e do Rol da ANS – Não preenchimento dos requisitos da ADI 7.265 do STF

O deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. A análise dos autos certifica a ausência dos pressupostos legais.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

A pretensão autoral objetiva impor a cobertura do procedimento "mamoplastia para correção da hipertrofia mamária". A técnica cirúrgica pleiteada, contudo, **não compõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)**.

A autarquia federal afasta a obrigatoriedade da cobertura no parecer técnico nº 19/2024 **(doc. 04)**, com a seguinte disposição:

> "Já, o procedimento MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória."

A disciplina do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, nos §§ 12 e 13, estabelece a taxatividade do rol regulatório e as condições normativas para a sua superação. A flexibilização da lista de coberturas submete-se ao preenchimento de requisitos cumulativos de comprovação científica e, sobretudo, **chancela regulatória pela ANS**.

A aplicação da norma submete-se às diretrizes do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS). Quanto ao **deferimento de medidas liminares**, o comitê estabelece a necessidade de respaldo técnico isento prévio à decisão, conforme a redação do Enunciado 18:

> Enunciado nº 18 do FONAJUS: "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente, observando-se a obrigatoriedade nas hipóteses definidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF."

Além da exigência probatória isenta para deferimento da liminar, o FONAJUS condiciona a concessão de procedimentos extrarrol à observância de critérios objetivos, materializados no Enunciado 109:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

> Enunciado nº 109 do FONAJUS: "Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13 da Lei n° 9.656/98: a) **se existe, para o tratamento do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS**; b) **se não foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento**; c) **se há expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou tratamento solicitado**; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e efetividade do plano terapêutico."

A pretensão da Autora contraria as premissas do referido enunciado. O parecer técnico da ANS atesta expressamente a não inclusão do procedimento no Rol (item "b"). O laudo médico (ID. 242020101) silencia sobre a falha ou insuficiência de terapias conservadoras já incorporadas e disponíveis (item "a"). Por fim, o contrato firmado estipula exclusão expressa da cobertura pleiteada (item "c").

O enquadramento fixado pelo FONAJUS converge com o entendimento definitivo do Supremo Tribunal Federal no julgamento da **ADI 7.265**. A corte superior firmou tese vinculante sobre o tema:

> "Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
>
> (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente;
>
> (ii) **inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol** (PAR);
>
> (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS;

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. **Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:** (...) (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, **não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte** (...)"

O preenchimento do inciso II da tese vinculante é materialmente impossível, visto que a ANS possui manifestação expressa (Parecer Técnico 19/2024) acerca da não incorporação da mamoplastia para correção de hipertrofia mamária.

A ausência de obrigatoriedade regulatória alinha-se à exclusão contratual expressa. O contrato de plano de saúde firmado pelas partes **(doc. 01)** veda a cobertura do procedimento, resguardando a limitação mesmo diante de alegações de repercussões ortopédicas. O artigo 54, inciso VIII, do instrumento dita:

"Art. 54. Estão **excluídas** da cobertura deste contrato: (...)

VIII cirurgias plásticas, exceto as reparadoras, decorrentes de acidentes ocorridos na vigência deste contrato (vigência esta considerada para o usuário), e que estejam causando problemas

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

> funcionais; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por motivos de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção de envelhecimento, para emagrecimento (exceto o relacionado a obesidade mórbida) ou ganho de peso; tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, **ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral**."

A norma contratual afasta o dever de custeio e corrobora a natureza da intervenção. A mamoplastia assume **feição estética em sua execução padrão**. A finalidade do procedimento justifica a inexistência de requerimento, via Proposta de Atualização do Rol (PAR), perante a agência reguladora para a sua inclusão no catálogo de coberturas compulsórias.

Ademais, verifica-se que a condição clínica relatada prescinde de uma abordagem cirúrgica imediata. A hipertrofia mamária possibilita o manejo eficaz por meio de **terapias conservadoras**, a exemplo do acompanhamento fisioterapêutico direcionado à reeducação postural, do controle farmacológico de sintomas e da redução de massa corporal.

O laudo médico anexado à inicial (ID. 242020101) **omite a tentativa e a falha ou insuficiência de tratamentos prévios**. A falta de submissão aos métodos não invasivos demonstra que **a cirurgia foi prescrita como opção primária**, subvertendo as etapas da medicina baseada em evidências e descaracterizando a urgência.

Por fim, vale destacar que o laudo médico unilateral apresentado pela autora não possui, isoladamente, o condão de compelir a operadora ao custeio de procedimento expressamente excluído do Rol da ANS e do contrato. Conforme tese fixada pelo STF no julgamento da ADI 7.265, a ausência de inclusão no rol obsta a concessão judicial, salvo se preenchidos requisitos cumulativos, **cuja verificação não pode se restringir apenas à prescrição ou laudo trazido pela parte**. Sob pena de nulidade da decisão, o magistrado deve, obrigatoriamente, **aferir a**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

presença dos requisitos legais a partir de consulta técnica — como o NATJUS —, vedando-se a fundamentação da decisão baseada exclusivamente em documentos particulares da parte autora.

Portanto, a probabilidade do direito inexiste perante a exclusão contratual, a vedação regulatória expressa e a inobservância das diretrizes do FONAJUS e do STF. O risco de dano dissolve-se diante da viabilidade de tratamentos conservadores para a estabilização do quadro clínico da paciente.

2.2. Da necessidade da dilação probatória e da inexistência de urgência

Ainda que se cogite a abusividade da exclusão geral da mamoplastia redutora, impõe-se ressaltar que, na hipótese específica da autora, o procedimento vindicado demonstra probabilidade de revestir-se de natureza eminentemente estética.

A Lei nº 9.656/1998 delimita a cobertura assistencial obrigatória e protege o equilíbrio do sistema de saúde suplementar. O artigo 10, inciso II, da referida norma exclui expressamente os **procedimentos clínicos ou cirúrgicos com finalidade estética das obrigações das operadoras**:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (...)
>
> II - **procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos**, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

A inicial apoia-se em laudo médico que atribui finalidade funcional à intervenção. O documento, no entanto, ostenta **natureza unilateral** e **foi elaborado por profissional com interesse direto na autorização da cirurgia**. A divergência sobre a real finalidade da mamoplastia — puramente estética ou estritamente funcional — impõe a produção de prova pericial.

Somente o exame técnico imparcial, submetido ao contraditório, possui força para afastar a presunção de caráter estético inerente ao procedimento e atestar a veracidade da indicação funcional. A imposição de custeio antes da dilação probatória sujeita a operadora ao pagamento de tratamento com alto risco de enquadramento nas exclusões legais e contratuais, configurando provimento irreversível.

A necessidade de instrução probatória converge com a ausência de gravidade imediata no quadro clínico. A Lei nº 9.656/1998, no artigo 35-C, incisos I e II, fixa balizas exatas para a atuação iminente. A **emergência** restringe-se a casos de risco imediato de vida ou lesões irreparáveis, mediante declaração do médico assistente. A **urgência** vincula-se a acidentes pessoais ou complicações gestacionais.

A condição da paciente não se subsume aos critérios legais. A demanda retrata **cirurgia eletiva**. A execução do procedimento depende de **prévio agendamento** e da **conciliação de datas entre a autora e o corpo clínico**, dinâmica que dispensa o pronto-socorro e afasta o risco de dano irreparável. A **estabilidade do quadro** suporta o trâmite processual regular e a realização da perícia sem imposição de perigo à saúde.

3. DO PEDIDO

Diante do exposto, a Unimed Caruaru requer a Vossa Excelência:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

a) O **indeferimento do pedido de tutela de urgência**, em razão da ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano (artigo 300 do CPC), fundamentado na exclusão regulatória expressa no parecer 19/2024 da ANS, na exclusão contratual da cláusula 54, inciso VIII, e no não preenchimento dos requisitos cumulativos da ADI 7.265 do STF, cujo ônus de demonstração é da parte Autora, bem como na necessidade de realização de prova técnica pericial antes de qualquer tutela;

b) Subsidiariamente, acaso superado o pedido principal, a **determinação de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus)** para emissão de nota técnica pertinente à eficácia do tratamento demandado em contraponto às terapias conservadoras, em estrito cumprimento ao Enunciado 18 do FONAJUS e à ADI 7.265;

Nestes termos, pede deferimento.

Os patronos da empresa demandada atestam, sob sua responsabilidade, que as cópias dos documentos colacionados aos autos são autênticas e foram extraídas dos originais, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC.

Caruaru, 07 de julho de 2026.

Salomão Francisco Alves Filho
OAB/PE 27.989

José Lucas Romano da Luz
OAB/PE 60.980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250483900000239055240
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250483900000239055240
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:04

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA E HOSPITALARES

TIPO DE CONTRATO:
( ) INDIVIDUAL ( ) FAMILIAR

( ) COM OBSTETRÍCIA ( ) SEM OBSTETRÍCIA

CIÊNCIA DA FRANQUIA DE 20% PARA CONSULTAS E EXAMES: ( ) SIM

CIÊNCIA DA FRANQUIA DE 100,00 (CEM REAIS) QUANDO DA INTERNAÇÃO ( )SIM

CIÊNCIA DE QUE O ATENDIMENTO ESTÁ RESTRITO AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DAS UNIMED'S, SALVO EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

CONTRATO Nº

Certificado de Registro na ANS Nº 34095-2

Contratante: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Bairro: _____ Cidade: _____

CEP.: _____ Fone: _____ Estado Civil: _____

Data de Nasc.: ___/___/_____ RG.: _____

C.P.F.: _____

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

TÍTULO I DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

Art. 1°. O presente contrato tem por objeto a cobertura de serviços de assistência médico-hospitalar, de diagnóstico e terapia, conforme rol de procedimentos para os planos ambulatorial e hospitalar com ou sem obstetrícia, anexo à Resolução n.° 10, publicada em 4 de novembro de 1998, aos usuários regularmente inscritos, na forma e condições deste instrumento, na área de abrangência das Unimed's Caruaru, Agreste Meridional (Garanhuns) e Pernambuco Central (Arcoverde), conforme relação abaixo:

ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED CARUARU: Agrestina, Altinho, Brejo da M. de Deus, Belo Jardim, Belém de Maria, Barra de Guabiraba, Bonito, Cachoeirinha, Camocim de São Félix, Catende, Caruaru, Cupira, Cumaru, Gravatá, Ibirajuba, Jurema, Lajedo, Panelas, Lagoa dos Gatos, Riacho das Almas, Sairé, Santa Cruz do Capibaribe, São Caetano, Surubim, São Bento do Uma, São Joaquim do Monte, Tacaimbó, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes, Quipapá.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED AGRESTE MERIDIONAL (GARANHUNS): Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçados, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Lagoa do Ouro, Palmerina, Saloá, São João, Terezinha e Jucati.
ÁREA DE ABRANGÊNCIA UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL (ARCOVERDE): Arcoverde, Alagoinha, Afogados da Ingazeira, Brejo da Madre de Deus, Buique, Brejinho, Betânia, Caetés, Carnaiba, Calumbi, Custódia, Calumbi, Flores, Inajá, Ingazeira, Iguaraci, Ibirimim, Itapetim, Jataúba, Pesqueira, Porção, Pedra, Sanharó, Santa Terezinha, Serra Talhada, Sertânia, São José do Egito, Solidão, Tabira, Tacaratú, Terezinha, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa.

Art. 2°. A assistência ora pactuada visa à prevenção da doença e à recuperação da saúde, observando-se a legislação vigente nesta data e os termos deste instrumento.

Art. 3°. É parte integrante deste contrato a Proposta de Admissão de n.° .....

Art. 4°. Este contrato terá o início de vigência e a duração mínima previstos na Proposta de Admissão, prorrogando-se automaticamente, por tempo indeterminado.

TÍTULO II DAS DEFINIÇÕES

Art. 5°. Para os efeitos deste contrato, são adotadas as seguintes definições:
I CONTRATANTE: é a **pessoa física** (qualificada na proposta de admissão em anexo) que contrata a prestação de serviços de assistência à saúde para si, seus dependentes ou agregados.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

II CONTRATADA: é a operadora de planos privados de assistência à saúde descrita na Proposta de Admissão, que se obriga, na qualidade de mandatária de seus cooperados, a garantir a prestação de serviços de assistência à saúde aos usuários do plano ora convencionado, nos termos deste instrumento, através de seus médicos cooperados e de rede própria ou contratada.
III USUÁRIO: é a pessoa física, inscrita e aceita pela Contratada, que usufruirá dos serviços ora pactuados, seja na qualidade de titular, seus respectivos dependentes ou ainda, agregados, conforme definido no Título V.
IV PROPOSTA DE ADMISSÃO: é o documento validado pela Contratada, preenchido pelo Contratante, que expressa a constituição jurídica das partes e firma as condições do contrato.

Art. 6º. Também são assim definidos:
I ACIDENTE PESSOAL: é o evento exclusivo, com data caracterizada, diretamente externo, súbito, imprevisível, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, torne necessário o tratamento médico.
II AGRAVO DA CONTRAPRESTAÇÃO: é qualquer acréscimo no valor da contraprestação pecuniária do plano, decorrente da aceitação de inclusão de tratamento doenças pré-existentes e que elide a possibilidade de se omitir atendimentos no período legalmente permitido de 24 meses.
III ATENDIMENTO AMBULATORIAL: é aquele executado no âmbito do ambulatório, sem necessidade de internação hospitalar, incluindo a realização de curativos, pequenas cirurgias, primeiros socorros e outros procedimentos que não exijam uma estrutura mais complexa para o atendimento.
IV BENEFICIÁRIO: é aquele que é favorecido por uma cobertura denominada de benefício.
V BENEFÍCIO: é uma cobertura não obrigatória, oferecida aos usuários, nas condições expressas do contrato.
VI CÁLCULO ATUARIAL: é o cálculo estatístico com base em análise de informações sobre a freqüência de utilização, peculiaridades do usuário, tipo de procedimento, com vistas a manutenção do equilíbrio financeiro do plano e o cálculo das contraprestações.
VII CARÊNCIA: é o prazo ininterrupto, contado a partir do início de vigência do contrato, durante o qual os usuários não têm direito, total ou parcial, às coberturas contratadas.
VIII CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO: é a cédula onde se determina a identidade do usuário (nome, idade, código de inscrição na cooperativa contratada, etc.) e é, também, o comprovante de sua aceitação no plano de saúde.
IX CERTIFICADO CONTRATUAL: é o documento que, juntamente com o Cartão Individual de Identificação, comprova a contratação do plano de assistência à saúde.
X CID-10: é a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, 10ª revisão.
XI CO-PARTICIPAÇÃO: é o montante, definido na Proposta de Admissão, em termos percentuais ou valores monetários, para cada procedimento realizado, o

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

possibilita uma investigação diagnóstica, para melhor avaliar as condições clínicas do usuário.

. São considerados EXAMES SIMPLES de diagnóstico e terapia: 1) Ácido Úrico; 2) Colesterol total; 3) Glicose; 4) Triglicerídeos; 5) Eritrograma; 6) Hemograma completo; 7) Leucograma; 8) Beta HCG; 9) Rotina de urina. São considerados EXAMES ESPECIAIS de diagnóstico e terapia:1) análises clínicas; 2) histocitopatologia; 3) eletrocardiograma convencional; 4) eletroencefalograma convencional; 5) exames radiológicos simples sem contraste. 6) angiografia; 7) angioplastia; 8) arteriografia; 9) eletroencefalograma prolongado, potencial evocado, polissonografia e mapeamento cerebral; 10) ecocardiograma uni e bidimensional, inclusive com Doppler colorido; 11) eletrocardiografia dinâmica (Holter); 12) endoscopia diagnóstica e cirúrgica; 13) ultra-sonografia; 14) tomografia computadorizada; 15) ressonância nuclear magnética; 16) medicina nuclear; 17) densitometria óssea; 18) laparoscopia diagnóstica; 19) monitorização ambulatorial de pressão arterial; 20) litotripsia; 21) radiologia com contraste e intervencionista; 22) cineangiocoronariografia e videolaringoestroboscopia computadorizada; 23) videolaparoscopia diagnóstica e cirúrgica; 24) oxigenoterapia hiperbarica; 25) tratamento esclerosante de varizes; 26) exames e testes alergológicos; 27) exames e testes oftalmológicos; 28) exames e testes ortorrinolaringológicos; 29) eletromiografia; 30) eletroneuromiografia; 31) prova de função pulmonar; 32) inaloterapia; 33) teste ergométrico. São também considerados procedimentos especiais a quimioterapia, radioterapia, diálise e hemodiálise.

XXVII GUIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE: é a relação de serviços próprios e contratados pela operadora.

XXVIII HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA: é aquele hospital que utiliza sua própria lista de preços e procedimentos, não se sujeitando a Tabela de Referência de terceiros.

XXIX INSCRIÇÃO: é o ato de incluir um usuário no plano, condicionado ao aceite da Contratada.

XXX INTERNAÇÃO HOSPITALAR: é quando o usuário adentra o hospital, ficando sob os seus cuidados, para ser submetido a algum tipo de tratamento.

XXXI MÉDICO COOPERADO: é o médico que participa com cotas, numa das cooperativas de trabalho médico, existentes no Sistema Nacional UNIMED.

XXXII MENSALIDADE: é o valor pecuniário a ser pago mensalmente à Contratada, em face das coberturas previstas no contrato.

XXXIII ÓRTESE: acessório usado em atos cirúrgicos e que não substitui parcial ou totalmente nenhum órgão ou membro, podendo, ou não, ser retirado posteriormente.

XXXIV PATOLOGIA: modificações funcionais produzidas pela doença no organismo.

XXXV PLANO: é a opção de coberturas adquirida pelo Contratante.

XXXVI PLANO BÁSICO: Plano de coberturas com internação em quarto coletivo

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

XXXVII PLANO ESPECIAL: Plano de coberturas com internação em quarto privativo com banheiro e direito a acompanhante de acordo com a disponibilidade do hospital.
XXXVIII PRIMEIROS SOCORROS: é o primeiro atendimento realizado nos casos de urgência ou emergência.
XXXIX PRODUTOS: são modalidades de planos oferecidos pela Contratada.
XL PRÓTESE: é a peça artificial empregada em atos cirúrgicos, em substituição parcial ou total de um órgão ou membro, reproduzindo sua forma e/ou sua função.
XLI RECURSOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS ou CREDENCIADOS: são aqueles colocados à disposição do usuário pela Contratada, para atendimento médico-hospitalar, mas que não são realizados pelos médicos cooperados ou pela rede própria das cooperativas, e sim, por terceiros.
XLII ROL DE PROCEDIMENTOS: é a lista editada pelo CONSU através de anexo à Resolução n.º 10/98, publicada em 4 de novembro de 1998, que referencia os procedimentos básicos obrigatórios, individualizados para os planos especificados (ambulatorial, hospitalar sem obstetrícia, hospitalar com obstetrícia, odontológico e o plano referência).
XLIII SISTEMA NACIONAL UNIMED: é o conjunto de todas as UNIMEDs, cooperativas de trabalho médico, constantes da relação entregue ao Contratante, associadas entre si ou vinculadas contratualmente, para a prestação de serviços aos usuários.
XLIV TABELA DE REFERÊNCIA: é a lista indicativa de procedimentos e seus respectivos valores, aplicada às hipóteses em que seja necessária a aferição de preços dos serviços de assistência à saúde.
XLV UNIMED é uma cooperativa de trabalho médico, regida pela Lei n.º 5.764, de 16 de dezembro de 1971, criada e dirigida por médicos.
XLVI URGÊNCIA: é o evento resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional.

Art. 7º. Por convenção, adotou-se neste contrato o gênero masculino quando há referência ao(à) CONTRATANTE, aos(às) usuários(as), aos(às) filhos(as), aos(às) menores, etc.

TÍTULO III DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

Art. 8º. O presente contrato se caracteriza pela contratação individual, por livre adesão de pessoas físicas, com ou sem seu grupo familiar.
Parágrafo único. Em face de o CONTRATANTE ter a faculdade de incluir seus dependentes ou grupo familiar, este plano também é denominado contrato **familiar**.

Art. 9º. No plano de assistência à saúde sob o regime de contratação individual ou familiar, poderá haver cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, além de ser facultada a exigência de cumprimento de prazos de carência.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Parágrafo único. Na Proposta de Admissão estão especificadas as condições do plano mencionadas no caput deste artigo.

TÍTULO IV DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Os serviços ora contratados serão prestados pela CONTRATADA, através de seus médicos cooperados e de rede própria básica ou por ela contratada, na área geográfica de abrangência do plano conforme consta opção na Proposta de Admissão, bem como por todas as cooperativas médicas que integram o SISTEMA REGIONAL UNIMED (Caruaru, Arcoverde e Garanhuns), além do SISTEMA NACIONAL UNIMED, quando em caso de urgência e/ou emergência.

Parágrafo único: Somente em caso de urgência e emergência o atendimento será prestado através do SISTEMA NACIONAL UNIMED.

CAPÍTULO II DO INÍCIO DO DIREITO

Art. 11. Os serviços previstos neste contrato serão prestados aos usuários regularmente incluídos através da Proposta de Admissão e aceitos pela CONTRATADA, **após o cumprimento das carências específicas** para os procedimentos, conforme o caso, de acordo com as coberturas contratadas.

Parágrafo único. Contratada a ampliação da cobertura através dos módulos adicionais, os usuários sujeitar-se-ão às carências e limites previstos para cada um deles.

CAPÍTULO III DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

Art. 12. Somente terão direito aos serviços ora contratados os usuários regularmente inscritos.

Art. 13. A CONTRATADA assegurará aos usuários os serviços médico-hospitalares, ambulatoriais, auxiliares de diagnóstico e terapia, previstos neste contrato, **obedecida a cobertura contratada**, conforme especificado abaixo:
a) consultas: os usuários serão atendidos no consultório do médico escolhido, **dentre os cooperados das cooperativas médicas que integram o SISTEMA REGIONAL UNIMED**;
b) atendimentos clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais: serão prestados em consultórios, clínicas, serviços ou hospitais próprios;
c) exames complementares e serviços auxiliares: serão prestados através de rede própria ou contratada, mediante solicitação do médico assistente.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Art. 14. Neste ato o entregue do CONTRATANTE o GUIA DE SAÚDE, editado pela CONTRATADA, informando a relação de seus prestadores, médicos cooperados, hospitais e clínicas, bem como a relação, com os respectivos endereços, das cooperativas participantes do Sistema Regional e Nacional UNIMED, devendo, entretanto, o usuário, ao utilizar-se dos serviços, confirmar as informações nele contidas em razão do processo dinâmico do quadro de médicos cooperados e da rede contratada e/ou credenciada.

Art. 15. A CONTRATADA não se responsabilizará pelo pagamento de quaisquer serviços eventualmente utilizados de maneira diversa da pactuada.

CAPÍTULO IV DO REEMBOLSO

Art. 16. A CONTRATADA assegurará o reembolso no limite das obrigações deste contrato, das despesas efetuadas pelo usuário com assistência à saúde, dentro do território nacional, **nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando não for comprovadamente possível a utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados** pelo Sistema UNIMED REGIONAL.

Art. 17. O reembolso de que trata o artigo anterior será efetuado de acordo com os valores da Tabela de Referência vigente à data do evento, praticada pela CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação dos seguintes documentos originais, que posteriormente serão devolvidos, na hipótese de reembolso parcial:

a) solicitação de reembolso através de preenchimento de formulário próprio;

b) relatório do médico assistente, declarando o nome do paciente, descrição do tratamento e respectiva justificação dos procedimentos realizados, data do atendimento, e, quando for o caso, período de permanência no hospital e data da alta hospitalar;

c) conta hospitalar discriminando materiais e medicamentos consumidos, com preço por unidade, juntamente com notas fiscais, faturas ou recibos do hospital;

d) recibos individualizados de honorários dos médicos assistentes, auxiliares e outros, discriminando funções e o evento a que se referem;

e) comprovantes relativos aos serviços de exames complementares de diagnóstico e terapia, e serviços auxiliares, acompanhados do pedido do médico assistente.

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo do **caput**, o valor a ser reembolsado será atualizado, a partir da data de entrada do requerimento, pelo IGP-M/FGV, ou por outro índice que vier a substituí-lo, de modo a repor a perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 18. **Só serão reembolsáveis as despesas vinculadas diretamente ao evento que originou o atendimento ao usuário, realizado enquanto perdurar o estado de urgência ou emergência.**

Art. 19. **O CONTRATANTE perderá o direito ao reembolso decorridos doze**

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

meses da data do evento.

TÍTULO V DOS USUÁRIOS

CAPÍTULO I DO TITULAR

Art. 20. Para efeito deste contrato, o CONTRATANTE é o usuário titular.

CAPÍTULO II DOS DEPENDENTES

Art. 21. São usuários dependentes, com grau de parentesco ou afinidade e dependência econômica em relação ao usuário titular:
a) o cônjuge;
b) os filhos solteiros com até 18(dezoito anos)
c) o enteado, o menor sob a guarda por força de decisão judicial e o menor tutelado, que ficam equiparados aos filhos;
d) convivente, havendo união estável, na forma da lei, sem eventual concorrência com o cônjuge, salvo por decisão judicial;
e) os filhos comprovadamente inválidos.

CAPÍTULO III DOS AGREGADOS

Art. 22. A critério da CONTRATADA, poderão ser admitidas outras pessoas indicadas pelo usuário titular, na qualidade de usuários agregados, para apenas utilizarem a assistência médica e hospitalar, objeto deste instrumento, excluídos os benefícios do Título XIII.

CAPÍTULO IV DA INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Art. 23. A inclusão do CONTRATANTE e respectivos dependentes e agregados será processada através da Proposta de Admissão que, aceita pela CONTRATADA, integrará este contrato para todos os fins de direito.

Art. 24. Ficará a critério da CONTRATADA a realização de exame prévio de admissão nos usuários, a fim de averiguar lesões e doenças preexistentes, bem como de solicitar, a qualquer tempo, documentação probatória das declarações do CONTRATANTE.

Art. 25. É assegurada a inclusão:
I do recém-nascido, filho natural ou adotivo do usuário titular, isento do cumprimento dos períodos de carência, contanto que, simultaneamente:
a) As carências para atendimento obstétrico já tenham sido cumpridas integralmente;
b) A inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias após o nascimento.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

II do filho adotivo, menor de doze anos, com aproveitamento dos períodos de carência já cumpridos pelo usuário titular adotante, **desde que efetivada em até trinta dias após o deferimento da adoção**;

III do cônjuge do usuário titular, com aproveitamento dos períodos de eventual carência já cumpridos por este, **quando contrair matrimônio durante a vigência deste contrato**, e for inscrito no prazo de 30 (trinta) dias a contar do evento.

Parágrafo único. Ultrapassados os prazos previstos neste artigo, ressalvadas as condições específicas das coberturas adicionais posteriormente contratadas, cujo cumprimento de carências se dará integralmente, e ainda, quando à observância do disposto no Capítulo II do Título XIII, **os novos usuários cumprirão os períodos de carências indicados na Proposta de Admissão.**

Art. 26. **O usuário que, por qualquer motivo, deixar de atender às condições exigidas para sua inscrição, será automaticamente excluído do contrato.**

Parágrafo único. O dependente que vier a perder a condição de dependência poderá assinar contrato em seu próprio nome, **em até 30 (trinta) dias a contar da data da perda do direito como usuário dependente**, aproveitando as carências já cumpridas neste contrato.

TÍTULO VI CARTÃO INDIVIDUAL DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 27. A CONTRATADA fornecerá aos usuários o Cartão Individual de identificação referente ao plano a que pertencerem, com prazo de validade, cuja apresentação, acompanhada de documento de identidade legalmente reconhecido e o recibo de pagamento das mensalidades em dia, na forma da lei, assegura a fruição dos direitos e vantagens deste contrato, podendo a CONTRATADA adotar, a qualquer tempo, novo sistema para melhor atendimento dos usuários.

Art. 28. É obrigação do CONTRATANTE, na hipótese de rescisão, resolução ou resilição deste contrato, devolver os respectivos cartões de identificação e quaisquer outros documentos porventura fornecidos pela CONTRATADA, respondendo, sempre, sob todos os aspectos, pelos prejuízos resultantes do uso indevido desses documentos, restando isenta, neste caso, de qualquer responsabilidade, a CONTRATADA, a partir da rescisão do usuário, resolução ou resilição do presente.

§ 1º. Considera-se uso indevido a utilização desses documentos para obter atendimento, mesmo que na forma contratada, pelos usuários que perderam essa condição, por exclusão ou término do contrato, ou, em qualquer hipótese, por terceiros, que não sejam usuários, com ou sem o conhecimento destes.

§ 2º. O uso indevido do cartão de identificação, de qualquer usuário, a critério da CONTRATADA, ensejará pedido de indenização por perdas e

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

danos, bem como a exclusão do respectivo titular, e suas conseqüências, ainda que o ato tenha sido praticado sem o seu conhecimento, além de ser o CONTRATANTE responsabilizado penalmente.

Art. 29. Ocorrendo a perda ou extravio de qualquer desses documentos, o CONTRATANTE deverá comunicar, por escrito, o fato à CONTRATADA, para cancelamento ou, quando for o caso, emissão de segunda via. O cancelamento só terá validade quando reconhecido por escrito, pela CONTRATADA.

TÍTULO VII DO PLANO

Art. 30. Os usuários farão jus, satisfeitas as respectivas condições, à cobertura básica prevista neste Título, exclusivamente dentro dos recursos próprios, nos termos da Proposta de Admissão.
Parágrafo único. É facultada a opção pelas coberturas de módulos opcionais, sujeitando-se, no entanto, às respectivas condições específicas de cada um deles.

Art. 31. A cobertura básica está discriminada neste Título nos capítulos I e II, que, respectivamente, discriminam o atendimento ambulatorial e a internação hospitalar sem obstetrícia, cujo somatório representa o plano contratado.

CAPÍTULO I DA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL

SEÇÃO I DA COBERTURA

Art. 32. A cobertura deste capítulo compreende os atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios, definidos e listados no Rol de Procedimentos anexo à Resolução nº10/98 do CONSU, observada a seguinte abrangência:
I cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho federal de Medicina;
II cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais incluindo
procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, **desde que não demandem o apoio da estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas;**
III cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, **pelo período de até 12 (doze) horas;**
IV cobertura de remoção por via terrestre, após realizados os atendimentos classificados como urgência ou caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação;
V a psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, **com duração máxima de 12 (doze) semanas,** tendo início imediatamente após o

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano de **contrato, não cumulativas**;
VI cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais:
a) hemodiálise e diálise peritonial CAPD;
b) quimioterapia ambulatorial;
c) radioterapia (megavoltagem, cobaltoterapia, cesioterapia, eletronterapia, etc.);
d) hemoterapia ambulatorial;
e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais.

SEÇÃO II DAS EXCLUSÕES

Art. 33. **Estão excluídos desta cobertura quaisquer atendimentos odontológicos, bem como as exclusões genéricas descritas no Capítulo III deste título.**

Art. 34. **Também estão excluídas da cobertura deste capítulo:**
I os procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas;
II serviços como de recuperação pós anestésica, UTI, CETIN e similares;
III procedimentos diagnósticos e terapêutica em Hemodinâmica;
IV procedimentos que exijam forma de anestesia diversa da anestesia local, sedação ou bloqueio;
V quimioterapia intra-tecal ou as que demandem internação;
VI radiomoldagens, radioimplantes e braquiterapia;
VII nutrição enteral ou parenteral:
VIII embolizações e radiologia intervencionista.

Parágrafo único. Os procedimentos deste artigo estarão cobertos pela segmentação hospitalar, integrante deste plano, se tiver sido contratada, após o cumprimento dos períodos de carência, conforme o caso.

Art. 35. Dentro da abrangência desta segmentação, quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, e esta esteja em cumprimento de carências, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do CONTRATANTE, não cabendo ônus algum à CONTRATADA.

CAPÍTULO II DA SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR, SEM OBSTETRÍCIA

SEÇÃO I DA COBERTURA

Art. 36. <u>Durante a internação</u> clínica, inclusive a psiquiátrica e/ou cirúrgica, a CONTRATADA garante aos usuários, dentro dos recursos próprios, os seguintes

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

serviços hospitalares:
I diárias de internação hospitalar, sem limitação de prazo, valor máximo e quantidade, desde que justificada pelo médico assistente cooperado: a) Plano Básico Internação em quarto coletivo ou padrão enfermaria e b) Plano Especial: Internação em quarto privativo.
II exames complementares especializados para diagnóstico e controle do tratamento e da evolução da doença que tenha motivado a internação, **exceto os não cobertos por este contrato;**
III assistência médica através de médicos cooperados;
IV medicamentos, anestésicos, oxigênio, transfusões de sangue e derivados e demais recursos terapêuticos;
V taxas de sala de cirurgias, inclusive material utilizado e esterilização, de acordo com o porte cirúrgico;
VI serviços gerais de enfermagem, **exceto em caráter particular;**
VII utilização de leitos especiais, monitores e toda aparelhagem e material, indispensáveis ao tratamento;
VIII unidade de terapia intensiva ou isolamento, quando determinado pelo médico assistente;
IX alimentação específica ou normal, fornecidas pelo hospital, até a alta hospitalar, limitada aos recursos do estabelecimento;
X acomodação e alimentação fornecidas pelo hospital a acompanhante do usuário menor de 18 (dezoito) anos, nas mesmas condições da cobertura contratada, exceto no caso de internação em UTI ou similar;
XI despesas com remoção inter-hospitalar do usuário, em ambulância, quando comprovadamente necessária ao atendimento coberto, e de acordo com a área geográfica de abrangência do plano;
XII cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções, sendo que, a urgência decorrente de acidente pessoal será garantida, sem restrições, **após o período de carência legal de 24 (vinte quatro) horas.**

Art. 37. Estão incluídos na cobertura, os seguintes **procedimentos** considerados **especiais**, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada a nível de internação.
a) hemodiálise e diálise peritoneal (CAPD);
b) quimioterapia;
c) radioterapia, incluindo radiomoldagem, radioimplantes e braquiterapia;
d) hemoterapia;
e) nutrição parenteral ou enteral;
f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica;
g) embolizações e radiologia intervencionista;
h) exames pré-anestésicos ou pré-cirúrgicos;
i) remoções em urgências ou emergências;
j) fisioterapia.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Art. 38. Terão cobertura as cirurgias [illegible]
ambiente hospitalar.

17

Art. 39. A Cirurgia Plástica Reparadora terá cobertura contratual quando efetuada, exclusivamente, para restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidas em virtude e acidentes pessoais ocorridos na vigência deste contrato para o respectivo usuário, e que estejam causando problemas funcionais.

Art. 40. Os transplantes de córnea e rim, estarão cobertos, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, isto é, todos aqueles necessários à realização do transplante, sem prejuízo da legislação específica que normativa estes procedimentos, incluindo:
a) despesas assistenciais com doadores vivos;
b) medicamentos nacionais utilizados durante a internação;
c) acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, **exceto medicamentos de manutenção.**
Parágrafo único. **Os transplantes de córnea e rim provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, estarão cobertos desde que o usuário esteja cadastrado em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos, integrantes do Sistema Nacional de Transplantes, sujeito ao critério de fila única de espera e de seleção.**

Art. 41. Com exceção dos casos de dependência química, tratados no artigo seguinte, estará coberto o tratamento de usuários portadores de transtornos mentais, que estiverem em situação de crise ou de surto psicótico agudo e que necessitarem de internação hospitalar, em hospitais psiquiátricos especializados no tratamento de quadros agudos ou em unidades psiquiátricas de hospitais gerais, **pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, contínuos ou não, durante o período de 12 (doze) meses, a contar do primeiro dia de internação.** Após esse prazo, essas internações estarão sujeitas a co-participação financeira nas despesas, conforme referenciado na Proposta de Admissão, ou ficará isenta a CONTRATADA da responsabilidade pelo atendimento após o prazo acima, quando não for contratada co-participação.
§ 1º. Quando o CONTRATANTE fizer opção de também co-participar nas despesas para custeio das internações referentes às demais especialidades médicas, **não haverá a isenção a que se refere o *caput*.**
§ 2º. Não estando coberto o atendimento referente ao "caput" deste artigo, no contrato, poderá o usuário ser atendido, por custo operacional, ou seja, pagando tabela própria da CONTRATADA, previamente ao serviço necessitado.
Art. 42. Também estarão cobertas as internações para os usuários portadores de quadros de intoxicação ou abstinência provocados por alcoolismo ou outras formas de dependência química que necessitem hospitalização.
§ 1º. As internações, circunscritas ao tratamento de "desintoxicação", serão **isentas de co-participação** pelo prazo máximo de **15 (quinze) dias contínuos ou não, por ano, não cumulativos**. Após esse prazo, essas internações estarão sujeitas a co-participação financeira nas despesas, conforme referenciado na

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Proposta de Admissão, ou ficará isenta a CONTRATADA da responsabilidade pelo atendimento após o prazo acima, quando não for contratada co-participação. ..
§ 2º. Quando o CONTRATANTE fizer opção de também co-participar nas despesas para custeio das internações referentes às demais especialidades médicas, **não haverá a isenção a que se refere o *caput*.**
§ 3º. As internações de que trata este artigo estarão sujeitas a exclusão por cobertura parcial temporária pelo prazo fixado na Proposta de Admissão.
§ 4º. Não estando coberto o atendimento referente ao "caput" deste artigo, no contrato, poderá o usuário ser atendido, por custo operacional, ou seja, pagando tabela própria da CONTRATADA, previamente ao serviço necessitado.

Art. 43. As lesões auto-infligidas e as intercorrências clínicas agudas ocorridas em usuários portadores de transtornos mentais, serão sempre tratadas em hospitais gerais quando a hospitalização for necessária.

SEÇÃO II DAS EXCLUSÕES PARA INTERNAÇÃO

Art. 44. **Além das exclusões genéricas descritas no Capítulo III deste Título. esta segmentação também não inclui:**
a) medicamentos não prescritos pelo médico cooperado assistente;
b) despesas de acompanhantes, excepcionadas as de alimentação (servida exclusivamente pela instituição) e acomodação de um acompanhante para o paciente menor de 18 anos;
c) produtos de toalete e higiene pessoal;
d) serviços telefônicos ou qualquer outra despesa que não seja vinculada diretamente à cobertura;
e) despesas decorrentes de serviços médico-hospitalares prestados por médicos não cooperados do SISTEMA NACIONAL UNIMED ou entidades não credenciadas por este;
f) serviços realizados em desacordo com o disposto neste contrato;
g) consultas ou internações referentes a obstetrícia (parto).

SEÇÃO III DOS PROCEDIMENTOS

Art. 45. As internações hospitalares serão processadas mediante pedido firmado por médico cooperado, e guia de internação expedida pela UNIMED prestadora do atendimento em favor do usuário.

Art. 46. Nos casos de urgência, o usuário, ou quem por ele responda, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da internação para providenciar os documentos acima mencionados, sob pena da CONTRATADA não se responsabilizar por quaisquer despesas.

Art. 47. Os usuários deste contrato obrigam-se, ao se internarem, a fornecer à

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

administração do hospital, juntamente com a guia de internação, o documento de identidade, o cartão de identificação emitido pela UNIMED, em pleno vigor, e o comprovante de pagamento da mensalidade atualizado, na forma da lei.

Art. 48. O prazo de internação, fixado pela UNIMED, constará da guia expedida e corresponderá à média de dias utilizados para casos idênticos.

Art. 49. Em caso de necessidade de prorrogação do prazo de internação previamente autorizado, o usuário ou quem por ele responda deverá apresentar à UNIMED a solicitação de prorrogação emitida pelo médico cooperado assistente.

Art. 50. O pagamento das despesas não cobertas deverá ser realizado diretamente pelo usuário ao prestador do atendimento.

Art. 51. Na hipótese do usuário optar por acomodação hospitalar superior àquela contratada, deverá arcar com a diferença de preço e a complementação dos honorários médicos e hospitalares, conforme negociação direta com o médico ou hospital.

Art.52. A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer acordo ajustado particularmente pelos usuários com médicos, hospitais ou entidades contratadas, ou não, por ela. Tais despesas correm por conta exclusiva do usuário.

Art. 53. Para todos os efeitos será considerado um mesmo evento a nova internação ocorrida no período de sete dias da alta hospitalar, desde que motivada pela mesma patologia.

CAPÍTULO III DAS EXCLUSÕES CONTRATUAIS

Art. 54. Estão excluídas da cobertura deste contrato:
I consultas, tratamentos e internações realizados antes do início da cobertura ou do cumprimento das carências previstas;
II tratamentos e cirurgias experimentais, exames e medicamentos ainda não reconhecidos pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia (S.N.F.M.F.), cirurgias e tratamentos não éticos ou ilegais, cirurgias para mudança de sexo e inseminação artificial;
III atendimento nos casos de calamidade pública, conflitos sociais, guerras, revoluções e outras perturbações da ordem pública, e ainda de envenenamentos de caráter coletivo ou outra causa física que atinja maciçamente a população;
IV tratamentos e cirurgias decorrentes de danos físicos ou lesões causados por radiações ou emanações nucleares ou ionizantes.
V vacinas; medicamentos importados, exceto aqueles cujos custos sejam inferiores ou iguais aos nacionais;
VI tratamentos e cirurgias para controle de natalidade, para infertilidade, esterilidade e suas conseqüências, bem como tratamento cirúrgico e

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

exames laboratoriais diagnósticos e de preservação para todos os tipos de impotência sexual;

VII enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar;

VIII cirurgias plásticas, exceto as reparadoras, decorrentes de acidentes ocorridos na vigência deste contrato (vigência esta considerada para o usuário), e que estejam causando problemas funcionais; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por motivos de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção de envelhecimento, para emagrecimento (exceto o relacionado a obesidade mórbida) ou ganho de peso; tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral;

IX medicamentos e materiais cirúrgicos que não sejam ministrados, em internações ou em atendimentos em prontos-socorros;

X *check-up*, investigação diagnóstica eletiva, em regime de internação hospitalar, necrópsias, medicina ortomolecular e mineralograma do cabelo;

XI exames para piscina e ginástica;

XII aparelhos ortopédicos, fornecimento de próteses e órteses não ligados ao ato cirúrgico;

XIII aluguel de equipamentos hospitalares e similares;

XIV consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência;

XV tratamentos de lesões ou doenças causadas por atos reconhecidamente perigosos, praticados pelo usuário e que não sejam motivados por necessidade justificada (nos termos do art. 160 do Código Civil) ou ainda causados por competição com veículos, inclusive treinos preparatórios, ou outras atividades esportivas de risco voluntário;

XVI despesas não vinculadas diretamente à cobertura deste contrato.

XVII implantes e transplantes, exceto os de córnea e rim que estarão cobertos, de acordo com as condições expressas neste contrato;

XVIII tratamentos em SPA, clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, casos sociais e clínicas de Idosos.

XIX procedimentos, exames ou tratamentos realizados no exterior ou fora da área geográfica de abrangência contratada.

TÍTULO VIII DAS CARÊNCIAS

Art. 55. Os períodos de carência para cada procedimento, serão os seguintes

I A CONTRATADA assegura, aos usuários titulares, dependentes e agregados quando for o caso, regularmente inscritos, a realização de consultas e procedimentos de diagnóstico e terapia, e internações hospitalares, exclusivamente dentro dos recursos contratados, quando solicitados por médico cooperado e de acordo com as carências a seguir:

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

a) 24 (vinte e quatro) horas, para atendimentos de urgência e emergência;
b) 45 (quarenta e cinco) dias para consultas e exames simples;
c) 180 (cento e oitenta) dias: exames especiais de diagnóstico e terapia e fisioterapia;
d) 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e internamentos clínicos, quimioterapia, radioterapia, diálise e hemodiálise;
e) 180 (cento e oitenta) dias para o benefícios adicionais do Título XIII deste contrato;
f) 300 (trezentos) dias, para partos.

Parágrafo único. Desde que o parto esteja coberto por este contrato e que a mãe ou adotante tenha cumprido as carências específicas, estarão cobertas as despesas com honorários do pediatra, diárias de berçário e UTI do recém-nascido, filho natural ou adotivo, bem como medicamentos e materiais indispensáveis ao seu tratamento, pelo período de 30 (trinta) dias, contado da data de nascimento ou sentença de adoção. Após esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do recém-nascido no contrato ter ocorrido da forma determinada pelo Art. 25 do presente contrato.

TÍTULO IX DA FRANQUIA

Art. 56. Os valores/percentuais de franquia para cada procedimento se houver, estão dispostos na Proposta de Admissão.

Parágrafo único. **Será de responsabilidade do CONTRATANTE o pagamento da franquia pactuada, no ato da realização dos procedimentos médicos (consulta, exames e internação).**

TÍTULO X DAS LESÕES E DOENÇAS PREEXISTENTES

Art. 57. O CONTRATANTE está obrigado, por ocasião da contratação, a informar, por si e por seus dependentes e agregados, ser conhecedor ou não da condição de portador ou sofredor de doença ou lesão preexistente.
§ 1º. A informação será prestada, através de declaração de saúde, cujo formulário está à disposição do CONTRATANTE na sede da CONTRATADA, a fim de que seja realizada a entrevista qualificada com um médico cooperado sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, ou, a seu critério, com um médico não pertencente ao quadro de cooperados, assumindo, neste caso, as despesas daí decorrentes.
§ 2º. Na declaração de saúde, o usuário titular deverá relacionar todas as lesões e doenças preexistentes à contratação, sob pena da sua omissão caracterizar fraude contratual.
§ 3º. É condição prévia para inclusão do usuário a apresentação da declaração a que se refere o § 1º.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

§ 4º. Fica a critério da CONTRATADA a realizaçao de exame pre-admissional, posteriormente ou não à realização da entrevista qualificada, visando a identificar a existência de doenças ou lesões preexistentes. 22

§ 5º. A constatação seja através da entrevista qualificada, seja através do exame pré-admissional, da existência de lesão ou doença preexistente, que venha a gerar impacto nos custos da CONTRATADA, resultará em AGRAVO do valor da mensalidade ou na cobertura parcial temporária pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a critério do CONTRATANTE.

§ 6º. O valor correspondente ao agravamento será previamente informado ao CONTRATANTE.

§ 7º. Fica a critério da CONTRATADA, ainda, a solicitação, a qualquer tempo durante a relação contratual, de documentação comprobatória das declarações do CONTRATANTE, prestadas por ocasião da celebração do contrato.

§ 8º. A constatação, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, contados do início da vigência do contrato, da condição de portador ou sofredor de lesão ou doença preexistente caracterizará fraude, sujeitando o usuário, a critério da CONTRATADA, à suspensão da cobertura ou denúncia do contrato, sem prejuízo do direito de pleitear o ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento em decorrência da doença não informada.

TÍTULO XI DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
CAPÍTULO I DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE

Art. 58. O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, por si e por seus dependentes e agregados inscritos neste contrato, os valores relacionados na Proposta de Admissão para efeito de inscrição, franquia e mensalidade.

Parágrafo Único. Os valores a serem pagos a título de franquia deverão ser efetuados no ato da realização do procedimento e/ou internação no local onde o mesmo for prestado, devendo o prestador do serviço emitir recibo ao CONTRATANTE.

Art. 59. As mensalidades e os eventuais valores relativos à franquia serão pagos, conforme o acordado na Proposta de Admissão, podendo a CONTRATADA, a qualquer tempo, adotar a forma e a modalidade de cobrança que melhor lhe aprouver, desde que comunicado ao CONTRANTE previamente.

Parágrafo único. Quando a data de vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado até o primeiro dia útil subseqüente.

Art. 60. Se o CONTRATANTE não receber o documento que o possibilite realizar o pagamento de sua obrigação, até cinco dias antes do respectivo vencimento, deverá solicitá-lo diretamente na Unimed para que não se sujeite as conseqüências da mora, podendo ainda acessar a internet, através do site **www.unimedcaruaru.com.br.**

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

SEÇÃO I DA INADIMPLÊNCIA

Art. 61. Ocorrendo impontualidade no pagamento da mensalidade, serão cobrados juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que vier a substituí-lo, calculados proporcionalmente ao tempo de atraso, além de multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor do débito atualizado, ou ainda, conforme o caso, ressarcimento por perdas e danos, honorários advocatícios e reembolso de custas judiciais.

SEÇÃO II DA SUSPENSÃO DO CONTRATO

Art. 62. **O atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, implicará, sempre, na suspensão total dos atendimentos até a efetiva liquidação do débito, nos termos do artigo anterior, e sem prejuízo do direito da CONTRATADA denunciar o contrato.**

Parágrafo Único. Caso haja, de algum modo utilização no período da suspensão do contrato, a CONTRATADA poderá cobrar judicialmente os valores do que fora utilizado.

CAPÍTULO II DA VARIAÇÃO DOS VALORES

SEÇÃO I DO REAJUSTE E /OU REVISÃO

Art. 63. Os valores previstos na Proposta de Admissão foram fixados com base em cálculo atuarial levando-se em consideração os preços dos serviços colocados à disposição dos usuários, a freqüência de utilização desses serviços, o prazo contratual, os procedimentos não cobertos, as carências, os limites, valor e/ou percentual de franquia e a carga tributária que hoje recai sobre as cooperativas de trabalho médico. **Assim, qualquer alteração desses itens ensejará novos valores.**

Art. 64. Nos termos da lei, **o valor das mensalidades e inscrições será reajustado anualmente, observadas as formalidades legais, levando-se em conta os índices de elevação de preços observados para cada componente do custo, conforme fórmula genérica expressa no § 1º deste artigo, que também poderá ser revisto se houver utilização comprovada acima da média normal, acréscimo de novos métodos de elucidação diagnóstica e tratamento ou aumento comprovado dos custos dos serviços contratados que venha a afetar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.**

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

§ 1º. O cálculo dos reajustes obedecerá a seguinte formula: REAJUSTE = (DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (DESPESAS COM SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (DESPESAS ADMINISTRATIVAS X RESPECTIVOS PESOS NO CUSTO X ÍNDICES DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS) + (SINISTRALIDADE DA MASSA DE USUÁRIOS).
I Compõem as despesas médicas e/ou hospitalares: a) honorários médicos, sobre as consultas e outros procedimentos; b) diárias e taxas hospitalares; c) materiais e d) medicamentos.
II Compõem as despesas administrativas: a) salários; e b) outras despesas.

§ 2º. Caso nova legislação venha a autorizar o reajustamento em período inferior a doze meses, a mesma terá aplicação imediata sobre este contrato.

Art. 65. Se, por qualquer motivo, a CONTRATADA não puder praticar o reajustamento, nos termos do artigo anterior, provisoriamente, a mensalidade será reajustada, na periodicidade legal, pela variação do IGP-M (Índice de Preços do Mercado), **segmento saúde**, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na falta deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período.

Art. 66. Fica estabelecido que os valores relativos a inclusões de dependentes, ou de módulos adicionais, terão o primeiro reajuste, proporcional, na data de aniversário de vigência do presente contrato para o usuário titular, unificando-se as respectivas datas base.

§ 1º. Os valores e/ou percentuais previstos na proposta de admissão a título de franquia, serão reajustados, na da data de aniversário do presente instrumento, observada a periodicidade legal, pela variação do IGP-M, **segmento saúde,** ou na falta deste, por outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda no período.
§ 2º. Os reajustes subseqüentes à unificação das datas base respeitarão as disposições contidas neste Capítulo.

SEÇÃO II DAS FAIXAS ETÁRIAS

Art. 67. As mensalidades são estabelecidas de acordo com a faixa etária em que cada usuário inscrito esteja enquadrado. Ocorrendo alteração na idade de qualquer dos usuários que importe em deslocamento para a faixa etária superior, a contraprestação pecuniária será aumentada automaticamente, no mês seguinte ao do aniversário do usuário.

Art. 68. As faixas etárias para os fins deste contrato são:
a) 1ª - 00 (zero) a 18 (dezoito) anos; b) 2ª - de 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; c) 3ª - de 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; d) 4ª - de 29 (vinte e

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:57
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

nove) a 33 (trinta e três) anos; e) 5ª - de 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; f) 6ª - de 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos e g) 7ª - 44 (quarenta e quatro) anos a 48 (quarenta e oito); anos; 8ª de 49 (quarenta e nove) a 53 (cinqüenta e três) anos; 9ª de 54 (cinqüenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; 10ª de 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais.

Art. 69. Os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária corresponderão aos percentuais indicados a seguir:

FAIXAS	IDADES	VARIAÇÃO (%)
1ª	0 - 18	0 %
2ª	19 - 23	35,2 %
3ª	24 - 28	10,5 %
4ª	29 - 33	4,9 %
5ª	34 - 38	10,5 %
6ª	39 - 43	57,4 %
7ª	44 - 48	22,1 %
8ª	49 - 53	17,8 %
9ª	54 - 58	10,5 %
10ª	59 ou mais	38,7 %

Art. 70. Os usuários com mais de 60 (sessenta) anos de idade e que tiverem permanecido no plano por pelo menos 10 (dez) anos, consecutivos, estarão isentos do aumento decorrente de modificação de faixa etária.

TÍTULO XII DA RESCISÃO DO CONTRATO

Art. 71. **Será considerado rescindido este contrato, se houver atraso no pagamento da contraprestação por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, sem prejuízo do direito da CONTRATADA requerer judicialmente a quitação do débito com suas conseqüências moratórias.**

Art. 72. Rescinde-se também este contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ocorrendo:

a) Qualquer ato ilícito praticado pelos usuários, na utilização do objeto deste contrato;

b) Abuso, considerado como tal a utilização absolutamente desnecessária dos serviços contratados;

c) Utilização indevida do cartão individual de identificação UNIMED;

d) Omissão ou distorção de informações em prejuízo da UNIMED ou do resultado

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

de perícias ou exames, quando necessários;
e) Descumprimento das condições contratuais, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato;
f) A exclusão do usuário titular.

Art. 73. Antes do término do prazo mínimo fixado na Proposta de Admissão, é facultado ao CONTRATANTE denunciar o presente contrato, **mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sujeitando-se ao pagamento de multa pecuniária equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor das mensalidades que seriam devidas até o término do citado prazo.**
§ 1º. O contrato que estiver vigente por prazo indeterminado poderá ser denunciado pelo CONTRATANTE, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.
§ 2º. A falta de comunicação, nos termos deste artigo, implica na subsistência das obrigações assumidas.
§ 3º. Durante o prazo previsto neste artigo, não será admitida inclusão ou exclusão de usuários.

Art. 74. A responsabilidade da CONTRATADA sobre os atendimentos iniciados durante a vigência do contrato cessa no último dia do prazo de 30 (trinta) dias mencionado no artigo anterior, correndo as despesas a partir daí por conta do CONTRATANTE.

Art. 75. O CONTRATANTE reconhece como dívida líquida e certa, em favor da CONTRATADA, quaisquer despesas decorrentes de atendimento prestado a ele, seus dependentes e agregados, cessadas as responsabilidades da CONTRATADA, independentemente da data de início do tratamento, bem como aquelas coberturas deferidas liminar ou cautelarmente em procedimento judicial, e posteriormente revogadas ou decididas em contrário, e ainda, os procedimentos não cobertos explicitamente por este instrumento.

TÍTULO XIII DOS BENEFÍCIOS ESPECIAIS
CAPÍTULO I SEGURO DE VIDA UNIMED

Art.. 76. Este benefício assegura ao titular ou dependentes inscritos **seguro de vida** do titular, em favor dos beneficiários indicados na proposta de adesão, ou na falta destes, de acordo com a legislação específica, tudo de conformidade com as Condições da Apólice do seguro, em poder desta UNIMED, respeitadas as seguintes condições:
§ 1º. Somente será assegurada a cobertura se o usuário titular:
a) estiver em perfeito estado de saúde, na data de sua inscrição;
b) tiver idade inferior a 65 (sessenta e cinco) anos, na data de sua inscrição;
c) estiver rigorosamente em dia o pagamento das mensalidades, na data do óbito; e,
d) ter cumprido o prazo de permanência de 06 (seis) meses no plano, contados da

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

data da sua inscrição.
§ 2º. O seguro de vida é instituído em forma de seguro de vida em grupo, sendo devido nos casos de morte natural ou morte acidental;
§ 3º. O valor das indenizações será aquele vigente na data do sinistro.
§ 4º. Fica preservado ao usuário titular o direito de alterar, a qualquer tempo, os beneficiários da cláusula.
§ 5º. Em caso de sinistro, deverão ser encaminhados à Seguradora, através da CONTRATADA, os seguintes documentos: I Do Segurado falecido: a) aviso de sinistro devidamente preenchido; b) Certidão de Óbito; c) cópia autenticada do documento de identidade. I.1 Para morte acidental, mais os seguintes: a) cópia do Boletim de Ocorrência; b) cópia do Laudo Cadavérico; c) cópia do Laudo de Dosagem Toxicológica, se houver. II Do(s) beneficiário(s): a) cônjuge: Certidão de Casamento atualizada (emitida após o óbito) e cópia do documento de identidade; b) filhos: Certidão de Nascimento; c) pais: Certidão de Nascimento, ou de Casamento; d) convivente: prova dessa condição; e) incapazes: alvará judicial e, quando for o caso, termo de tutela ou curatela.
§ 6º. Poderão, ainda, ser solicitados quaisquer outros documentos que se façam necessários à liquidação do sinistro.

Art. 77. O atraso nos pagamentos das mensalidades implicará na suspensão do seguro de que trata esta cláusula, enquanto perdurar.
Parágrafo único. O atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento das mensalidades implicará no cancelamento do seguro.

Art. 78. A indenização não será devida na hipótese do usuário titular, ou seu respectivo dependente, de alguma maneira, der causa ou contribuir para a ocorrência do falecimento, bem como os eventos cujas despesas decorram, direta ou indiretamente, de:
a) atos ou operações de guerra, declarada ou não, de guerra química ou bacteriológica, guerra civil, rebelião, insurreição, guerrilha, revolução, agitação, motim, revolta, sedição, tumulto, confisco, sublevação, greves, bem como quaisquer outras perturbações da ordem pública e delas decorrentes, e, ainda, atos das Forças Armadas e de Segurança em tempos de paz;
b) inundação, furacão, ciclones, erupção vulcânica, tempestades, terremotos, maremotos, movimentos sísmicos ou movimentos de terra em geral e qualquer outro fenômeno atmosférico, meteorológico, sísmico ou geológico de caráter extraordinário e outras convulsões da natureza;
c) radiações ionizantes, materiais e armas nucleares, contaminação pela radioatividade ou resíduo de combustão de material nuclear e explosões nucleares;
d) ato reconhecidamente perigoso que não seja motivado por necessidade justificada e a prática, por parte do Segurado, de atos ilícitos ou contrários à lei;
e) competições com veículos, inclusive treinos preparatórios;
f) doenças preexistentes e conhecidas pelo usuário na época da contratação do seguro e acidentes ocorridos antes da contratação individual do seguro;

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Art. 79. O presente seguro será coberto pela UNIMED Seguradora S/A, com sede na cidade de São Paulo SP.

28

CAPÍTULO II DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR FAC

Art. 80. Ocorrendo o falecimento do usuário titular, com idade de até 59(cinqüenta e nove) anos na data da assinatura deste contrato, que seja há mais de 06 (seis) meses participante do plano de assistência à saúde objeto deste contrato, que as mensalidades estejam rigorosamente em dia na data do óbito, os usuários dependentes abaixo indicados, terão direito aos serviços previstos no plano em que estiverem inscritos, observadas as respectivas condições, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, contados da data do óbito, sem o pagamento das mensalidades.
Parágrafo único. Não estão incluídos neste benefício os eventuais valores de franquia por procedimento, cuja obrigação de pagamento pelos usuários subsistirá na forma e condições anteriores.

Art. 81. Desde que inscrito há mais de 06 (seis) meses; antes da data do óbito, considera-se usuário dependente aquele indicado no art. 21, aceito como tal no plano, **excluídos os agregados mencionados no art. 22 deste contrato.**
Parágrafo único. O direito ao FAC também é conferido ao nascituro, considerado filho do usuário titular falecido, nos termos da legislação civil, inscrito na forma do Capítulo IV do Título V deste instrumento.

Art. 82. O usuário dependente que não for inscrito no mesmo ato de inscrição do usuário titular, ou em até 30 (trinta) dias do implemento da condição que permitisse seu ingresso no plano, só terá direito ao benefício se o óbito ocorrer após decorrido o prazo de 12 (doze) meses de sua respectiva inscrição.
Art. 83. Perderá imediatamente o direito ao benefício estabelecido neste Capítulo o dependente que vier a perder sua condição de dependência.

Art. 84. O benefício previsto neste Capítulo fica condicionado à apresentação, pelos usuários dependentes, da Certidão de Óbito do usuário titular, além de cópias autenticadas dos documentos que se fizerem necessários à comprovação da dependência.
§ 1º. Os usuários dependentes que não apresentarem os documentos exigidos no ***caput***, ficam impedidos de gozar do benefício do FAC, ainda que estivessem em gozo do direito à cobertura deste contrato, quando vivo o usuário titular, salvo se houver continuidade nos pagamentos das mensalidades.
§ 2º. Os valores pagos nos termos do parágrafo anterior, sob nenhuma hipótese, serão devolvidos.

Art. 85. Os cartões de Identificação dos usuários dependentes, no caso de falecimento do titular, serão substituídos pela Identificação Pessoal do FAC.

Art. 86. O direito Assistência Complementar (FAC), aos dependentes do usuário

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

titular falecido, será assegurado na mesma área de abrangência do plano de assistência à saúde contratado.

TÍTULO XIV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 87. Os usuários com mais de sessenta e cinco anos de idade, as gestantes, lactantes, lactentes e crianças até cinco anos têm privilégio na marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos.

Art. 88. Na eventualidade de insatisfação quanto ao plano ou atendimento dos profissionais e empregados da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá encaminhar reclamação escrita para o endereço constante da Proposta de Admissão, para a devida apuração.

Art. 89. A utilização dos serviços contratados, durante o período de suspensão ou de carência, neste caso, ressalvadas as urgências e emergências, implica em dever do CONTRATANTE pagar à CONTRATADA o respectivo custo, aferido através da Tabela de Referência.

Art. 90. A CONTRATADA reserva-se o direito de rescindir o contrato com qualquer participante da sua rede assistencial, bem como de contratar novos serviços, a seu exclusivo critério, sempre objetivando o aprimoramento da prestação dos serviços previstos neste instrumento.

Art. 91. O CONTRATANTE reconhece expressamente que seu vínculo contratual é apenas com a CONTRATADA, mesmo em caso de atendimento por outras cooperativas integrantes do SISTEMA NACIONAL UNIMED.

Art. 92. A inserção de mensagens no recibo de cobrança das mensalidades valerá como intimação do CONTRATANTE, para todos os efeitos deste contrato, a partir da data do respectivo pagamento.

Art. 93. Qualquer tolerância não implica perdão, novação, renúncia ou alteração do pactuado.

Art. 94. **O CONTRATANTE, por si e pelos dependentes e agregados, autoriza a CONTRATADA a prestar todas as informações cadastrais, inclusive quanto aos atendimentos, solicitadas pelos órgãos de fiscalização da assistência à saúde.**

Art. 95. Integram este contrato, para todos os fins de direito, a Proposta de Admissão e demais anexos firmados pelos contraentes.

Art. 96. Casos omissos e eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre os contraentes e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

o Contratante se obriga a pagar a Contratada.
FRANQUIA: Custeio por parte do contratante de um valor e/ou, previamente
:uado no ato da realização do procedimento.
COBERTURA: é a cláusula contratada, que o usuário tem direito.
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA: é aquela que admite num prazo
arminado, a concessão de apenas algumas das coberturas contratadas, com a
pensão de cobertura de eventos cirúrgicos, leitos de alta tecnologia e
cedimentos de alta complexidade, relacionados às exclusões estabelecidas
contrato.
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (CONSU): é o órgão
egiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com
mpetência para deliberar sobre questões relacionadas à prestação de serviços
saúde suplementar nos seus aspectos médico, sanitário e epidemiológico.
VI CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS (CNSP): é o órgão
legiado vinculado ao Ministério da Fazenda que, dentre outras atribuições, é
sponsável por ditar as características gerais dos instrumentos contratuais
lizados pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde.
VII CONSULTA: é o ato realizado pelo médico, que avalia as condições clínicas
usuário.
VIII CONTRATO INDIVIDUAL: é aquele oferecido para livre adesão de
suários, pessoas físicas, com ou sem seu grupo familiar.
IX CONTRATO FAMILIAR: é aquele em que é facultado ao contratante, pessoa
sica, a inclusão de seus dependentes ou grupo familiar.
X CONVIVENTE: é a pessoa que vive em união estável com outrem em
timidade, familiaridade, concubinato ou mancebia; amigado; amasiado;
ompanheiro.
XI DOENÇA: é o processo mórbido definido, tendo um conjunto característico
e sintomas e sinais, que leva o indivíduo a tratamento médico.
XII DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE: é todo evento mórbido, congênito
u adquirido, que comprometa função orgânica ou coloque em risco a saúde do
ndivíduo, quer por sua ação direta ou indiretamente por suas conseqüências, do
ual o usuário tenha conhecimento ou recebido tratamento clínico ou cirúrgico,
ntes até a data de inclusão no plano.
XIII ELETIVO: é o termo usado para designar procedimentos médicos não
considerados de urgência ou emergência.
XIV EMERGÊNCIA: é o evento que implicar no risco imediato de vida ou de
esões irreparáveis para o usuário, caracterizado em declaração do médico
assistente.
XXV EVENTO: é o conjunto de ocorrências ou serviços de assistência médica ou
hospitalar que tenham por origem, ou causa, dano involuntário à saúde ou à
integridade física do usuário, em decorrência de acidente ou doença, desde que
tenha se verificado durante a vigência do contrato e não figure como exclusão de
cobertura. O evento se inicia com a comprovação médica de sua ocorrência e
termina com a alta médica definitiva, concedida ao paciente, com o abandono do
tratamento por parte do usuário, ou com a sua morte.
XXVI EXAME: é o procedimento complementar solicitado pelo médico, que

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

MÓDULO OPCIONAL - INTERNAÇÃO EM QUARTO PRIVATIVO

Art. 1º. Se firmado este Módulo, a contratação e os valores estarão expressos na Proposta de Admissão.

Art. 2º. Desde que contratado, será assegurado aos usuários, o direito à internação em quarto privativo com banheiro, e direito a acompanhante, de acordo com a disponibilidade do hospital.

Art. 3º. O direito à ampliação, ora contratada, será conferido aos usuários após o cumprimento das seguintes carências, quando for o caso, não cumulativas ao contrato, contadas da data da vigência do respectivo Módulo:

§ 1º. Sendo este Módulo contratado até trinta dias contados da assinatura deste contrato ou do implemento da condição que permita a inscrição do usuário no plano, os usuários estarão isentos de carências de acordo com as coberturas a seguir:

a) urgências e emergências;

b) binternações;

c) parto, desde que contratada a cobertura obstétrica.

§ 2º. Sendo este Módulo contratado após o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o usuário deverá cumprir os seguintes período de carência:

a) 300 dias: partos, desde que contratada a cobertura obstétrica; e

b) 180 dias: quaisquer outras internações.

Art. 4º. É responsabilidade do CONTRATANTE, o pagamento de despesas não vinculadas diretamente à cobertura do contrato.

Art. 5º. Fica estabelecido que o CONTRATANTE não poderá renunciar à ampliação ora contratada e manter as demais coberturas, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da data da inscrição do usuário neste Módulo.

Art. 6º. Por conseqüência da contratação deste Módulo, fica alterado o preço pactuado, que é acrescido da quantia descrita na Proposta de Admissão, por usuário inscrito.

Parágrafo único. Os valores referentes a este módulo, são calculados em função das mesmas faixas etárias descritas no Capítulo II do Título X e adotam o mesmo critério de variação e reajuste.

Art. 7º. Permanecem em plena vigência as Cláusulas do contrato não alteradas por este Módulo.

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Art. 97. Fica eleito o foro do domicílio da prestação dos serviços (Garanhuns-PE), dirimir qualquer demanda sobre o presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Art. 98. Este contrato foi elaborado levando-se em consideração a legislação vigente até 31/12/98, assim, qualquer alteração das normas que implique em necessária modificação do que aqui foi avençado, sujeitará a novo ajuste das condições, inclusive com possíveis reflexos na contraprestação.

Por estarem assim, justos e contratados, firmam a Proposta de Admissão que é parte integrante deste instrumento.

Contratada: UNIMED CARUARU/COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Contratante:_____

Testemunhas:

1. Nome:_____

RG.: _____ **C.P.F.:**_____

2. Nome:_____

RG.: _____ **C.P.F.:**_____

CONTRATO REGISTRADO SOB Nº_____

Cartório de Registro de Títulos e Documentos

_____

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

MÓDULO OPCIONAL ATENDIMENTO OBSTÉTRICO

DA COBERTURA

Art. 1º. Este módulo é complementar à cobertura definida no Capítulo II do Título VII, que é acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal e da assistência ao parto.
Parágrafo único. Em caso de necessidade de assistência médica hospitalar decorrente da condição gestacional coberta por este módulo, porém, estando a usuária ainda cumprindo período de carência, a CONTRATADA estará obrigada a tão-somente cobrir o atendimento prestado nas mesmas condições previstas na segmentação ambulatorial (Capítulo I do Título VII).

Art. 2º. Desde que a mãe ou adotante tenha cumprido as carências específicas, estarão cobertas as despesas com honorários médicos, diárias de berçário e centro de terapia intensiva do recém-nascido, filho natural ou adotivo, bem como materiais e medicamentos ministrados durante a internação, e exames indispensáveis ao seu tratamento, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o nascimento. Decorrido esse prazo, a cobertura fica condicionada à inclusão do recém-nascido em plano de assistência à saúde, observado o disposto no Título V.

DAS EXCLUSÕES

Art. 3º. As exclusões deste módulo são as mesmas da segmentação Hospitalar sem Obstetrícia, exceto no que se refere à cobertura de procedimentos obstétricos, ora contratada.

DOS PROCEDIMENTOS

Art. 4º. Para este módulo, observar-se-ão os mesmos procedimentos dispostos na Seção III do Capítulo II do Título VII.

Caruaru, _____ de _____ de _____

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Endereços

SEDE
Rua Deputado Souto Filho, 178 Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-312 Fone/fax (81) 3721-5068

POSTOS DE VENDAS
CARUARU
Glmar Representações
Rua Silvino Macêdo, 125 A Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-380 Fone/Fax: (81) 3721-7215

Allyson Representações
Rua Dom Sebastião Leme, 60 Maurício de Nassau
Caruaru PE CEP 55012-360 Fone/Fax: (81) 3721-2454

Rosineide Representações
Rua Capitão João Velho, 201 Centro
Caruaru PE CEP 55002-400 Fone/Fax: (81) 3721-8971

Valdir e Sérgio Representações
Rua Cel. Limeira, 25 Centro
Caruaru PE CEP 55002-350 Fone/Fax: (81) 3722-3769

Antônio Filho Representações
Rua Tiradentes, 55 Centro
Caruaru PE CEP 55004-230 Fone/Fax: (81) 3721-4911
E-mail: marianeide@ig.com.br

CUPIRA
Antônio Filho Representações
Rua Dr. Aderbal Jurema, 10 Centro
Fone: (81) 3738-1459

GRAVATÁ
Antônio Filho Representações
Rua Rui Barbosa, 91 1° andar Centro
Gravatá -PE- CEP 55640-000 Fone/Fax: (81) 3533-1325

TORITAMA
Betânia Representações
Rua do Comércio, 184 Centro
Toritama Pe CEP 55125-000 Fone: (81) 3741-1803

BELO JARDIM
Gonzaga e Cristina Representações
Rua Valdemar de Lira, 65 Boa Vista
Belo Jardim -PE CEP 55150-000 Fone/Fax: (81) 3726-1712

PALMARES
Rua Conselheiro João Alfredo, Casa A, 95 Centro
Fone: (81) 3661-4874

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
Betânia Representações
Av. 29 de Dezembro, 381 Centro
Santa Cruz do Capibaribe PE CEP 55190-000 Fone: (81) 3731-2321

UTI Móvel Ambulância
Fone: (81) 9104-1063

UNIVIDA AIR Remoção Aérea
Fone: 0800-992500

HOSPTIAL UNIMED
Rua Arthur Antônio da Silva, 549 Fone: (81) 3722-8600

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250511700000239055241
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250511700000239055241
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:05

Dados Pessoais:

Código:	5019481769000		
Nome:	Maria Davinny Leticia Da Silva Pereira Torres		
Dt. de Nascimento:	03/08/2005	**Declaração Nascimento:**	
Sexo:	Feminino		
Matrícula:			
Nº do CPF:	09779818430	**Nº da Identidade:**	
Data Expedição RG:	**UF RG:**	**Órgão Expedidor RG:**	
Nome da Mãe:	Maria Lucimara Da Silva Braga		
Nome do Pai:	Davi Jaciel Pereira De Torres		

Dados Complementares:

Status Cartão:	Aguardando confecção	Renda:	
Validade Cartão:	31/10/2023	Profissão:	
Via Cartão:	1	Estado Civil:	Indeterminado
Faixa Etária:	019-023	Escolaridade:	
Mensalidade(R$) - Plano Principal:	230,84	Home page:	
		CNS:	704602692683422
Mensalidade(R$) - Plano Secundário:	0,00	CCO:	011949982246
Banco:		E-mail:	
Agência:			
Plano originado de:	ÚNICO ENFERMARIA PESSOA FÍSICA III		

Endereço(s):

Logradouro: R	17 DE DEZEMBRO	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Caixa postal:	
Cidade:	CACHOEIRINHA	Estado:	PERNAMBUC
CEP:	55380000	Pais:	BRASIL
Número:	210	Corresp.: S	

Telefone(s):

Número:	Tipo do telefone:	DDD:	Ramal:
96148242	Celular	81	
999144694	Celular	81	

Dados Gerais:

Código: *5019481769000*
Nome: *Maria Davinny Leticia Da Silva Pereira Torres*
Contrato Nº: *481769*
Contratante: *Maria Lucimara Da Silva*
Data Inclusão: *26/10/2005* **Data Exclusão:**
Situação: *Ativo* **Dependência:** *Titulares*
Vinculado a: *Maria Davinny Leticia Da Silva Pereira Torres*
Data Contratação: *26/10/2005* **Dia Vencimento:** *30*
Lotação:
Data Inativação: **Situação do Contrato:** *Ativo*

Plano:

Descrição: *A+H+O*
Originado de: *ÚNICO ENFERMARIA PESSOA FÍSICA III*
Acomodação: *ENF*
Abrangência: *Grupo de Municipios*

Intercâmbio (origem):

Operadora:
Código:
Contrato:

Intercâmbio (destino):

Operadora:
Data:
Forma:
Atendimento:

PARECER TÉCNICO Nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024

COBERTURA: MAMA E SISTEMA LINFÁTICO (MASTECTOMIA / MASTOPLASTIA)

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - Rol, atualmente previsto no anexo I da RN n.º 465/2021, vigente a partir de 1º/4/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º/1/1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Esclarecemos que o procedimento MASTECTOMIA está previsto no Rol, e, portanto, deve ser obrigatoriamente coberto por planos com segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e plano-referência, quando solicitado pelo médico assistente.

O referido procedimento engloba outros com diferentes descrições, tais como, Mastectomia radical ou radical modificada - qualquer técnica; Mastectomia simples; Mastectomia dupla; Mastectomia poupadora da pele; Mastectomia poupadora do mamilo; Mastectomia redutora de risco; Mastectomia subcutânea; Adenomastectomia e Lumpectomia (Cirurgia conservadora da mama; Mastectomia parcial; Mastectomia segmentar; Tumorectomia, Setorectomia; Ressecção ampliada; Ressecção segmentar e Quadrantectomia).

A MASTECTOMIA, por não estar vinculada a uma Diretriz de Utilização – DUT e não ter qualquer restrição em sua denominação, terá cobertura sempre que indicada pelo médico assistente, incluindo, por exemplo, as seguintes situações:

1. Cirurgia redutora de risco com ou sem exame genético que indique mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas em determinados genes, na forma descrita nas OBS 3 da DUT 110.7, OBS 1 da DUT 110.26, OBS 1 da DUT 110.30, OBS 1 da DUT 110.32, OBS 1 da DUT 110.38;

2. Mama oposta em paciente com câncer diagnosticado em uma das mamas;

3. Procedimento complementar ao processo de transexualização, conforme Parecer Técnico específico (PARECER TÉCNICO Nº26/GCTIS/GGRAS/DIPRO/2024).

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250590900000239055244
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250590900000239055244
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:06

Quanto à reconstrução mamária, informamos que o art. 10-A da Lei nº 9.656/1998 estabelece que cabe às operadoras de planos de saúde, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.

Nesse sentido, os procedimentos RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES; RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS MUSCULARES E/OU CUTÂNEOS EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES e RECONSTRUÇÃO PARCIAL DA MAMA PÓS-QUADRANTECTOMIA EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES, os quais são modalidades de reconstrução plástica mamária, associadas ou não ao uso de próteses e/ou expansores, estão previstos no Rol. Assim, como disposto em suas nomenclaturas, a cobertura dos referidos procedimentos é obrigatória, quando houver solicitação médica e estiverem relacionados a lesões traumáticas e tumores.

Cabe destacar que a reconstrução da mama oposta está contemplada no Rol sob o procedimento MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA CONTRALATERAL EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES. Assim, sua cobertura é obrigatória quando o médico assistente indicar a cirurgia da mama oposta para pacientes com diagnóstico de câncer firmado ou lesão traumática em uma mama.

Além das referidas hipóteses de cobertura, a reconstrução das mamas também tem cobertura obrigatória quando exame genético indicar mutações patogênicas ou provavelmente patogênicas em determinados genes, na forma descrita nas OBS 3 da DUT 110.7, OBS 1 da DUT 110.26, OBS 1 da DUT 110.30, OBS 1 da DUT 110.32, OBS 1 da DUT 110.38.

Já, o procedimento MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória.

Convém destacar que o Rol é continuamente atualizado, tendo em vista que novas tecnologias em saúde são continuamente incorporadas à prática assistencial. Na saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias em saúde, a alteração de nome de

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250590900000239055244
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250590900000239055244
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:06

procedimento e a definição de regras para sua utilização são atualmente regulamentadas pela Resolução Normativa nº 555/2022, em vigor desde 2/1/2023, que dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol.

Nesse sentido, propostas de atualização do Rol com vistas à incorporação de novos procedimentos, à alteração de diretrizes de utilização ou de nome de procedimento poderão ser apresentadas, por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio da plataforma FormRol Web, acessível pelo sítio da ANS na internet (https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos).

Por fim, é relevante pontuar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 1º/1/1999 e não ajustados à Lei n.º 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura em análise somente será obrigatória se houver previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual.

Gerência de Cobertura Assistencial e Incorporação de Tecnologias em Saúde - GCITS
Gerência-Geral de Regulação Assistencial – GGRAS
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250590900000239055244
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250590900000239055244
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:06

COMPROVANTE DE NEGATIVA CONTRATUAL/ ASSISTENCIAL - em conformidade com a RN nº 319

CARUARU - PE,15/04/26 17:03

Dados da Operadora
Razão Social: Unimed Caruaru
Registro ANS: 340952
CNPJ: 24449225000198
Endereço: CARUARU CORPORATE, 3º ANDAR - AV. ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 INDIANÓPOLIS
Protocolo: 34095220260407004967

Dados do Beneficiário
Nome: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Data De Nascimento: 03/08/2005 **CPF:** 09779818430
Número da Carteira: 174 5019481769000 **Data De Inclusão:** 26/10/2005
Plano: 536 - UNICO ENFERMARIA PESSOA FISICA III
Abrangência: Grupo de Municípios **Acomodação:** ENFERMARIA
Número da Guia: 144786009
Contrato: 62689 - MARIA LUCIMARA DA SILVA

A Unimed Caruaru - Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de assistência privada a saúde, registrada na ANS sob o nº340952, inscrita no CNPJ/MF sob o nº24.449.225/0001-98, com sede Av. Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis, Ed. Empresarial Caruaru Corporate, 3º Andar, Caruaru Shopping, Caruaru, Pernambuco, CEP: 55024-740, informa acerca de sua solicitação médica de acordo com o dispositivo legal:

Dados dos Procedimentos

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
22	30602351	Mamoplastia	2

Motivo Da Negativa

Em conformidade com a RN 623/24, Art. 14, vimos apresentar a justificativa da negativa de autorização do exame/procedimento referido. Esclarecemos que o contrato ao qual V.Sa. está vinculado é regido pela Lei nº 9.656/98, tratando-se, portanto, de um contrato regulamentado, que possui cobertura estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no chamado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Ocorre que a solicitação do procedimento apresentada por V.Sa., após análise técnica realizada, recebeu parecer desfavorável, pois de acordo com o PARECER TÉCNICO Nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024: MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória.

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
18	60000805	DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO	1

Motivo Da Negativa

Atenciosamente,

Relacionamento com o Cliente

Obs: A Lei nº 9.656/98 e as normas citadas acima podem ser consultadas no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br). A presente informação, relata as razões da negativa de cobertura que poderá ocorrer por razões contratuais ou assistenciais, ou ambas.
É facultado ao cliente requerer a reanálise de sua solicitação, devendo direcionar o seu pedido com a Indicação do número deste protocolo de atendimento e de documentos adicionais que corroborem na análise mais precisa do caso, para ser apreciada pela Ouvidoria através de Email: ouvidoria@unimedcaruaru.com.br ou presencialmente, no endereço: Shopping Caruaru - Corporate / Rua Adjar da Silva Casé, 800- Indianópolis.

COMPROVANTE DE NEGATIVA CONTRATUAL/ ASSISTENCIAL - em conformidade com a RN nº 319

CARUARU - PE,09/04/26 13:26

Dados da Operadora
Razão Social: Unimed Caruaru
Registro ANS: 340952
CNPJ: 24449225000198
Endereço: CARUARU CORPORATE, 3º ANDAR - AV. ADJAR DA SILVA CASÉ, 800 INDIANÓPOLIS
Protocolo: 34095220260409034269

Dados do Beneficiário
Nome: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Data De Nascimento: 03/08/2005 **CPF:** 09779818430
Número da Carteira: 174 5019481769000 **Data De Inclusão:** 26/10/2005
Plano: 536 - UNICO ENFERMARIA PESSOA FISICA III
Abrangência: Grupo de Municípios **Acomodação:** ENFERMARIA
Número da Guia: 144786009
Contrato: 62689 - MARIA LUCIMARA DA SILVA

A Unimed Caruaru - Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de assistência privada a saúde, registrada na ANS sob o nº340952, inscrita no CNPJ/MF sob o nº24.449.225/0001-98, com sede Av. Adjar da Silva Casé, 800, Indianópolis, Ed. Empresarial Caruaru Corporate, 3º Andar, Caruaru Shopping, Caruaru, Pernambuco, CEP: 55024-740, informa acerca de sua solicitação médica de acordo com o dispositivo legal:

Dados dos Procedimentos

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
22	30602351	Mamoplastia	2

Motivo Da Negativa

Em conformidade com a RN 623/24, Art. 14, vimos apresentar a justificativa da negativa de autorização do exame/procedimento referido. Esclarecemos que o contrato ao qual V.Sa. está vinculado é regido pela Lei nº 9.656/98, tratando-se, portanto, de um contrato regulamentado, que possui cobertura estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no chamado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Atualmente, o referido Rol está previsto na RN nº 465/2021 da ANS, que, em relação ao exame/procedimento solicitado, estabelece, em seus Anexos II e III, Diretrizes de Utilização (DUT) e Diretrizes Clínicas (DC) que devem ser observadas para que a cobertura se torne obrigatória.

Ocorre que a solicitação do exame apresentada por V.Sa., após análise técnica realizada, recebeu parecer desfavorável, tendo como justificativa que, segundo a Lei nº 9.656/98 (Lei Geral dos Planos de Saúde), procedimentos de natureza estética não possuem obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de saúde.

Tabela	Serviço	Descrição	Qtd Solicitada
18	60000805	DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO	1

Motivo Da Negativa

Motivo citado acima.

Atenciosamente,

Relacionamento com o Cliente

Obs: A Lei nº 9.656/98 e as normas citadas acima podem ser consultadas no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br). A presente informação, relata as razões da negativa de cobertura que poderá ocorrer por razões contratuais ou assistenciais, ou ambas.
É facultado ao cliente requerer a reanálise de sua solicitação, devendo direcionar o seu pedido com a Indicação do número deste protocolo de atendimento e de documentos adicionais que corroborem na análise mais precisa do caso, para ser apreciada pela Ouvidoria através de Email: ouvidoria@unimedcaruaru.com.br ou presencialmente, no endereço: Shopping Caruaru - Corporate / Rua Adjar da Silva Casé, 800- Indianópolis.

GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

Unimed CARUARU

Nº do protocolo: 340952202604070049 Status: NEGADA

2-Nº Guia no Prestador
1078827

1-Registro ANS	3-Número da Guia Atribuído pela Operadora	4-Data da Autorização	5-Senha	6-Data Validade Senha
340952	144786009			

Dados do Beneficiário

7-Número da Carteira	8-Validade da Carteira	9-Atendimento de RN
174 5019481769000	30/10/2027	N

10-Nome: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

50-Nome Social:

Dados do Contratado Solicitante

12-Código na Operadora / CNPJ	13-Nome do Contratado
110000323	HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA

14-Nome do Profissional Solicitante	15-Conselho Profissional	16-Número Conselho	17-UF	18-Código CBO
MARCOS ANTONIO GOMES ALVES	CRM	11305	26	225235

Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação

19-Código na Operadora/CNPJ	20-Nome do Contratado	21-Data Sugerida
110000323	HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA	13/04/26

22-Caráter do Atendimento	23-Tipo de Internação
1 (1-Eletiva 2-Urgência/Emergência)	2 (1-Clínica 2-Cirúrgica 3-Obstétrica 4-Pediátrica 5-Psiquiátrica)

24-Regime de Internação	25-Qtde. Diárias	26-Previsão Uso	27-Previsão Uso de Quimioterápico
1 (1-Hospitalar 2-Hospital-dia 3-Domiciliar)	1	N	N

28-Indicação Clínica: SEGUE IN DICAÇÃO CLINICA EM ANEXO N60 -- Displasias mamárias benignas.

29-CID 10 Principal	30-CID 10 (2)	31-CID 10 (3)	32-CID 10 (4)	33-Indicação de Acidente
N60				9 (0-Trabalho 1-Trânsito 2-Outros 9-Não)

Procedimentos Solicitados

34-Tabela	35-Cód do Procedimento	36-Descrição	37-Qt. Solic.	38-Qt. Autoriz.	Status
22	30602351	Mamoplastia	2	0	NEGADO
18	60000805	DIÁRIA DE QUARTO COLETIVO DE 2 LEITOS	1	0	NEGADO

Dados da Autorização

39-Data Provável da Admissão	40-Qtde. Diárias Autorizadas	41-Tipo da Acomodação Autorizada
13/04/2026	0	41

42-Código na Operadora/CNPJ	43-Nome do Prestador Autorizado	44-Código CNES
110000323	HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA	7895682

45-Observação

-Observação Operadora: Parecer desfavorável !o segundo a lei 9656 (lei geral dos planos de saúde) cirurgias estéticas não tem obrigatoriedade de atendimento pelas operadoras de saúde .

46-Data Solicitação	47-Assinatura Profissional Solicitante	48-Assinatura Beneficiário/Responsável	49-Assinatura Responsável Autorização
07/04/26			1

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26070722250647900000239055247
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26070722250647900000239055247
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 07/07/2026 22:25:06

MELQUISEDEQUE LIMA
ADVOCACIA

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU – PE

Proc. nº 0008172-04.2026.8.17.2480

MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, já qualificada nos autos do processo epigrafado, que tramita perante esta 5ª Vara Cível, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção à manifestação da Requerida (ID 245851547), expor e requerer o que segue.

1. DO FATO SUPERVENIENTE (ART. 493 DO CPC): REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR

Nos termos do art. 493 do CPC, fato constitutivo superveniente à propositura da ação deve ser levado em consideração pelo juízo no momento de decidir. É o que ora se comunica.

Diante da ausência de decisão liminar e da impossibilidade de postergação do quadro clínico, a cirurgia de mamoplastia redutora indicada no laudo médico foi realizada no Hospital Memorial São Gabriel, em Caruaru/PE, com internamento em 16/06/2026 e alta em 17/06/2026, poucos dias após a data originalmente agendada (13/06/2026), tendo a Autora e sua família suportado a integralidade dos custos.

Os documentos ora juntados comprovam o desembolso remanescente: (i) NFS-e nº 53016 e NFS-e nº 53017, do Hospital Memorial São Gabriel, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 1.400,00; (ii) conta hospitalar detalhada, emitida em nome da própria Autora, cujo total (R$ 4.400,00) coincide com a soma das duas notas; (iii) NFS-e nº 5345, de Albuquerque Anestesias Ltda., no valor de R$ 1.600,00, com discriminação expressa "Serviços Prestados de Anestesias: CIRURGIA MAMOPLASTIA"; (iv) recibos de instrumentação cirúrgica (R$ 750,00), de serviços prestados na cirurgia (R$ 450,00) e de cuidados pós-operatórios com curativo e drenagem (R$ 400,00); e (v) registro fotográfico da identificação do leito, que documenta o internamento em 16/06/2026 sob os cuidados do Dr. Marcos Gomes.

O quadro consolidado do dano patrimonial é o seguinte:

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

Item	Valor	Documentação
Honorários do cirurgião (já documentados na inicial)	R$ 9.000,00	NF-e nº 377
Materiais cirúrgicos (já documentados na inicial)	R$ 1.100,00	Recibo anexo à inicial
Despesas hospitalares (internamento)	R$ 4.400,00	NFS-e nºs 53016 e 53017 e conta hospitalar
Serviços de anestesia	R$ 1.600,00	NFS-e nº 5345
Instrumentação cirúrgica	R$ 750,00	Recibo de 16/06/2026
Serviços prestados na cirurgia	R$ 450,00	Recibo de 16/06/2026
Cuidados pós-operatórios (curativo e drenagem)	R$ 400,00	Recibo
TOTAL DESEMBOLSADO	**R$ 17.700,00**	

Registre-se que o valor efetivamente desembolsado no remanescente (R$ 7.600,00) ficou inclusive abaixo da estimativa constante da inicial (R$ 9.900,00), demonstrando a lisura e a moderação da Autora na condução da demanda.

Nesses termos, ativa-se o pedido formulado na alínea "b" da exordial, que expressamente previu esta hipótese: a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, com o reembolso integral dos valores desembolsados. A tutela de urgência não perdeu o objeto; apenas mudou de modalidade, na exata forma antecipada pela inicial.

2. DA INAPLICABILIDADE DA ADI 7.265 DO STF À CAUSA DE PEDIR PRINCIPAL

Toda a manifestação da Requerida repousa sobre premissa falsa: a de que a pretensão autoral seria de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS, atraindo a tese da ADI 7.265 do STF. Não é disso que trata esta ação.

A causa de pedir principal é composta por quatro fundamentos autônomos, nenhum deles dependente da discussão sobre o rol: (i) o procedimento tem natureza reparadora e

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

funcional, atestada por laudo de neurocirurgião com quatro CIDs ortopédicos e neurológicos; (ii) a hipertrofia mamária é doença listada na Classificação Internacional de Doenças (CID N62), o que torna obrigatória a cobertura do respectivo tratamento nos termos do art. 10, caput, da Lei 9.656/98; (iii) a cláusula 54, VIII, do contrato é nula por abusividade (art. 51, IV, do CDC); e (iv) o próprio contrato, em seu art. 39, assegura cobertura à cirurgia plástica reparadora destinada à restauração de funções.

Esse é precisamente o enquadramento já reconhecido pela Primeira Câmara Regional de Caruaru deste Egrégio Tribunal, em caso idêntico e contra a própria Requerida:

> *"A cirurgia de correção de hipertrofia mamária consiste em um procedimento médico para atenuar os problemas corporais do paciente, que afetam a sua saúde e qualidade de vida, reduzindo o risco de agravamento do estado de saúde, demonstrando o seu caráter não estético. A hipertrofia mamária está listada na Classificação Internacional de Doenças, CID 10, da Organização Mundial de Saúde e, por isso, é obrigatória a cobertura do respectivo tratamento por parte dos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98. Resta configurado e imperioso o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário referentes à cirurgia de correção de hipertrofia mamária."* (TJPE, AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, j. 29/05/2020, caso envolvendo a Unimed Caruaru)

A tese da ADI 7.265 disciplina hipótese diversa (cobertura de procedimentos não previstos no rol) e somente teria pertinência em relação ao fundamento subsidiário da inicial. A Requerida tenta deslocar o eixo da controvérsia para o único terreno em que sua defesa encontraria algum apoio, ignorando que a pretensão principal prescinde por completo desse debate.

3. DA IMPRESTABILIDADE DO PARECER TÉCNICO Nº 19/2024 COMO "NEGATIVA EXPRESSA DA ANS"

Ainda que se adentrasse o debate da ADI 7.265, o argumento da Requerida não se sustenta. O requisito (ii) da tese vinculante refere-se à inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em Proposta de Atualização do Rol (PAR). Trata-se, portanto, de ato decisório da agência em procedimento formal de incorporação.

O Parecer Técnico nº 19/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024 não é ato decisório de indeferimento de incorporação. É documento de gerência técnica que responde consulta genérica, sem procedimento regulatório, sem contraditório e sem força normativa. A própria

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

manifestação da Requerida reconhece que jamais existiu PAR relativa ao procedimento, ao afirmar que a suposta natureza estética "justifica a inexistência de requerimento" perante a agência.

Inexistindo PAR indeferida e inexistindo pendência de análise, o requisito (ii) da tese do STF encontra-se atendido, e não violado, no caso concreto. O argumento da Requerida inverte o sentido da tese que invoca.

4. DA FALSIDADE DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO LAUDO QUANTO AOS TRATAMENTOS CONSERVADORES

A Requerida afirma que o laudo médico "omite a tentativa e a falha ou insuficiência de tratamentos prévios" e que a cirurgia teria sido "prescrita como opção primária". A alegação é desmentida pelo próprio documento.

O laudo do Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins (ID 242020101) registra expressamente: dorsalgia crônica mecânico-postural "com alívio apenas parcial com analgésicos"; e escoliose torácica com necessidade de "tratamento conservador e compensação muscular". O documento atesta, portanto, que a terapia conservadora foi utilizada e se revelou insuficiente, pois atenua sintomas sem eliminar a causa biomecânica do quadro, que é o volume mamário excessivo.

A indicação cirúrgica não foi opção primária; foi a consequência clínica da refratariedade do quadro ao manejo conservador, exatamente como reconhecido pelo TJPE em caso análogo:

> *"Mamoplastia redutora indicada em razão de hipertrofia mamária sintomática não se confunde com cirurgia meramente estética, possuindo natureza terapêutica/corretiva, voltada à preservação da saúde e da funcionalidade. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação contratual mais favorável ao consumidor e controle de abusividade."* (TJPE, AC nº 0119703-19.2022.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 09/12/2025)

5. DA DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E DE CONSULTA AO NATJUS

O pedido de perícia prévia e a consulta ao NatJus devem ser rejeitados por quatro razões autônomas e cumulativas.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

Primeira: a controvérsia central destes autos é jurídico-contratual, consistente na validade da cláusula 54, VIII, e no enquadramento do procedimento na exceção reparadora do art. 39 do próprio contrato, matéria de interpretação à luz do CDC que nenhuma prova técnica resolve.

Segunda: o feito está instruído com laudo técnico e circunstanciado de neurocirurgião, com CRM e RQE ativos, que a Requerida não contrapôs com nenhum documento médico próprio. Este Egrégio Tribunal já fixou tese expressa sobre a hipótese:

> *"A realização de prova pericial é desnecessária quando o processo está instruído com laudo médico técnico e circunstanciado, subscrito por profissional habilitado. Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento adequado ao paciente."* (TJPE, AI nº 0007731-91.2025.8.17.9000, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 29/09/2025)

Terceira: o procedimento já foi realizado. Perícia e nota técnica são instrumentos destinados a subsidiar decisão sobre tratamento futuro; realizado o ato cirúrgico, tais diligências perdem qualquer utilidade prática e assumem caráter meramente protelatório, devendo ser indeferidas nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A pretensão remanescente é de reembolso, matéria de prova exclusivamente documental, já integralmente produzida.

Quarta: o Enunciado 18 do FONAJUS contém recomendação expressamente condicionada ("sempre que possível"), não requisito de validade da decisão, e a exigência de consulta ao NatJus prevista na ADI 7.265 não incide sobre a causa de pedir principal, pelas razões do tópico 3 desta petição.

7. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Autora:

a) A apreciação imediata do pedido de tutela de urgência, na modalidade de obrigação de pagar já prevista na alínea "b" da inicial, com a determinação de reembolso dos R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

reais) integralmente documentados nos autos, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b) A rejeição dos pedidos de realização de perícia prévia e de consulta ao NatJus, por desnecessários e protelatórios;

c) A juntada dos documentos que acompanham esta petição;

d) A citação formal da Requerida para, querendo, contestar a ação, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Caruaru/PE, 13 de julho de 2026.

Melquisedeque S. De Lima
OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Doc. 01. NFS-e nº 53016, Hospital Memorial São Gabriel (R$ 3.000,00)
2. Doc. 02. NFS-e nº 53017, Hospital Memorial São Gabriel (R$ 1.400,00)
3. Doc. 03. Conta hospitalar detalhada, Hospital Memorial São Gabriel (R$ 4.400,00)
4. Doc. 04. NFS-e nº 5345, Albuquerque Anestesias (R$ 1.600,00)
5. Doc. 05. Recibo de instrumentação cirúrgica, 16/06/2026 (R$ 750,00)
6. Doc. 06. Recibo de serviços prestados na cirurgia, 16/06/2026 (R$ 450,00)
7. Doc. 07. Recibo de cuidados pós-operatórios, curativo e drenagem (R$ 400,00)
8. Doc. 08. Registro fotográfico da identificação de leito (internamento em 16/06/2026)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582537100000239625169
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582537100000239625169
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:25

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 53016 Código de Verificação XW4PBAXYP Emissão da NFS-e 17/06/2026 11:54:43	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 22.721.288/0001-26 Inscrição 90602272

Nome/Razão Social: HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA.

Endereço RUA José Veríssimo Número: 752

Complemento: Bairro: Maurício de Nassau

CEP: 55014-250 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil

E-mail: jose505@zipmail.com.br Telefone: 3727-7250

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 097.798.184-30 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

Endereço: Rua RUA 17 DE DEZEMBRO Número: 210

Complemento: Bairro: CENTRO

CEP: 55380-000 Município: CACHOEIRINHA UF: PE País: Brasil

E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 327,90

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
19,50	Apuração Própria	90,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	3.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	109,50
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	3.000,00
Classificação Tributária	200029	Alíquota	5,00
Competência	06/2026	ISSQN	150,00
Município Prestação	CARUARU - PE	IBS	2,74
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	CBS	24,66
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	3.000,00

Outras Informações

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 53017 Código de Verificação 9RCDTMB7O Emissão da NFS-e 17/06/2026 11:59:15	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 22.721.288/0001-26 Inscrição 90602272

Nome/Razão Social: HOSPITAL MEMORIAL SAO GABRIEL LTDA.

Endereço RUA José Veríssimo Número: 752

Complemento: Bairro: Maurício de Nassau

CEP: 55014-250 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil

E-mail: jose505@zipmail.com.br Telefone: 3727-7250

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 153.678.108-88 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: MARIA LUCIMARA DA SILVA BRAGA

Endereço: Rua 17 DE DEZEMBRO Número: 210

Complemento: Bairro: CENTRO

CEP: 55380-000 Município: CACHOEIRINHA UF: PE País: Brasil

E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Discriminação do Serviço

REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES.
CPF: 097.798.184-30.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 153,02

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
9,10	Apuração Própria	42,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.400,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	51,10
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	1.400,00
Classificação Tributária	200029	Alíquota	5,00
Competência	06/2026	ISSQN	70,00
Município Prestação	CARUARU - PE	IBS	1,28
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	CBS	11,51
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.400,00

Outras Informações

Avenida José Verissimo, 752 - Caruaru - PE
CNPJ:22721288000126 - Inscrição estadual: - Fone:37277250
(CNES 2680394)

Conta paciente

Nota:

Emissao:

N° atend: 14.364
Nº IC: 29.161

Paciente:	Convênio:	Usuário/Matrícula:
Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres	PARTICULAR	
Categoria: Apartamento		

Prontuário: 5351 Data entrada: 16/06/2026 16:08:04 Data saída:
Médico: Marcos Antonio Gomes
Proc Princ: 30602351 Mamoplastia
Tipo acomodação Apartamento
Idade: 20a 10m 14d
CID Princ:
Guia: Não informada Validade

Motivo Alta: 171
Tipo atend: 1 - Internado
Espec/Clinica: 2 Cirúrgica

Dt Conta: 16/06/2026 Dt inicial: 16/06/2026 Dt final: 17/06/2026 Refer: 01/06/26

Diárias

Seq	Setor	Código	Descrição	Data	Qtde	Unitario	Vl Total
1	HG_Intern	60000651	DIARIA DE APARTAMENTO STANDARD	16/06/2026	1	330,00	330,00
			Total de Diárias		**1**		**330,00**

Taxas

Seq	Setor	Código	Descrição	Data	Qtde	Vl Unitario	Vl Total
1	HG_Intern	10000107	TX UNICA CENTRO CIRURGICO -	16/06/2026	1,00	1.300,00	1.300,00
2	HG_Intern	60033487	TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO,	16/06/2026	1,00	200,00	200,00
			Total de Taxas		**2,00**		**1.500,00**

Medicamentos

Seq	Setor	Descrição Medicamento	Medic.	Data	Unid.	Qtde	Vl Unit.	Vl Total
1	HG_Bloco	AGUA PARA INJECAO Restrito Hosp. 10 ml cx.	942	16/06/2026	Amp	1,0000	0,87	0,87
2	HG_Bloco	CEFAZOLINA SODICA GENERICO Restrito	129	16/06/2026	FA	2,0000	16,28	32,55
3	HG_Bloco	CLONIDIN Restrito Hosp. 150 mcg/ml 30 est. 1	883	16/06/2026	Amp	1,0000	11,22	11,22
4	HG_Bloco	CLORETO DE SODIO 09 SISTEMA FECHADO	5	16/06/2026	Fr	2,0000	8,52	17,05
5	HG_Bloco	DEXAMETASONA GENERICO Restrito Hosp. 4	999	16/06/2026	Amp	1,0000	3,76	3,76
6	HG_Bloco	EFRINALIN Restrito Hosp. 1 mg/ml sol. inj. cx.	94	16/06/2026	Amp	1,0000	2,64	2,64
7	HG_Bloco	FENTANEST Restrito Hosp. 0,05 mg/ml 50 est. x	1232	16/06/2026	Amp	1,0000	7,54	7,54
8	HG_Bloco	Midazolam 5mg/ml 3mL - Ampola	382	16/06/2026	Amp	1,0000	19,07	19,07
9	HG_Bloco	NOVABUPI EPINEFRINA Restrito Hosp. 0,5%	1234	16/06/2026	mL	20,0000	2,00	40,07
10	HG_Bloco	Ondansetrona 2mg/mL 2mL - Ampola	582	16/06/2026	Amp	1,0000	22,75	22,75
11	HG_Bloco	RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO	87	16/06/2026	Fr	2,0000	10,18	20,36
12	HG_Bloco	TROMETAMOL CETOROLACO GENERICO	1139	16/06/2026	Amp	1,0000	9,21	9,21
13	HG_Bloco	XYLESTESIN EPINEFRINA Restrito Hosp. 2%	1237	16/06/2026	mL	20,0000	1,92	38,38
14	HG_Intern	AGUA PARA INJECAO Restrito Hosp. 10 ml cx.	942	16/06/2026	Amp	4,0000	0,87	3,48
15	HG_Intern	CEFAZOLINA SODICA GENERICO Restrito	129	16/06/2026	FA	2,0000	16,28	32,55
16	HG_Intern	CETOFENID Restrito Hosp. 100 mg co sol. infus.	218	16/06/2026	FA	2,0000	3,66	7,32
17	HG_Intern	CLORETO DE SODIO 09 SISTEMA FECHADO	5	16/06/2026	Fr	2,0000	8,52	17,05
18	HG_Intern	CLORETO DE SODIO 09 SOLUFLEX Restrito	6	16/06/2026	Fr	1,0000	7,42	7,42
19	HG_Intern	Ondansetrona 2mg/mL 4 mL - Ampola	45	16/06/2026	Amp	2,0000	32,26	64,52
20	HG_Intern	RINGER COM LACTATO SISTEMA FECHADO	87	16/06/2026	Fr	4,0000	10,18	40,72
21	HG_Intern	TRANSAMIN 50 mg/ml sol. inj. ct. 5 amps. vd.	429	16/06/2026	Amp	1,0000	14,91	14,91
		Total de Medicamentos				**72,0000**		**413,44**

Materiais

Seq	Setor	Descrição Material	Material	Unid.	Data	Qtde	Vl Unit.	Vl Total
1	HG_Bloco	ADAPTADOR C/DUPLA PTA.PERFURANTE LA	1297	Un	16/06/2026	1,0000	18,9000	18,90
2	HG_Bloco	AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM	11	Un	16/06/2026	2,0000	2,0950	4,19
3	HG_Bloco	AGULHA PERIDURAL 18GA 080MM PERICAN	1262	Un	16/06/2026	1,0000	200,0000	200,00
4	HG_Bloco	ATADURA CREPOM CYSNE 30CMX1,8MT	1271	Un	16/06/2026	4,0000	7,1725	28,69
5	HG_Bloco	CATETER NASAL OXIGENIO TP.OCULOS 1,40	1285	Un	16/06/2026	1,0000	17,8700	17,87
6	HG_Bloco	CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.	1287	Un	16/06/2026	1,0000	61,1500	61,15

XBRIEL
Avenida José Veríssimo, 752 - Caruaru - PE
CNPJ:22721288000126 - Inscrição estadual: - Fone:37277250
(CNES 2680394)

Conta paciente

Nota:

Emissao:

N° atend: 14.364

Nº IC: 29.161

Paciente:	Convênio:	Usuário/Matrícula:
Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres	PARTICULAR	
Categoria: Apartamento		

Materiais

Seq	Setor	Descrição Material	Material	Unid.	Data	Qtde	Vl Unit.	Vl Total
7	HG_Bloco	CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.	1289	Un	16/06/2026	1,0000	61,1500	61,15
8	HG_Bloco	CATETER VENOSO PERIFERICO PUR DISP.	1290	Un	16/06/2026	1,0000	61,1500	61,15
9	HG_Bloco	COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM 20G	1295	Pct	16/06/2026	7,0000	64,6400	452,48
10	HG_Bloco	COMPRESSA GAZE ALGODONADA 15X30CM	1668	Un	16/06/2026	1,0000	27,4900	27,49
11	HG_Bloco	COMPRESSA GAZE NIDIA 11FIOS 7,5X7,5CM	58	Pct	16/06/2026	6,0000	6,5067	39,04
12	HG_Bloco	EQUIPO INTRAFIX PRIMELINE AIR IL	1325	Un	16/06/2026	1,0000	19,7000	19,70
13	HG_Bloco	FIO FILAPRON POLIGLECAPRONE 25 5.0	1729	Un	16/06/2026	1,0000	44,2300	44,23
14	HG_Bloco	FIO MITSU POLIGLACTINA 910 VIOLETA 0	1727	Un	16/06/2026	2,0000	74,9800	149,96
15	HG_Bloco	FIO POLIGLECAPRONE 25 3-0 70CM GASTRO	1909	Un	16/06/2026	3,0000	74,9800	224,94
16	HG_Bloco	FIO SUTURA NYLON PRETO 3-0 45CM AG.	1708	Un	16/06/2026	11,0000	26,1300	287,43
17	HG_Bloco	FITA MICROPOROSA 02,5CMX10CM	1580	Rl	16/06/2026	4,0000	5,8050	23,22
18	HG_Bloco	FIXADOR IV FIX EST.100UNID.	1304	Un	16/06/2026	1,0000	3,0200	3,02
19	HG_Bloco	LAMINA BISTURI EST.NR.15 100UN FEATHER	1353	Un	16/06/2026	3,0000	5,1333	15,40
20	HG_Bloco	LAMINA BISTURI EST.NR.22 100UN FEATHER	1354	Un	16/06/2026	3,0000	5,1333	15,40
21	HG_Bloco	LUVA CIRURGICA 7,5 SENSITEX EST.PAR 106	1372	Un	16/06/2026	3,0000	4,7333	14,20
22	HG_Bloco	LUVA CIRURGICA 8,0 SENSITEX EST.PAR 106	1373	Un	16/06/2026	1,0000	4,7300	4,73
23	HG_Bloco	MANGUEIRA P/CONEXAO TANDEM	1493	Un	16/06/2026	1,0000	33,0800	33,08
24	HG_Bloco	PLACA ELETROCIRURGICA BLUEPAD ADU.BI-	1396	Un	16/06/2026	1,0000	103,5000	103,50
25	HG_Bloco	SERINGA ANESTESICA 08ML LUER SLIP	1415	Un	16/06/2026	1,0000	100,0000	100,00
26	HG_Bloco	SERINGA INSULINA 1ML AG.13X0,45MM	1402	Un	16/06/2026	1,0000	4,0500	4,05
27	HG_Bloco	SERINGA 03ML AG.25X0,70MM LUER SLIP	1405	Un	16/06/2026	1,0000	2,3500	2,35
28	HG_Bloco	SERINGA 10ML AG.25X0,70MM LUER SLIP	1400	Un	16/06/2026	1,0000	4,3500	4,35
29	HG_Bloco	SERINGA 20ML AG.25X0,70MM LUER SLIP	1403	Un	16/06/2026	2,0000	7,9300	15,86
30	HG_Bloco	TORNEIRINHA 3VIAS POLIAMIDA LL P/SOL.	1489	Un	16/06/2026	1,0000	50,9800	50,98
31	HG_Bloco		1583	Un	16/06/2026	2,0000	15,0000	30,00
32	HG_Intern	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM C/DISP.SEG	1254	Un	16/06/2026	5,0000	0,5900	2,95
33	HG_Intern	AGULHA HIPODERMICA 40X1,20MM	8	Un	16/06/2026	2,0000	0,5900	1,18
34	HG_Intern	COMPRESSA CIRURGICA 25X28CM 20G	1295	Pct	17/06/2026	1,0000	64,6400	64,64
35	HG_Intern	COMPRESSA GAZE NIDIA 11FIOS 7,5X7,5CM	58	Pct	17/06/2026	2,0000	6,5050	13,01
36	HG_Intern	EQUIPO INTRAFIX PRIMELINE AIR IL	1325	Un	17/06/2026	1,0000	19,7000	19,70
37	HG_Intern	SERINGA 05ML S/AG.LUER LOCK	1414	Un	17/06/2026	3,0000	3,7800	11,34
38	HG_Intern	SERINGA 10ML AG.25X0,70MM LUER SLIP	1400	Un	17/06/2026	4,0000	4,3475	17,39
		Total de Materiais				**88,0000**		**2.248,72**

Total geral R$ **4.492,16**

-92,16
4.400,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 5345 Código de Verificação B9ZMMWOKJ Emissão da NFS-e 18/06/2026 12:13:16	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 22.122.088/0001-57 Inscrição 90605762

Nome/Razão Social: ALBUQUERQUE ANESTESIAS LTDA.

Endereço RUA José Veríssimo Número: 752

Complemento: Bairro: Maurício de Nassau

CEP: 55014-250 Município: CARUARU UF: PE País: Brasil

E-mail: SERVCONTSERVICOSCONTABEIS@HOTMAIL.COM Telefone: 98856-9965

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 097.798.184-30 Inscrição Municipal: NIF:

Nome/Razão Social: MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

Endereço: Rua 17 DE DEZEMBRO Número: 210

Complemento: Bairro: CENTRO

CEP: 55380-000 Município: CACHOEIRINHA UF: PE País: Brasil

E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

4.03 / 861010101 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Discriminação do Serviço

Serviços Prestados de Anestesias: CIRURGIA MAMOPLASTIA.

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 178,40.

PAGAMENTO EM ESPECIE.

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
10,40	Apuração Própria	48,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	1.600,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	58,40
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2301.19.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	200	Base de Cálculo	1.600,00
Classificação Tributária	200029	Alíquota	5,00
Competência	06/2026	ISSQN	80,00
Município Prestação	CARUARU - PE	IBS	1,46
Munícipio Incidência	CARUARU - PE	CBS	13,15
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.600,00

Outras Informações

RECIBO Nº VALOR 750,00

Recebi (emos) de Mc Daianny Lo da S. Pereira

a quantia de Setecentos e Cinquenta reais

Referente a Instrumentação de mastro - peça reduzida

e para clareza firmo (amos) o presente.

Cabedelo, 16 de Junho de 2026

Assinatura Joyane Mc Farias Silva.

Emitente

CPF 948.365.314-20 RG 5.610.766

ANIMATIVA

Num. 246438462 - Pág. 1

Nº

RECIBO

R$ 430,00

Receb _____ do (s) Sr. (s) Maria Divinny L. da S. P Torres

Endereço _____

a importância de Quatrocentos e Cinquenta reais

Referente Cistos mentecf. Nanoplastic

Para maior clareza firm ..... o presente

Coruau 16 de 06 de 2026

Emitente _____

Endereço _____

901 966 354-20

CNPJ - CPF - RG

Josiene da Penha

ASSINATURA

Nº

RECIBO

R$ 400,00

Receb ____ do (s) Sr. (s) Maria Dávinny Laetícia da Silva Torres

Endereço Av. Aracaju 784, Universitário

a importância de Quatrocentos reais

Referente Cuidados pós operatórios Curativo, Tapping e drenagem

Para maior clareza firm ..... o presente

Caruaru 05 de Junho de 2026

Emitente Fernanda Santos

Endereço R- R23 100 Caruaru

047.377.184-59

CNPJ - CPF - RG

ASSINATURA

LOTE 05/24

TAMOIO

Scanned with CamScanner

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26071313582708200000239625181
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071313582708200000239625181
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 13/07/2026 13:58:27

IDENTIFICAÇÃO DE LEITO

DATA DE ADMISSÃO 16/06/26

TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA
01-07 DIAS [X] 08-12 DIAS [ ] ACIMA DE 12 DIAS [ ]

PACIENTE MARIA DAVINCY

DATA DE NASCIMENTO 03/08/05

REGISTRO Nº 14.364

MÉDICO MARCOS GOMES

DIAGNÓTICOS MAMOPLASTIA

ALERGIAS [X] DIETA ZERO [X] DIPIRONA

CURATIVOS / / [ ] DRENOS / / [ ] SONDA / / [ ]

GERENCIAMENTO DE RISCOS

EXTUBAÇÃO ACIDENTAL [ ] PERDA DE SONDA/ CATETER [ ] QUEDA [ ] UPP [ ] TEV [ ] FLEBITE [ ] BRONCOASPIRAÇÃO [ ]

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

Processo nº **0008172-04.2026.8.17.2480**

AUTOR(A): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DECISÃO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento de despesas e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria Davinny Leticia da Silva Pereira Torres em face de Unimed Caruaru, Cooperativa de Trabalho Médico, por meio da qual a autora busca, em sede de urgência, a autorização e o custeio integral de cirurgia de mamoplastia redutora, de caráter reparador/funcional segundo laudo médico que instrui a inicial, procedimento que havia sido negado pela ré sob o fundamento de suposta natureza estética.

Sobreveio aos autos petição da própria autora noticiando, nos termos do art. 493 do CPC, que o procedimento cirúrgico foi efetivamente realizado em 16/06/2026, com alta em 17/06/2026, tendo a autora e sua família arcado com a integralidade dos custos, razão pela qual requer a apreciação do pedido de urgência já sob a ótica da obrigação de pagar (reembolso dos valores desembolsados), nos termos do que fora previamente formulado, de forma subsidiária, na exordial.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações relativas ao direito de cobertura, o requisito do periculum in mora não mais subsiste, na forma em que originalmente pleiteado. O procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, cuja autorização e custeio prévios eram objeto do pedido de urgência, já

foi integralmente realizado, conforme comunicado pela própria parte autora. Não há, portanto, situação de urgência a ser tutelada por meio de cognição sumária, na medida em que o risco que se pretendia afastar já se exauriu.

A pretensão relativa ao ressarcimento dos valores desembolsados, embora tenha sido antecipada pela própria autora como desdobramento do pedido original, não se reveste da urgência que autoriza a apreciação em sede de tutela provisória, tratando-se de matéria a ser regularmente instruída e decidida no curso do processo, após o crivo do contraditório, juntamente com os demais pedidos formulados na inicial.

Assim, ausente o requisito do perigo de dano, de rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência, sem prejuízo da análise, no momento processual oportuno, dos pedidos de mérito, inclusive quanto ao ressarcimento dos valores comprovadamente desembolsados.

Ante o exposto, **INDEFIRO** o pedido de tutela de urgência, ante a ausência do requisito do perigo de dano (art. 300 do CPC), tendo em vista que o procedimento cirúrgico já foi integralmente realizado, não subsistindo situação de urgência a ser tutelada por cognição sumária.

Cite-se a parte ré para, querendo, contestar a ação no prazo legal, prosseguindo o feito em seus ulteriores termos.

Intimem-se.

Caruaru/PE, 07/08/2026.

Elias Soares da Silva

Juiz de Direito

AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480
Autor(a): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
Réu: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados constituídos, vem à presença de Vossa Excelência oferecer **CONTESTAÇÃO** em face de MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.

1. SÍNTESE DA DEMANDA

O(A) Autor(a) de fato é usuário(a) de plano de saúde individual/familiar administrado pela Unimed Caruaru, cujo nome comercial é "Único Enfermaria Pessoa Física III", com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e área de abrangência regional (grupo de municípios). O plano foi contratado em 26/10/2005, de forma que é regulamentado pela Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde), conforme dispõe o seu art. 35, *caput*. Tudo isso conforme cópia do contrato de plano de saúde, proposta de adesão e relatórios já anexados aos autos.

Em sua petição inicial, a autora alega ser portadora de **macromastia com repercussão funcional na coluna vertebral**. Sustenta que o médico assistente indicou a realização de **mamoplastia redutora de caráter reparador** em razão da sua condição clínica.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

Contudo, alega que a solicitação do procedimento foi negada pela operadora sob a justificativa de se **tratar de cirurgia com natureza estética**. A demandante sustenta que a recusa se baseou em cláusula de exclusão contratual (art. 54, VIII) considerada abusiva à luz das regras de proteção ao consumidor. Narra, por fim, que optou por agendar o procedimento de forma particular para o dia 13 de junho de 2026. Informa o desembolso prévio de R$ 10.100,00 referentes a honorários e materiais, apontando a estimativa de um custo remanescente de R$ 9.900,00 a ser pago no momento da internação.

Diante da narrativa apresentada, a parte formulou pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear integralmente a cirurgia de mamoplastia redutora. No mérito, requereu o provimento da ação e a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

No despacho ID. 242085446, o juízo determinou que a Ré fosse intimada para falar sobre o pedido de tutela antecipada, o que foi feito na manifestação ID. 245851547.

Em momento posterior, a parte Autora noticiou o custeio e a realização da cirurgia por meios particulares no Hospital São Gabriel, efetuada no período de 16 a 17 de junho de 2016. Consoante recibos e notas fiscais acostados aos autos, a quantia total despendida no procedimento foi de R$ 17.700,00.

Com a superveniência dessa alteração fática decorrente do custeio privado, a parte Autora reiterou a pretensão expressa na exordial para converter a obrigação de fazer em obrigação de pagar. Assim, passou a pleitear a condenação da Unimed Caruaru ao reembolso da quantia de R$ 17.700,00, além do pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação por supostos danos morais.

Por meio da decisão ID. 249706193, o magistrado indeferiu o pleito de tutela de urgência diante do novo quadro fático. Entendeu o julgador que o pedido de ressarcimento das despesas efetuadas — postulado de forma antecipada pela

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

autora como desdobramento do requerimento exordial —, carece do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos para a concessão da tutela provisória, cabendo a matéria ser devidamente instruída e julgada ao longo da instrução processual.

Como será demonstrado os pleitos autorais de ressarcimento e de condenação da Unimed Caruaru não merecem prosperar, pelas razões expostas a seguir.

2. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

A demandante indicou originariamente à causa o valor equivalente a R$ 30.100,00. Todavia, em virtude da realização do procedimento cirúrgico por meio do custeio particular, constatou-se que as despesas efetivamente pagas somaram R$ 17.700,00, patamar aquém da estimativa inicial.

Estando o pleito autoral restrito à restituição dos gastos médico-hospitalares (R$ 17.700,00) acrescida da reparação moral almejada (R$ 10.000,00), a vantagem econômica pretendida no litígio alcança exatamente R$ 27.700,00.

Por conseguinte, necessária se faz a readequação do valor da causa para **R$ 27.700,00**, com esteio no art. 292, V, do Código de Processo Civil, garantindo-se a devida correspondência ao conteúdo patrimonial em disputa.

3. DO MÉRITO

3.1. Da licitude da negativa assistencial – Ausência de previsão no rol da ANS e decumprimento dos requisitos da ADI 7.265 do STF – Ausência de obrigação de reembolso

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

A autora pretende a condenação da Unimed Caruaru à restituição da quantia de R$ 17.700,00, sob o argumento de ter custeado de forma particular a realização de cirurgia de mamoplastia redutora.

Sem embargo, a apreciação do pedido ressarcitório pressupõe o prévio exame acerca da própria obrigatoriedade de cobertura do procedimento. Assim, antes de aferir eventual dever de reembolso, cumpre averiguar se subsistia à ré a obrigação legal ou contratual de autorizar e custear a referida intervenção cirúrgica.

Pois bem, em 07 de abril de 2026, a operadora recebeu solicitação administrativa referente aos procedimentos de mamoplastia redutora. O pedido foi submetido à auditoria médica que, em 09 de abril de 2026, concluiu pela **negativa de cobertura assistencial**, uma vez que o procedimento de redução das mamas não possui cobertura contratual nem integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A beneficiária foi informada sobre a negativa no mesmo dia, restando a guia finalizada como procedimento "nagado", conforme documento já anexo aos autos (ID. 245851552).

A recusa de cobertura para o procedimento de mamoplastia redutora decorreu da estrita observância normativa e contratual. O procedimento pleiteado não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual consubstancia a referência básica para a cobertura assistencial mínima obrigatória, nos termos do art. 10, §12, da Lei nº 9.656/98.

A exclusão da obrigatoriedade do procedimento não é uma deliberação isolada da operadora, mas diretriz técnica do ente regulador. O Parecer Técnico nº 19/2024 da ANS (ID. 245851551) dispõe de maneira expressa e indene de dúvidas que:

> "Já, o procedimento MASTOPLASTIA OU MAMOPLASTIA PARA CORREÇÃO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol e, portanto, não possui cobertura obrigatória."

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

Impende destacar, ademais, que o afastamento do procedimento pleiteado do Rol da ANS **remonta ao ano de 2009**. Por meio da Consulta Pública nº 31/2009[1], a autarquia reguladora avaliou diversas intervenções não constantes do catálogo oficial, dentre as quais a mamoplastia redutora, **rejeitando expressamente a sua inclusão ante a ausência de evidências científicas aptas a demonstrar o nexo causal direto entre o gigantismo mamário e as afecções de coluna**, o que reforça a natureza predominantemente estética do ato cirúrgico.

Cumpre esclarecer que, embora a cirurgia plástica de mama *tenha previsão no rol da ANS*, a obrigatoriedade de cobertura para o procedimento, conforme diretrizes da ANS, limita-se estritamente a **casos de natureza reparadora ou reconstrutiva**, não possuindo qualquer relação com o tratamento de gigantismo mamário (hipertrofia). As hipóteses taxativas de cobertura no Rol da ANS são a seguintes, conforme constam na busca pelo procedimento no site da ANS:

[1] Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/consultas-publicas-encerradas/consulta-publica-31

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

Verificar cobertura de plano

Cheque aqui se um determinado procedimento faz parte da cobertura assistencial que seu plano de saúde é obrigado a cobrir.

Segmentação | Procedimento | Cobertura

Confira se o procedimento é coberto pelo seu plano:

Escreva abaixo o nome do procedimento que você quer verificar se está incluído no seu plano.

Nome do procedimento: mamoplastia OK

Selecione um dos resultados abaixo e clique em continuar

ROL*	TUSS**	OUTROS SINÔNIMOS
MASTOPLASTIA EM MAMA OPOSTA APÓS RECONSTRUÇÃO DA CONTRALATERAL EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES	Mamoplastia	
RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES	Mamoplastia	
RECONSTRUÇÃO DA PLACA ARÉOLO MAMILAR	Mamoplastia	
RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS MUSCULARES E/OU CUTÂNEOS EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES	Mamoplastia	
SUBSTITUIÇÃO DE PRÓTESE EM CASO DE LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES	Mamoplastia	

1 de 1 1

*Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde: É a lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a segmentação assistencial do plano.
**Terminologia Unificada da Saúde Suplementar: tabela com os nomes e descrições de procedimentos de saúde conforme o padrão de nomenclatura estabelecido por planos de saúde, hospitais, profissionais de saúde e a ANS.

Como se observa, tais cenários referem-se a situações severas de mutilação ou patologias oncológicas e traumáticas, sendo, portanto, descabida a tentativa de equiparação com o quadro de gigantismo mamário, o qual possui caráter eminentemente estético e não atende aos critérios reparadores exigidos para a cobertura obrigatória.

Inexistindo previsão *específica* no rol da agência reguladora para a cirurgia de redução de mama, **a regra geral impõe a não autorização do procedimento pelo plano de saúde**. Aliado a isso, contrato de plano de saúde firmado pelas partes (ID. 245851548) veda a cobertura do procedimento, resguardando a limitação mesmo diante de alegações de repercussões ortopédicas. O artigo 54, inciso VIII, do instrumento dita de forma expressa:

> "Art. 54. Estão **excluídas** da cobertura deste contrato: (...)
>
> VIII cirurgias plásticas, exceto as reparadoras, decorrentes de acidentes ocorridos na vigência deste contrato (vigência esta

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

> considerada para o usuário), e que estejam causando problemas funcionais; tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos por motivos de senilidade, para rejuvenescimento, bem como para prevenção de envelhecimento, para emagrecimento (exceto o relacionado a obesidade mórbida) ou ganho de peso; tratamentos com finalidade estética, cosmética ou para alterações somáticas, **ficando claro que a mamoplastia não está assegurada, ainda que a hipertrofia mamária possa repercutir sobre a coluna vertebral**."

Sob este prisma, a negativa de cobertura possui lastro duplo: a normatização estatal delimitadora das obrigações mínimas e o princípio da força obrigatória dos contratos (*pacta sunt servanda*). A conduta da Ré evidencia, portanto, o exercício regular de direito, consubstanciado no estrito cumprimento do dever regulatório e da avença pactuada.

A imposição de cobertura extra-rol, como pretendido pela parte Autora, consubstancia medida de exceção, subordinada a critérios rigorosos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.265 com efeito vinculante e eficácia *erga omnes*, definiu que a cobertura fora do rol exige a constatação de cinco requisitos cumulativos:

> (...) Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
>
> (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente;
>
> (ii) **inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR)**;
>
> (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS;

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. **Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:** (...) (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, **não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte** (...)" *(STF, ADI 7.265, Tribunal Pleno, Julgamento concluído, Efeito Vinculante)*

A Autora não atende aos referidos parâmetros. A demonstração do preenchimento destes critérios perfaz o fato constitutivo do direito alegado, recaindo sobre a Demandante o ônus da prova, por força do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição inicial negligencia a demonstração da ausência de alternativa terapêutica no rol da ANS (requisito iii) e carece de literatura científica calcada na medicina baseada em evidências de alto nível que corrobore a superioridade e a imprescindibilidade da mamoplastia redutora para o tratamento da suposta patologia ortopédica noticiada (requisito iv), em detrimento de procedimentos e tratamentos já previstos no rol.

Ainda mais obstativo ao pleito é o descumprimento do requisito (ii). O Supremo Tribunal Federal veda a autorização extra-rol diante de **negativa**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

expressa da Agência Reguladora. Conforme delineado, o Parecer Técnico nº 19/2024 constitui exatamente o posicionamento oficial da ANS rechaçando a obrigatoriedade da cobertura da mastoplastia especificamente para correção de hipertrofia mamária. Há, logo, a frustração imediata dos pressupostos exigidos pela Corte Constitucional.

A tentativa de justificar a determinação de custeio com arrimo exclusivo nos relatórios dos médicos da Autora encontra barreira no mesmo precedente vinculante do STF. A tese firmada na ADI 7.265 (item 3, alínea 'c') impõe ao julgador o dever de aferir **a presença dos requisitos mediante consulta a entes com expertise técnica**. O STF é categórico ao estipular que, sob pena de nulidade da decisão judicial (art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC), o magistrado **não pode fundamentar a ordem de obrigação de fazer unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte**. O documento unilateral é legalmente insuficiente para a superação do rol legal e contratual.

Nesse contexto probatório, a suposta natureza funcional do procedimento carece de respaldo em critérios médicos objetivos. Conforme diretrizes evidenciadas pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) em Notas Técnicas sobre o tema, a exemplo da NT 1530, (**doc. 01**), a transmutação de uma mamoplastia redutora da **categoria estética** *para a* **reconstrutiva/reparadora** exige o preenchimento de parâmetros rigorosos e a comprovação documental do esgotamento de tratamentos alternativos.

A literatura médica baseada em evidências indica que o manejo inicial da hipertrofia mamária sintomática exige a tentativa prévia de opções terapêuticas conservadoras, tais como fisioterapia postural continuada, uso de sutiãs de suporte anatômico adequados e o emprego de analgésicos e anti-inflamatórios, medidas voltadas ao alívio da mastalgia, cervicalgia e dorsalgia. Agências internacionais exigem a persistência de sintomas a despeito de, no mínimo, três meses de teste documentado com tais medidas conservadoras para que a cirurgia seja considerada.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

Além disso, a avaliação da necessidade reparadora demanda correlação estrita com o Índice de Massa Corporal (IMC) da paciente. A relevância do peso do tecido mamário é diretamente atrelada ao IMC, sendo a estabilidade de peso (geralmente documentada em IMC < 30) um indicativo de que a hipertrofia não é uma mera decorrência do excesso de peso global da paciente (obesidade), condição que descaracterizaria a eficácia e a indicação primária do procedimento cirúrgico.

Os laudos subscritos pelos médicos assistentes da Autora são documentações estritamente unilaterais que não demonstram o preenchimento desses requisitos mínimos. Não há prova documental do esgotamento prévio de tratamentos fisioterápicos, tampouco a apresentação de achados de exame físico (peso, altura, estabilidade do IMC) e exames de imagem objetivos que isolem outras causas prováveis e estabeleçam, de forma imparcial, que os supostos problemas de coluna eram consequência direta da hipertrofia mamária.

A ausência de demonstração clínica isenta sobre o nexo causal e o não esgotamento de tratamentos alternativos afastam a presunção de natureza terapêutica da intervenção, mantendo seu enquadramento técnico-jurídico como procedimento de ordem estética. Sob esta premissa fática, a operadora encontra-se desobrigada do respectivo custeio por expressa vedação legal, insculpida no art. 10, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, que exclui procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos das exigências mínimas de cobertura:

> Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, **exceto**: (...)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

> II - **procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos**, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

Diante disso, evidencia-se a ausência de dever legal ou contratual da operadora em autorizar e custear a cirurgia de redução de mama, tendo em vista o seu caráter estético e a falta de previsão no Rol de Procedimentos da ANS. Por conseguinte, resta totalmente descabido qualquer pedido de reembolso dos valores despendidos pela beneficiária perante a rede particular.

3.2. Da inexistência de danos morais – Aplicação do Tema 1.365 do STJ e ausência de prova de violação aos direitos da personalidade

A autora requer o pagamento de indenização de R$ 10.000,00 a título de danos morais, sob o argumento de o abalo moral no caso concreto seria *in re ipsa* (presumido). O pleito carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos da responsabilidade civil estatuídos nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O dever de indenizar demanda a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O procedimento cirúrgico pleiteado ostentava natureza eletiva. Após a comunicação da negativa administrativa, a autora assumiu o custeio particular da intervenção. A realização da cirurgia pela via privada evidencia que a recusa da operadora não gerou agravamento do quadro clínico, nem descontinuidade de tratamento em regime de urgência que impusesse risco sistêmico.

Com o custeio particular, a discussão experimentou conversão imediata para a esfera patrimonial. A lide alicerça-se em divergência de interpretação contratual (abrangência do rol da ANS e das exclusões normativas e contratuais), sem irradiação de efeitos aos direitos da personalidade da demandante.

A demandante sequer se ocupa em comprovar a efetiva ocorrência de abalo psíquico, sustentando (conforme expressamente consta na inicial), de forma equivocada, a tese do dano moral presumido e dispensando a produção de prova a esse respeito.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.365), firmou o entendimento de que **o dano moral não possui presunção (*in re ipsa*) em episódios de negativa de cobertura por plano de saúde**. A tese paradigma estabelece:

> "A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (*in re ipsa*), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

Incumbia à autora, por imposição do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a produção de prova do dano efetivo. A petição inicial abstém-se de colacionar atestados psiquiátricos, laudos de evolução desfavorável da patologia ou evidências do agravo clínico decorrente da espera que atestem o propalado abalo psicológico. A ausência de provas do impacto na esfera extrapatrimonial obsta o acolhimento do pedido indenizatório.

Soma-se a isso o fato de a conduta da ré figurar amparada em exclusões contratuais e regulamentação técnica da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A jurisprudência pátria afasta a reparação civil em litígios fundados na interpretação de cláusula limitativa. Conforme determinação da Corte Superior, a recusa de tratamento fulcrada **em exclusão expressa ou interpretação de cláusula controvertida não enseja reparação imaterial**. O entendimento consolida-se nas seguintes ementas:

> "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. **É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral. Precedentes.** 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária afastaram o pleito indenizatório por força da natureza controvertida de cláusula do contrato. Rever tal entendimento exigiria o vedado reexame de provas. 4. Agravo interno não provido. *(STJ - AgInt no REsp 1681848/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)*"

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE DE MATERIAL IMPORTADO. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. **Não configura dano moral in re ipsa a recusa de tratamento expressamente excluído em contrato de plano de saúde, ainda que posteriormente a cláusula seja tida por abusiva e o tratamento venha a ser custeado por força de decisão judicial.** 2. Agravo interno desprovido. *(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1718060/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 05/09/2018)*"

Carecendo os autos de prova do dano suportado e demonstrada a conformidade normativa da conduta da operadora, requer-se a total improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por força do princípio da eventualidade, caso este Juízo entenda pela configuração de danos extrapatrimoniais, o *quantum* indenizatório postulado de R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional. A fixação da verba reparatória subordina-se à diretriz do artigo 944 do Código Civil, que impõe a medição da indenização pela extensão do dano. A realização do procedimento cirúrgico pela via particular obstou o desdobramento nocivo à saúde física da autora, esvaziando a extensão lesiva

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

oriunda da recusa. A ausência de agravo clínico demanda a redução da reparação a patamares mínimos, em cumprimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa, prática vedada pelo artigo 884 do diploma civil.

4. DA NECESSIDADE DE CONSULTA AO NATJUS – PREMISSA TÉCNICA PARA ANÁLISE DO PLEITO DE REEMBOLSO

A procedência do pedido de restituição de valores exige a constatação prévia e irrefutável de que a operadora detinha a obrigação legal e contratual de custear a intervenção cirúrgica. A divergência estabelecida sobre a natureza da mamoplastia redutora – se estética ou terapêutica – e o preenchimento dos parâmetros clínicos para a cobertura extra-rol consubstanciam matéria estritamente técnica, insuscetível de resolução exclusiva mediante a prova documental unilateral carreada à petição inicial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.265, firmou tese vinculante impondo ao Poder Judiciário o dever processual de consultar o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) ou entes com expertise técnica ao apreciar requerimentos de cobertura de procedimentos não abarcados pelo rol da ANS. O acórdão paradigma interdita a fundamentação de decisões judiciais com arrimo exclusivo em prescrição ou laudo médico elaborado por profissional particular da parte, exigindo a chancela técnica imparcial.

A averiguação do direito alegado demanda o crivo pericial sobre critérios médicos objetivos, que não restaram demonstrados nos atestados da autora. Nesse diapasão, para viabilizar o escorreito deslinde da lide patrimonial, requer-se a intimação do NATJUS para a confecção de Nota Técnica específica sobre as condições clínicas específicicas da autora e a conformidade da indicação cirúrgica aos protocolos da medicina baseada em evidências, cabendo à parte autora juntar aos autos exames médicos e demais documentos que entenda pertinentes para

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

análise do caso pelo NATJUS, em observância à distribuição do ônus da prova fixado na ADI 7.265.

5. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO requer a Vossa Excelência:

a) Preliminarmente, a readequação do valor da causa para R$ 27.700,00, com esteio no art. 292, V, do Código de Processo Civil, por representar o efetivo proveito econômico perseguido pela parte após realização da cirurgia, garantindo-se a devida correspondência ao conteúdo patrimonial em disputa

b) A notificação prévia do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) para elaboração de Nota Técnica, com o objetivo de atestar a natureza do procedimento cirúrgico e o preenchimento dos requisitos clínicos e normativos, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265;

c) No mérito, a **TOTAL IMPROCEDÊNCIA** dos pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se a licitude da negativa de cobertura assistencial e afastando-se, por conseguinte, as condenações por danos materiais (restituição de valores) e morais;

d) Pelo princípio da eventualidade, em caso de condenação à restituição de valores, que esta seja fixada na forma simples, limitando-se aos valores estipulados na tabela de honorários e serviços da operadora;

e) Pelo princípio da eventualidade, caso reconhecida a ocorrência de danos morais, a fixação do *quantum* indenizatório em patamar mínimo, em estrita observância aos artigos 944 e 884 do Código Civil;

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

f) A condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de novos documentos e a produção de prova técnica requerida no item "a" e, caso necessário, a prova pericial.

Nestes termos, pede deferimento.

Os patronos da empresa demandada atestam, sob sua responsabilidade, que as cópias dos documentos colacionados aos autos são autênticas e foram extraídas dos originais, a teor do que dispõe o art. 425, IV, do CPC.

Caruaru (PE), 01 de setembro de 2026.

Salomão Francisco Alves Filho
OAB/PE 27.989

José Lucas Romano da Luz
OAB/PE 60.980

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042765800000246153596
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042765800000246153596
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:27

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS

NOTA TÉCNICA

GIGANTOMASTIA / MAMOPLASTIA REDUTORA

PROCESSO: 0701497-61.2022.8.07.0003

Vara/ Serventia: 1º Juizado Especial Cível de Ceilândia

1. PACIENTE:

1.1. Nome: A. K. O. L.

1.2. Data de nascimento: 31/07/1990

1.3. Sexo: Feminino

1.4. Diagnóstico: Gigantomastia (ou hipertrofia mamária) sintomática (CID10: N62)

1.5. Meios confirmatórios do diagnóstico já realizados: Não foram anexados ao processo exames ou laudos de exames complementares que subsidiem o diagnóstico.

1.6. Resumo da história clínica e CID:

Conforme relatório médico da lavra do cirurgião plástico Cristian Haesbaert (CRM/DF nº 21.489), de 28 de outubro de 2021, trata-se de paciente portadora de mamas volumosas (gigantomastia) e dor crônica de padrão miofascial concentrada em cintura escapular. Segundo o relatório, a hipertrofia mamária promovia "p*rojeção para a frente [do corpo], ocasionando desbalanço sagital compensado pelo esforço muscular em manter-se ereta*", "*fadiga crônica, dor postural e desconforto pelo uso de suporte que traciona a musculatura dos ombros*". Refere ainda que a paciente tinha "*balanço sagital negativo compensando por hiperlordose lombar*".

A paciente foi submetida à mamoplastia redutora em 26/10/2021, dois dias antes da elaboração do relatório médico acima citado, e não foram identificados no processo outros documentos (exames prévios, avaliação ortopédica ou de qualquer outra área médica, ou parecer de junta pericial) que atestem sobre o quadro da paciente antes da realização do procedimento.

2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA

2.1. Tipo da Tecnologia: Procedimento

2.2. Princípio Ativo: Não se aplica

2.3. Via de administração: Não se aplica

2.4. Posologia: Não se aplica

2.5. Registro na ANVISA? Não se aplica

2.6. Situação do registro: Não se aplica

2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Não se aplica

2.8. Oncológico? Não

2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não

2.9. O medicamento faz parte do ROL da ANS? Não.

A mamoplastia redutora para tratamento da hipertrofia mamária é realizada no SUS quando se trata de cirurgia plástica não estética (cirurgia reconstrutiva). Nesse caso, o encaminhamento para esse procedimento deve ser realizado por um médico profissional da rede pública de saúde.

Segundo a Associação Médica Americana, a cirurgia estética é indicada quando se deseja remodelar as estruturas normais do corpo, objetivando melhor aparência e autoestima do paciente. Já a cirurgia reconstrutiva seria aquela destinada a corrigir ou atenuar estruturas anormais do corpo, em decorrência de defeitos congênitos, anormalidades de desenvolvimento, trauma, infecção, tumores ou doenças. Geralmente ela é feita para melhorar uma função corporal, porém também pode ser realizada para aproximar a aparência àquela considerada normal.

2.10. Descrever as opções disponíveis na Saúde Suplementar:

O único tratamento definitivo para a gigantomastia é a correção cirúrgica, entretanto, este não faz parte expressamente do rol da ANS. Pode-se empregar tratamento sintomático para as manifestações decorrentes da gigantomastia (mastalgia, ulceração, infecção submamária, problemas posturais, cervicalgia, dorsalgia e injúria por tração crônica dos 4º, 5º e 6º nervos intercostais), como, por exemplo, fisioterapia postural, sutiãs de apoio ou ainda uso de analgésicos e anti-inflamatórios, com vistas ao alívio da dor, que, entretanto, não visam resolver a causa do problema.

3. EVIDÊNCIAS SOBRE A EFICÁCIA E SEGURANÇA DA TECNOLOGIA:

3.1 SOBRE A HIPERTROFIA MAMÁRIA (GIGANTOMASTIA)

Gigantomastia (ou hipertrofia mamária) é uma rara condição caracterizada pelo crescimento excessivo da mama, que pode ser física e psicossocialmente incapacitante.

A hipertrofia mamária sintomática pode ser definida como uma síndrome causada pelo aumento do volume e peso do tecido mamário além das proporções normais. A paciente pode cursar com dor mamária (mastalgia); dor persistente na região do pescoço e ombros, com formação de sulcos dolorosos nos ombros devido às alças do sutiã; erupção cutânea, ulceração ou infecção na região inframamária; problemas posturais; dor nas costas; lesão crônica por tração de nervos intercostais; episódios frequentes de cefaleia; entre outras queixas.

Algumas publicações consideram o peso da mama como critério para o diagnóstico de gigantomastia. Dancey *et al.* propuseram que a gigantomastia fosse definida como um crescimento mamário em excesso de mais de 1.500g em cada mama.

Dafydd *et al*, em 2011, argumentaram que a relevância do peso do tecido mamário está relacionada com o IMC (Índice de Massa Corporal) da paciente, pois uma paciente com IMC alto pode apresentar mamas grandes e pesadas, mas que seriam proporcionais naquele caso, porém, consideradas excessivas numa paciente mais magra. Daí, a porcentagem de peso corporal seria um termo mais adequado para avaliar o tamanho da mama. Com base nesse entendimento, eles conceituaram a hipertrofia mamária como um excesso de

tecido mamário que contribui com 3% ou mais para o peso corporal total da paciente.

Infelizmente, a mensuração exata da quantidade de tecido mamário removido é uma avaliação pós-operatória, logo, é difícil sua utilização para estabelecer um diagnóstico ou influenciar o manejo. Dessa forma, sugere-se uma análise estimada do excesso de peso da mama no pré-operatório, podendo-se utilizar técnicas como a fotografia 3D juntamente com a volumetria assistida por computador.

Em 2008, Dancey *et al.* sugeriram uma classificação para gigantomastia, dividindo-a em:

> 1a: Condição espontânea/idiopática em paciente com obesidade (IMC >30)
>
> 1b: Condição espontânea/idiopática em paciente com IMC <30
>
> 2a: Ginecomastia relacionada a um desequilíbrio da produção hormonal endógena que ocorre durante a puberdade
>
> 2b: Ginecomastia relacionada a um desequilíbrio da produção hormonal endógena que ocorre durante a gravidez
>
> 3: Crescimento excessivo da mama induzido por um agente farmacológico

Pacientes que se encontram na condição 1 (1a ou 1b) costumam obter melhores resultado e prognóstico com a redução de mama. Para aquelas enquadradas na condição 2 (2a ou 2b), que sofrem com desequilíbrio da atividade hormonal endógena, a evolução pode ser crítica e a mastectomia (retirada de todo tecido mamário) certamente deve ser considerada. Já a condição 3 é um fenômeno induzido por drogas e tem sido atribuído a vários

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042791600000246153597
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042791600000246153597
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:28

agentes farmacológicos (bucilamina e penicilamina), que tende a ser interrompido quando a utilização da droga ou do medicamento é suspensa. Contudo, a redução mamária pode ser necessária para retornar as mamas ao seu padrão anterior.

3.2 SOBRE A MAMOPLASTIA REDUTORA

A mamoplastia redutora é um dos procedimentos mais comumente realizados no Brasil e no mundo. Em 2014, foram realizadas 101.192 mamoplastias redutoras nos Estados Unidos, segundo as estatísticas da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

Uma mamoplastia redutora pode ser considerada uma cirurgia reconstrutiva, no caso de uma hipertrofia mamária sintomática, ou uma cirurgia estética.

Por exemplo, no Reino Unido, a cirurgia de redução de mama é considerada cosmética, a menos que a hipertrofia da mama esteja causando dor significativa, parestesias ou ulceração. Neste caso, ela é considerada uma cirurgia reconstrutiva e pode ser realizada no sistema de saúde britânico, caso sejam preenchidas algumas condições pré-operatórias, tais como: IMC menor que 30 e estável por 12 meses, além de registro fotográfico pré-cirúrgico da condição.

Uma mamoplastia redutora, no contexto de uma hipertrofia mamária sintomática, tem o intuito de obter um tamanho de mama proporcional ao corpo, aliviando o desconforto (dores nas costas, pescoço e ombros) e mitigando o risco de infecção ou outras comorbidades relacionadas a seios excessivamente grandes.

Segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, tratamentos conservadores para alívio permanente dos sintomas de hipertrofia mamária,

tais como sutiãs de apoio, fisioterapia, exercícios e medicamentos, não são considerados eficazes para pacientes com hipertrofia mamária sintomática e não são consideradas medidas custo-efetivas com esse propósito.

Conforme a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, a cirurgia de redução de mama é considerada a primeira linha de tratamento nos casos de hipertrofia mamária sintomática (Nível de Evidência I).

Nos Estados Unidos, o peso das mamas é muito usado como critério determinante para cobertura do seguro de saúde. Para o *National Health System* (NHS) do Reino Unido, esse dado também é considerado importante na avaliação pré-operatória, caso a paciente deseje realizar essa cirurgia pelo sistema público britânico. Isso porque se entende improvável que haja alívio significativo de dores cervicais com a remoção de apenas pequenas quantidades de tecido mamário. Assim, é ponderada a relação “dose-resposta” entre a quantidade de tecido mamário removido e o alívio dos sintomas.

Entretanto, a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos argumenta que é muito difícil determinar qual o tamanho de mamas é considerado patológico para uma paciente. Por isso orienta que a justificativa para a cirurgia de redução de mama, num caso de gigantomastia sintomática, deve basear-se no grau de sintomatologia da paciente, ou seja, na probabilidade de alívio dos sinais e sintomas clínicos da gigantomastia sintomática com a cirurgia redutora.

O volume de mama ressecado não está correlacionado com o grau de alívio dos sintomas pós-operatórios (Nível de Evidência II), segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos. Dessa forma, para mulheres com gigantomastia sintomática, independentemente do volume mamário, a

mamoplastia redutora pode provocar alívio pós-operatório semelhante e melhora da qualidade de vida.

Segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, os critérios de cobertura do seguro para hipertrofia mamária sintomática nos Estados Unidos devem se basear no registro de pelo menos dois sintomas, dentre os quais podem ser citados:

- Dor mamária crônica devido ao peso das mamas;

- Intertrigo (lesão da pele) inframamário que não responde ao tratamento médico;

- Dor na parte superior das costas, pescoço e ombro;

- Sulcos nos ombros decorrentes do peso das alças do sutiã;

- Dormência nos braços devido à compressão do plexo braquial (secundária ao peso das mamas transferido para a área da alça no ombro).

Assim, a documentação pré-cirúrgica é fundamental para a justificativa de cobertura pelo seguro de saúde da mamoplastia redutora, demonstrando sua necessidade médica (cirurgia reconstrutiva).

Além da descrição da sintomatologia da paciente, sua duração e gravidade, sugere-se incluir no prontuário médico exames de imagem que indiquem patologias osteomusculares (tais como hiperlordose lombar), fotografias da mama da paciente antes da cirurgia, possíveis sulcos do ombro, cifose etc.; informações sobre outras possíveis causas dos sintomas álgicos da paciente que foram descartadas, medidas conservadoras para o tratamento da dor, impacto da dor na qualidade de vida da paciente, conforme questionários específicos.

4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA:

Alívio da sintomatologia da paciente e melhora na sua qualidade de vida física e emocional.

5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: Não há.

6. RECOMENDAÇÕES DE AGÊNCIAS INTERNACIONAIS DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE:

O NHS, do Reino Unido, considera a mamoplastia redutora uma cirurgia reconstrutiva quando são preenchidos os seguintes critérios:

- Evidência fotográfica da condição (incluindo apenas fotografias tiradas por fotografia médica) E;

- IMC menor que 30kg/m^2 e estável por 12 meses E;

- Remoção estimada de 500g de tecido mamário E.

A paciente deve ter pelo menos um dos seguintes sintomas:

- Dor crônica na coluna cervical ou torácica superior sem outros fatores precipitantes agudos;

- Dor crônica nos ombros e sobre o músculo trapézio;

- Dores de cabeça não relacionadas a outra causa;

- Dor com inclinação cervical e cifose associada documentada por raios-X;

- Dor / desconforto / ulceração na região das alças do sutiã cortando os ombros;

Desde que os sintomas de dor persistam, conforme documentado por um médico, apesar de pelo menos 3 meses de teste com medidas terapêuticas, como:

- Dispositivos de suporte orientado por um profissional (por exemplo, suporte adequado para o sutiã);

- Intervenções com analgésicos/anti-inflamatórios não esteroides.

7. CONCLUSÕES

Considerando tratar-se de paciente de 31 anos, portadora de mamas volumosas (gigantomastia) e dor crônica de padrão miofascial concentrada em cintura escapular, com "*projeção para a frente [do corpo], ocasionando desbalanço sagital compensado pelo esforço muscular em manter-se ereta*", "*fadiga crônica, dor postural e desconforto pelo uso de suporte que traciona a musculatura dos ombros*" e "*balanço sagital negativo compensando por hiperlordose lombar*", conforme relatório do cirurgião plástico Cristian Haesbaert (CRM/DF nº 21.489), emitido dois dias após a mamoplastia redutora;

Considerando que o documento disponível nos autos sobre a patologia da paciente limita-se ao relatório médico emitido após a cirurgia, feito pelo próprio médico cirurgião plástico que realizou o procedimento;

Considerando que não constam nos autos avaliação ortopédica ou outro relatório médico anterior ao procedimento cirúrgico que informe sobre o quadro da dor referida da paciente, achados de exame físico (tais como peso e altura), resultado de exames de imagem (que indiquem patologias osteomusculares (tais como hiperlordose lombar), fotografias da mama da paciente, antes da cirurgia ou possíveis sulcos do ombro decorrente das alças dos sutiã, informações sobre outras possíveis causas dos sintomas álgicos da paciente que foram descartadas ou medidas conservadoras para o tratamento da dor;

Este NATJUS conclui manifestar-se como **NÃO FAVORÁVEL** à demanda.

8. Há evidências científicas?

Sim.

9. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM:

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.451/95 traz a definição de urgência e emergência

"*Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata.*

Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"

De acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.

10. Referências Bibliográficas:

1. *American Society of Plastic Surgeons. ASPS Recommended Insurance Coverage Criteria for Third-Party Payers. Reduction Mammaplasty. 2017. Disponível em: https://www.plasticsurgery.org/Documents/Health-Policy/Reimbursement/insurance-2017-reduction-mammaplasty.pdf*
2. *Dafydd H, Roehl KR, Phillips LG, Dancey A, Peart F, Shokrollahi K. Redefining gigantomastia. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Feb;64(2):160-3. doi: 10.1016/j.bjps.2010.04.043. Epub 2010 Jun 8. PMID: 20965141.*
3. *Dancey A, Khan M, Dawson J, Peart F. Gigantomastia--a classification and review of the literature. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61(5):493-502. doi: 10.1016/j.bjps.2007.10.041. Epub 2007 Nov 28. PMID: 18054304.*
4. *Greco R, Noone B. Evidence-Based Medicine: Reduction Mammaplasty. Plast Reconstr Surg. 2017 Jan;139(1):230e-239e. doi: 10.1097/PRS.0000000000002856. PMID: 28027257.*
5. *Koltz PF, Frey JD, Langstein HN. Insurance coverage and reduction mammaplasty: a systematic review of current health care policies. Plast Reconstr Surg. 2013 Oct;132(4):692e-693e. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182a014f6. PMID: 24076738.*
6. *Nguyen JT, Wheatley MJ, Schnur PL, Nguyen TA, Winn SR. Reduction mammaplasty: a review of managed care medical policy coverage*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042791600000246153597
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042791600000246153597
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:28

criteria. Plast Reconstr Surg. 2008 Apr;121(4):1092-1100. doi: 10.1097/01.prs.0000304238.43482.9c. PMID: 18349625.

7. *NHS Leeds North Clinical Commissioning Group, NHS Leeds South and East Clinical Commissioning Group e NHS Leeds West Clinical Commissioning Group. Aesthetic (Cosmetic) surgery and other related procedures: Evidence based framework for decision making. Leeds CCGs Cosmetic Framework 2013-16. 2015. Disponível em: https://www.leedsccg.nhs.uk/content/uploads/2014/07/Cosmetic-exceptions-and-exclusions.pdf*

11. NATJUS responsável: NATJUS/TJDFT

BSB, 12/07/2022.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26090117042791600000246153597
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26090117042791600000246153597
Assinado eletronicamente por: JOSE LUCAS ROMANO DA LUZ - 01/09/2026 17:04:28

5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru
Processo nº 0008172-04.2026.8.17.2480
AUTOR(A): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES
RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ATO ORDINATÓRIO - INTIMAÇÃO

Em cumprimento ao Provimento do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Pernambuco nº 08/2009 (DOPJ de 09/06/2009), bem como com fundamento no art. 152, VI, e no art. 203, § 4º, ambos da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), fica(m) intimado(a)(s) o(a)(s) Autor(a)(es)/Exequente(s) para que, no prazo legal, manifeste(m)-se sobre a contestação, impugnação, exceção e documentos eventualmente juntados aos autos.

Caso tenha sido apresentada reconvenção, deverá(ão) apresentar resposta específica no mesmo prazo legal.

CARUARU, 1 de setembro de 2026.

INFORMAÇÃO

A presente intimação foi expedida e disponibilizada nos autos por **AUTONOMIA – plataforma integrada de automações e IA** - em conformidade com o art. 21, § 2º, e art. 22 da Resolução CNJ nº 615/2025, bem como observadas as normas processuais e administrativas aplicáveis.

DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU/PE

PROCESSO Nº
0008172-04.2026.8.17.2480

AUTORA
MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

RÉ
UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

OBJETO
Réplica à contestação de ID 253221618

MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES, já qualificada nos autos do processo epigrafado, por intermédio de seu advogado que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, tempestivamente, apresentar

RÉPLICA À CONTESTAÇÃO

de ID 253221618, oferecida por **UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I · CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DO QUE A CONTESTAÇÃO NÃO IMPUGNOU

Antes do enfrentamento dos argumentos defensivos, cumpre registrar o que a contestação, por silêncio eloquente, tornou incontroverso nos autos (art. 341 do CPC).

A Ré não impugna a existência e a vigência do contrato há mais de vinte anos. Não impugna o regular adimplemento das mensalidades. Não impugna a autenticidade do laudo médico que instruiu o pedido administrativo, tampouco a das notas fiscais e recibos que documentam o desembolso de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais).

Não impugna a realização do procedimento cirúrgico, que ela própria reconhece expressamente em sua peça. E, sobretudo, não apresenta um único documento médico produzido a partir do exame da Autora: não há contraparecer, não há auditoria clínica individualizada, não há avaliação presencial.

Registre-se, desde logo, que a pecha de "documentação unilateral", repetida ao longo da defesa, cai diante da origem dos próprios documentos que instruem os autos: **a solicitação do procedimento foi formalizada no formulário oficial da própria Ré, por médico que atende pela sua rede, fundada em laudo de neurocirurgião produzido em**

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

atendimento realizado pelo convênio mantido com a própria operadora, como se demonstrará no tópico 3.

Toda a defesa se resume, portanto, a duas linhas argumentativas abstratas: o enquadramento genérico do procedimento como estético e a invocação dos requisitos da ADI 7.265 do STF para hipótese que, como se demonstrará, não é a destes autos.

II · DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA: CONCORDÂNCIA DA AUTORA

A Ré requer a readequação do valor da causa para R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), correspondente à soma do ressarcimento documentado (R$ 17.700,00) e da indenização por danos morais postulada (R$ 10.000,00).

A Autora concorda com a readequação. A retificação decorre naturalmente do fato superveniente já comunicado nos autos (art. 493 do CPC), consistente na realização do procedimento por custeio particular, que converteu a estimativa inicial em valores líquidos e documentados. Nos termos do art. 292, V, do CPC, o valor da causa passa a corresponder exatamente ao proveito econômico perseguido.

Registre-se que, sendo a Autora beneficiária da justiça gratuita, não há recolhimento complementar de custas. A preliminar, assim, resolve-se sem qualquer repercussão sobre o mérito.

III · DA CAUSA DE PEDIR PRINCIPAL, QUE A CONTESTAÇÃO NÃO ENFRENTOU

A defesa construiu-se integralmente sobre o debate acerca do rol da ANS e dos requisitos de cobertura de procedimentos nele não previstos. Ocorre que a causa de pedir principal desta ação é anterior e independente desse debate, e está apoiada em quatro fundamentos autônomos, nenhum deles enfrentado pela contestação.

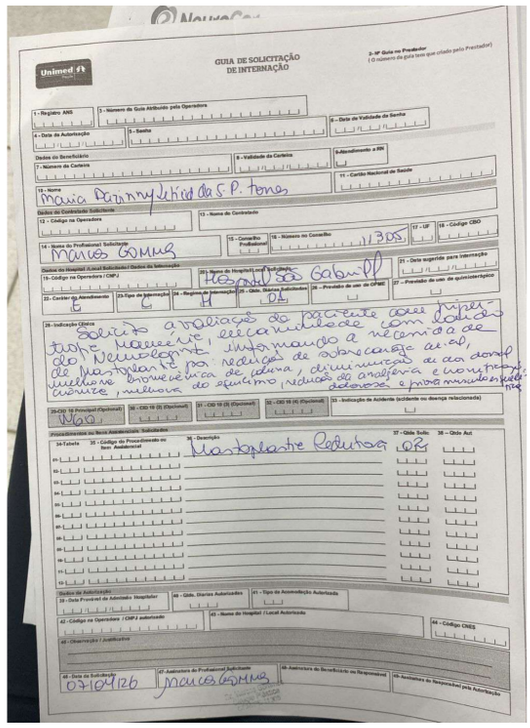
Primeiro: o procedimento realizado não é estético, mas reparador e funcional. O laudo do Dr. Felipe Augusto Fernandes Martins, neurocirurgião (CRM 20619/PE, RQE 10833), emitido em 07/04/2026, mais de dois meses antes do ato cirúrgico, descreve dorsalgia crônica mecânico-postural com alívio apenas parcial com analgésicos, alteração postural com hipercifose torácica, dor à palpação da musculatura paravertebral, sobrecarga musculoligamentar posterior e escoliose torácica objetivamente medida (18,9° a

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

20°), consignando quatro CIDs (N62, M54.6, M40.2 e M41.9) e concluindo expressamente pela indicação de mamoplastia redutora de caráter reparador e funcional, e não estético.

E aqui reside dado que a contestação preferiu ignorar, mas que os documentos de ID 242020101 revelam com clareza. O laudo do Dr. Felipe consigna, em seu próprio cabeçalho, o campo "Convênio: Unimed": a avaliação neurocirúrgica que fundamentou a indicação foi realizada em atendimento coberto pelo convênio mantido com a própria Ré.

E a solicitação do procedimento foi formalizada na Guia de Solicitação de Internação, formulário oficial timbrado da Unimed, preenchida e assinada em 07/04/2026 pelo Dr. Marcos Gomes, médico que atende pela rede da própria Ré, com CID principal N62, procedimento "Mastoplastia Redutora" e indicação clínica que declara expressamente a concordância com o laudo do especialista, enumerando finalidades exclusivamente funcionais: redução de sobrecarga axial, melhora da dor dorsal, melhora da biomecânica da coluna, melhora do equilíbrio, redução da analgesia contínua e prevenção de cronificação dolorosa. Confira-se:


GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO

Unimed

Maria [illegible] da S. P. Jones

Marcos Gomes

Mastoplastia Redutora

07/04/26

Marcos Gomes

Guia de Solicitação de Internação (ID 242020101): formulário oficial timbrado da Unimed, preenchido e assinado pelo Dr. Marcos Gomes em 07/04/2026, com CID N62, procedimento "Mastoplastia Redutora" e finalidades exclusivamente funcionais.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

A solicitação foi processada no sistema administrativo da Ré (Guia nº 144786009) e negada em apenas dois dias, sem exame da paciente e sem contraparecer. A Ré recebeu, dentro do seu próprio fluxo, a convergência de dois médicos de especialidades distintas, **um deles atuante em sua rede e outro em atendimento que ela própria cobriu, e desprezou ambos sem produzir um único documento clínico**.

Segundo: a hipertrofia mamária é doença listada na Classificação Internacional de Doenças (CID N62). Por força do art. 10, caput, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do tratamento das doenças listadas na CID. Esse é precisamente o fundamento adotado pela Primeira Câmara Regional de Caruaru deste Egrégio Tribunal, em caso idêntico e contra a própria Ré:

> *"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E DE DANOS MORAIS. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO E NÃO ESTÉTICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A cirurgia de correção de hipertrofia mamária consiste em um procedimento médico para atenuar os problemas corporais do paciente, que afetam a sua saúde e qualidade de vida, reduzindo o risco de agravamento do estado de saúde, demonstrando o seu caráter não estético. 2. No caso em análise, existe solicitação pormenorizada do profissional de saúde indicando o procedimento solicitado como solução adequada à condição médica apresentada pela paciente. Configurado está, portanto, o ato abusivo do plano de saúde ao recusar a cobertura da cirurgia reparadora pleiteada. 3. A hipertrofia mamária está listada na Classificação Internacional de Doenças, CID 10, da Organização Mundial de Saúde e, por isso, é obrigatória a cobertura do respectivo tratamento por parte dos planos de saúde, nos termos do art. 10 da Lei 9.656/98. 4. O rol da ANS não é taxativo, pois contém apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde contratados no território nacional, de maneira que funciona como mero orientador das prestadoras de serviços de saúde, consoante jurisprudência majoritária. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em situações semelhantes (negativa indevida de cobertura por plano de saúde), caracteriza-se o dano moral indenizável. 6. O quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), anulando as cláusulas consideradas abusivas perante a situação desigual entre as partes, bem como a necessidade da interpretação do contrato em favor do consumidor, conforme arts. 47 e 51, incisos I e IV do CDC. 8. Resta configurado e imperioso o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário referentes à cirurgia de correção de hipertrofia mamária unilateral. 9. Inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados estes em 20% sobre o valor da condenação. 10. Apelação provida, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Regional de Caruaru, 1ª Turma, deste Tribunal de Justiça, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO à apelação nº 0009675-12.2016.8.17.2480, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, Desembargador JOSÉ VIANA ULISSES FILHO*

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

> *Relator.*" (TJ-PE, AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru, 1ª Turma, j. 29/05/2020, caso envolvendo a Unimed Caruaru)

Terceiro: a cláusula 54, VIII, do contrato é nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC), porquanto pré-exclui qualquer avaliação clínica individualizada, chegando ao ponto de antecipar e rechaçar, em abstrato, exatamente o argumento clínico que fundamenta a indicação médica da Autora (a repercussão da hipertrofia sobre a coluna vertebral). O TJPE fixou tese expressa:

> *"EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Caso em exame Apelação interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a cobertura integral de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora prescrito à autora, bem como o pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00. 2. Questão em discussão Há duas questões centrais postas em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura por parte do plano de saúde encontra respaldo contratual legítimo e se o procedimento cirúrgico possui natureza meramente estética ou terapêutica; (ii) saber se a sentença merece reforma quanto ao índice de correção monetária aplicado sobre a indenização moral arbitrada. III. Razões de decidir 3. Os laudos médicos carreados aos autos, firmados por especialistas em mastologia, ortopedia e cirurgia plástica, apontam para a necessidade clínica da intervenção cirúrgica, restando demonstrada a finalidade terapêutica do procedimento e, por conseguinte, a abusividade da negativa de cobertura por parte da operadora, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 4. A indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional ao abalo vivenciado e compatível com os precedentes desta Corte em hipóteses similares. 5. No que concerne à atualização do montante indenizatório, aplica-se o entendimento firmado no REsp n. 2.170.806/RJ, julgado em 17/03/2025 pela Terceira Turma do STJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que estabelece a Taxa SELIC como índice unificado para correção monetária e juros moratórios nas condenações por danos morais, afastando a cumulatividade com o IPCA. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para alterar o critério de correção monetária da indenização por danos morais, que deverá observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, desde a data da sentença. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora, quando clinicamente indicada, ainda que prevista exclusão contratual, por se tratar de procedimento de finalidade terapêutica. 2. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice unificado de atualização monetária e juros de mora sobre indenização por danos morais. (...)"* (TJPE, AC nº 0097813-53.2024.8.17.2001, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 08/10/2025)

Quarto: o próprio contrato, em seu art. 39, assegura cobertura à Cirurgia Plástica Reparadora destinada à restauração de funções em regiões que estejam causando problemas funcionais. O laudo demonstra que a mamoplastia redutora visou à restauração da

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

função biomecânica da coluna torácica. A contestação silenciou por completo sobre essa exceção contratual, que, sozinha, resolve a lide em favor da Autora.

Qualquer um desses quatro fundamentos é suficiente, por si só, para a procedência. E nenhum deles depende da discussão sobre o rol da ANS, terreno para o qual a Ré tenta deslocar artificialmente a controvérsia.

IV · DA NOTA TÉCNICA NT 1530: DOCUMENTO DE OUTRO PROCESSO, DE OUTRO TRIBUNAL E DE OUTRA PACIENTE, CUJO CONTEÚDO CIENTÍFICO CONFIRMA A TESE AUTORAL

A "Nota Técnica NatJus NT1530" juntada pela Ré (ID 253221619) merece exame atento, porque revela mais do que a defesa pretendia.

Em **primeiro** lugar, a nota não foi produzida nestes autos e nada diz sobre a Autora. Trata-se de nota técnica do NATJUS/TJDFT, datada de 12/07/2022, emitida no processo nº 0701497-61.2022.8.07.0003, do 1º Juizado Especial Cível de Ceilândia, Distrito Federal, a respeito de paciente diversa, então com 31 anos de idade. A Ré apresentou ao Juízo, como subsídio técnico, documento de outro caso, de outro tribunal, de outro estado, emitido há mais de quatro anos.

Em **segundo** lugar, a conclusão desfavorável daquela nota fundou-se exclusivamente nas lacunas probatórias daquele caso concreto, como consta expressamente de suas "Conclusões": lá, o único documento médico era relatório emitido dois dias após a cirurgia, pelo próprio cirurgião que a realizou, sem exames prévios, sem avaliação ortopédica independente, sem exames de imagem e sem registro de medidas conservadoras.

O caso destes autos é o oposto simétrico daquele. Aqui há laudo prévio, emitido mais de dois meses antes da cirurgia; subscrito por neurocirurgião que não realizou o procedimento; com achados de exame físico descritos; com análise radiográfica objetiva (escoliose de 18,9° a 20°, hipercifose torácica); e com registro expresso da insuficiência do tratamento conservador. Cada deficiência que motivou a conclusão negativa daquela nota encontra, nestes autos, o documento correspondente que a supre.

Em **terceiro** lugar, e este é o ponto decisivo, pelo princípio da comunhão da prova o conteúdo da nota agora pertence ao processo, e seu mérito científico confirma integralmente a tese autoral. A nota afirma, textualmente: que "o único tratamento definitivo

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

para a gigantomastia é a correção cirúrgica"; que os tratamentos sintomáticos "não visam resolver a causa do problema"; que, segundo a Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, os tratamentos conservadores "não são considerados eficazes" para hipertrofia mamária sintomática nem constituem medidas custo-efetivas; que "a cirurgia de redução de mama é considerada a primeira linha de tratamento nos casos de hipertrofia mamária sintomática (Nível de Evidência I)"; que o volume de mama ressecado não se correlaciona com o grau de alívio dos sintomas (Nível de Evidência II), devendo a justificativa da cirurgia basear-se no grau de sintomatologia da paciente; que os critérios de cobertura da ASPS exigem o registro de apenas dois sintomas, dentre os quais dor mamária crônica, dor na parte superior das costas, pescoço e ombro, e sulcos nos ombros, quadro que a Autora ostenta com sobras nos autos; e que, entre os critérios do NHS britânico, figura justamente a "dor com inclinação cervical e cifose associada documentada por raios-X", que é o achado radiográfico literal do laudo que instruiu esta ação.

A nota registra, ainda, que a mamoplastia redutora em caso de hipertrofia mamária sintomática constitui cirurgia reconstrutiva, tanto que realizada pelo SUS como cirurgia plástica não estética.

Em síntese: a Ré trouxe aos autos o estado da arte da medicina baseada em evidências sobre o tema, e ele demonstra que o procedimento indicado à Autora é reconstrutivo, de primeira linha, com evidência científica de nível máximo, e que as alternativas conservadoras são ineficazes. O documento da defesa é, em seu conteúdo, prova da Autora.

V · DA CONSULTA PÚBLICA Nº 31/2009 E DO PARECER TÉCNICO Nº 19/2024: ATOS SEM NATUREZA DECISÓRIA E SUPERADOS PELO MARCO NORMATIVO POSTERIOR

A contestação inova ao invocar a Consulta Pública ANS nº 31/2009, da qual extrai a suposta rejeição da inclusão da mamoplastia redutora no rol "ante a ausência de evidências científicas do nexo causal entre gigantismo mamário e afecções de coluna".

O argumento não resiste a três observações.

Primeira: consulta pública é instrumento de participação social, não ato decisório de indeferimento de incorporação; encerrada há dezessete anos, nada delibera e nada vincula.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

Segunda: o cenário normativo e jurisprudencial que aquela consulta refletia deixou de existir, pois lhe sobrevieram a Lei nº 14.454/2022, o EREsp 1.886.929/SP e a própria ADI 7.265, que redesenharam por completo o regime da cobertura assistencial. Confira-se a tese então fixada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:

> *"1 - o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS."* (STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/06/2022, DJe 03/08/2022)

Note-se que o subitem (i) da tese exige, para a exceção, que não tenha havido indeferimento expresso, pela ANS, da incorporação do procedimento ao rol. É exatamente a hipótese dos autos: jamais existiu Proposta de Atualização do Rol indeferida quanto à mamoplastia redutora, como a própria contestação admite. A consulta pública de 2009 e o parecer de gerência de 2024 não são, nem nunca foram, atos de indeferimento de incorporação.

Terceira observação, e a mais eloquente: a premissa científica que a Ré extrai da consulta (ausência de nexo entre gigantomastia e afecções da coluna) é frontalmente desmentida pela NT 1530 que a própria Ré juntou, a qual arrola, entre as manifestações clínicas da hipertrofia mamária sintomática, exatamente os problemas posturais, a dor nas costas, a cervicalgia e a lesão crônica por tração de nervos intercostais.

Quanto ao Parecer Técnico nº 19/2024, reitera-se o que já consta dos autos: documento de gerência técnica emitido em resposta a consulta genérica, sem procedimento regulatório, sem contraditório e sem natureza decisória, não constitui a "negativa expressa" da ANS a que se refere o requisito (ii) da tese vinculante da ADI 7.265. A negativa ex-

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

pressa ali referida é o indeferimento em Proposta de Atualização do Rol (PAR), **e a própria contestação admite que jamais existiu PAR relativa ao procedimento**. Inexistindo PAR indeferida e inexistindo pendência de análise, o requisito encontra-se atendido, e não violado, no caso concreto.

VI · SUBSIDIARIAMENTE: AINDA QUE SE ADENTRASSE O EXAME EXTRARROL, OS REQUISITOS DA ADI 7.265 ESTÃO PREENCHIDOS

Sem prejuízo da causa de pedir principal (tópico 3), que dispensa por completo o debate do rol, os cinco requisitos da tese vinculante estão demonstrados nos autos, em parte pelo próprio documento juntado pela defesa.

O requisito **(i)**, prescrição por médico assistente, está atendido com qualificação rara: **a indicação proveio de laudo de neurocirurgião produzido em atendimento pelo convênio da própria Ré e foi formalizada por médico que atende pela sua rede, no formulário oficial da operadora (ID 242020101)**.

O requisito **(ii)**, inexistência de negativa expressa da ANS ou de PAR pendente, está atendido conforme o tópico anterior.

O requisito **(iii)**, ausência de alternativa terapêutica adequada no rol, está atestado pela NT 1530 juntada pela Ré: **o único tratamento definitivo é a correção cirúrgica, e os conservadores são ineficazes e não custo-efetivos**.

O requisito **(iv)**, comprovação de eficácia pela medicina baseada em evidências de alto nível, está igualmente atestado pela mesma nota: primeira linha de tratamento, Nível de Evidência I.

O requisito **(v)**, registro na Anvisa, é inaplicável a procedimento cirúrgico, como a própria nota consigna em seu item 2.5 (“não se aplica”).

O ônus probatório que a Ré alega descumprido foi, portanto, satisfeito nos autos, e parcela relevante dessa satisfação proveio do documento que a própria Ré escolheu juntar.

VII · DO RESSARCIMENTO INTEGRAL: INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO À TABELA DA OPERADORA

Em pedido subsidiário, a Ré postula que eventual condenação restituitória seja limitada “aos valores estipulados na tabela de honorários e serviços da operadora”. O pedido confunde institutos distintos.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

O reembolso limitado à tabela é próprio da hipótese de livre escolha de prestadores não credenciados (art. 12, VI, da Lei 9.656/98), na qual a operadora nenhum ilícito cometeu e o beneficiário optou, por conveniência, pela rede particular.

Não é o caso dos autos.

Aqui, o custeio particular foi consequência direta e forçada de negativa ilícita de cobertura: a Autora não escolheu a rede particular; foi a ela empurrada pela recusa da operadora. A hipótese é de reparação civil integral (arts. 389 e 944 do Código Civil), que restitui à vítima exatamente aquilo que ela perdeu por causa do inadimplemento.

Essa é a solução consagrada por este Tribunal no precedente da Câmara Regional de Caruaru contra a própria Ré, que determinou, sem qualquer limitação tarifária, o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário: "Resta configurado e imperioso o ressarcimento das despesas feitas pelo usuário referentes à cirurgia de correção de hipertrofia mamária unilateral" (TJ-PE, AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480, item 8 da ementa integralmente transcrita no tópico 3).

Os valores, ademais, são módicos, líquidos e integralmente documentados por notas fiscais e recibos que a contestação não impugnou. E o desembolso remanescente efetivo (R$ 7.600,00) ficou abaixo da estimativa declinada na inicial (R$ 9.900,00), a evidenciar a moderação e a boa-fé da Autora na condução da demanda.

VIII · DOS DANOS MORAIS: OS ELEMENTOS CONCRETOS EXIGIDOS PELO TEMA 1.365 DO STJ ESTÃO PRESENTES

A Autora não postula a aplicação automática de presunção de dano. A própria tese invocada pela contestação (Tema 1.365 do STJ) admite expressamente a indenização quando presentes "outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor". Esses elementos estão documentados nos autos, e não são poucos.

A Autora é jovem de vinte anos que convivia com dor crônica refratária, com alívio apenas parcial mediante uso contínuo de analgésicos, conforme laudo não impugnado. A negativa foi emitida em apenas dois dias, sem exame da paciente, sem contraparecer técnico e desprezando indicação que nasceu do próprio sistema da Ré: laudo de neurocirurgião produzido em atendimento pelo seu convênio e solicitação formalizada em

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

seu formulário oficial por médico que atende pela sua rede. A família da Autora, hipossuficiente (gratuidade da justiça deferida nos autos), foi compelida a mobilizar R$ 17.700,00 para custear obrigação que era da operadora, à qual paga mensalidades há mais de vinte anos ininterruptos.

O ato cirúrgico precisou ser adiado de 13 para 16/06/2026. E a conduta da Ré é reincidente: este mesmo Tribunal, por sua Câmara Regional de Caruaru, já a condenou em caso idêntico de negativa de cobertura de cirurgia de correção de hipertrofia mamária, reconhecendo, ali, o dano moral (AC nº 0009675-12.2016.8.17.2480, ementa integralmente transcrita no tópico 3).

No mesmo sentido, a Súmula deste Tribunal:

> *"SÚMULA 35 do TJPE: A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral."*

Não socorrem a Ré, tampouco, os precedentes que invoca sobre "cláusula controvertida". Confira-se a integralidade de ambos:

> *"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária afastaram o pleito indenizatório por força da natureza controvertida de cláusula do contrato. Rever tal entendimento exigiria o vedado reexame de provas. 4. Agravo interno não provido."* (STJ, AgInt no REsp 1.681.848/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/04/2018, DJe 17/04/2018)
>
> *"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE DE MATERIAL IMPORTADO. EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a recusa de tratamento expressamente excluído em contrato de plano de saúde, ainda que posteriormente a cláusula seja tida por abusiva e o tratamento venha a ser custeado por força de decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido."* (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.718.060/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/08/2018, DJe 05/09/2018)

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

Ambos os julgados pressupõem controvérsia interpretativa razoável, e nenhum deles enfrentou hipótese de operadora já condenada, pelo mesmo Tribunal e na mesma Comarca, pela mesma negativa. Controvérsia razoável não existe quando a recusa afronta jurisprudência consolidada e reiterada do Tribunal local sobre a mesma cláusula, o mesmo procedimento e a mesma operadora, e despreza indicação médica gestada dentro da própria rede da recusante. A recusa, aqui, não traduz divergência interpretativa de boa-fé: traduz insistência em prática já reiteradamente censurada por esta Corte, e a reiteração da conduta já censurada é exatamente o elemento concreto que o Tema 1.365 exige.

O quantum postulado (R$ 10.000,00) situa-se no patamar moderado da faixa praticada pelo TJPE em casos análogos (R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00, conforme precedentes já colacionados nos autos), com atualização pela Taxa SELIC exclusiva a partir da sentença, nos exatos termos da tese de julgamento nº 2 firmada por este Tribunal na AC nº 0097813-53.2024.8.17.2001 (ementa integralmente transcrita no tópico 3), que incorporou às condenações por danos morais o entendimento do REsp n. 2.170.806/RJ (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/03/2025).

IX · DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO: PROVA DOCUMENTAL COMPLETA E DESNECESSIDADE DE NOVA CONSULTA AO NATJUS

A controvérsia remanescente nestes autos é exclusivamente de direito: a validade da cláusula 54, VIII, o alcance da exceção reparadora do art. 39 do contrato e as consequências jurídicas da negativa. Todos os fatos relevantes estão documentados e incontroversos: o quadro clínico (laudo prévio de neurocirurgião com análise radiográfica, não impugnado), a negativa (guia e resposta à NIP), a realização do procedimento (reconhecida pela própria contestação) e os desembolsos (notas fiscais e recibos não impugnados).

E não há que se falar em "documentações estritamente unilaterais". Como demonstrado no tópico 3, a indicação médica que instrui os autos proveio de dentro do sistema da própria Ré: laudo de neurocirurgião emitido em atendimento coberto pelo seu convênio e solicitação formalizada em seu formulário oficial, por médico que atende pela sua rede, processada em seu sistema administrativo. A parte que nada produziu foi a Ré, que em toda a fase administrativa e em toda a fase judicial não apresentou um único documento clínico sobre a paciente.

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

A própria Ré, ademais, incorporou aos autos o estado da arte científico sobre o tema (NT 1530), que reconhece a cirurgia como primeira linha de tratamento da hipertrofia mamária sintomática, com evidência de Nível I.

Nada há a perquirir tecnicamente: nova consulta ao NatJus serviria apenas para subsidiar decisão sobre tratamento futuro, e o procedimento já se realizou; a pretensão remanescente é ressarcitória, de prova exclusivamente documental, já integralmente produzida. A diligência requerida pela Ré é, com as vênias de estilo, desnecessária e meramente protelatória, devendo ser indeferida (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Este Egrégio Tribunal tem tese expressa para a hipótese:

> *"EMENTA: Direito à Saúde. Plano de Saúde. Agravo de Instrumento. Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pedido de tutela de urgência. Decisão interlocutória que determinou a realização de prova pericial médica. Reforma. Desnecessidade da perícia. Existência de laudo médico fundamentado. Prerrogativa do profissional assistente. Abusividade de cláusula restritiva. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Provimento do recurso. (...)* ***Compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento adequado ao paciente. A cláusula contratual que limita cobertura de tratamento prescrito por profissional qualificado é nula de pleno direito, por violar o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A realização de prova pericial é desnecessária quando o processo está instruído com laudo médico técnico e circunstanciado, subscrito por profissional habilitado****."* (TJPE, AI nº 0007731-91.2025.8.17.9000, Rel. Des. Djalma Andrelino Nogueira Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 29/09/2025)

Estando o feito maduro, **requer-se o julgamento antecipado do mérito**, na forma do art. 355, I, do CPC.

X · DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer a Autora:

a) O acolhimento da concordância manifestada quanto à readequação do valor da causa para R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), sem recolhimento complementar, ante a gratuidade deferida;

b) A rejeição do pedido de consulta ao NatJus e o indeferimento de qualquer outra dilação probatória requerida pela Ré, por desnecessárias e protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), com o consequente julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC);

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

c) No mérito, a total procedência dos pedidos, com a condenação da Ré ao ressarcimento integral de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, afastada expressamente qualquer limitação à tabela de honorários e serviços da operadora;

d) A condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização pela Taxa SELIC exclusiva a partir da sentença, nos exatos termos da tese de julgamento nº 2 da AC nº 0097813-53.2024.8.17.2001 deste Tribunal (transcrita no tópico 3), que incorporou o entendimento do REsp n. 2.170.806/RJ (STJ, Terceira Turma, j. 17/03/2025);

e) A condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), com majoração em caso de recurso desprovido, na forma da tese do Tema 1.059 do STJ: *"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"* (STJ, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.059).

Nestes termos,
pede e espera deferimento.

Caruaru/PE, 10 de setembro de 2026.

MELQUISEDEQUE S. DE LIMA
Advogado · OAB/PE 56.324

Este documento foi gerado pelo usuário 094.***.***-60 em 15/10/2026 21:21:58
Número do documento: 26091020115263800000247181899
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26091020115263800000247181899
Assinado eletronicamente por: MELQUISEDEQUE SOUZA DE LIMA - 10/09/2026 20:11:52

Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
5ª Vara Cível da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

Processo nº **0008172-04.2026.8.17.2480**

AUTOR(A): MARIA DAVINNY LETICIA DA SILVA PEREIRA TORRES

RÉU: UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DESPACHO

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem se desejam produzir outras provas, especificando-as. Em caso de prova testemunhal, apresentar rol, sob pena de preclusão.

Não havendo outras provas a produzir, o mérito será julgado antecipadamente.

Cumpra-se.

CARUARU, 6 de outubro de 2026.

Juiz de Direito